

ICCP

Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad

EVALUACIÓN DE RASGOS POSITIVOS Y PATOLÓGICOS DE LA PERSONALIDAD

GUADALUPE DE LA IGLESIA
ALEJANDRO CASTRO SOLANO

ICCP

Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad

EVALUACIÓN DE RASGOS POSITIVOS Y PATOLÓGICOS DE LA PERSONALIDAD



LEGALES

Los autores

GUADALUPE DE LA IGLESIA. Licenciada en Psicología y Doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Estadística para Ciencias de la Salud, por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es Jefa de Trabajos Prácticos de la asignatura Teoría y Técnicas de Exploración y Diagnóstico Psicológico, Módulo I, Cátedra II en la Universidad de Buenos Aires. Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con sede en la Universidad de Palermo.

ALEJANDRO CASTRO SOLANO. Licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Psicología, egresado de la Universidad Complutense de Madrid. Es Profesor Adjunto Regular de la asignatura Teoría y Técnicas de Exploración y Diagnóstico Psicológico, Módulo I, Cátedra II en la Universidad de Buenos Aires. Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con sede en la Universidad de Palermo. Director del Doctorado de la Universidad de Palermo en Psicología.

Índice

CAPÍTULO 1. LA PERSONALIDAD “NORMAL” Idiográfico vs. Nomotético, <i>por Alejandro Castro Solano</i>	00
El abordaje idiográfico	00
El abordaje nomotético o psicométrico	00
Unidades de análisis de la personalidad: niveles y dominios	00
El enfoque léxico y los Cinco Grandes de la Personalidad (<i>Big Five</i>)	00
La evaluación de la personalidad	00
En síntesis	00
 CAPÍTULO 2. LA PERSONALIDAD “PATOLÓGICA” Los trastornos de personalidad y los DSM, <i>por Alejandro Castro Solano</i>	00
Nosologías internacionales: los DSM	00
La propuesta de Theodore Millon y los DSM	00
Los problemas del DSM	00
La propuesta del DSM-5	00
La evaluación de la personalidad	00
 CAPÍTULO 3. LA PERSONALIDAD “POSITIVA” Las fortalezas del carácter, las virtudes y los rasgos positivos, <i>por Alejandro Castro Solano</i>	00
La psicología positiva y el funcionamiento óptimo	00
La evaluación de las fortalezas del carácter	00
Los problemas de la clasificación VIA: aspectos culturales	00
Los estudios émicos: aproximación psicoléxica	00
Los estudios derivados del consenso de expertos: El continuo salud-enfermedad	00
A modo de conclusión	00
 CAPÍTULO 4. MODELO DUAL DE LA PERSONALIDAD El Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad (ICCP), <i>por Guadalupe de la Iglesia</i>	00
El Modelo Dual de la Personalidad (MDP)	00
El Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad (ICCP)	00
 CAPÍTULO 5. INVENTARIO DE LOS CINCO CONTINUOS DE LA PERSONALIDAD (ICCP) Propiedades psicométricas, <i>por Guadalupe de la Iglesia, Alejandro Castro Solano y Mercedes Fernández Liporace</i>	00
Diseño de ítems y estudios iniciales	00

Análisis de las escalas específicas	000
Construcción de los Índices Globales	000
Desarrollo de las escalas de validez	000
Baremización	000
CAPÍTULO 6. Administración y Puntuación del ICCP, <i>por Guadalupe de la Iglesia</i>	000
Descripción del ICCP	000
Índices de validez	000
Índices globales	000
Escalas específicas	000
Ámbito de aplicación del test	
Indicaciones para la administración del test	
Materiales para la administración y puntuación manual	000
Materiales para la administración y puntuación <i>on line</i>	000
Interpretación de los perfiles del ICCP	000
CAPÍTULO 7. Interpretación del ICCP y casuística, <i>por Guadalupe de la Iglesia y Alejandro Castro Solano</i>	000
Interpretación de los perfiles del ICCP	000
Escalas de Validez	000
Ausencia de respuesta (AR), 000; Inconsistencia (INC), 000; Magnificación de Psicopatología (MGPAT), 000; Minimización de Psicopatología (MNPAT), 000; Magnificación de Rasgos Positivos (MGPOS), 000	
Interpretación de los Índices Globales	000
Índice de Funcionamiento de la Personalidad (IFP), 000; Índice de Rasgos Patológicos de la Personalidad (IPAT), 000; Índice de Rasgos Positivos de la Personalidad (IPOS), 000; Índice de Ajuste de la Personalidad (IAP), 000; Índice de Conductas Externalizantes (IEXT), 000; Índice de Conductas Internalizantes (IINT), 000	
Interpretación de las Escalas Específicas	000
Funcionamiento del Sí-Mismo (FS), 000; Funcionamiento Interpersonal (FI), 000; Afecto Negativo (AF), 000; Serenidad (SE), 000; Desapego (DA), 000; Humanidad (HU), 000; Antagonismo (AN), 000; Integridad (IN), 000; Desinhibición (DI), 000; Moderación (MO), 000; Psicoticismo (PS), 000; Vivacidad y foco (VF), 000	
Casuística	
1. Caso Delfina, 000; 2. Caso Pedro, 000; 3. Caso Lisa, 000; 4. Caso Amanda, 000; 5. Caso Mariano, 000; 6. Caso Florencia, 000	
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	000
ANEXO 1. Administración manual	
1.A ICCP - Cuadernillo de Administración	000
1.B ICCP - Tablas de puntuación y Baremo 2019	000
1.C ICCP - Perfil	000
ANEXO 2. Administración <i>on line</i>	
.....	
.....	
.....	

ÍNDICE DE TABLAS

Capítulo 1

Tabla 1. Niveles de análisis de la personalidad (Emmons, 1995)	000
Tabla 2. Dominios de la personalidad (Emmons, 1995).	000
Tabla 3. Algunas unidades de análisis para el estudio de la personalidad	000
Tabla 4. Subdimensiones de los cinco factores (Sánchez-Cánovas & Sánchez López, 1994).	000

Capítulo 2

Tabla 1. Sistema Multiaxial del DSM-III (1980)	000
Tabla 2. Agrupación de los trastornos de la personalidad en clúster según el DSM-IV	000
Tabla 3. Sistema Multiaxial del DSM-IV (1994)	000
Tabla 4. Clasificaciones de los trastornos de la personalidad según las diferentes versiones del DSM	000
Tabla 5. Innovaciones del DSM-5	000
Tabla 6. Dimensiones e indicadores del Criterio A para valorar los trastornos de la personalidad	000
Tabla 7. Dimensiones de los rasgos patológicos de la personalidad (Criterio B)	000
Tabla 8. Facetas por cada rasgo de personalidad patológico	000
Tabla 9. Facetas de los cinco rasgos de la personalidad patológicos del DSM-5	000
Tabla 10. Trastornos de personalidad propuestos por la Sección III del DSM-5	000

Capítulo 3

Tabla 1. Fortalezas y Virtudes en el modelo de Peterson y Seligman	000
Tabla 2. Principales hallazgos empíricos de la relación entre fortaleza y diferentes componentes del bienestar psicológico	000
Tabla 3. Modelo de los Cinco Altos. Definición breve e ítems	000
Tabla 4. Rasgos positivos de la personalidad (Positive Personality Model)	000

Capítulo 4

Tabla 1. Escalas del ICCP	000
---------------------------	-----

Capítulo 5

Tabla 1. Cargas factoriales de las escalas de funcionamiento de la personalidad (Criterio A)	000
Tabla 2. Cargas factoriales de las escalas de rasgos patológicos	000
Tabla 3. Índices de ajuste: análisis factoriales confirmatorios de los índices globales	000
Tabla 4. Ítems de la escala Inconsistencia	000
Tabla 5. Ítems de la escala Magnificación de Psicopatología	000
Tabla 6. Ítems de la escala Minimización de Psicopatología	000
Tabla 7. Ítems de la escala Magnificación de Rasgos Positivos	000
Tabla 8. Percentiles correspondientes a puntuaciones T lineales	000

Capítulo 7

Tabla 1. Interpretación de Ausencia de Respuesta (AR)	000
Tabla 2. Interpretación de Inconsistencia (INC)	000
Tabla 3. Interpretación de Magnificación de Psicopatología (MGPAT)	000
Tabla 4. Interpretación de Minimización de Psicopatología (MNPAT)	000
Tabla 5. Interpretación de Magnificación de Rasgos Positivos (MGPOS)	000
Tabla 6. Interpretación del Índice de Funcionamiento de la Personalidad (IFP)	000
Tabla 7. Interpretación del Índice de Rasgos Patológicos de la Personalidad (IPAT)	000
Tabla 8. Interpretación de Índice de Rasgos Positivos de la Personalidad (IPOS)	000
Tabla 9. Interpretación del Índice de Ajuste de la Personalidad (IAP)	000
Tabla 10. Interpretación del Índice de Conductas Externalizantes (IEXT)	000
Tabla 11. Interpretación del Índice de Conductas Internalizantes (IINT)	000
Tabla 12. Interpretación de Funcionamiento del Sí-Mismo (FS)	000
Tabla 13. Interpretación de Funcionamiento Interpersonal (FI)	000
Tabla 14. Interpretación de Afecto Negativo (AF)	000
Tabla 15. Interpretación de Serenidad (SE)	000
Tabla 16. Interpretación de Desapego (DA)	000
Tabla 17. Interpretación de Humanidad (HU)	000

Tabla 18. Interpretación de Antagonismo (AN)	000
Tabla 19. Interpretación de Integridad (IN)	000
Tabla 20. Interpretación de Desinhibición (DI)	000
Tabla 21. Interpretación de Moderación (MO)	000
Tabla 22. Interpretación de Psicoticismo (PS)	000
Tabla 23. Interpretación de Vivacidad y Foco (VF)	000
Anexo 1	
Tabla B.1. Codificación de las respuestas	000
Tabla B.2. Ítems de la escala INC	000
Tabla B.3. Ítems de las escalas MGPAT, MNPAT y MGPOS	000
Tabla B.4. Ítems de las escalas específicas	000
Tabla B.5. Escalas pertenecientes a los Índices Globales	000
Tabla B.6. Fórmula para el cálculo del Índice de Ajuste de la Personalidad	000
Tabla B.7. Medias y desviaciones estándar para el cálculo manual del Índice de ajuste de la personalidad	000
Tabla B.8. Baremo 2019 para las Escalas de Validez e Índices Globales del ICCP	000
Tabla B.9. Baremo 2019 para las Escalas Específicas del ICCP	000

ÍNDICE DE FIGURAS

Capítulo 2	
Figura 1. Relación entre ejes del DSM y dinámica de los trastornos de personalidad	000
Capítulo 3	
Figura 1. Proceso Inductivo de generación de los rasgos positivos (Modelo High Five)	000
Capítulo 4	
Figura 1. Continuos de rasgos de la personalidad	000
Figura 2. Zonas de ajuste global de la personalidad	000
Capítulo 6	
Figura 1. Perfil del ICCP	000
Figura 2. Ejemplo de escalas de validez	000
Figura 3. Ejemplo de índices globales	000
Figura 4. Ejemplo de escalas específicas	000
Figura 5. Ejemplo de codificación de respuestas	000
Figura 6. Espacio para transcribir las puntuaciones brutas	000
Figura 7. Ejemplo de respuestas no puntuables (ítems 3, 4 y 5)	000
Figura 8. Ejemplo de puntaje bruto de la escala AR	000
Figura 9. Ejemplo de cálculo de puntaje bruto de la escala INC	000
Figura 10. Ejemplo de puntaje bruto de la escala INC	000
Figura 11. Ejemplo de puntaje bruto de la escala MGPAT	000
Figura 12. Ejemplo de puntaje bruto de una escala específica	000
Figura 13. Ejemplo de puntaje bruto de una escala global	000
Figura 14. Ejemplo de uso del baremo	000
Figura 15. Ejemplo de perfil	000
Figura 16. Guía para la interpretación del perfil obtenido con el ICCP	000
Capítulo 7	
Figura 1. Perfil del caso Delfina	000
Figura 2. Perfil del caso Pedro	000
Figura 3. Perfil del caso Lisa	000
Figura 4. Perfil del caso Amanda	000
Figura 5. Perfil del caso Mariano	000
Figura 6. Perfil del caso Florencia	000

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL TEST: Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad (ICCP)

AUTORES: Guadalupe de la Iglesia y Alejandro Castro Solano

PROCEDENCIA: Buenos Aires, Argentina

APLICACIÓN: Individual o grupal

EDAD DE APLICACIÓN: 18 años en adelante

DURACIÓN: 30 minutos aproximadamente

FINALIDAD: Evaluación de rasgos patológicos y positivos de la personalidad

TIPIFICACIÓN LOCAL: Baremos generales para sujetos de 18 años o más de edad

ÁMBITOS DE APLICACIÓN: Psicología (ámbito clínico, ámbito laboral, ámbito comunitario, ámbito educacional, ámbito forense) y Psiquiatría

MATERIAL:

Para la administración manual: Cuadernillo de administración, Tablas de puntuación y baremo, Perfil (Anexo 1)

Para la administración on line: licencia de uso o toma, computadora con conexión a Internet.

1. La personalidad “normal”

Idiográfico vs. Nomotético

Alejandro Castro Solano

El término *personalidad* es un término relativamente nuevo, y como palabra dentro del lenguaje psicológico contemporáneo surge en los primeros años del siglo XX. Durante el siglo XIX la palabra *personalidad* era utilizada en textos nuevos, religiosos o en tratados éticos, o bien era dominio de la medicina y estaba reservada solamente para la descripción de los casos psiquiátricos. En aquella época la personalidad no formaba parte del dominio de la psicología.

El gran auge de la psicología de la personalidad puede situarse en los años 20 con el surgimiento de los *tests de personalidad*. El primer test de personalidad fue el *Woodworth Personal Data Sheet* (1920). Los tests de personalidad eran técnicas de lápiz y papel, en los que las personas respondían a una gran cantidad de ítems, de los cuales se obtenía una puntuación que indicaba la presencia y la magnitud de alguna característica psicológica específica. Estos tests de personalidad intentaban imitar, de algún modo, a los tests de inteligencia que habían tenido gran éxito durante la Primera Guerra Mundial, para la selección de soldados aptos para la guerra.

Los primeros teóricos de la personalidad fueron los que observaron las diferencias individuales en el ámbito clínico. Esta tradición clínica estaba vinculada con la concepción del ser humano como único, individual e irrepetible. Los teóricos que proponían este enfoque eran partidarios del abordaje individual y del estudio intensivo de un solo sujeto. La idea que guía este enfoque es que la explicación de los malestares psicológicos por los que las personas consultan es única e individual y está en relación con los eventos vitales de la biografía personal. Este abordaje tuvo gran impacto durante la primera mitad del siglo XX, gracias al auge del psicoanálisis. Este movimiento se popularizó en los Estados Unidos a partir de la visita de Freud en 1909 al Nuevo Mundo y la traducción de sus escritos al idioma inglés. No obstante, en los ámbitos académicos este enfoque era considerado poco científico y se lo asociaba con el abordaje médico y psiquiátrico del cual la nascente psicología científica intentaba distanciarse para consolidarse como disciplina independiente (Barnbaun & Winter, 2008).

Estas dos tradiciones respecto del estudio de la personalidad pueden resumirse en: 1) El estudio de las *diferencias psicológicas individuales*, cuyo eje central de estudio son los *rasgos psicológicos* y 2) El estudio de las personas como seres únicos, individuales e integrados. A este último enfoque se lo denomina *idiográfico*. A continuación, comentaremos cada uno de ellos.

EL ABORDAJE IDIOGRÁFICO

En las primeras tres décadas del siglo XX tuvo lugar el surgimiento de las grandes teorías de la personalidad. Los psicólogos que abogaban por un enfoque *idiográfico* eran partidarios de una concepción *holística* u *organísmica* de la personalidad. Tenían un particular interés en descubrir los principios de funcionamiento que explicaban la singularidad de cada sujeto. Estos psicólogos consideraban que cada persona era *singular, única e irrepetible*. Los autores basaban sus afirmaciones en el estudio clínico de pocos sujetos (pacientes) que estaban realizando tratamiento psicoterapéutico. En este enfoque, *personalidad* era sinónimo de *psiquismo* o *aparato psíquico*, otorgándose especial importancia al influjo de los vectores internos en la determinación tanto de los actos, los pensamientos, como de las emociones de las personas (Fierro, 1996). En esta línea cobraba especial importancia el poder comprender las causas del funcionamiento psicológico individual.

Se trataba de una línea de abordaje psicodinámica vinculada al auge del psicoanálisis freudiano en la primera mitad del siglo XX; su exponente más importante fue el psicólogo Henry Murray. En su libro *Explorations in Personality* (1938) describe de forma exhaustiva 51 casos clínicos de pacientes. Murray es muy conocido por la creación del test proyectivo TAT (*Thematic Apercepción Test*), técnica mediante la cual era posible explorar, a través de la narración de historias, las motivaciones y necesidades profundas de las personas. El trabajo de Murray tuvo gran impacto sobre el desarrollo de la psicología de la personalidad en los años siguientes.

Dentro de este abordaje idiográfico también podemos citar a Carl Rogers y a George Kelly: son las contribuciones más importantes al campo de la psicología de la personalidad desde este punto de vista y de gran auge durante los años 50. El abordaje de Rogers se encuentra dentro de lo que denominamos *psicología humanista*, que fue una alternativa tanto al psicoanálisis clásico como al conductismo. Se trata de una psicología interpretativa de la experiencia humana consciente, que rescata la búsqueda de sentido vital, la libertad de acción y considera a la personalidad como un proceso en desarrollo. Estas concepciones humanistas fueron retomadas desde otra óptica por la psicología positiva hacia finales del siglo XX (véase capítulo 3).

EL ABORDAJE NOMOTÉTICO O PSICOMÉTRICO

Los seres humanos difieren en su comportamiento. Estas diferencias no ocurren al azar ni de modo desorganizado o incoherente. Los psicólogos enrolados dentro de la tradición *rasguista* intentaron aislar estos rasgos básicos que diferenciaban a las personas. Se basaron principalmente en el análisis de una gran cantidad de respuestas que daban las personas a los tests de personalidad, que analizaron posteriormente con metodología estadística (principalmente el análisis factorial) y cuyo objetivo final era identificar la estructura última de la organización comportamental. Se establecían así las regularidades del comportamiento tomando como unidad de análisis los *rasgos psicológicos*, a través del estudio de muchos sujetos.

Los rasgos se definen como tendencias latentes que predisponen a los seres humanos a comportarse de determinado modo, se considera que son los responsables de las diferencias individuales y predicen la conducta humana en diferentes situaciones.

Esta aproximación también se denominó *nomotética* (nomos = ley). Este abordaje había tenido un gran éxito para el desarrollo de los tests de inteligencia de gran auge en las primeras décadas del siglo XX. El foco de estos modelos consistía en identificar las leyes diferenciales que guiaban los comportamientos humanos tanto en el plano individual como grupal. Esta tradición estuvo muy ligada al desarrollo de la psicometría y estuvo muy preocupada por describir las diferencias individuales y no tanto por explicarlas. Estos modelos trabajan principalmente mediante el refinamiento de los instrumentos de evaluación y dependen del isomorfismo entre realidad e instrumentos, ya que las respuestas dadas a los tests configuran dimensiones latentes que de algún modo estarían representando la realidad (Millon, 1994). El principal exponente de este abordaje fue el psicólogo Raymond Cattell.

Si tomamos como unidad de análisis los rasgos psicológicos, suponemos que *rasgo* es opuesto a *estado*. El rasgo tiene características más fijas y permanentes (por ejemplo, la extraversión, el neuroticismo) y el estado es mucho más variable (por ej. la ansiedad, las emociones negativas). Uno de los primeros teóricos de la personalidad que propusieron al rasgo como unidad de análisis fue Gordon Allport (1937). Asimismo, este autor fue uno de los pioneros en considerar el campo de estudio de la personalidad como exclusivo de la psicología. El rasgo tiene dos propiedades: *consistencia* y *estabilidad*. La consistencia se refiere a cierta regularidad de la conducta en situaciones o contextos diferentes y la estabilidad está en relación con la perdurabilidad de las conductas de una persona a lo largo de su vida. Dicho de otro modo, decimos que una persona es *extravertida* cuando se comporta de modo extravertido en muchas situaciones diferentes y a lo largo de un período de su vida prolongado. Esta tradición de estudio de las diferencias individuales a través de los rasgos tuvo su auge a principios del siglo XX, y luego se dejó de lado hacia la mitad del siglo, resurgiendo con vigor hacia finales de los años 80 con el modelo de los cinco factores de la personalidad.

Otra visión alternativa del enfoque de los rasgos son los *enfoques racionales*. Estos enfoques se caracterizan por la construcción de un edificio taxonómico teórico que nos permite clasificar los diferentes tipos, estilos o rasgos de personalidad en una misma teoría que provea una explicación acabada del fenómeno objeto de estudio. Luego, esta tipología es puesta a prueba empírica con el objeto de confirmar la estructura teórica propuesta. Se avanza así hacia la explicación de las relaciones entre los constructos y hacia la conceptualización de las categorías empleadas en su estudio. Se diferencia del enfoque anterior porque parte de una teoría que se intenta verificar o contrastar con la realidad. El enfoque de la personalidad de Theodore Millon (1969, 1981, 1994, 1996) se ubica dentro de este marco conceptual. Esta teoría está ubicada dentro de los modelos integradores en el campo de la personalidad y puede considerarse un puente entre la personalidad normal y sus trastornos.

Si bien estos enfoques obedecen a tradiciones de investigación diferentes y estuvieron de algún modo disociados durante muchas décadas en la práctica estos enfoques deben tomarse de modo integrado. Ya en los años 50 Paul Meehl, en su clásico libro *Clinical vs. Statistical Prediction* (1954), había demostrado que si abordamos a los sujetos desde uno u otro enfoque no existían diferencias notorias en la interpretación del caso clínico en cuestión. La evaluación de la personalidad no debe realizarse exclusivamente sobre datos cualitativos (juicio clínico del psicólogo) ni cuantitativos (procedimientos formales de interpretación de los tests), sino que ambos elementos deben integrarse para lograr conceptualizar y comprender cabalmente el caso en toda su

problemática y contexto (Castro Solano, 2017). El diagnóstico no se reduce a comentar los hallazgos de las puntuaciones de las pruebas ni a emitir una etiqueta nosológica. Hacemos especial énfasis en este aspecto ya que quienes no acuerdan con los procesos de evaluación psicológica suelen asociarla con un “etiquetado” de sujetos o de patologías. Si bien esto no puede negarse como herencia de las clásicas prácticas psiquiátricas (situar a una persona en una nosología a los efectos de prescribirle el uso de determinada medicación), está muy alejado de aquello que hoy en día se realiza (o debe realizarse) en la práctica clínica psicológica.

UNIDADES DE ANÁLISIS DE LA PERSONALIDAD: NIVELES Y DOMINIOS

Si tenemos que conceptualizar la personalidad, ¿qué unidades de análisis debemos considerar? ¿Es lo mismo hablar de rasgos, estilos, estructura de la personalidad o motivaciones inconscientes? ¿En qué se diferencian y qué tienen en común estas unidades de análisis? El problema de la conceptualización de la personalidad no ha sido resuelto a la fecha y los autores proponen diferentes soluciones. Los autores clásicos (e.g. Allport) proponían considerar los rasgos estilísticos, los patológicos, las actitudes, las motivaciones inconscientes y el temperamento, entre otros. Algunos autores contemporáneos proponen incluir aspectos tan diversos tales como procesos básicos, los estilos de afrontamiento, los comportamientos, los estilos cognitivos, los motivacionales y las representaciones sociales, solo para nombrar algunos (Fierro, 1996). Las teorías de la personalidad más modernas incluyen los aspectos emocionales, motivacionales y cognitivos, y toman tanto los aspectos conscientes como los inconscientes (Emmons, 1995).

Comentaremos brevemente la propuesta integradora de Robert Emmons que reúne estos diferentes aspectos en tres niveles. En el nivel I, el más desnaturalizado y neutro, están los rasgos tal como los entienden las aproximaciones analítico-factoriales (por ejemplo, el enfoque de los Cinco Grandes Factores) comentado en el apartado anterior. El nivel II está compuesto por aquellos aspectos motivacionales que se contextualizan en tiempo y espacio, también los llamamos unidades de análisis de nivel intermedio. Estas unidades de análisis operarían como un puente entre los niveles más bajos (las conductas, los eventos) y los niveles más altos (e.g. rasgos, valores). El nivel III considera los actos de conducta que componen la biografía individual de las personas, que tiene cierta coherencia, unidad y propósito. Así por ejemplo, podemos hablar de una persona predominantemente extravertida (nivel I), una persona que tiene una motivación predominantemente orientada hacia el logro (nivel II) o bien una persona que se comporta igual (con las mismas conductas) con sus amigos, que con su esposa o sus compañeros de trabajo (nivel III). En los tres casos estamos hablando de personalidad, pero la única distinción es que lo estamos haciendo en niveles de análisis diferentes. Los niveles I y II son los que se puede visualizar a través de los tests de personalidad (predomina tal o cual rasgo o motivación). El nivel III lo puedo ver fácilmente si “observo” los actos de conducta de una persona en diferentes contextos y a lo largo de un cierto período de tiempo.

Tabla 1. Niveles de análisis de la personalidad (Emmons, 1995)

NIVEL I	Rasgos /Valores	Unidades de alto nivel. Enfoques analítico-factoriales.
NIVEL II	Constructos motivacionales	Unidades de análisis de nivel intermedio.
NIVEL III	Conductas que configuran narrativa personal	Unidades de análisis de bajo nivel.

El autor también propone estudiar diferentes dominios de la personalidad que aluden a las diferentes esferas de la actividad humana (Emmons, 1995). Puedo hablar de la personalidad en tanto estructura morfológica e intrapsíquica de los individuos (nivel intrapsíquico). Es posible hablar de personalidad teniendo en cuenta cómo las personas se comportan en relación con otras (nivel interpersonal). También puedo hablar de personalidad al estudiar los componentes temperamentales de las personas (nivel biofísico). Finalmente, puedo hablar de personalidad en el nivel efectivo en el que se comportan las personas, ya sea en uno o varios contextos y en un momento o en varios a través del tiempo (nivel fenomenológico).

Tabla 2. Dominios de la personalidad (Emmons, 1995)

NIVEL BIOFÍSICO	Temperamento	Ej. En Juan predomina la búsqueda de sensaciones y la impulsividad.
NIVEL INTRAPSÍQUICO	Organización de la personalidad - Estructura de la personalidad	Ej. La personalidad de base de Sabrina es predominantemente neurótica.
NIVEL INTERPERSONAL	Conductas en episodios de interacción	Ej. Pedro se comporta distinto cuando está acompañado de sus amigos que cuando está solo.
NIVEL FENOMENOLÓGICO	Conductas específicas en situaciones determinadas. Tienden a repetirse.	Ej. Analía llegó tarde a su trabajo esta semana, la semana anterior y el mes pasado.

Millon (1981) considera que la personalidad es el patrón complejo de características psicológicas en su mayor parte inconscientes, que no pueden ser erradicadas fácilmente y que se expresan de modo automático en muchos comportamientos. El autor agrega que ellas emergen de una matriz de disposiciones biológicas y aprendizajes experienciales e implica modos distintos de percibir, sentir, pensar y afrontar la realidad por parte de los individuos.

Pervin (1985), en una extensa revisión de las investigaciones en este campo, afirma que los investigadores son en general críticos y pesimistas respecto del estado actual de las producciones. Muy pocos autores han hecho hincapié en la complejidad del funcionamiento individual, y los hallazgos encontrados en campos diferentes (por ejemplo, la cognición, las emociones) no se vincularon a una teoría integrada de la personalidad. El constructo personalidad quizá puede unificar y dar coherencia a diferentes conceptos psicológicos que tradicionalmente se trataron de forma aislada. El campo de la per-

sonalidad resulta un campo tan vasto que podría incluir aspectos tan diversos como procesos básicos, afrontamiento, conductas, autocompetencia, estilos cognitivos y representaciones sociales, solo para nombrar algunos.

A continuación, consignamos una tabla con las unidades de análisis personológicas y que son de uso corriente en psicología.

Tabla 3. Algunas unidades de análisis para el estudio de la personalidad

RASGOS PSICOLÓGICOS	Tendencias latentes que predisponen a comportarse de una u otra manera.	Ej. Juan es introvertido.
TIPOS PSICOLÓGICOS	La agrupación de varios rasgos distintos se denomina <i>tipo</i> . A diferencia del rasgo, la consideración del tipo hace alusión a un perfil y es categorial.	Ej. Martín es introvertido y orientado al pensamiento. Laura es extravertida y orientada a la sensación.
ESTILOS DE PERSONALIDAD	Consiste en un perfil que integra metas motivacionales, modos cognitivos y conductas interpersonales.	Ej. José toma sus decisiones de modo independiente, se interesa por los datos tangibles, que procesa de modo sistemático, y los vínculos que establece con los demás tienden a ser de colaboración y respeto.
TRASTORNOS DE PERSONALIDAD	Alteraciones patológicas de la personalidad (véase DSM-5)	Ej. Vanesa tiene un trastorno de personalidad histriónico.
CONSTRUCTOS MOTIVACIONALES	Constructos basados en el <i>drive</i> o en las metas o proyectos.	Ej. Sabrina tiene como objetivo vital ser físicamente atractiva. Su plan de vida consiste en comer sano, hacer gimnasia y extremar el cuidado externo.
ESTILOS O MODOS COGNITIVOS	Diferencias individuales en el procesamiento de la información.	Ej. José es dependiente del campo. Roberto tiene un modo cognitivo orientado hacia la captación de datos tangibles (sensación) y los procesa de forma sistemática (sistematización).
ESTILOS DE ATRIBUCIÓN	Expectativas que tienen las personas concernientes al desarrollo de los acontecimientos futuros.	Ej. Marcos es predominantemente optimista y Alejandro es predominantemente pesimista.
ESTILOS DE AFRONTAMIENTO	Acciones que implementan las personas para hacer frente al estrés.	Ej. Frente a un problema Agustín utiliza como estrategia la resolución de éste (modo aproximativo).
TEMPERAMENTO	Aspectos biológicos de la personalidad.	Ej. Este bebé es más <i>irritable</i> que aquel otro. En su vida cotidiana noto que Esteban es más <i>activo</i> que Marcos.

EL ENFOQUE LÉXICO Y LOS CINCO GRANDES DE LA PERSONALIDAD (*BIG FIVE*)

Este modelo parte de considerar que las diferencias humanas (psicológicas) están codificadas en el lenguaje natural; otorga un papel fundamental al léxico

como una sólida base para construir una clasificación de las diferencias psicológicas.

Gordon Allport y Henry Odbert (1936) partieron de este axioma en los años 30 para describir la personalidad: *Todas las diferencias individuales entre las personas están codificadas en el lenguaje natural*. Para estos autores, si la diferencia es importante, entonces se habrá inventado una palabra para nombrarla. Si la diferencia es más pronunciada, la palabra es más singular y por ende tendrá más relevancia. Desde esta perspectiva el análisis del vocabulario natural representaría un conjunto de atributos que las personas han considerado importantes para señalar las diferencias entre ellas. Ahora bien, ¿en dónde se encuentra representado este vocabulario natural? Allport y Odbert recurrieron al novedoso método de seleccionar las palabras del diccionario inglés Webster, que contenía alrededor de medio millón de términos. Seleccionaron 18.000 palabras que según ellos representarían las diferencias individuales entre las personas.

Esas palabras se clasificaron en:

TENDENCIAS GENERALES DEL COMPORTAMIENTO	4504 palabras	Agresivo, sociable, introvertido
ESTADOS DE ÁNIMO TEMPORALES	4541 palabras	Avergonzado, furioso
JUICIOS DE VALOR	5226 palabras	Insignificante, valioso
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, INTELECTUALES O PALABRAS DUDOSAS	3682 palabras	Delgado, genio, dotado

La primera categoría (tendencias generales del comportamiento) fue tomada por otro psicólogo de la época, Raymond Cattell, para hacer un modelo taxonómico que describiera la personalidad. Cattell agrupó esas palabras por su similitud semántica, quedando 35 grupos de ellas que constituyeron la base de su clasificación de la personalidad. Mediante la tecnología estadística de la época (análisis factorial) el autor llegó a concluir en un modelo de 12 rasgos de la personalidad (Sánchez-Cánovas & Sánchez López, 1994).

En 1949, otro psicólogo, Donald Fiske, utilizó la misma base de palabras de Cattell para evaluar la personalidad de sus estudiantes de psicología clínica. Asimismo, les había pedido que se autocalificaran y que evaluaran a otros compañeros, utilizando siempre el mismo listado de palabras. Posteriormente, Tupes y Christal en 1961 y Norman en 1963, analizando esas palabras mediante el procedimiento estadístico del análisis factorial, obtuvieron 5 dimensiones de la personalidad.

Durante los años 80 Goldberg (1983) fue el primero en utilizar la palabra *Big Five* (en español, Cinco grandes) para denominar a estas agrupaciones. La lista ya era de 1700 palabras. En los años siguientes dos autores importantes, John Mc Crae y Paul Costa, estudiaron a fondo el modelo (Costa & McCrae, 1985). Esas dimensiones eran las mismas en diferentes países, contextos y para diferentes grupos de edades. Hoy en día es un modelo internacionalmente aceptado para evaluar la personalidad.

Según estos autores la personalidad estaría compuesta de 5 dimensiones: Neuroticismo, Extraversión, Apertura a la Experiencia, Afabilidad y Responsabilidad. Estas son las cinco dimensiones que resumen las preguntas básicas que me hago cada vez que conozco a una persona. ¿Será estable emocionalmente? (Neuroticismo). ¿Es

divertido/a y/o gracioso/a? (Extraversión), ¿Se podrá conectar bien con los demás? (Afabilidad). ¿Es una persona inteligente? (Apertura a la experiencia). ¿Tiene el tesón y la motivación necesaria para llevar adelante sus proyectos personales? (Responsabilidad). En la tabla 4 podemos observar las dimensiones y sus subescalas o facetas.

*Tabla 4. Subdimensiones de los cinco factores
(Sánchez-Cánovas & Sánchez López, 1994)*

FACTOR	SUBESCALAS
NEUROTICISMO	• Ansiedad • Depresión • Hostilidad • Autoconciencia • Impulsividad • Vulnerabilidad
EXTRAVERSIÓN	• Afecto • Gregarismo • Asertividad • Actividad • Búsqueda de emociones • Emociones positivas
APERTURA A LA EXPERIENCIA	• Fantasía • Estética • Sentimientos • Acciones • Ideas • Valores
AFABILIDAD	• Sinceridad • Altruismo • Condescendencia • Modestia • Susceptibilidad
RESPONSABILIDAD	• Competencia • Orden • Obediencia • Esfuerzo hacia el logro • Autodisciplina • Reflexión

Las palabras originales con las que se realizó la estructura taxonómica de la personalidad para el Big Five provenían del idioma inglés. Estas palabras se tradujeron posteriormente a otros idiomas y se crearon tests de personalidad para una variedad importante de lenguas y contextos. Pero, ¿qué sucede en otros países que no tienen el inglés como lengua materna? ¿Al traducir las palabras y construir tests sobre la base de estas traducciones, ¿seguiría siendo el mismo modelo léxico? Con la traducción se pierden las dimensiones únicas o locales de la personalidad. Si existe alguna variación individual, por ejemplo, una palabra que no tenga equivalente en inglés o que sea menos importante en inglés que en castellano, o bien que no señale una verdadera diferencia individual o que sea socialmente relevante, entonces esa dimensión sencilla-

mente se pierde. Los autores del enfoque léxico no revisaron los diccionarios en todos los idiomas para analizar las dimensiones de la personalidad, trabajaron solo con el diccionario en inglés y luego se tradujeron las palabras.

Al procedimiento comentado se lo llama ético-impuesto. Se toman como válidas y universales las dimensiones inglesas, en este caso, de la personalidad y se *trasladan* (traducen) a otra cultura como si fueran las únicas y *propias*, cuando en realidad son locales, en este caso, inglesas. El resultado es que se pierden las variantes locales o émicas de la personalidad y se toma como universal aquello que no lo es (Berry, 1969; Triandis, Malpass & Davidson, 1973).

Este modelo tiene una complicación adicional. Los diccionarios no representan el lenguaje que utilizamos diariamente para comunicarnos. Muchas palabras que están en los diccionarios son de uso poco frecuente o, mejor dicho, su frecuencia depende de cada cultura. El diccionario no es un corpus de palabras vivo y no distingue qué es más importante para determinado contexto o grupo de personas. Por lo tanto, el diccionario no representa el lenguaje natural con el que nos comunicamos. Un enfoque verdaderamente *léxico* debería considerar las palabras que las personas utilizan más. Les deberíamos preguntar a las personas cuáles son las palabras que identifican diferencias individuales entre ellas y no simplemente listar los términos del diccionario. A esta aproximación se la denomina *psicoléxica* (Castro Solano & Cosentino, 2016).

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información las personas producen a diario una gran cantidad de textos (e.g. posts en Facebook, tweets, blogs, comentarios en WhatsApp o simplemente e-mails). Estos textos tienen la ventaja de que son textos naturales, que las personas producen libremente y que expresan sentimientos, pensamientos y actitudes diversas. James Pennebaker, psicólogo social de la Universidad de Texas, afirma que mediante estos textos se comunica más de lo que realmente se quiere decir. El autor desarrolló sus investigaciones en torno al análisis del lenguaje natural de las personas. Según Pennebaker, el *estilo* es más importante que el contenido. Aquellas palabras que para nosotros no tienen importancia (artículos, pronombres, preposiciones) comunican más de nuestra personalidad, intereses y motivaciones de lo que realmente creemos. Una simple descripción de una fotografía o de una lata de gaseosa puede dar más información sobre alguien que un test de personalidad. El autor desarrolló un programa de computación para identificar estas palabras que él denominó *funcionales*. A través del empleo de estas palabras Pennebaker pudo determinar el estilo de personalidad, las emociones predominantes, las características de los líderes e incluso si las personas mentían o no (Pennebaker, 2011).

Hoy en día el enfoque de los Cinco Grandes es ampliamente utilizado ya que mediante el análisis de los rasgos de personalidad es posible predecir otras variables psicológicas de interés –véase Castro Solano (2005) y De la Iglesia y Freiberg Hoffman (2014)–. Así por ejemplo las personas que puntúan más alto en Apertura a la experiencia tienen más éxito en sus estudios (Spengler, Lüdtke, Martin & Brunner, 2013). Aquellos que puntúan más alto en Afabilidad tienen mejor rendimiento en la atención al público (Timmermar, 2004). Quilty, Sellbom, Tackett y Bagby (2009) concluyeron que los factores Neuroticismo, Afabilidad y Extraversión podían predecir la presencia de un trastorno bipolar. En relación con las adicciones, los adictos al tabaco demostraron obtener puntajes más elevados en Neuroticismo y menores en Afabilidad (Jafar, 2012). Y quienes presentan mayor estrés laboral solían tener elevada la escala de Neuroticismo, y disminuidas las de Apertura y Responsabilidad (Törnroos, Hintsanen, Hintsanen,

Jokela, Pulkki-Råback, Hutri-Kähönen & Keltikangas-Järvinen, 2013). En relación con la temática del uso de Internet, los estudios indicaron que aquellos que utilizaban más frecuentemente la red social Facebook presentaban altos grados de Neuroticismo, Extraversión y Apertura a la experiencia, mientras que quienes usaban Twitter tenían bajos niveles (Hughes, Rowe, Batey & Lee, 2012).

LA EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD

Las técnicas derivadas del abordaje idiográfico para evaluar la personalidad recaen en el uso de la *entrevista clínica* y de los *métodos proyectivos*. La entrevista clínica es el método por excelencia que usan los psicólogos. Sin embargo, es la herramienta para evaluar la personalidad que tiene más inconvenientes para arribar a un diagnóstico confiable (Sharp, Williams, Rhyner & Ilardi, 2013). Durante gran parte del siglo XX los diagnósticos realizados mediante esta metodología registraban una muy baja confiabilidad. La proliferación de las nosologías consensuadas (e.g., Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales -DSM- y Clasificación Internacional de Enfermedades -CIE- de la Organización Mundial de la Salud) y los métodos de evaluación objetivos durante la primera mitad del siglo XX intentaron de algún modo sortear las dificultades de la entrevista verbal para evaluar la personalidad de los sujetos.

En cuanto a las técnicas proyectivas, tuvieron auge hacia principios y mediados del siglo XX y estuvieron envueltas en la polémica de actuariales versus clínicos. Estas técnicas se basan en los postulados psicoanalíticos y consideran el mecanismo básico de la *proyección*, que se manifiesta a partir de estímulos y consignas poco estructurados. La *hipótesis proyectiva* sostiene que las personas proporcionan estructura a los estímulos inestructurados de una manera consistente con su propio patrón de emociones, deseos, necesidades y motivaciones profundas inconscientes (Cohen, Swerdlik & Sturman, 2012). Por lo tanto, las respuestas brindadas tanto en forma de narrativas como de dibujos suponen la manifestación de la dinámica de la personalidad profunda. La ambigüedad tanto del estímulo como de la consigna hace que la proyección tome lugar revelando aspectos distintivos de la configuración personal. La principal crítica de estos enfoques fue la falta de validación de los indicadores obtenidos mediante este tipo de metodología.

Según Fernández Liporace (2015), este abordaje involucra interpretaciones de modo holístico, se trabaja con una nutrida variedad de indicadores y el informe final que se logra apunta hacia la exhaustiva descripción del funcionamiento individual en diversas situaciones, sobre la base de los postulados psicoanalíticos. Según la autora entre los tests más comunes pueden citarse: el Test Proyectivo del Dibujo de la Figura Humana (Machover, 1949) y todas sus variantes –Test de la Familia Kinética (Burns & Kaufman, 1978), HTP (Buck, 1947, 1948) entre otras–, el Cuestionario Desiderativo (Córdoba & Pigem, 1946), el Test de Relaciones Objetales (Phillipson, 1955), el Test de Apercepción Temática (Morgan & Murray, 1935) o el ya mencionado Test de Manchas de Tinta de Rorschach (1942), solo para mencionar algunos.

El *abordaje nomotético* se basa principalmente en la evaluación de los rasgos mediante el uso de *cuestionarios*, *escalas* y *check-lists*. Se trata en general de técnicas de evaluación psicométricas que se caracterizan por ser metodologías altamente estructuradas y con respuesta generalmente preestablecidas. Los tests para evaluar

personalidad se denominan *autoinformes o autorreportes* y reposan sobre el supuesto de que es el propio sujeto quien responde sobre cómo él mismo cree o piensa que es o cómo se comporta habitualmente). El término *cuestionario* se reserva para aquellos instrumentos cuyos ítems son preguntas que implican una respuesta cerrada (Verdadero-Falso/Sí-No/De acuerdo/Likert u otras variantes). En cambio, los *checklists* son comúnmente listados de adjetivos o frases que, según el evaluado o un evaluador externo, definen su personalidad, su estilo o sus comportamientos habituales, y que también prevén una respuesta cerrada (Fernández Liporace, 2015).

Para este tipo de instrumentos psicométricos resulta indispensable la calibración de los mismos y la existencia de investigaciones que reporten las propiedades psicométricas y evidencias de validez aparente, de contenido, empírica y de constructo, así como análisis de confiabilidad en términos de consistencia interna y de estabilidad temporal, junto con estudios sobre la capacidad discriminativa de los reactivos (Fernández Liporace, Cayssials & Pérez, 2009).

Entre las técnicas para evaluar personalidad “normal” con este tipo de metodología las más utilizadas son las derivadas del enfoque de los rasgos, especialmente de los Cinco Grandes, siendo el BFI (Big Five Inventory) y el NEO-FFI (NEO Five Factors Inventory) las más utilizadas (Castro Solano, 2005; Castro Solano & Casullo, 2001). En cuanto a estudios locales de calidad psicométrica para instrumentos derivados de este modelo, podemos nombrar los desarrollados recientemente con el IPIP-NEO (Cupani, Pilatti, Urrizaga, Chincolla & Richaud de Minzi, 2014), con el NEO-FFI, versión abreviada del NEO-PI –NEO Personality Inventory– (Cupani, Vaiman, Font, Pizzichini & Saretti, 2012) y con el Adjective Checklist for Personality Assessment (Ledesma, Sánchez & Díaz Lázaro, 2011).

También merecen considerarse las técnicas derivadas del enfoque de Theodore Millon, especialmente el MIPS –Millon Index of Personality Styles– (véase Castro Solano, Casullo & Pérez, 2004). Para evaluar la personalidad con trastornos debemos considerar principalmente al MMPI-RF –Minnesota Multifasic Personality Inventory Restructured Form– (versión actual en circulación del MMPI, Ben-Porath & Tellegen, 2009), al PAI –Personality Assessment Inventory– (Morey, 1991, 2007) y al MCMI-IV (Millon Clinical Multiaxial Inventory), también derivado del enfoque de Millon (Millon, Grossman & Millon, 2015). Estos últimos instrumentos evalúan la personalidad con trastornos (véase capítulo 2).

EN SÍNTESIS

A lo largo de este capítulo se ha intentado realizar una revisión de las principales conceptualizaciones clásicas y contemporáneas acerca de la personalidad. Tal vez, la mayoría de los constructos psicológicos que comúnmente manejan los psicólogos se refieran a alguna “parte” de la personalidad. Tanto si hablamos de rasgos, de afrontamiento, de motivaciones, de estructura psicopatológica o de motivaciones inconscientes, estamos, de algún modo, hablando de la personalidad. Este es un campo de estudio muy vasto y existen una variedad de instrumentos y metodologías muy diversas para su abordaje. Los autores en términos generales se han focalizado más en los aspectos estilísticos de la personalidad y se han preocupado mucho menos por los aspectos que aluden al funcionamiento de la misma. Al respecto, Pervin (2000)

propone para el estudio de la personalidad la combinación de estrategias diferenciales para poder estudiar unidades de análisis de distinto nivel, como por ejemplo el análisis de los procesos inconscientes (inferenciales) y las expresiones más conscientes de la conducta humana.

Un capítulo aparte merece el estudio de la variación sistemática de los constructos psicológicos en función de las variables culturales. Considerar la universalidad de los constructos psicológicos es un postulado fundamental de la ciencia psicológica, ya que nos permitiría hacer generalizaciones respecto de grupos humanos que hablan lenguas distintas, que tienen distintas creencias y que difieren de forma sistemática respecto de aquellos países que presentan un mayor desarrollo de la psicología como ciencia (Casullo & Fernández Liporace, 2006; Norenzayan & Heine, 2005).

Muchos profesionales dan por sentada la supuesta universalidad de los constructos psicológicos. Se extraen conclusiones acerca de poblaciones muy específicas (e.g, estudiantes universitarios, poblaciones anglosajonas, de raza blanca, de nivel socioeconómico medio, etc.) y se extrapolan estos resultados a contextos culturales más amplios, sin un estudio adecuado de las variaciones locales de los conceptos estudiados. La presuposición de universalidad partiendo de muestras limitadas constituye no solo un problema teórico, sino también empírico, ya que se establecen estrategias de intervención en los ámbitos de aplicación, tomando como referencia investigaciones con sesgos culturales evidentes (Casullo & Fernández Liporace, 2006).

Para el estudio de la personalidad ha prevalecido este enfoque. La adopción de esta estrategia de trabajo hace que desaparezcan las variantes únicas locales, quedando éstas subrepresentadas. Esto lleva a que los constructos psicológicos estudiados revistan características pseudoéticas o que, en suma, sean “falsamente universales”. El abordaje mediante estudios étnicos de las variables más propias de la cultura en términos generales no es tomado en cuenta por las teorías y modelos de la personalidad ya consagrados.

Un área nueva de estudio la constituyen las neurociencias: el gran desafío para los psicólogos de la personalidad consistiría en la integración de aquello que ya se sabe de la personalidad con los nuevos hallazgos procedentes de marcadores neurobiológicos, todo sin caer en una propuesta reduccionista.

En el capítulo siguiente comentaremos el abordaje de la personalidad patológica y trataremos de esclarecer definiciones y modelos para el tratamiento de los trastornos de personalidad. En el capítulo 3 hablaremos de un nuevo enfoque de la personalidad basado en las propuestas de la psicología positiva.

2. La personalidad “patológica”

Los trastornos de personalidad y los DSM

Alejandro Castro Solano

Los *trastornos de personalidad* son bastante comunes en la población general, con una prevalencia cercana al 10%. Aquellos que los padecen manifiestan algún tipo de sintomatología psiquiátrica, generalmente crónica, y presentan un funcionamiento disminuido en su esfera social, laboral o en términos de cuidado personal. En este tipo de pacientes es frecuente la mayor utilización de los servicios de salud y la solicitud de consultas tanto médicas como psicológicas (Meehan & Clarkin, 2015). Por lo tanto, resulta esencial su diagnóstico, a los efectos de poder esclarecer sus probables causas, su curso y la mejor forma de intervención terapéutica posible.

En términos generales, a lo largo de la historia de la psicología se ha podido observar un divorcio entre los psicólogos que estudiaban la personalidad normal y los aspectos más psicopatológicos de la misma (Pelechano, De Miguel & Hernández, 1995). Esto llama la atención ya que los modelos de personalidad “normal” en términos generales siempre hacen referencia a algún componente disfuncional o patológico de la personalidad, como por ejemplo, el rasgo *Neuroticismo* en el modelo de los Cinco Grandes de la personalidad.

En la descripción etiológica de los grandes cuadros psicopatológicos descritos por la psiquiatría del siglo XIX y principios del XX, se recurría generalmente como explicación última a los antecedentes premórbidos de las personas. Kraepelin (1907), por ejemplo, consideraba a la personalidad patológica como formas intermedias de las psicosis (Liveslye, Schroeder, Jackson, & Jang, 1994). Kretschmer (1925), por otro lado, proponía un continuo que iba desde la esquizofrenia hasta la psicosis maniaco-depresiva con intervalos intermedios de personalidad más o menos patológicos en función de la cercanía a cada uno de estos polos (Pelechano, De Miguel & Hernández, 1995). La idea base era que las personas tenían un núcleo predisponente que era la *causa* de las graves manifestaciones, y que éstas eran disparadas por sucesos externos. Esta línea de trabajo, aunque con matices diferentes, fue defendida por autores psicodinámicos y de forma más moderna por Theodore Millon. En suma, por un lado, estaría la sintomatología y, por otro lado, la personalidad o sus alteraciones, que sería el factor predisponente de esos cuadros sintomáticos.

Los trastornos de personalidad históricamente ocuparon así un área intermedia entre las neurosis y las psicosis (Silk, 2015). Los psicoanalistas clásicos comenzaron a hablar de estos cuadros en aquellos pacientes que conservaban su juicio de realidad,

pero podían tener el pensamiento distorsionado o incluso tener alterado su prueba de realidad, pero solo de manera transitoria. Kernberg fue uno de los primeros en proponer una clasificación de los *trastornos del carácter* o, como el los denominó más tarde, de la *organización de la personalidad* en función de tres elementos básicos: los mecanismos de defensa, la prueba y juicio de realidad, y la difusión de la identidad (Kernberg, 1984). La idea implícita era que cuando la estructura de la personalidad era endeble generaba sintomatología, ante la impronta de ciertos eventos vitales estresantes.

Más allá de los grandes cuadros psiquiátricos comentados, la personalidad patológica en sí misma comenzó a considerarse a partir de la creación de los inventarios especialmente diseñados para su evaluación. Hacia finales de los años 40 surge el MMPI (Minnesota Multifasic Personality Inventory) con el propósito de identificar personas con cuadros psicopatológicos diversos. Si bien la idea original era el diagnóstico de cuadros nosológicos puros (e.g. histeria, psicastenia, depresión), este objetivo inicial fracasó. A los clínicos, usuarios asiduos del MMPI, les resultó imposible identificar cuadros psicopatológicos puros. Sin embargo, constataron cierta estabilidad y consistencia del perfil patológico de la *personalidad* (por ejemplo, código 4-9/9-4, perfil antisocial, con poco respeto por valores y normas sociales y baja tolerancia a la frustración, poca respuesta al tratamiento). Así el MMPI, a mediados del siglo XX, fue uno de los precursores de la *evaluación configural* de la personalidad a través de sus escalas clínicas (psiquiátricas) y refleja de algún modo lo que hoy denominamos *trastornos de la personalidad*.

Durante los años 60 y 70 puede observarse un eclipse en la evaluación de la personalidad, debido principalmente al auge de los abordajes conductistas, según los cuales las acciones individuales no eran fruto de las variables centradas en la persona, sino de poderosos *vectores ambientales* (Millon, 1984). Como prueba de esto tenemos dos experimentos realizados en el ámbito de la psicología social que ponen de manifiesto que hasta las más bajas acciones humanas (¿personalidad patológica?) podían ser generadas por el ambiente. Milgran llevó a cabo su conocido experimento realizado hacia finales de los años 50 en la Universidad de Yale y publicado posteriormente en 1963. El experimento surgió a raíz de los juicios por el Holocausto judío que se estaban llevando a cabo en esos años. La pregunta original era: ¿es posible que un grupo amplio de personas obedezcan simplemente órdenes y podamos tener otro holocausto a instancia de un líder de las características de Hitler? Para ello, Milgran diseñó una cuidadosa situación experimental en la que evaluó a más de 700 personas en una situación simulada, a quienes se les solicitaba aplicar una corriente eléctrica a otro sujeto si no respondía de forma adecuada una serie de preguntas. Si la respuesta era incorrecta el participante debía administrar la descarga, si se sucedían otras respuestas incorrectas debía aumentar el voltaje. El participante no podía ver a la persona en cuestión (el que respondía), pero la podía escuchar y tener interacción. El que sufría las supuestas descargas era un actor y no recibía corriente eléctrica alguna. Sin embargo, el participante seguía aplicando la descarga eléctrica en una dosis tan alta que ningún ser vivo podría soportar. Estas acciones las realizaban a instancias de otro participante (otro actor) que indicaba seguir adelante con el experimento y que cumpliera con la instrucción solicitada. Más del 90% de los participantes manifestaron *obediencia a la autoridad*: en términos del experimento, seguían aplicando la descarga eléctrica hasta niveles mortales. Si hubiera sido una situación real todos los sujetos hubiesen muerto. Ninguno de los participantes registraba trastornos psicopatológicos, ni tenía alteraciones clínicas significativas. El ambiente, en esta situación era *altamente determinante*.

de la conducta humana y producía resultados alarmantes. La personalidad, según el contexto de este experimento era inexistente. Las *manifestaciones psicopatológicas* (e.g. sadismo extremo) de los participantes eran generadas por las peculiares características del contexto.

Siguiendo una metodología experimental, Philip Zimbardo diseñó otra situación experimental en la Universidad de Stanford en los años 70. El experimento consistió en montar una cárcel simulada para la que se contrataron 24 participantes varones y mujeres que tenían que permanecer allí durante 15 días. Se dividió al grupo al azar en dos grupos de 9 participantes (6 eran suplentes) y la única instrucción que se les había dado era que unos tenían que ser reclusos y otros guardias. El experimento era simplemente observar lo que sucedía. El impacto de la situación de control fue tan alto, que a la semana Zimbardo tuvo que suspender el experimento, dado que al segundo día los reclusos se amotinaron y al sexto día uno de los participantes se había quebrado. Los guardias de forma espontánea comenzaron a maltratar al resto de los participantes y a exhibir conductas de descontrol y sadismo hacia los presos. Este experimento, si bien hoy resultaría muy controvertido, nos está indicando que el contexto tiene una influencia determinante en la conducta humana, en este caso en las *conductas patológicas* de las personas. Dicho con terminología de hoy en día, el contexto puede *crear* por sí mismo la *sintomatología de un trastorno de la personalidad*. Resulta llamativo que los participantes no tenían trastornos psicopatológicos previos, ni historial de abusos de sustancias, o enfermedades médicas. Eran simples estudiantes universitarios y no tenían ninguna característica diferencial psicológica importante.

Con los experimentos de este tipo, el auge de esta psicología conductual eclipsó de algún modo los estudios y la evaluación sobre la personalidad, así como sus trastornos.

NOSOLOGÍAS INTERNACIONALES: LOS DSM

La idea de una nomenclatura consensuada de los trastornos mentales surgió en los años 50 con la aparición de la primera edición del DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) a instancias de la Asociación de Psiquiatría Americana (APA). En los años previos, no existía un acuerdo sobre las nosologías a utilizar y cada clínico utilizaba su propia clasificación para diagnosticar los trastornos psicológicos (Kendell, 1975). Esto resultaba muy problemático para la comunicación entre los clínicos y entre los investigadores, y su consecuencia inmediata fue la baja confiabilidad de los diagnósticos.

En 1952 con la publicación del primer **DSM** surgió el primer intento de generar una clasificación de la psicopatología consensuada por los clínicos de la época. La idea base era poder contar con un lenguaje “psicopatológico” uniforme y no favorecer a ninguna perspectiva teórica en particular (Wakefield, 1998). Este primer DSM se basó explícitamente en la experiencia clínica de los expertos y de su conocimiento implícito de la literatura existente (Widiger & Clark, 2000). En cuanto a los trastornos de personalidad, este primer intento clasificatorio consideraba a la personalidad con trastornos como: “...defectos del desarrollo o tendencias psicopatológicas en la estructura de la personalidad, con mínima o ninguna sensación de ansiedad o estrés subjetivo. Este desorden se caracteriza por un patrón conductual de larga duración más que por uno mental o emocional” (American Psychiatric Association 1952, p. 34).

Cabe considerar que el borrador de este primer DSM solo circuló entre el 10% de los psiquiatras miembros de la APA, y no se publicaron los resultados de los borradores (*drafts*) previos al lanzamiento final del manual. En esta primera edición los trastornos de personalidad se agrupaban en cuatro categorías: a) trastornos de patrón; b) trastornos de rasgos; c) trastornos del impulso, del control y de las relaciones, y d) trastornos sociopáticos.

En 1968 surge el **DSM-II**, de su redacción participaron 120 psiquiatras. Este DSM consideraba a la personalidad con trastornos como: “...un patrón desadaptativo de conducta, cualitativamente diferente de los síntomas neuróticos y psicóticos. Este patrón es de larga duración y puede ser reconocible a partir de la adolescencia” (American Psychiatric Association, 1968, pp. 41-42). Se diagnosticaba como pacientes con un trastorno de personalidad a aquellos que tenían alteraciones profundas y duraderas y no se los podía encuadrar ni en las neurosis, ni en las psicosis (Gunderson, 1984).

Tanto el DSM-I como el DSM-II fueron ignorados por la comunidad de clínicos de la época. En términos generales se trató de un acuerdo clasificatorio y un *diccionario común* de términos referidos a los trastornos psicológicos, pero no tenía la intención de promover estudios futuros en el terreno de los trastornos mentales o de la personalidad.

El borrador del **DSM-III** se publicó en 1978, se elaboró durante cuatro años y su lanzamiento fue en 1980 (American Psychiatric Association, 1980). La intención de este manual era considerar la evidencia empírica sobre los diagnósticos disponibles en la época y no basarse exclusivamente en el juicio de los expertos. Así, en comparación con sus predecesores, el DSM-III constituyó una verdadera revolución diagnóstica, ya que describía trastornos específicos en los que se incluía una serie de criterios específicos para poder hacer los diagnósticos correspondientes, en un formato *multiaxial* y situando a los trastornos de la personalidad en un eje aparte, el Eje II (Silk, 2015). El diagnóstico multiaxial propuesto, que se realizaba a través de 5 ejes, giraba sobre la idea implícita de que el clínico pudiera realizar un *diagnóstico comprehensivo* y no basado solamente en la sintomatología presente, a los fines de tomar en cuenta las alteraciones de la personalidad. La idea base era que la personalidad no debía ser ignorada y al tener su propio eje, el clínico se viera obligado a emitir algún juicio clínico sobre la personalidad del paciente. En esta propuesta se incluyeron 11 trastornos –Paranoide, Esquizoide, Esquizotípico, Antisocial, Límite, Histriónico, Narcisista, Evitativo, Dependiente, Obsesivo, Pasivo-Agresivo– y una categoría que agrupaba los casos que no se correspondiesen con los trastornos anteriormente mencionados –Trastornos Atípicos, Mixtos y Otros Trastornos–. En la tabla 1 se incluyen los 5 ejes del DSM-III:

Tabla 1. Sistema Multiaxial del DSM-III (1980)

EJE I	Síntomas clínicos y estados no atribuibles a otro trastorno mental, que merecen atención o tratamiento.
EJE II	Trastornos de personalidad y trastornos específicos del desarrollo
EJE III	Estados y trastornos somáticos
EJE IV	Intensidad del estrés psicosocial
EJE V	Máximo nivel de adaptación del sujeto en el último año

Los dos primeros ejes estaban en relación con la valoración diagnóstica y los últimos dos estaban más relacionados con la planificación del tratamiento y los factores que podían favorecer o entorpecer el mismo. El Eje I incluía casi todos los trastornos mentales. Se reservaba para el Eje II aquellos trastornos más *estables* y que afectaban de un modo más permanente la vida de una persona.

El manual diferenciaba entre *rasgo* y *trastorno* de personalidad. Los rasgos eran pautas duraderas que concernían a los modos de percibir, pensar y relacionarse con el ambiente y se expresaban en una variedad de contextos personales y sociales. Los trastornos, en cambio, eran los casos en que los rasgos se volvían *inflexibles* y *desadaptativos* y causaban discapacidad social significativa, o disfunción ocupacional o bien malestar subjetivo (Belloch, Martínez Narváez & Pascual, 1996).

La otra novedad del DSM-III fue la agrupación de los trastornos en grupos diferenciados o *clústers* (véase tabla 2). El clúster A agrupa trastornos más graves, ya que estarían relacionados con la sintomatología más llamativa (e.g. pensamiento extravagante, sintomatología psicótica). El clúster B hoy podríamos llamarlo, de conductas predominantemente externalizantes (e.g. antisocial, histriónico) y el clúster C corresponde a las conductas más internalizantes (e.g., evitativo, compulsivo). Si bien no existió un soporte empírico para esta agrupación, el sistema de agrupación de los trastornos en grupos diferenciados se mantuvo durante largo tiempo y permaneció hasta el DSM-5.

Tabla 2. Agrupación de los trastornos de la personalidad en clúster según el DSM-IV

CLUSTER	A	B	C
CARACTERÍSTICAS	Los individuos parecen raros o excéntricos	Los sujetos parecen dramáticos, emocionales y erráticos	Individuos que se muestran ansiosos o temerosos
TRASTORNOS	Paranoide Esquizoide Esquizotípico	Antisocial Límitrofe Histriónico Narcisista	Evitativo Dependiente Compulsivo Pasivo-Agresivo

El objetivo del manual era que los clínicos prestasen atención a la personalidad, más allá de los síntomas más llamativos de los consultantes. Desafortunadamente este objetivo nunca llegó a alcanzarse y el Eje II permaneció ignorado o en muchos casos mal diagnosticado por los usuarios del manual. La poca pericia observada por los clínicos en el diagnóstico de este eje y el alto uso de la categoría *trastornos de personalidad sin especificar*, fueron una constante en las críticas del abordaje de categorial de la personalidad durante la redacción del reciente DSM-5 (Bornstein & Huprich, 2011). La idea de los creadores del DSM-III fue que el manual fuese *ateórico*, para no favorecer ninguna orientación psicoterapéutica en particular. Sin embargo, muchos de los trastornos listados en este manual estaban estrechamente conectados con un abordaje psicoterapéutico afín a una línea de corte psicodinámico (Auchincloss & Michels, 1983).

En 1987 surge el **DSM-III-R**, donde se refinan los criterios para valorar la personalidad con trastornos. En esta propuesta se variaron dos nomenclaturas: por un lado,

el trastorno Compulsivo pasó a llamarse Obsesivo-Compulsivo, y, en segundo lugar, los trastornos Atípicos, Mixtos y Otros Trastornos se denominaron No Especificados. En el apéndice de dicha edición se sugieren dos nuevos trastornos –Sádico y Auto-destructivo– que serían incluidos en la siguiente revisión del manual y que finalmente no fueron considerados. El cambio más significativo fue clarificar el Eje II en relación con el Eje I. El Eje II quedó constituido por los *trastornos del desarrollo* (retraso mental, trastornos específicos del desarrollo y trastornos profundos del desarrollo) que tenían la característica de tener un inicio temprano y mantenerse de forma estable hasta la edad adulta. Así el Eje II integraba la categoría de rasgo psicológico tal como habitualmente se lo utiliza en psicología de la personalidad; este rasgo, al ser inflexible y desadaptativo y causar disfunción en la persona, cobraba la característica de trastorno.

El **DSM-IV** fue algo más conservador a la hora de incluir nuevos trastornos mentales y observó un procedimiento mucho más sistemático para determinar nuevos cuadros clínicos. No fue tanta la innovación que trajo sino que aportó una forma más científica de abordar los trastornos mentales. Se trabajó con más de 12 estudios de campo, 223 proyectos de investigación, realizados en varios lugares, 175 revisiones de la literatura y varias revisiones críticas de los borradores del manual realizadas por la comunidad de psiquiatras. Sin embargo, a pesar del refinamiento científico, el manual siguió descansando en el criterio de clínicos expertos (Widiger & Clark, 2000).

Este manual continuó con el diagnóstico multiaxial de su predecesor, pero con algunos cambios. El cambio más llamativo fue que los trastornos del desarrollo pasaron al Eje I y el Eje II quedó exclusivamente reservado para los trastornos de la personalidad y lo que en esa época se denominaba *retraso mental* (ahora discapacidad intelectual; véase tabla 3). En este manual se considera a los trastornos de personalidad como un patrón persistente tanto de la *experiencia interna como de la conducta*, y que no se corresponden con lo que sería de esperar en función del contexto sociocultural del individuo. Dichos trastornos se manifiestan en la cognición, en la afectividad o en el control de los impulsos (al menos dos de las áreas mencionadas). Se caracteriza por ser *inflexible y generalizado*; provoca o bien *malestar subjetivo o disfunción* a nivel social, personal o laboral; es *estable, duradero* y su aparición se sitúa en la adolescencia o a principios de la edad adulta. No se explica por otro trastorno mental y no es producido ni por el efecto fisiológico de alguna droga o medicación o debido a alguna condición médica (American Psychiatric Association, 1994).

Tabla 3. Sistema Multiaxial del DSM-IV (1994)

EJE I	Trastornos clínicos. Otras condiciones objeto de atención clínica.
EJE II	Trastornos de personalidad. Retraso mental
EJE III	Condiciones médicas generales
EJE IV	Problemas psicosociales y del entorno
EJE V	Evaluación global del funcionamiento

El DSM-IV mantuvo las mismas categorías básicas del DSM-III-R. En el apéndice se incluyeron para futuros estudios el *trastorno depresivo de la personalidad* y el *pasivo-*

agresivo (trastorno negativista de la personalidad). En el DSM-IV se reservó una última categoría para el *trastorno de personalidad no especificado*. Se diagnosticaba con esta categoría a aquellos trastornos de la personalidad en los que se dieran dos condiciones: (a) no reunir los criterios de algún trastorno de personalidad específico de los listados y, (b) que el paciente presente algún trastorno que no cubra la categoría propuesta. A pesar de que esta fue una categoría residual, fue una de las más utilizadas en los años siguientes y uno de los ejes de las críticas del abordaje categorial, recogida en las discusiones previas al lanzamiento del DSM-5. En la tabla 4 podemos ver la evolución de las etiquetas diagnósticas asignadas a los trastornos de la personalidad en todos los DSM hasta la fecha. En el apartado siguiente comentaremos la concepción de Millon acerca de los trastornos de la personalidad, dado que este autor tuvo gran importancia en el establecimiento del Eje II en los DSM anteriores, para luego pasar a comentar las propuestas más modernas del DSM-5.

Tabla 4. Clasificaciones de los trastornos de la personalidad según las diferentes versiones del DSM

VERSIÓN	III	III-R	IV	IV-TR	DSM-5
AÑO	1980	1897	1994	2000	2013
EJE	II	II	II		Sin ejes
TRASTORNO	Paranoide	Paranoide	Paranoide	Paranoide	
	Esquizoide	Esquizoide	Esquizoide	Esquizoide	
	Esquizotípico	Esquizotípico	Esquizotípico	Esquizotípico	
	Antisocial	Antisocial	Antisocial	Antisocial	
	Límite	Límite	Límite	Límite	
	Histriónico	Histriónico	Histriónico	Histriónico	
	Narcisista	Narcisista	Narcisista	Narcisista	
	Evitativo	Evitativo	Evitativo	Evitativo	
	Dependiente	Dependiente	Dependiente	Dependiente	
	Compulsivo	Obsesivo-Compulsivo	Obsesivo-Compulsivo	Obsesivo-Compulsivo	
	Pasivo-Agresivo	Pasivo-Agresivo	-	-	
	Atípico Mixto Otros trastornos	No especificado	No especificado	No especificado	
APÉNDICE	-	Sádico	Depresivo	-	
	-	Autodestructivo	Pasivo-Agresivo (Negativista)	-	

LA PROPUESTA DE THEODORE MILLON Y LOS DSM

Merece mencionarse la contribución de Millon a la creación y desarrollo del Eje II, exclusivo para el diagnóstico de los trastornos de personalidad y otros cuadros que afectaran durante largo tiempo la vida de las personas (Millon, 1984). Millon aseveraba que la personalidad *con trastornos* surgía cuando los estilos propios de cada persona se tornaban *desadaptativos* debido a conflictos para poder *afrontar* de modo adecuado las demandas del contexto (Millon & Davis, 2000). En palabras de Millon, el no tener las estrategias adecuadas para poder resolver los problemas que nos plantea a diario el contexto daría lugar a la sintomatología, que sería a su vez la expresión de una *personalidad con trastornos*.

La propuesta de Millon es que las personas no se patologizan al azar, sino sobre las mismas bases de funcionamiento que tiene la personalidad normal y no son producto de la intromisión de alguna fuerza extraña sobre la personalidad del individuo. Los estilos de personalidad tienen una función *esencialmente adaptativa* y son el equivalente en términos humanos de nuestro sistema inmunológico (Millon & Davis, 2000). Ante ciertas demandas del ambiente (estresores) una personalidad balanceada (sin trastornos) puede poner en marcha acciones y mecanismos para afrontar estas situaciones siempre cambiantes, obtener resultados exitosos y por lo tanto no patologizarse, siendo este el caso de la personalidad normal. Aquellos estilos rígidos y poco flexibles serán muy vulnerables a los estresores ambientales, dando lugar a los que en las nosologías DSM se caracteriza como trastorno de la personalidad. El resultado en este caso consiste en conductas desadaptativas y autofrustrantes, en suma, trastornos y síndromes clínicos de Eje I (véase figura 1).

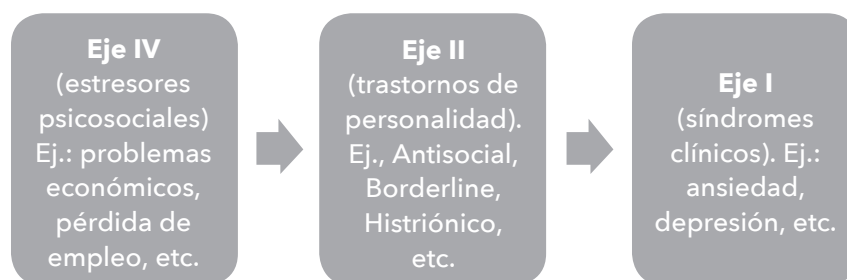


Figura 1. Relación entre ejes del DSM y dinámica de los trastornos de personalidad

Desde la perspectiva de Millon las diferencias entre personalidad normal y con trastornos se realiza en función de tres criterios diferenciados: 1) Inflexibilidad adaptativa; 2) Tendencia a fomentar círculos viciosos y 3) Estabilidad lábil.

En esa época Millon había propuesto no solo una teoría de la personalidad, sino una nosología e instrumentos de evaluación psicológica derivados de esa nosología. La idea sobre la que gira el modelo del autor es el principio de *continuidad sindrómica*. La estructura básica y los mecanismos de la personalidad normal y con trastornos son originariamente los mismos, que van patologizándose en función de las experiencias ambientales vividas tempranamente y que hacen imposible que algunos individuos afronten las demandas siempre cambiantes del entorno. Esto da lugar en las nosologías oficiales a un sistema de evaluación multiaxial: en el Eje I estarían

los cuadros sintomáticos y en el Eje II los cuadros vinculados con los desórdenes de la personalidad. El Eje IV (estresores ambientales) serían los responsables de la emergencia de los síntomas, y el Eje V corresponde al nivel de funcionamiento global de las personas.

Una persona con trastornos de personalidad puede ser caracterizada como alguien incapaz de adaptarse al ambiente, que exhibe conductas desadaptativas con imposibilidad para acomodarse a las circunstancias siempre cambiantes del entorno, y con un limitado repertorio conductual. Esta persona, dada la labilidad de sus estrategias de afrontamiento, es muy sensible a las presiones ambientales, sus esfuerzos por afrontar la realidad se vuelven ineficaces y pone en marcha nuevas conductas autofrustrantes (modelo de la vulnerabilidad). Si esto se perpetúa el sujeto se *patologiza* y el trastorno de personalidad avanza hacia formas más patológicas. Por ello es que Millon comenta que la normalidad y la anormalidad son conceptos relativos y pueden ser mejor descritos como *continuos* o *gradientes* más que como entidades discretas, como clásicamente tomaba la psiquiatría y la psicología de finales del siglo XIX y principios del XX. Desde esta perspectiva los trastornos de personalidad son entidades *dinámicas* más que *estáticas*. La conducta patológica se desarrolla y se forma según los mismos principios y mecanismos que están involucrados en el desarrollo de la conducta normal. Sin embargo, en función de estas disposiciones biológicas comentadas y la exposición a ciertos aportes del ambiente a edades tempranas, algunas personas aprenden hábitos desadaptativos (cognitivos, emocionales, conductuales) mientras que otras simplemente no lo hacen (Millon & Everly, 1994).

Millon propone la construcción de una taxonomía que permita clasificar y explicar tanto la personalidad normal (estilos) como sus trastornos. Este modelo integrador, como comentamos, propone un continuo entre personalidad normal y patológica (Millon, 1969, 1981, 1994, 1996). El autor (1996) comenta que el problema de la clasificación en la personalidad no puede ser explicado simplemente por las diferencias manifiestas que exhiben los individuos. Esta proposición trae como consecuencia que aquellos que exhiben conductas similares parezcan iguales, pero puedan en realidad no serlo; y viceversa, sujetos con conductas aparentemente diferentes pueden estar en posesión de la misma estructura de la personalidad. Lo aparente y manifiesto es una base falsa para la construcción de una teoría de la personalidad.

Millon fue evolucionando a lo largo de los años en su conceptualización de la personalidad. En 1969 era partidario de una teoría biosocial y consideraba el cruce de dos dimensiones teóricas (actividad/pasividad vs. fuentes de refuerzo instrumental). Estas dos dimensiones teóricas pueden gráficamente representarse como ejes ortogonales que sintetizan los ocho tipos básicos de personalidad (prototipos). Millon otorga importancia en su teoría tanto a los aspectos nomotéticos como idiográficos y considera que un sujeto difícilmente pueda encuadrarse en un solo prototipo. Una persona puede ser abordada en términos de perfil. Así, la individualidad humana se entiende como el resultado de la combinación de diferentes prototipos, de naturaleza nomotética. Millon (1981) propone que la clasificación en psicopatología no debe utilizarse como un *algoritmo* para realizar los diagnósticos, sino que debe ser un verdadero recurso *heurístico*, es decir interpretativo, que ayude a mejorar la comprensión de los fenómenos y la praxis profesional.

LOS PROBLEMAS DEL DSM

Un grupo importante de clínicos venía reclamando que el diagnóstico de los trastornos de personalidad tal como se proponía desde el DSM era poco útil y carecía de suficiente base empírica. Esta situación motivó la formación de un grupo de trabajo en el año 2009, encabezado por Andrew Skodol, que tenía como objetivo presentar las ideas iniciales sobre las cuales debían girar los cambios a realizarse en el futuro DSM. Estas nuevas propuestas consistieron básicamente en el abandono de un abordaje categorial por uno dimensional, situación que generó un acalorado debate entre los clínicos respecto de la metodología a utilizar para diagnosticar las alteraciones patológicas de la personalidad (Huprich, 2015).

La crítica más importante y eje del cambio en la propuesta del DSM-5 fue al diagnóstico de trastornos de personalidad mediante *categorías*. *La aproximación categorial* era un resabio del modelo médico, al considerar los trastornos mentales equivalentes a *entidades discretas* con límites claramente marcados. Durante muchos años los psicólogos clínicos se manejaron con un modelo más *médico* que psicológico, al diagnosticar las alteraciones psicopatológicas con nosologías de banda estrecha, por ejemplo, psicosis, neurosis y cuadros límites (Kernberg, 1984). Si bien los autores, desde diferentes líneas teóricas, venían criticando esta aproximación (véase Blashfield & Reynolds, 2012), este sistema categorial se mantuvo, e incluso a pesar de las críticas se mantiene hoy en día tanto para la evaluación de los trastornos psicológicos como de la personalidad en el recientemente lanzado DSM-5, ante la imposibilidad de consensuar un sistema diagnóstico alternativo.

La premisa básica del DSM al utilizar categorías era que el modelo de 10 trastornos propuestos refleje de algún modo la realidad “objetiva”. La idea implícita es que existen *categorías latentes* de trastornos de personalidad, razón por la cual podemos ubicar a los pacientes en uno u otro cuadro. Asimismo, desde este punto de vista, existe un límite claro entre personalidad normal y con trastornos. Esta crítica al abordaje categorial cobra impacto ante la ausencia de evidencia empírica de este modo de diagnosticar a los trastornos de la personalidad (Krueger *et al.*, 2011).

Un segundo grupo de críticas estuvo en relación con un criterio de *utilidad clínica*. En muchos casos los clínicos hacen un uso excesivo del Eje I sin tomar en cuenta el Eje II. En otros casos se opta por una solución de compromiso al utilizar una categoría de trastorno en particular, habida cuenta de que los pacientes no se ajustan totalmente a un cuadro nosológico específico (Pelechano, De Miguel & Hernández, 1995). En la arena clínica reina más la *heterogeneidad* que los cuadros psicopatológicos puros y las alteraciones de la personalidad no son una excepción. Una misma persona puede ser diagnosticada con varios cuadros de trastornos de personalidad o con un cuadro base y rasgos patológicos de otros trastornos. En el mismo caso, sujetos que presentan diagnósticos de trastornos de personalidad similares podrían tener características diversas (Krueger, 2013; Skodol *et al.*, 2011). La *comorbilidad* entre los trastornos resulta un problema para el abordaje de los trastornos de personalidad mediante 10 categorías discretas exclusivas y excluyentes.

Un tercer grupo de críticas se refiere a la *estabilidad temporal* de los diagnósticos del DSM-IV y la continuidad (o discontinuidad) entre los diagnósticos de la infancia y de la adolescencia (Mervielde, De Clercq, De Fruyt & Van Leeuwen, 2006; Widiger, Simonsen, Krueger, Livesley & Verheul, 2005). Si bien es ampliamente reconocido que

los trastornos psicológicos de la edad adulta tienen sus raíces en edades tempranas, no existe una relación uno a uno entre estos cuadros, y esto es uno de los puntos más controvertidos de la relación entre psicopatología infantil y adulta. Los estudios longitudinales realizados demuestran que los antecedentes de los trastornos de la personalidad aparecen muy tempranamente al inicio de la adolescencia, alrededor de los 12 y 13 años, la sintomatología decrece luego en la adultez y se estabiliza alrededor de los 20 años. Los síntomas encontrados en la adolescencia aparecen siendo más severos en la adultez (Johnson *et al.*, 2000). En otro estudio se demostró que, si bien los trastornos de personalidad se mantenían estables dentro de los clusters, su sintomatología iba disminuyendo con la edad (Lenzenweger, 1999). En suma, si bien los trastornos de personalidad tienen cierta estabilidad, exhiben variaciones a lo largo de la vida de las personas. Estos hallazgos atacan de forma directa una de las características centrales de los rasgos psicológicos: la estabilidad (Keuroghlian & Zanarini, 2015; Widiger, 2011).

Finalmente, debemos comentar la importancia de evaluar la *severidad de los cuadros psicopatológicos*, con un criterio menos vago y con mayor justificación teórica. El punto de corte para determinar cuándo una persona tiene o no tiene un trastorno de personalidad (límite discreto) carece de un criterio teórico claro (Pelechano *et al.*, 1995; Skodol *et al.*, 2011). Estos problemas se recogen de alguna manera en el DSM-5 al agrupar los trastornos mediante el concepto de *espectro*, integrándose así las formas más leves y más graves de los cuadros clínicos en un continuo y en función de criterios teóricos (por ejemplo, formas leves de los trastornos bipolares –ciclotimia– a las más graves; diferentes cuadros dentro del trastorno de espectro autista, etc.). En relación con los trastornos de personalidad se incorpora en el DSM-5 el *Criterio A* que estaría indicando los niveles de severidad de los trastornos de la personalidad.

Como respuesta a las críticas enunciadas algunos autores proponen la consideración de un *abordaje dimensional* de los trastornos de la personalidad, procurando resolver el problema básico de la comorbilidad y estableciendo un modelo integrativo de la continuidad entre los rasgos de personalidad normal y patológica, tal como lo proponen los modelos psicológicos modernos para el abordaje de la personalidad (De la Iglesia & Castro Solano, 2018; Stover, 2014). Estos modelos dimensionales serían más útiles para comunicar la información a pacientes y legos o para describir las patologías de los pacientes, comunicar de modo más adecuado las problemáticas y poder planificar mejor los tratamientos (Bastiaansen, Rossi, Schotte & De Fruyt, 2011; Krueger *et al.*, 2011; Mullins-Sweatt & Widiger, 2011; Widiger, 2011).

LA PROPUESTA DEL DSM-5

La aparición del DSM-5 en 2013 constituyó un cambio de paradigma, tal como lo había sido en su momento el DSM-III. No solo se reagruparon los diagnósticos y se incluyeron nuevos cuadros, sino que hubo un cambio en la consideración de los trastornos en general. En la tabla 5 se listan las principales innovaciones que trajo el DSM-5 al campo de la psicopatología. Remitimos al lector interesado a publicaciones más específicas para saber más de este tema (véase Echeburúa, Salaberría & Cruz-Sáez, 2014). La propuesta del DSM-5 consiste en una aproximación más dimensional o, si se quiere, más psicológica a los cuadros psicopatológicos, menos

psiquiátrica. Esto se ve reflejado en el concepto de *espectro* que consiste en agrupar los cuadros psicopatológicos de un origen común conocido en un mismo capítulo. En lo que respecta al diagnóstico se conectan los cuadros con las técnicas de evaluación psicológica validadas para valorar las diferentes alteraciones psicopatológicas. En suma, el DSM-5 se volvió más psicológico y menos psiquiátrico. En este apartado nos concentraremos en lo referido a los trastornos de la personalidad que es el eje de este capítulo.

Tabla 5. Innovaciones del DSM-5

→ Incluye nuevos diagnósticos (e.g., trastorno neurocognitivo leve, trastorno por ingesta compulsiva).
→ Desaparece el diagnóstico multiaxial en ejes.
→ Se reduce la categoría "sin especificar".
→ Se actualiza el vocabulario y se intenta utilizar un lenguaje más inclusivo (retraso mental se cambia por discapacidad intelectual) y menos patológico (e.g., parafilias vs. disforia o trastorno de identidad de género).
→ Concepto de espectro: Los trastornos similares basados en una etiología común conocida se agrupan juntos en un espectro de severidad leve, moderado, grave (e.g. trastornos del espectro autista).
→ Integra el dominio físico con el psicológico y el solapamiento entre trastornos psicológicos y físicos: "El cuerpo afecta la mente y la mente afecta al cuerpo".
→ Aproximación dimensional: Espectro para la mayoría de los cuadros y, rasgos y dimensiones para entender la personalidad con trastornos.
→ Sensibilidad cultural: Conducta anormal o poco común no es sinónimo de patología. Considera el contexto en el que se desarrollan los trastornos.
→ Incorpora la evaluación de la discapacidad mediante las escalas WHODAS (Cuestionario para la evaluación de la discapacidad) de la OMS en seis dominios.
→ Vincula los trastornos psicopatológicos con técnicas de evaluación modernas tanto de <i>screening</i> como de diagnóstico.

Previamente al lanzamiento del DSM-5, la APA promovió un amplio debate en un sitio específico en una página web especialmente dedicada (www.dsm5.org), en la cual los profesionales de todo el mundo podían aportar sus opiniones. Surgieron así artículos en revistas científicas especializadas y conferencias especiales dedicadas a examinar las dificultades y ventajas de abandonar el modelo categorial y su reemplazo por uno dimensional (Widiger, Huprich & Clarkin, 2011; Widiger, Simonsen, Krueger, Livesley & Verheul, 2005; Widiger, Simonsen, Siorvatka & Regier, 2006).

El debate más controvertido se situó en relación con el abordaje *dimensional* de los trastornos de la personalidad. Si bien muchos autores estaban a favor de esta aproximación, no hubo un acuerdo total entre los clínicos y en el DSM-5 se mantuvo el abordaje categorial para los trastornos de personalidad, casi sin cambios respecto del DSM-IV. Sin embargo, se incluyó una sección especial en el manual (la Sección III) en la que se propone un abordaje dimensional de las alteraciones de la perso-

alidad y compatible con el modelo de los cinco grandes de la personalidad. En el cuerpo del manual se incluyen instrumentos especialmente diseñados a efectos de promover la investigación y el abordaje dimensional de la personalidad en futuras revisiones de la obra, tomando como base una amplia evidencia empírica (Hopwood *et al.*, 2013).

En este modelo los trastornos de la personalidad se caracterizan considerando dos aspectos. En primer lugar, una *deficiencia moderada o grande en el funcionamiento de la personalidad, tanto en el sí-mismo como en las relaciones interpersonales*. En segundo término, la *presencia de rasgos patológicos en la personalidad*. Al igual que la definición del sistema categorial, se sigue valorizando que tanto las deficiencias en el funcionamiento de la personalidad como los rasgos patológicos se expresen de un modo *relativamente inflexible y generalizado* a lo largo de un *amplio rango de situaciones personales y sociales*, resultando *relativamente estables* a lo largo del tiempo, ubicándose su *inicio en la adolescencia o adultez temprana*. Finalmente, se remarca que las deficiencias *no puedan ser mejor explicadas por otro desorden mental, los efectos fisiológicos de una sustancia o condición médica, o considerarse normales de acuerdo al estadio de desarrollo evolutivo del individuo o por su entorno sociocultural* (American Psychiatric Association, 2013).

Entonces, para valorar los trastornos de la personalidad desde esta aproximación dimensional tenemos que tener dos criterios diferenciados: el **Criterio A**, que indica el nivel de *deficiencia en el funcionamiento de la personalidad*, dicho de otra manera, el grado de *severidad* del trastorno, que se puede apreciar en disfunciones relativas al sí-mismo y a los aspectos interpersonales; y el **Criterio B**, que consiste en los *rasgos de personalidad patológicos* derivados del modelo de los cinco grandes. Serían extensiones patológicas de los rasgos de personalidad “normales”, que comentamos en el capítulo 1. En las tablas 6 y 7, podemos apreciar la descripción de estos criterios. Estas cuatro dimensiones comentadas pueden entenderse en un continuo que iría desde ninguna o poca disfunción hasta la disfunción extrema, con niveles intermedios –moderado, severo–. Para poder diagnosticar un trastorno en la personalidad el nivel de disfunción tiene que *ser al menos moderado en por lo menos dos de los cuatro aspectos del Criterio A*. El profesional debe evaluar cuánta disfunción presenta el sujeto utilizando el gradiente comentado (American Psychiatric Association, 2013).

La *disfunción de la personalidad* se constituye en el común denominador de los trastornos personológicos y está vinculados a la *severidad* del cuadro clínico. Los rasgos patológicos –Criterio B– generan las *diferencias* estilísticas entre los *tipos* de trastornos (Bastiaansen, De Fruyt, Rossi, Schotte & Hofmans, 2013; Bender, Morey & Skodol, 2011; Morey *et al.*, 2011).

Los rasgos psicopatológicos son extensiones disfuncionales de los rasgos de personalidad derivados del modelo de los cinco grandes de la personalidad. Estos pueden evaluarse con criterios dimensionales y es posible establecer un perfil de la personalidad del consultante (véase descripción en tabla 7). Así una persona puede presentar un trastorno de la personalidad moderado con la manifestación de diferentes rasgos patológicos. Por ejemplo, frente a una persona que no se considere muy capaz en situaciones sociales, con sentimientos de vergüenza (puntuación baja en Identidad), con poca capacidad para tomar riesgos personales, especialmente si involucran contacto

Tabla 6. Dimensiones e indicadores del Criterio A para valorar los trastornos de la personalidad

CRITERIO A			
DIMENSIÓN	SUBDIMENSIÓN	DEFINICIÓN	EJEMPLO
SÍ-MISMO	IDENTIDAD	Claros límites entre yo/no-yo. Estabilidad de la autoestima. Capacidad de regulación emocional.	Ezequiel tiene baja autoestima y se considera incapaz para resolver distintos aspectos de su vida. Elena tiene una autoestima exagerada y se cree mucho más capaz que sus pares en varios aspectos de su vida.
	AUTODIRECCIÓN	Búsqueda de metas coherentes. Capacidad para reflexionar. Conductas prosociales.	Juan no puede establecer un proyecto de vida claro. María tiene metas inestables y no puede consolidar su decisión vocacional. Pedro tiene objetivos de vida solo vinculadas con su gratificación personal.
INTERPERSONAL	EMPATÍA	Tolerancia de diferentes perspectivas. Tomar en cuenta el efecto del propio comportamiento en los demás.	Ricardo es muy sensible a las críticas que recibe de sus amigos. Juan tiene una baja capacidad empática y no toma en cuenta en sus acciones cómo esto puede afectar a su esposa.
	INTIMIDAD	Capacidad para establecer relaciones íntimas, profundas y duraderas con los demás.	Los vínculos que establece Miguel están basados en el engaño y en la explotación de los demás. Ayelén establece relaciones cercanas con los demás, pero en extremo conflictivas. Mauro no establece vínculos cercanos a menos que esté muy seguro de que le caerá bien a la otra persona.

interpersonal (puntuación baja en Autodirección), con temor al rechazo y dificultad para establecer vínculos personales (puntuación baja en subdimensiones Interpersonal y Empatía) y que presente ansiedad excesiva (rasgos Afectividad negativa) y sentimientos de anhedonia y evitación de la intimidad (rasgo Desapego), estaríamos hablando de un trastorno de personalidad evitativo.

Tabla 7. Dimensiones de los rasgos patológicos de la personalidad (Criterio B)

AFECTO NEGATIVO	Este rasgo representa la vivencia de emociones negativas tales como ansiedad, depresión, inseguridad y preocupación. Quienes puntúan alto en este rasgo sienten que sus emociones negativas son impredecibles y pueden invadirlos en cualquier momento. Además, se perciben como incapaces de manejarlas. El polo opuesto de este dominio es la estabilidad emocional.
DESAPEGO	Este rasgo, también llamado <i>Indiferencia</i> , implica la evitación de las experiencias socioemocionales con otras personas. Ello incluye una gama tan variada que parte desde las interacciones diarias con amigos hasta las relaciones íntimas. Quienes obtienen puntuaciones altas en Desapego poseen importantes dificultades para establecer relaciones de amistad o vínculos amorosos. Generalmente se sienten tan incómodos en situaciones sociales que, de ser posible, las evitan. Su contrapartida es la extraversión, en este caso en sentido equilibrado y abierto hacia las relaciones interpersonales, sin excesos de histrionismo, narcisismo ni egocentrismo. Es decir, este polo opuesto se describe como un polo sociable y abierto, con capacidad para relacionarse con los otros, pero sin componentes exagerados o egocéntricos.
ANTAGONISMO	Quienes obtienen puntuaciones altas en este rasgo se caracterizan por presentar comportamientos antisociales. Suelen recurrir a la agresividad, el engaño y la manipulación para lograr sus objetivos personales, sin importar las consecuencias que ello cause en los otros. Experimentan sentimientos de superioridad y piensan que las reglas no les atañen, por lo que suponen que pueden actuar como deseen con tal de lograr sus metas. El polo opuesto es la agradabilidad o afabilidad en el trato con los demás, a quienes tienen en cuenta y respetan en todas sus acciones e interacciones.
DEINHIBICIÓN	Este rasgo se vincula con un elevado grado de impulsividad en los comportamientos. Los sujetos desinhibidos buscan la gratificación inmediata de sus necesidades sin considerar las posibles consecuencias de sus actos. Generalmente incurren reiteradamente en conductas riesgosas, tanto para ellos como para los demás. No piensan antes de actuar puesto que no poseen capacidad para el control de sus impulsos. Su polo opuesto es la escrupulosidad, donde se hallan las personas cuidadosas, reflexivas y prudentes.
PSICOTICISMO	Este rasgo evalúa una percepción distorsionada de la realidad. Puntuaciones altas indican la presencia de experiencias extrañas generalmente ligadas a alucinaciones o delirios. El realismo, o sentido de realidad conservado, es su polo opuesto. Las puntuaciones intermedias-altas en Psicoticismo pueden indicar algún grado de extravagancia o de creencias peculiares que no necesariamente lleguen hasta una realidad percibida en forma distorsionada. Es muy importante, en esos casos, diferenciar a estas personas, que pueden presentar cierta extravagancia o pensar diferentes con respecto a posiciones filosóficas o cosmovisiones no tradicionales para una sociedad dada, de aquellas que sí exhiben distorsiones en la percepción de su entorno y que, seguramente, puntuarán alto en este rasgo.

Estos rasgos comentados pueden a su vez descomponerse en facetas (véase tabla 8).

Tabla 8. Facetas por cada rasgo de personalidad patológico

DOMINIOS	AFECTIVIDAD NEGATIVA	DESAPEGO	ANTAGONISMO	DESHINIBICIÓN	PSICOTICISMO
POLARIDAD OPUESTA	Estabilidad emocional	Extraversión	Afabilidad	Escrupulosidad	Lucidez
FACETAS	Inestabilidad emocional Ansiedad Inseguridad de separación Sumisión Perseveración Depresividad Desconfianza Afectividad restringida (o ausente) ostilidad	Apartamiento Evitación de la intimidad Anhedonia Depresividad Desconfianza Afectividad restringida	Manipulación Falsedad Grandiosidad Búsqueda de atención Insensibilidad Hostilidad	Irresponsabilidad Impulsividad Distractibilidad Toma de riesgos Perfeccionismo rígido (o ausencia del mismo)	Creencia y experiencias inusuales Excentricidad Desregulación cognitiva y perceptual

Según los criterios comentados propuestos en la Sección III del DSM-5 (2013), una persona con trastornos de su personalidad para ser establecida como tal, habría de tener una disfunción **moderada o grande** en el funcionamiento de la personalidad en relación al **sí mismo** y a **los demás** (Criterio A); presentaría uno o más rasgos de personalidad patológicos (Criterio B). Este patrón sería **relativamente inflexible y generalizado** a lo largo de un **amplio rango** de **situaciones** sociales y personales (Criterio C), **relativamente estable y de larga duración**, habiendo empezado en la adolescencia o adultez temprana (Criterio D) y no se explicaría mejor como manifestación o consecuencia de otros trastornos psicológicos (Criterio E). Finalmente, no sería atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra condición médica (Criterio F) y no se comprende mejor como un estadio normal del desarrollo del individuo o el ambiente sociocultural (Criterio G).

En la tabla 9 describimos las 25 facetas de cada una de las dimensiones propuestas y su correspondiente descripción teórica.

Tabla 9. Facetas de los cinco rasgos de la personalidad patológicos del DSM-5

DEPRESIVIDAD	Sentimientos de desesperanza, dificultad para recuperarse de tales estados de ánimo; pesimismo sobre el futuro; vergüenza y/o culpa generalizados; sentimientos de baja autoestima; pensamientos y comportamiento suicida.
DESCONFIANZA	Extrema sensibilidad a la detección de señales de malas intenciones o daño; dudas sobre la lealtad y la fidelidad de los demás; sentimientos de ser maltratado, utilizado y / o perseguidos por otros.
AFECTIVIDAD RESTRINGIDA	Poca reacción a situaciones de intensidad emocional; indiferencia y frialdad en situaciones que requieren participación.
INESTABILIDAD EMOCIONAL	Las emociones aparecen con facilidad, son intensas y resultan desproporcionadas en relación con los eventos y las circunstancias.

ANSIEDAD	Sentimientos de nerviosismo, tensión o pánico como reacción a diversas situaciones; miedo ante la incertidumbre, expectativa de que suceda lo peor.
INSEGURIDAD DE SEPARACIÓN	Temor a la soledad, debido al rechazo o la separación de otros significativos, basado en una falta de confianza en la propia capacidad para cuidar de sí mismo, tanto física como emocionalmente.
SUMISIÓN	Adaptación de la conducta a los intereses y a los deseos reales o percibidos de los demás, aunque hacerlo sea la antítesis de los intereses, necesidades o deseos propios.
HOSTILIDAD	Sentimientos de ira frecuentes o persistentes; ira o irritabilidad en respuesta a los desaires e insultos menores; comportamiento desagradable o vengativo.
PERSEVERACIÓN	Persistencia en las tareas o en una forma particular de hacer las cosas mucho después de que el comportamiento ha dejado de ser funcional o efectivo.
APARTAMIENTO	Preferencia por estar solo en vez de con los otros; reticencia en situaciones sociales; falta de iniciativa para el contacto social.
EVITACIÓN DE LA INTIMIDAD	Evitación de relaciones cercanas o románticas, de vínculos interpersonales y de relaciones sexuales íntimas.
ANHEDONIA	Déficit en la capacidad de sentir placer y tener interés en las cosas.
MANIPULACIÓN	Uso de la seducción, encanto, labia, o adulación para conseguir fines propios, manipulando y controlando a los demás.
FALSEDAD	Deshonestidad y fraudulencia; distorsión del sí-mismo; embellecimiento e invenciones al relatar los acontecimientos.
GRANDIOSIDAD	Creer que uno es superior a los demás y merece tratamiento especial; egocentrismo.
BUSQUEDA DE ATENCIÓN	Participación en conductas para ser el foco de la atención y la admiración de los demás.
INSENSIBILIDAD	Falta de preocupación por los sentimientos o los problemas de los demás; falta de culpa o remordimiento por los efectos negativos o perjudiciales de las acciones de uno en los demás.
IRRESPONSABILIDAD	Incumplimiento de obligaciones y compromisos; incumplimiento de acuerdos y promesas; descuido de las propiedades de los demás.
IMPULSIVIDAD	Acción como respuesta inmediata a estímulos externos, sin un plan o consideración de resultados.
DISTRACTIBILIDAD	Dificultad para concentrarse; la atención es fácilmente desviada por estímulos externos; dificultad para mantener el comportamiento y focalizar en metas, incluyendo la planificación y la realización de tareas.
TOMA DE RIESGOS	Participación en actividades peligrosas y potencialmente dañinas para sí mismo, sin tener en cuenta las consecuencias; falta de preocupación por las limitaciones y la negación de la realidad del peligro personal; búsqueda desenfrenada de las metas sin importar el nivel de riesgo involucrado.
PERFECCIONISMO RÍGIDO	Insistencia rígida en que todo sea preciso y sin errores o fallas, incluyendo el rendimiento de uno mismo y de los demás; creencia de que sólo hay una manera correcta de hacer las cosas; dificultad para cambiar ideas y/o punto de vista; preocupación por los detalles, la organización y el orden.
CREENCIAS O EXPERIENCIAS INUSUALES	Creencias sobre poseer habilidades inusuales, como lectura de la mente, telequinesis, experiencias inusuales de realidad; incluye experiencias similares a alucinaciones.

EXCENTRICIDAD	Comportamiento, apariencia y/o discurso raro, inusual o bizarro; pensamientos extraños o impredecibles.
DESREGULACIÓN COGNITIVA Y PERCEPTUAL	Procesos de pensamiento y experiencias inusuales, incluyendo despersonalización, desrealización y experiencias disociativas; experiencias mixtas de estados de sueño y vigilia; experiencias de control de pensamiento.

En esta propuesta no se incluyen los trastornos *Paranoide*, *Esquizoide*, *Histriónico* y *Dependiente* por considerarse que no son de amplia utilización, por su excesivo solapamiento con otros diagnósticos y por la falta de investigaciones empíricas sobre ellos (Skodol *et al.*, 2011). Se proponen 6 tipos de trastornos: *Antisocial*, *Evitativo*, *Limítrofe*, *Narcisista*, *Obsesivo-compulsivo* y *Esquizotípico*. En la tabla 10, se comentan las principales características de estos cuadros tomando en cuenta el Criterio A (déficit en el sí-mismo e interpersonales) y B (rasgos patológicos).

Tabla 10. Trastornos de personalidad propuestos por la Sección III del DSM-5

ANTISOCIAL	Personas egocéntricas, con metas centradas en la gratificación personal, sin tomar en cuenta a los otros y con falta de remordimiento tras haber hecho algún daño (déficits en el sí-mismo). Incapacidad para mantener relaciones íntimas y significativas. Uso de la dominación e intimidación (déficits en aspectos interpersonales). Presencia del rasgo Antagonismo (e.g. manipulación, mentiras, insensibilidad, hostilidad) y Desinhibición (e.g. irresponsabilidad, impulsividad y toma de riesgos).
EVITATIVO	Personas con muy baja autoestima y poca valoración de sí mismas. Reticencia a tomar riesgos personales o a comprometerse con actividades nuevas que involucren contacto interpersonal (déficit en el sí-mismo). Preocupación excesiva por el rechazo de los demás, poca capacidad de vincularse con los demás por temor al rechazo o al ridículo (déficit en aspectos interpersonales). Presencia del rasgo Afectividad negativa (e.g. ansiedad) e Indiferencia (e.g. retraimiento, anhedonia, evitación de la intimidad).
LIMÍTROFE	Tienen una autoimagen muy inestable, con excesiva autocrítica, sentimientos crónicos de vacío y alta inestabilidad en las metas y el proyecto de vida (déficit en el sí-mismo). Percepciones de los demás sesgadas hacia atributos negativos o desfavorables, hipersensibilidades interpersonales. Mantienen relaciones y vínculos cercanos, pero estos son inestables y muy conflictivos. Los vínculos oscilan entre la idealización y la desvalorización. Presencia del rasgo Afectividad negativa (e.g. labilidad emocional, inseguridad de separación, depresividad), Antagonismo (e.g. hostilidad) y Desinhibición (e.g. impulsividad, toma de riesgos).
NARCISISTA	Tienen una excesiva referencia hacia los demás para la regulación de su autoestima. Manifiestan una autovaloración exagerada del sí-mismo o bien disminuida, pudiendo oscilar de un polo al otro. Estándares excesivamente altos e irracionales que los hace verse a sí mismos como seres excepcionales (déficits en el sí-mismo). Presentan fallas para reconocer sentimientos y necesidades de los demás. Establecen vínculos personales mayormente superficiales con el objetivo de regular su propia autoestima. Reciprocidad restringida en los vínculos con los demás (déficits interpersonales). Presencia del rasgo Antagonismo (e.g. grandiosidad, búsqueda de atención).

OBSESIVO-COMPULSIVO	Su identidad deriva principalmente de su trabajo y/o productividad. Exceso de meticulosidad, actitudes moralistas. Debido a su comportamiento rígido tienen dificultades para completar tareas y realizar metas (déficit en el sí-mismo). Las relaciones personales son vistas como una cuestión secundaria al trabajo y como una actividad no prioritaria. Alta rigidez y terquedad en los vínculos. Baja capacidad empática (déficits en relaciones interpersonales). Presencia del rasgo Afectividad negativa (e.g. perseveración), Indiferencia (e.g. evitación de la intimidad, afectividad restringida) y Deshinbicion (e.g. perfeccionismo rígido).
ESQUIZOTÍPICO	Presenta límites confusos entre el yo y los demás. Su autoconcepto está distorsionado y su expresión emocional a menudo no es congruente con el contexto o con la experiencia interna. Tienen metas irreales o incoherentes (déficits en el sí-mismo). Alta dificultad para comprender el impacto de sus acciones en los otros. Marcado deterioro en el establecimiento de los vínculos interpersonales, asociado con extrema desconfianza y ansiedad (déficits en las relaciones interpersonales). Presencia de los rasgos Afectividad negativa (e.g., desconfianza); Desapego (e.g. retraimiento, afectividad restringida) y Psicoticismo (e.g. experiencias inusuales, excentricidad, desregulación cognitiva y perceptual).

Esta aproximación también considera el diagnóstico de *rasgos patológicos específicos* (por ejemplo, Antagonismo), que puede determinarse cuando se considera la presencia de un trastorno de la personalidad, pero no se alcanza a cumplir el criterio para cada uno de los seis trastornos de personalidad mencionados (por ejemplo, Antisocial). Como puede advertirse, si bien el modelo tiende a ser dimensional, sigue manteniendo las categorías diagnósticas (criterios categoriales) de los DSM anteriores. Es por ello que algunos autores enfatizan que se trata de un sistema *híbrido* –categorial y dimensional– en lugar de exclusivamente dimensional (Anderson *et al.*, 2013; Krueger, 2013). Esto se ha realizado de este modo para guardar cierta continuidad con los usos y costumbres de la práctica clínica hasta el momento (Skodol, Morey, Bender & Oldham, 2013b).

LA EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD

Los trastornos de personalidad, desde la aparición de las nosologías DSM, han descansado casi exclusivamente en la evaluación mediante la entrevista clínica verbal, en donde el clínico debía valorar la presencia o ausencia de criterios específicos para poder realizar un diagnóstico. Dado que se ha criticado extensamente este tipo de metodología para establecer diagnósticos clínicos seguros y confiables comenzaron a surgir instrumentos basados en el formato de entrevista estructurada o bien mediante la metodología del inventario (Fernández Liporace, 2015; Sharp, Williams, Rhyner & Ilardi, 2013).

En relación con las entrevistas estructuradas para evaluar psicopatología la SCID (Structured Clinical Interview for DSM) es la más utilizada. Se trata de una entrevista semiestructurada que se ha utilizado en más de 1000 artículos publicados en las últimas décadas (Summerfeldt, Kloosterman, & Antony, 2010). Existe una versión para su uso clínico y otras para investigación y una versión abreviada para los trastornos más frecuentes encontrados en la práctica clínica. Posee la ventaja de hacer una evaluación conforme a los criterios de los DSM. Se aplica mayormente para evaluar sintomatología clínica (Sharp, Williams, Rhyner & Ilardi, 2013).

El instrumento más utilizado y quizá el más antiguo para diagnosticar alteraciones de la personalidad es el MMPI actualmente en la versión RF (Ben-Porath & Tellegen, 2009). Si bien el MMPI es un instrumento surgido en los años 40 y basado en una nosología psiquiátrica, la *interpretación configural* de sus escalas fueron las pioneras en la evaluación de la personalidad con trastornos (Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen & Kaemmer, 1989). El MMPI original (Hathaway & McKinley, 1942) implicó un destacable esfuerzo tanto de diseño como de elaboración, y siguió los criterios diagnósticos imperantes en la época generando una importante caudal de investigaciones empíricas en las décadas siguientes (Fernández Liporace, 2015). Es uno de los instrumentos más utilizados aún hoy en día para valorar las alteraciones de la personalidad (Butcher, Bubany & Mason, 2013). Merecen destacarse los estudios realizados en la Argentina por la Dra. Martina Casullo para validar la técnica en diferentes ámbitos tanto de investigación como aplicados (Casullo, 1999; Casullo & Samartino, 1996).

Otro de los instrumentos que cuentan con mayor cantidad de investigaciones para evaluar la personalidad patológica fueron los derivados del modelo teórico de Theodore Millon, los MCMI, actualmente en su versión IV (Millon, Grossman & Millon, 2015). El autor diseñó diferentes instrumentos derivados racionalmente de su teoría de la personalidad y en conexión con las nosologías internacionales (Millon & Davis, 2000). El primer instrumento fue el MCMI-I lanzado en 1977; se trataba de un instrumento que permitía valorar los diferentes trastornos de personalidad propuestos por las nosologías DSM de la época, así como también la presencia de la sintomatología más prevalente. Se volvió muy popular entre clínicos y psicoterapeutas, siendo sus características centrales el bajo número de ítems comparado con el tradicional MMPI (175 vs. 567). El MCMI permitía la valoración acorde con la nosología al uso y fue uno de los pioneros en brindar informes narrativos computarizados de los pacientes hacia principios de los años 90. El MCMI-III cuenta con estudio locales realizados en la Argentina (Casullo, Castro Solano, Braude & Koldovsky, 2000).

De modo más reciente y con un aumento creciente de investigaciones sobre su validez y utilidad ha surgido el *Personality Assessment Inventory –PAI–* (Morey, 1991, 2007). Ha sido adaptado al español por Ortiz-Tallo, Santamaría, Cardenal y Sánchez (2011) y a nuestro medio por el equipo de trabajo integrado por la Fernández Liporace y Castro Solano tanto en sus versiones adulta y adolescente (Stover, De la Iglesia, Castro Solano, & Fernández Liporace, 2017; Stover, Freiberg Hoffmann, Fernández Liporace, & Castro Solano, 2016; Stover, Castro Solano, & Fernández Liporace, 2015). Presenta objetivos diagnósticos a partir de relevar distintas dimensiones de la personalidad y focaliza en la identificación de sintomatología psicopatológica en adultos. Resulta, de este modo, una herramienta útil para el diagnóstico clínico y el diseño de tratamientos. Este inventario dispone de tres versiones: una, completa, de 344 ítems, otra abreviada de 165 reactivos en la versión en español, seleccionados en virtud de su especialmente adecuada calidad psicométrica, y una más, de *screening*. Como todos los instrumentos de *screening*, es apto para administraciones rápidas, colectivas, atendiendo a la detección de sintomatología en grandes poblaciones (Fernández Liporace, 2015).

Finalmente, y en relación con el nuevo abordaje propuesto en el DSM-5, surgió el PID-5 (Personality Inventory Disorders para el DSM-5) tanto en su forma de autoinforme (Krueger, Derringer, Markon, Watson & Skodol, 2012), como la diseñada para

ser completada por un informante externo (Markon, Quilty, Bagby & Krueger, 2013). Existe una versión extensa de 220 ítems y una versión abreviada de 25 que permite evaluar los cinco rasgos patológicos principales. La versión extensa permite evaluar las 25 facetas comentadas. Si bien estos instrumentos son de reciente lanzamiento, cuentan con una amplia cantidad de investigaciones y tienen adaptaciones y estudios locales realizados en la Argentina (Góngora & Castro Solano, 2017; Stover, Castro Solano & Fernández Liporace, 2019).

3. La personalidad “positiva”

Las fortalezas del carácter, las virtudes y los rasgos positivos

Alejandro Castro Solano

Personalidad e inteligencia fueron los primeros constructos que estudió la psicología cuando comenzó a consolidarse como un campo de trabajo independiente y separado de la filosofía, la medicina y la sociología, hacia comienzos de los años 20. El estudio de las diferencias individuales fue el primer objetivo de estudio de la naciente disciplina científica. Así, los rasgos de personalidad y las capacidades intelectuales resultaron las primeras unidades de análisis consideradas adecuadas para fundar este incipiente campo de trabajo. Los *adjetivos*, generalmente con connotación neutral, (e.g. sociable, extravertido, tenaz, responsable) identificaban las tendencias generales del comportamiento de las personas y fueron las primeras categorías de análisis utilizadas para conceptualizar a los rasgos de personalidad. Los estados de ánimo temporales, mucho más inestables, las características físicas o intelectuales y los juicios de valor fueron excluidos de forma deliberada como componentes esenciales de la personalidad. La psicología se centró así en un léxico científico, neutral y *no valorativo*, situación necesaria en aquella época para fundar un campo científico que necesitaba consolidarse.

Hacia la década del 40 el campo de la psicología de la personalidad estaba ya afianzado. La publicación del libro de Allport (1937) sobre los rasgos de personalidad y la obra de Murray (1938) dieron gran impulso a la disciplina, dotándola de una importante vitalidad teórica, empírica y aplicada (Barembaum & Winter, 2008). Las floridas descripciones de los casos clínicos, comunes en la psiquiatría del siglo XIX, eran ya parte de la psicología popular y no formaban parte de la psicología científica de la época.

Este recorte neutral y no valorativo del campo de la personalidad no careció de inconvenientes. Se dejó de lado la consideración del contexto social y cultural, situación que era patrimonio más de la sociología que de la psicología. Los ideales y valores, teñidos de connotación ética, también fueron eliminados y se entendía que no debían formar parte de la naciente disciplina psicológica. Allport (1937) se opuso tenazmente al uso del término *carácter* como sinónimo de personalidad, por tratarse de una categoría moral y con connotación valorativa, no propia de la personalidad (Nicholson, 1998). Este alejamiento de las bases sociales, culturales y éticas para describir la individualidad humana ha traído como consecuencia que los estudios vinculados con las virtudes humanas tradicionales (e.g. esperanza, prudencia, gratitud o perdón) u otros vinculados con la excelencia moral –en suma, aquello que nos hace mejores personas– fuera dejado de lado durante mucho tiempo (Mc Cullough & Snyder, 2000).

Por quedar el carácter moral corrido a un lado de la esfera principal de estudio de la psicología, lo “malo” y lo “bueno” permanecieron ligados a la psicopatología o a la ausencia de ella (Cosentino, 2011). Durante una parte importante del siglo XX, la psicología ha hecho progresos significativos en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicopatológicos y se ha ocupado de morigerar el sufrimiento de las personas (Seligman, 1995). Sin embargo, la psicología ha trabajado mayormente desde un punto de vista *patogénico*. Durante las décadas del 50 al 80 se hicieron esfuerzos por categorizar la totalidad del espectro psicopatológico, prueba de ello fue el surgimiento de las taxonomías y clasificaciones DSM (véase capítulo 2). Desde este *modelo médico*, el buen funcionamiento psicológico era equivalente a ausencia de malestar. Un tratamiento psicológico resultaba efectivo cuando la persona no tenía síntomas, trastornos o no sufría más de aquello que lo había llevado a la consulta. Sin embargo, una persona puede no tener síntomas y puede no estar teniendo un nivel óptimo de funcionamiento. Desde una óptica *salugénica*, salud psicológica no es igual a ausencia de enfermedad.

El problema derivado de esta situación es que no existe una taxonomía tan clara de la salud mental como de los trastornos mentales, en parte porque la psicología estuvo durante gran parte del siglo XX ocupándose más de las variables psicopatológicas que de las salugénicas (Seligman & Csikszentmihalyi, 2001). Hacia el año 2004, Peterson y Seligman señalaron que no existía una clasificación de las “sanidades” que pudiera ser el reverso del DSM. Si bien los trastornos psicopatológicos estaban bien delimitados, no existía una clasificación de las sanidades que fuera el eje directriz de la investigación, el diagnóstico y la intervención psicológica (Dahlsgaard, Peterson & Seligman, 2005). Teniendo en cuenta esto, construyeron una clasificación de las fortalezas y de las virtudes humanas. Esta agrupación se denominó *Values in Action* (VIA). Este modelo, conjuntamente con el estudio científico del bienestar psicológico, que había surgido de forma incipiente hacia finales de los años 60, cobró auge hacia los 80, y hacia fines de la década del 90 fue la piedra angular de la denominada *psicología positiva* (Castro Solano, 2010).

LA PSICOLOGÍA POSITIVA Y EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO

La psicología positiva es el estudio del funcionamiento óptimo de grupos, personas e instituciones. Asimismo, intenta entender las condiciones, procesos y mecanismos que llevan a estados subjetivos, sociales y culturales que caracterizan a una vida plena (Linley, Joseph, Harrington & Wood, 2006). Su impulsor, el conocido psicólogo y psicoterapeuta Martin Seligman aseveraba que la psicología a lo largo del siglo XX se había preocupado más por la enfermedad que por la salud, dejando de lado las metas originales que se había propuesto en su surgimiento a inicios del siglo XX: la identificación del talento humano y el hacer más plena la vida de las personas (Seligman & Csikszentmihalyi, 2001).

El modelo fundamental propuesto originalmente por Seligman fue el de *tres vías de acceso* a la vida plena o, dicho de otro modo, tres formas posibles de alcanzar la felicidad. La primera vía corresponde a la obtención de placer a través de las emociones positivas, esta forma es quizá la más conocida y responde a la noción más común de la felicidad. Una persona feliz es aquella que tiene una mayor cantidad de emociones positivas durante gran parte de su vida. La felicidad desde esta perspectiva es la suma

de momentos placenteros felices. A este modo del logro del bienestar también se lo llama *bienestar hedónico*. La segunda vía de acceso es la obtención del bienestar a través del compromiso (*engagement life*). Aquí el bienestar se deriva de la aplicación de las fortalezas personales para generar estados de *flow*. El *flow* es una sensación subjetiva de absorción completa que se alcanza cuando se domina de forma completa una tarea (e.g., tocar bien el piano, hacer algún deporte). Si somos conscientes de nuestras fortalezas personales (para qué somos buenos y qué somos capaces de hacer), al aplicarlas a la realización de una actividad tendremos esa sensación particular de conexión, que Seligman denomina *compromiso (engagement)*. El tercer pilar está vinculado con la búsqueda de sentido y esto solo puede entenderse en un contexto global más amplio. Esta tercera vía es la aplicación de las fortalezas personales al desarrollo de algo más importante que uno mismo. Generalmente este proceso se da en las instituciones (por ejemplo, familia, trabajo, escuela, comunidad). En suma, sería poner nuestras capacidades al servicio de los demás para obtener un significado vital como resultado del proceso.

La idea de Seligman es que, mediante estas tres vías de acceso, de forma alternativa o combinada, podemos alcanzar el bienestar psicológico. Estas vías no solo se pueden medir, sino que se pueden *entrenar* a través de tareas específicas, para que las personas incrementen su felicidad. Esta es la base de las denominadas *intervenciones positivas* que pueden aplicarse de forma individual, grupal o autoadministrada y que han demostrado una amplia efectividad no solo para aumentar el bienestar psicológico, sino para reducir la sintomatología clínica (Mazzucchelli, Kane & Rees, 2010; Sin & Lyubomirsky, 2009).

En el año 2011 Seligman publicó una nueva propuesta del modelo de 3 vías que pasó a tener 5 componentes. A este modelo lo denominó PERMA, el cual propone alcanzar el estado de bienestar máximo que ahora denomina *flourishing* a través de 5 factores: emociones positivas, compromiso, relaciones positivas, significado y logro. En este modelo las fortalezas son la piedra fundamental para movilizar los 5 componentes comentados y así alcanzar estados de *flourishing*. El *flourishing* desde la concepción de Seligman es lo opuesto al *languishing*. Una persona “florece” (tiene *flourishing*) cuando posee emociones positivas, puede generar fácilmente estados de *flow*, tiene buenos vínculos, realiza actividades con significado y alcanza sus logros personales.

El segundo pilar de acceso (vida comprometida, fortalezas y *flow*) o el estudio de las fortalezas en el modelo PERMA, fue quizá una de las temáticas más trabajadas y quizá una de las aportaciones más novedosas de la psicología positiva. Según Park y Peterson (2009) el estudio de las *fortalezas del carácter* es quizá el constructo que puede ocupar el rol más importante, ya que opera como bisagra entre las emociones y las instituciones positivas. Tanto las experiencias positivas como la vida en grupos e instituciones están sostenidas por el buen carácter de las personas. Desde el punto de vida de la psicología positiva el carácter consiste en un conjunto de rasgos positivos esenciales para la comprensión del buen vivir psicológico (Cosentino, 2010).

Dado que no existían antecedentes de una clasificación de las virtudes humanas, en el año 2004 Peterson y Seligman lanzaron un manual en el que se desarrolla una amplia y detallada clasificación de los rasgos positivos. Para producir esta clasificación se partió del criterio de expertos. Un grupo de académicos consideró a lo largo de las tradiciones religiosas y filosóficas de Oriente y Occidente cuáles eran las concepciones sobre el comportamiento moralmente bueno, que habían perdurado a lo largo de la

historia de la humanidad. Se consideraron religiones y culturas tan diversas como el judaísmo, la filosofía ateniense, el islam, el cristianismo o el confucionismo. El resultado fue la obtención de 6 virtudes que se repetían implícita o explícitamente en la mayoría de las tradiciones religiosas y filosóficas. Sobre esta clasificación un grupo de expertos psicólogos generó una clasificación de fortalezas del carácter que formara parte de cada una de las virtudes; así surgió la clasificación 24 x 6 de las fortalezas del carácter (véase tabla1).

Tabla 1. Fortalezas y Virtudes en el modelo de Peterson y Seligman

CORAJE	Valentía Persistencia Integridad Vitalidad	Hago lo correcto, corriendo riesgos. Concluyo mi tarea, pese a los obstáculos. Practico lo que le predico a los demás. Me siento vivo y efectivo.
JUSTICIA	Ciudadanía Liderazgo Imparcialidad	Me comprometo con mi grupo social. Guío a mi grupo en armonía hacia el éxito. Hago juicios sociales equitativos y “fríos”.
HUMANIDAD	Amor Bondad Inteligencia social	Busco estar cerca de mis afectos. Ayudo a todos, sin fines utilitarios. Sé lo que los demás desean y buscan.
SABIDURÍA	Perspectiva Apertura mental Amor por el saber Curiosidad Creatividad	Juicio elevado y profundo sobre la vida. Busco visiones alternativas a las mías. Busco más y mejores conocimientos. Deseo vivo por experimentar y conocer. Tengo ideas originales y útiles.
TEMPLANZA	Clemencia Humildad Prudencia Autorregulación	Me torno benévolo hacia un transgresor. Dejo que mis logros hablen por sí solos. Veo los pros y contras de mis decisiones. Gobierno mis respuestas a los estímulos.
TRASCENDENCIA	Apreciación Gratitud Esperanza Humor Espiritualidad	Me emociono con lo excelso. Siento y expreso las gracias. Sé que todo saldrá bien. Mi visión de la vida es alegre y serena. Mi vida tiene un sentido más allá de mí.

El buen carácter está formado por diversos componentes ubicados en diferentes niveles de abstracción: los componentes más abstractos son las virtudes y el nivel siguiente de abstracción hacia abajo corresponde a las fortalezas del carácter, que serían los ingredientes psicológicos (procesos o mecanismos) que definen a las virtudes. En un tercer nivel estarían los temas o historias positivas, que son el resultado de aplicar las fortalezas en una situación concreta. Se entiende a las fortalezas como rasgos y por lo tanto como componentes esenciales de la personalidad. Las fortalezas del carácter son estables y se pueden observar, varían según cada persona, por lo tanto, son una fuente de diferencias individuales. Así, por ejemplo, una persona puede tener como rasgo positivo la ayuda a los demás de forma desinteresada (fortaleza Bondad) y estar comprometido con su grupo social (fortaleza Ciudadanía), estos dos rasgos en los que sobresale (*signature strenghts*) son parte integrante de las virtudes Ciudadanía y Humanidad y estarían señalando su particular carácter. Las fortalezas del carácter

son rasgos personológicos, valorativos y positivos. Asimismo, estas fortalezas en tanto rasgos pueden apreciarse en pensamientos, emociones y conductas, son medibles, maleables a través de la vida y están sujetas a la influencia del contexto ambiental y cultural más amplio (Peterson & Seligman, 2004).

Peterson y Seligman (2004) han afirmado que la clasificación VIA se desarrolló con la esperanza de impulsar y generar un lenguaje común para la realización de los estudios empíricos en psicología positiva. A la fecha podemos contar con una gran cantidad de investigaciones que demuestran que las fortalezas del carácter están asociadas con diversas variables de interés. El instituto VIA, con sede en los Estados Unidos, nuclea los estudios e investigaciones sobre las fortalezas del carácter desde el punto de vista de esta clasificación de las fortalezas (ver <http://www.viacharacter.org>).

En términos generales los estudios empíricos han señalado que las fortalezas estaban asociadas con diferentes variables de interés, como sexo y edad (Linley, Joseph, Harrington & Wood, 2007), genética (Steger, Hicks, Kashdan, Krueger & Bouchard, 2007), grupos sociales (Cosentino & Castro Solano, 2012), satisfacción con la vida (Park, Peterson & Seligman, 2004), personalidad (Macdonald, Bore & Munro, 2008), rendimiento académico en estudiantes universitarios (Lounsbury, Fisher, Levy & Welsh, 2009), rendimiento académico y militar en estudiantes militares (Cosentino & Castro Solano, 2012), recuperación de enfermedades (Peterson, Park & Seligman, 2006), buen rendimiento en el trabajo (Elston, & Boniwell, 2011; Meyers & Van Woerkom, 2014), crecimiento postraumático (Peterson, Park, Pole, D'Andrea & Seligman, 2008) y progreso en la psicoterapia (Gander, Proyer, Ruch, & Wyss, 2012), entre otros. (Para una revisión completa de los hallazgos de investigación sobre fortalezas consultar <http://www.viacharacter.org>).

A modo de ejemplo, en la tabla 2 ofrecemos los resultados de los estudios más importantes realizados dentro del marco de la Psicología Positiva en relación con las fortalezas del carácter y su asociación con diferentes constructos vinculados al bienestar y a la satisfacción con la vida.

Tabla 2. Principales hallazgos empíricos de la relación entre fortaleza y diferentes componentes del bienestar psicológico

HALLAZGO	AUTORES
Las cinco fortalezas más relacionadas con la satisfacción con la vida son esperanza, gratitud, curiosidad y amor.	Park, Peterson y Seligman (2004)
Las vías más asociadas con la búsqueda del significado y el compromiso predicen mejor la satisfacción con la vida que la búsqueda de placer hedónico (primera vía).	Peterson, Park y Seligman (2005)
La fortaleza más asociada con las emociones positivas (primera vía) son humor, vitalidad, esperanza, inteligencia social y amor.	Peterson, Ruch, Beerman, Park y Seligman (2007)
Las fortalezas más asociadas con el compromiso (<i>engagement</i>) son vitalidad, curiosidad, esperanza, perseverancia y perspectiva.	Peterson, Ruch, Beerman, Park y Seligman (2007)
Entre los más jóvenes las fortalezas más relacionadas con la satisfacción con la vida son amor, esperanza y vitalidad.	Park y Peterson (2009)

En 27 países se estudió la relación entre vías y satisfacción. Significado y compromiso eran las vías que explicaban más la satisfacción y el hallazgo que más se replicaba en todos los países.	Park, Peterson y Ruch (2009)
Esperanza y espiritualidad eran las fortalezas más vinculadas con la satisfacción con el futuro.	Proyer, Gander, Wyss y Ruch (2011)
Un estudio experimental demostró que las fortalezas más prevalentes en población general (vitalidad, esperanza, gratitud, curiosidad y humor) eran las más sensibles a la intervención psicológica.	Proyer, Ruch y Buschor (2012)
Se examinó la relación entre fortalezas, la satisfacción y la edad. Las que estaban más asociadas con la satisfacción en todos los grupos de edades fueron esperanza, vitalidad y humor.	Martínez-Martí y Ruch (2014)
Se examinó la asociación entre fortalezas y 5 áreas vitales que las personas comunes consideran más importantes. Se encontró que amor, honestidad y vitalidad estaban relacionadas con el bienestar personal; perseverancia y autorregulación con el logro de metas; honestidad y gratitud con los vínculos personales; ciudadanía e imparcialidad con las relaciones en el trabajo.	Castro Solano y Cosentino (2016)
Curiosidad y perseverancia predicen la mayor asociación con el logro de objetivos a lo largo de la vida. Curiosidad es la que aumenta más la satisfacción al alcanzar los objetivos vitales.	Sheldon, Jose, Kashdan y Jarden (2015)
Las fortalezas del carácter están asociadas con cada uno de los elementos del modelo PERMA de Seligman (emociones positivas, compromiso, vínculos positivos, significado y logro).	Wagner, Gander, Proyer y Ruch (2018)
Estudiantes de los Emiratos Árabes sobresalían en la virtud de trascendencia, que a su vez estaba vinculada con altos niveles de felicidad y salud mental.	Petkari y Ortiz-Tallo (2018)

LA EVALUACIÓN DE LAS FORTALEZAS DEL CARÁCTER

Las fortalezas se evalúan con la metodología de los cuestionarios y sigue el modelo de la evaluación de los rasgos en psicología de la personalidad (véase capítulo 1). Entre los inventarios más utilizados se encuentran el *Values in Action Inventory of Strengths* (VIA-IS), que desarrollaron los autores originales del modelo para poder verificar los presupuestos del modelo teórico y el *IPIP-VIA* que es un instrumento de uso libre basado en el banco de datos de uso libre IPIP (International Item Pool; Goldberg, 1999; Goldberg *et al.*, 2006). En el sitio del IPIP (<http://ipip.ori.org>) pueden encontrarse 213 ítems del VIA de libre acceso para evaluar las fortalezas del carácter del modelo comentado. Estos ítems están en inglés y tienen detallado el grado de confiabilidad obtenida por cada agrupación de elementos.

El VIA-IS es un inventario de 240 ítems que evalúa las 24 fortalezas del carácter del modelo de Peterson y Seligman. Es autoadministrable, tiene versiones en varios idiomas en papel y también puede obtenerse una versión informatizada en el sitio *on*

line de la Universidad de Pennsylvania (www.authentic happiness.sas.upenn.edu). Es un autoinforme en el que el evaluado indica la percepción de la presencia de cada una de las fortalezas en una escala likert de cinco puntos. Diferentes estudios han confirmado su confiabilidad. En cuanto a su validez se han obtenido evidencias de validez convergente con evaluaciones externas, y en relación con la validez de criterio, se han vinculado las fortalezas con la satisfacción, la personalidad y la deseabilidad social (Peterson & Seligman, 2004; Ruch *et al.*, 2010). La satisfacción se ha considerado importante ya que, por definición, las fortalezas del carácter contribuyen al bienestar y a la felicidad personal en sentido amplio (Park, Peterson & Seligman, 2004). Respecto a la personalidad, los autores han señalado la importancia de establecer la asociación entre las fortalezas en tanto rasgos estables de la personalidad y el modelo de los Cinco Grandes de la personalidad. Finalmente, los autores consideraron que, por su carácter positivo, todas las fortalezas son socialmente deseables, razón por la cual el constructo deseabilidad social es incluido de modo sistemático en todas las investigaciones sobre fortalezas. Los estudios realizados con el VIA-IS demostraron la asociación con los tres constructos psicológicos mencionados.

Existen ciertas controversias en cuanto a la validación interna del modelo y la confirmación de las virtudes originales propuestas por la teoría, ya que tanto los estudios realizados en los Estados Unidos y en otros países no han podido replicar de forma adecuada la estructura del modelo 24 x 6 (para una revisión, véase Castro Solano & Cosentino, 2018). Sin embargo, el VIA-IS es el instrumento que por excelencia se utiliza en las investigaciones internacionales. Las desventajas son que se demora más de una hora para responderlo. Si bien cuenta con versiones breves (Brief Strength Test), las validaciones se han realizado con la versión extensa.

En la Argentina contamos con el IVyF –Inventario de Virtudes y Fortalezas– (Cosentino & Castro Solano, 2008), que es un inventario de ítems de párrafos de autopuntuación directa global para evaluar las 24 fortalezas del carácter. El instrumento, derivado de la clasificación de Peterson y Seligman (2004), consta de 24 ítems bipolares, correspondiendo cada uno a una fortaleza, que se responden en formato Likert que va de 1 (*soy muy parecido a la primera persona*) a 5 (*soy muy parecido a la segunda persona*). Los análisis psicométricos de este instrumento han demostrado una confiabilidad test-retest aceptable (entre .72 a .92, véase Cosentino, 2010) y semejante a la encontrada para el VIA-IS. Asimismo, se han estudiado las relaciones con otras variables de interés, como satisfacción vital, personalidad y deseabilidad social (Cosentino & Castro Solano, 2015). También se verificó la validez concurrente con un criterio objetivo (correlaciones entre autopuntuaciones y puntuaciones derivadas de informantes, el rango .35 a .75). Estos resultados demuestran que el IVyF es una prueba con buenas propiedades psicométricas para la evaluación de las fortalezas del carácter. Los datos argentinos comentados son coherentes con los obtenidos en otras investigaciones realizadas con instrumentos derivados del modelo de fortalezas propuesto por Peterson y Seligman. También se ha validado una versión breve, el IVyFabre –Inventario de Virtudes y Fortalezas abreviado– (Castro Solano & Cosentino, 2018).

Existen también otros instrumentos derivados de este modelo para evaluar jóvenes de 10 a 17 años: *Values in Action Inventory of Strengths for Youth* (VIA-Youth, Peterson, 2006); el *Values in Action Rising to the Occasion Inventory* (VIA-RTO) que es un cuestionario especialmente diseñado para evaluar las fortalezas que son más probables que aparezcan en una situación específica (e.g., la valentía puede activarse

en una situación peligrosa). También existe un inventario basado en este modelo para evaluar niños, el *VIA Strength Survey for Children*. En población argentina infantil se ha diseñado y validado una prueba basada en este modelo para evaluar la presencia de fortalezas del carácter en población infantil, mediante la utilización de viñetas (Grinhauz & Castro Solano, 2013; Grinhauz & Castro Solano, 2015). Este instrumento cuenta con buenas propiedades psicométricas. A pesar de la amplia variedad de formas y aplicaciones del instrumento, el más utilizado es el VIA-IS, que es el inventario del que contamos con mayor información sobre su funcionamiento en diferentes tipos de poblaciones.

LOS PROBLEMAS DE LA CLASIFICACIÓN VIA: ASPECTOS CULTURALES

La existencia de diferencias individuales en las fortalezas del carácter según los distintos grupos culturales ha sido el aspecto menos explorado desde el lanzamiento de la clasificación VIA en el 2004. Peterson (2006) afirmaba que la clasificación era tentativa y que se encontraba sujeta a los cambios producto del avance científico, siendo esperable que la misma sea revisada e incluso modificada. En relación con la temática cultural podrían existir fortalezas del carácter que solo sean consideradas como tales en algunas culturas, pero no en otras (Lambert, Pasha-Zaidi, Passmore, & Al-Karam, 2015). De la misma forma, podrían existir fortalezas características de una población que no hayan sido incluidas en la clasificación original VIA comentada. Los primeros estudios culturales sobre fortalezas y virtudes fueron los realizados por Biswas-Diener (2006) y Park, Peterson y Seligman (2004). Estos estudios incluyeron una gran cantidad de participantes de varios países, incluso algunos de contextos culturalmente muy diversos tales como Groenlandia y Kenya. Estos estudios verificaron que las personas podían reconocer la mayoría de las fortalezas de la clasificación de Peterson y Seligman. Los autores aseveran que tales resultados abonarían la idea de que la clasificación era *universal*.

La equivalencia cultural de los constructos positivos ha sido una preocupación desde los inicios del movimiento (López *et al.*, 2002). El debate acerca de las virtudes y fortalezas humanas toma en cuenta dos aspectos contrarios. Por un lado, se encuentra la línea que sostiene que las fortalezas son universales, que la clasificación diseñada por Peterson y Seligman es aplicable a la mayoría de las culturas y que por lo tanto sería *cultural free*. La línea contraria sostiene que, si bien algunas de las fortalezas pueden estar presentes en varias culturas distintas, los investigadores deben estar alertas sobre posibles sesgos etnocéntricos al manejarse la clasificación solo desde la perspectiva ético-impuesta (Christopher & Hickinbottom, 2008; Snyder, López & Pedrotti, 2011).

Los estudios empíricos realizados señalan que la perspectiva más utilizada para el estudio de las fortalezas ha sido la ético-impuesta (Berry, 1969; Triandis, Malpass & Davidson, 1973). Este enfoque supone un sistema descriptivo que sea igualmente válido para todas las culturas estudiadas y que permite la representación de similitudes y diferencias entre ellas (Helfrich, 1999). Por lo tanto, los estándares para hacer la comparación deben ser equivalentes en todas las culturas (en nuestro caso la clasificación de fortalezas). Este enfoque incurre en el supuesto de utilizar instrumentos émicos como si fueran éticos (válidos universalmente). De manera contraria, el *enfoque*

émico considera los fenómenos psicológicos desde la perspectiva de las personas y evalúa el comportamiento desde una cultura en particular utilizando los conceptos más adecuados para esa cultura específica (Davidson, Jaccard, Triandis, Morales & Díaz-Guerrero, 1976).

Cabe destacar el escaso desarrollo en los países hispanoparlantes de los constructos más modernos sobre los que la psicología positiva hace foco: las fortalezas, las emociones positivas, las organizaciones positivas, entre otros. Todos ellos resultan temas de escaso interés y están subrepresentados en las producciones científicas de los psicólogos latinos (Castro Solano, 2014; Cosentino, 2014). En estos estudios, en términos generales, se descuida la perspectiva cultural-regional, dando por sentada la *supuesta universalidad* de los constructos psicológicos. Se extraen conclusiones acerca de poblaciones muy específicas y se extrapolan estos resultados a contextos culturales más amplios, sin un estudio adecuado de las variaciones locales de los constructos estudiados. La suposición de la universalidad partiendo de esta base representa sesgos culturales evidentes (Casullo & Fernández Liporace, 2006). Esto lleva a que los constructos psicológicos estudiados revistan características pseudoéticas o que en suma sean *falsamente universales*. En los trabajos de psicología positiva revisados en la última década se destaca el poco interés que reviste el estudio de las variaciones locales de los constructos positivos diseñados generalmente en Estados Unidos y en Europa y la escasa importancia dada a los estudios transculturales o interculturales (Castro Solano, 2014). Si bien en los últimos cinco años se registra un impulso sobre los estudios que toman en cuenta las variaciones culturales, estos aún son escasos y en particular en Latinoamérica son casi inexistentes.

En cuanto a la controversia fundamental de si la clasificación 24 x 6 es generalizable a otras culturas diferentes de la anglosajona, merece comentarse que ni en Estados Unidos, ni en otras culturas se ha encontrado soporte empírico del agrupamiento clasificatorio de las 24 fortalezas del carácter en 6 virtudes, tal como lo propusieron Peterson y Seligman en su modelo original (Castro Solano & Cosentino, 2018). Por ejemplo: Macdonald, Bore y Munro (2008) descubrieron 5 y 4 factores en una muestra de estudiantes de primer año de psicología de una universidad australiana; Khumalo, Wissing y Temane (2008) encontraron 3 factores en una muestra de estudiantes de psicología de Sudáfrica; Brdar y Kashdan (2010) hallaron soluciones de 3 y 4 factores en una muestra de estudiantes de Croacia; Singh y Choubisa (2010) aislaron 5 factores con una muestra de estudiantes de la India que respondieron en inglés; Cosentino (2011) encontró cinco y tres factores en una muestra de población general de la Argentina; Lavy y Littman-Ovadia (2012) hallaron cinco factores con una muestra de adultos de habla hebrea israelí; y finalmente, Duan *et al.*, (2012) descubrieron tres factores con una muestra de estudiantes universitarios de China.

En América Latina, casi no se ha estudiado el constructo fortalezas del carácter a excepción de algunos estudios realizados por investigadores locales (Cosentino, 2014; Cosentino & Castro Solano, 2012; Noronha, Dellazzana-Zanon & Zanon, 2015). Estos hallazgos nos abren dos caminos: o bien diseñar estudios émicos para el diseño de instrumentos de uso local que tomen en cuenta la singularidad de cada cultura, o bien proponer otro modelo teórico-racional alternativo que supla las fallas de los modelos preexistentes.

LOS ESTUDIOS ÉMICOS: APROXIMACIÓN PSICOLÉXICA

Estos estudios tienen como objetivo advertir las variantes locales y singulares de los constructos objeto de estudio en cada cultura particular. Se trata de estudios exploratorios e inductivos que analizan datos empíricos e intentan identificar agrupaciones de elementos (e.g. fortalezas, rasgos positivos) con el propósito de encontrar una generalización aceptable de los datos que pueda ser replicada en diferentes poblaciones. También se llaman enfoques guiados por los datos (*data-driven*).

Uno de los estudios pioneros sobre características humanas positivas es la investigación de Walker y Pitts (1998). Este estudio tuvo como objetivo analizar las concepciones naturalísticas de la excelencia moral de las personas. Los autores habían solicitado a los participantes un listado de atributos y características que identificaran a las personas con atributos de excelencia moral. Estos atributos fueron clasificados por jueces y como resultado se hallaron 6 agrupaciones de atributos de las personas con características morales: *idealista basado en principios; confiable y leal; íntegro; bondadoso; justo y confidente*. Estos atributos se agruparon en 2 dimensiones: orientación hacia el sí mismo vs. otro, y orientación interna vs. externa.

En otro estudio, Cawley, Martin, y Johnson (2000) partieron de la identificación de 140 términos del diccionario inglés que se correspondían con las virtudes morales. Estas virtudes (adjetivos) fueron convertidas en escalas y se evaluó un grupo de estudiantes universitarios que se habían autopuntuado en cada una de esas características. Como resultado, se propuso un modelo de cuatro dimensiones de virtudes, compuesto por *empatía, orden, ingenio y serenidad*.

Morales-Vives, De Raad y Vigil-Colet (2014) realizaron un proceso de varios pasos que finalizó en la identificación de 209 descriptores de virtudes. Partieron de depurar un listado de palabras emanados de una base de datos informatizada. Seleccionaron aquellas palabras que describían virtudes o rasgos morales y eliminaron todas aquellas que no incluían algún tipo de valoración de la conducta o del pensamiento. Como siguiente paso evaluaron un grupo de estudiantes universitarios en cada una de las palabras obtenidas (descriptores de virtudes). Como resultado, se propuso un modelo de siete factores que *llamaron autoconfianza, rectitud, compasión, sociabilidad, reflexividad, perseverancia y serenidad*.

Finalmente Cosentino y Castro Solano (2017), utilizando una aproximación *psicoléxica*, partieron de la identificación de las características humanas positivas desde el punto de vista de las personas comunes. Su investigación tuvo por objetivo desarrollar un modelo de factores de rasgos positivos humanos socialmente compartidos que pudiese ser replicable en otras poblaciones (Castro Solano & Cosentino, 2016b). Hasta el momento de esa investigación, los estudios sobre características positivas se habían focalizado solamente en un subtipo de rasgos positivos: *los rasgos morales* (e.g., virtudes y fortalezas del carácter), en tanto que talentos y habilidades habían sido sistemáticamente excluidos. Sin embargo, los autores consideraron las *características psicológicas positivas* en un sentido amplio, incluyendo características sin connotación moral (e.g., tranquilidad) como así también las relacionadas con la *performance* (e.g., inteligencia). Su investigación tuvo por resultado el desarrollo de un modelo replicable de cinco factores denominado *Modelo de los Cinco Altos o High Five Model (HFM)*: *erudición, paz, jovialidad, honestidad y tenacidad*.

Tabla 3. Modelo de los Cinco Altos. Definición breve e ítems

FACTOR ALTO	DESCRIPCIÓN BREVE	HFI ÍTEMS
ERUDICIÓN	Rasgo positivo ligado al conocimiento que se expresa en pensar soluciones, crear cosas, o tener deseos de aprender	Ser inteligente, tener sabiduría, ser visionario/a, tener genio, ser culto/a, tener ingenio
PAZ	Rasgo positivo ligado al equilibrio que se expresa en pensar en calma, en creer que todo tiene solución, o en que las cosas van a llegar.	Tener paciencia, ser tolerante, tener tranquilidad, tener serenidad
JOVIALIDAD	Rasgo positivo ligado a la excitación que se expresa en deseos de hacer reír, de divertir y divertirse, o tener ideas sobre cosas divertidas y graciosas.	Tener humor, ser simpático/a, ser divertido/a, ser gracioso/a
HONESTIDAD	Rasgo positivo ligado a lo moral que se expresa en desear mostrarse tal cual uno es, deseos de decir la verdad o de ser una buena persona.	Tener lealtad, ser confiable, tener valores, ser transparente, ser verdadero/a
TENACIDAD	Rasgo positivo ligado a la voluntad que se expresa en pensar en metas, lograr objetivos, o creer que los objetivos se logran con esfuerzo.	Tener dedicación, ser persistente, tener esfuerzo, tener laboriosidad

Para desarrollar este modelo de características positivas se evaluaron 745 participantes varones y mujeres residentes en la Ciudad de Buenos Aires, a los que se les había solicitado que generaran palabras para describir las cualidades positivas de una persona que admiraran más en su vida cotidiana. No se establecieron límites sobre el tipo de características positivas que podían mencionarse; así las personas podían incluir características morales (e.g. ser confiable), como características relacionadas con las habilidades (e.g. inteligencia) o alguna carente de connotación moral (por ejemplo, serenidad). Se utilizaron procedimientos sintácticos y estadísticos para reducir el cuerpo a una lista manejable de características psicológicas individuales positivas (rasgos positivos). Como resultado se generó un destilado de 140 palabras, a partir del cual se derivó un inventario. Este nuevo inventario construido a través de las palabras se administró a 516 participantes, donde tenían que indicar el grado en que cada una de las palabras (adjetivos) los autodescribían. Se llevaron a cabo sucesivos procedimientos estadísticos basados en el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, que dieron lugar a 23 ítems que se agrupaban en cinco dimensiones de características psicológicas positivas. A esta agrupación se la llamó High Five Model (véase tabla 3). Con una muestra alternativa de 1100 participantes no solo se verificó que estas características tenían altas asociaciones con el bienestar psicológico, emocional y social de los participantes, sino que predecían aun mejor el bienestar que el modelo de los Cinco Grandes de la personalidad (Costa & McCrae, 1985).

Como rasgos positivos de la personalidad, los Cinco Altos están presentes en cada individuo de forma relativamente estable, y están representados por características psicológicas positivas. Los factores altos presentan ciertas propiedades: pueden medirse, varían entre individuos, y supuestamente podrían ser incrementados o reducidos por influencias internas y/o externas. Estos factores altos son diferentes

de los factores del modelo de los Cinco Grandes de la personalidad, aunque están relacionados con ellos.

En otro estudio, se pudo demostrar que estos factores altos se asociaban negativamente con los indicadores de sintomatología, con los rasgos patológicos de la personalidad y con el riesgo de enfermedades médicas no transmisibles (Castro Solano & Cosentino, 2017). Recientemente, se pudo verificar que los factores altos permitían predecir el rendimiento académico y estaban asociados con el ajuste académico de los estudiantes universitarios (Castro Solano & Cosentino, 2019). Los pasos seguidos para la construcción del modelo pueden apreciarse en la figura 1.

Cabe comentar que este estudio representa un abordaje único y original porque, a diferencia de los estudios previamente citados, incorpora un enfoque profundamente psicoléxico (se partió de las palabras que piensan y utilizan las personas comunes, sin mediación de diccionarios). Se basó exclusivamente en procedimientos estadísticos (e.g., frecuencia de las palabras) para el análisis de los descriptores de los rasgos positivos, excluyendo la subjetividad de los juicios de expertos y jueces para clasificar y eliminar elementos en distintas instancias del proceso de investigación, como es práctica habitual en este tipo de estudios. Esta aproximación conlleva una mejor representación de los rasgos positivos internalizados por las personas en comparación con otros procedimientos.



Figura 1. Proceso Inductivo de generación de los rasgos positivos (*Modelo High Five*)

LOS ESTUDIOS DERIVADOS DEL CONSENSO DE EXPERTOS: EL CONTINUO SALUD-ENFERMEDAD

Otra forma de aproximarse a los rasgos positivos es partir de considerar que *teóricamente* los rasgos positivos de la personalidad son la *extensión positiva* de los rasgos patológicos. Para ello es necesario partir de las nosologías internacionales y del consenso de expertos que las construyeron. Esta perspectiva entiende que tanto rasgos positivos como patológicos se extienden a lo largo de un continuo en uno de cuyos extremos estarían los marcadores patológicos recogidos por las nosologías DSM y en el otro extremo los indicadores de personalidad positivos. Si bien esta aproximación no es original (Keyes, 2002, 2005; Leising, Rogers & Ostner, 2009), ha sido muy poco explorada en relación con las variables psicológicas.

La idea de la continuidad sindrómica entre psicopatología y personalidad normal no es nueva. Estas propuestas consideran que la línea divisoria entre salud y enfermedad es relativa, y tanto psicopatología como normalidad deberían ser vistas como puntos arbitrarios en el *continuo salud-enfermedad* (e.g., Leary, 1957; Millon, 1996; Offer & Sabshin, 1991; Strack & Lorr, 1994). En línea con esta noción de continuo, Millon (2011), en uno de sus últimos textos, postuló la existencia de 15 *espectros* de personalidad en un intento de integrar los aspectos normales y patológicos de la personalidad dentro de un continuo. Con el correr de los años se ha incrementado el reconocimiento de que las concepciones sobre normalidad y patología deberían estar organizadas en un único marco conceptual. Sin embargo, a la fecha no contamos con una clasificación integrada de psicopatología y normalidad, de amplia aceptación entre teóricos y clínicos.

Por el lado de las clasificaciones de psicopatologías, y en el caso particular de los *trastornos de personalidad*, desde los años 80 –fecha en la que oficialmente se ubicaron estos cuadros en un capítulo aparte dentro del Manual Diagnóstico– la *Task Force* del DSM ha encontrado grandes dificultades para consensuar una nosología que sea ampliamente aceptada. Desde el inicio estos trastornos se configuraron en un eje aparte separado de los cuadros sintomáticos del Eje I, y su sistema de diagnóstico ha sido desde siempre de índole categorial. Este enfoque categorial ha generado una serie de polémicas y discusiones frente a las modificaciones a introducirse con el DSM-5 lanzado finalmente en el 2013, como comentamos en el capítulo 2. El punto central de la discusión se ubicó en la limitación que tienen las aproximaciones categoriales para el estudio de los trastornos de personalidad. Si bien no se alcanzó un acuerdo pleno entre los miembros de la Task Force para el lanzamiento del DSM-5 en el 2013, se presentó como propuesta para futuros estudios un abordaje dimensional basado en Cinco Grandes de la Personalidad (Costa & McCrae, 1985), modelo histórica y enfáticamente rechazado para el diagnóstico de los trastornos personológicos (Krueger, Derringer, Markon, Watson, & Skodol 2013; Millon, 1996).

Así, se generaron 5 dimensiones principales para evaluar los rasgos psicopatológicos (e.g., afecto negativo, desapego, antagonismo, desinhibición y psicoticismo) y 25 facetas. En el DSM-5 se presentaron estos rasgos patológicos como los polos opuestos de los rasgos clásicos de la personalidad no patológicos sin aportarse mayores especificaciones al respecto (American Psychiatric Association, 2013).

Como hemos comentado, durante una parte importante del siglo XX los esfuerzos de la psicología estuvieron encaminados al diagnóstico y al tratamiento de los trastornos mentales y se ha hecho mucho menos por el énfasis en los componentes salugénicos. El modelo médico por el cual salud es igual a ausencia de psicopatología ha fijado el rumbo de la labor en el ámbito psicológico. Sin embargo, que una persona no presente sintomatología no es garantía de buena calidad de vida (Seligman & Csikzentmihalyi, 2014).

Ya desde los años 50, los científicos sociales han considerado que la salud era algo más que la ausencia de enfermedad. Jahoda (1958), por ejemplo, postulaba que la salud consistía en el funcionamiento psíquico óptimo de las personas, entendido esto como el ejercicio de las capacidades autónomas de los sujetos. Sin embargo, durante las décadas siguientes este concepto no fue más que un *slogan* y no se hicieron esfuerzos para definirlo operacionalmente e incluirlo seriamente en la práctica clínica (Keyes, 2002).

Por su parte, Keyes (2002) distinguió el continuo *languishing-flourishing* para valorar la salud mental positiva. De acuerdo con el autor, los individuos podrían clasificarse en tres grupos: (a) *Languishing*, compuesto por sujetos con dificultades en la vida, sentimiento de vacío, falta de intereses y compromiso, (b) *Flourishing*, que abarca a quienes tienen un desarrollo óptimo en la vida, y (c) *Moderate mental health*, que incluye a sujetos que no están ni en ninguna de las otras dos clasificaciones. Este modelo entiende salud y enfermedad como un continuo a través de la presencia (o ausencia) y el grado de bienestar hedónico (bienestar emocional) y eudaemónico (bienestar personal y social).

Tal como se ejemplificó en el capítulo 2, con los debates acerca de la clasificación idónea para diagnosticar trastornos de personalidad, se pueden vislumbrar a lo largo de todo el siglo XX los esfuerzos por arribar a una categoría consensuada de psicopatología. A pesar de haber aún algunos disensos, en términos generales contamos con una idea bastante acabada de aquello que las personas *no deben ser/hacer*. Muy por el contrario, aún no tenemos un mapa claro y consensuado de cómo deben ser las personas sanas (Leising *et al.*, 2009; Sadler & Fulford, 2006; Wakefield, 1992). Es decir, no contamos con un manual de uso común que englobe aquellos signos representativos de las sanidades. Si retomamos la idea de un marco conceptual común para la psicopatología y la salud, una propuesta de esta índole idealmente debería ser el “reverso” de cada uno de los síntomas patológicos enumerados en los DSM.

En principio debe decirse que idear un *manual de sanidades* nos llevaría necesariamente a recurrir a criterios valorativos e introducir una dimensión valórica en la personalidad (Leising *et al.*, 2009; Schwartz, 1992). Originalmente los rasgos de personalidad oficiaban como fuente primaria para la detección de diferencias individuales, tenían una connotación neutral y describían solamente cómo las personas eran (Nicholson, 1998). Las taxonomías vigentes de rasgos psicológicos, si bien son muy útiles, no incluyen una connotación valorativa que sirva al propósito comentado.

La psicología ha ignorado durante largo tiempo el estudio de los aspectos valorativos de la personalidad (e.g. carácter, virtudes, fortalezas, rasgos positivos). Los autores han preferido utilizar una terminología más neutral y menos valorativa para caracterizar las diferencias individuales entre las personas. No es sino de modo reciente que ha habido un creciente interés por parte de teóricos e investigadores en recuperar los conceptos vinculados con los rasgos psicológicos, como comentamos a lo largo de este capítulo.

Dentro de los modelos derivados de la teoría o de los expertos se puede destacar también el trabajo de Leising *et al.* (2009), quienes formularon criterios invertidos de cada uno de los criterios utilizados para el diagnóstico de trastornos de personalidad del DSM-IV-TR. De su estudio pudieron identificar 10 *clusters* de aspectos valorados como sanos o normales implícitos en el DSM. Para ello, tomaron los 79 criterios incluidos en los diagnósticos de trastornos de la personalidad tal como figuraban en el DSM-IV-TR y crearon enunciados que expresaban su opuesto semántico. Los autores encontraron ciertas dificultades en encontrar los opuestos ya que en muchos de ellos no alcanzaba simplemente con quitar la formulación negativa. Para esos casos debieron idear términos positivos. Recurrieron a 28 jueces que los agruparon de acuerdo con su similitud. Luego de un análisis jerárquico concluyeron que una agrupación de 10 clusters –que a la vez incluían 27 subclusters– era la más apropiada. Estos eran: (1) Ser autosuficiente e independiente, (2) Ser seguro de sí-mismo pero de un modo realista, (3) Llevarse

bien con los otros, (4) Tolerar la incertidumbre y la imperfección, (5) Buscar lo bueno de la gente, (6) Ser convencional, (7) Tener auto-control, (8) Conectarse con los otros emocionalmente y tratarlos de manera justa, (9) Disfrutar de las relaciones sociales y actividades, y (10) Ser confiable.

Por otra parte, Huppert y So (2013) buscaron generar una nueva medida de bienestar que denominaron *flourishing*. Para ello identificaron los opuestos a dos trastornos mentales comunes de acuerdo con el DSM-IV-TR: trastorno de ansiedad generalizada y trastorno depresivo mayor. Enumeraron todos los síntomas de esos trastornos y buscaron su versión positiva. Es decir, un enunciado que no solo hablara de la versión neutral del síntoma –de su ausencia–, sino que se refiriera a un aspecto positivo ubicado más allá de ese punto neutral. Luego de encontrar los enunciados opuestos, los agruparon en diez características positivas que combinaban *sentir* y *funcionar*. Si bien esta aproximación es muy reciente y novedosa no tomó en cuenta las variantes personológicas.

Retomando el continuo salud-enfermedad, se puede situar por un lado los rasgos normales de la personalidad y, por el otro, los rasgos patológicos propuestos en la Sección III del DSM-5. Sin embargo, la consideración de los rasgos normales de la personalidad no alcanza para describir el funcionamiento positivo de las personas. En un intento por dar respuesta a esta carencia, De la Iglesia y Castro Solano (2018 a y b) propusieron un modelo para evaluar *rasgos positivos de la personalidad* como los polos opuestos positivos de aquellos indicados en la nueva clasificación de trastornos de personalidad propuesta en el DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). El modelo fue diseñado en base a los indicadores de patología incluidos en el PID-5 (Krueger *et al.*, 2013). Los autores formularon las versiones positivas u opuestas de los 220 indicadores del PID-5 y sometieron el instrumento a distintos estudios psicométricos preliminares: estudio piloto, juicio experto, análisis de consistencia interna y estudios de validez externa con el mismo PID-5 y el BFI (John, Donahue & Kentle, 1991). Mediante diferentes procedimientos estadísticos realizados (análisis factoriales exploratorios y confirmatorios) y con amplias muestras de población no consultante de la Ciudad de Buenos Aires, cercanas a los 2000 participantes, se refinaron los indicadores propuestos, alcanzándose un instrumento de 60 ítems, que se denominó *Positive Traits Inventory (PTI-5)*. Se obtuvieron cinco rasgos positivos que operaban como continuos salugénicos o positivos de los rasgos patológicos de la personalidad propuestos por el DSM-5: serenidad, humanidad, integridad, moderación y vivacidad y foco. Los autores denominaron a este modelo *Positive Personality Model (PPM)*. Este modelo tiene validez incremental por sobre la predicción realizada con el modelo de los cinco factores de la personalidad respecto del bienestar psicológico y constituye el punto de partida para el abordaje de modo dimensional de una clasificación de las sanidades (De la Iglesia & Castro Solano, 2018b). Además, se ha verificado que los rasgos positivos del PPM predicen la *performance* y satisfacción laboral (De la Iglesia, Lupano Perugini & Castro Solano, 2019), el rendimiento y ajuste académico (de la Iglesia & Castro Solano, 2019a) y el estado de salud mental completa (De la Iglesia & Castro Solano, 2019b).

Tabla 4. Rasgos positivos de la personalidad (Positive Personality Model)

SERENIDAD	Gran capacidad de manejo de las emociones negativas propias y ajenas.	"Usualmente estoy tranquilo incluso cuando hay cosas que están fuera de mi control".
HUMANIDAD	Interés por el bienestar ajeno que motiva a acciones solidarias y de ayuda.	"Soy de ayudar a quienes están sufriendo".
INTEGRIDAD	Conductas de honestidad, humildad, sujetos confiables.	"No soy ni más ni menos importante que los demás".
MODERACIÓN	Ponderación de consecuencias y riesgos previos a la acción.	"Aunque se requiera cierta urgencia, siempre trato de pensar lo que voy a hacer".
VIVACIDAD Y FOCO	Metas vitales claras que se logran con éxito y se disfrutan.	"Cuando me propongo algo pongo toda mi atención en lograrlo".

A MODO DE CONCLUSIÓN

Hasta aquí hemos descripto la personalidad desde distintos enfoques teóricos y metodologías de análisis. La diferenciación entre rasgos normales o típicos, patológicos y positivos da cuenta de la necesidad de conceptualizar el constructo como un continuo en el que todos esos aspectos pueden ubicarse como polos más salugénicos o enfermos. Como mencionamos, el modelo médico guió gran parte del desarrollo de la psicología como ciencia, enfatizando la necesidad de identificar, clasificar y tratar los síntomas de enfermedad mental. Luego, las postulaciones de la psicología positiva trajeron a la luz el otro gran aspecto constituyente de la salud: los aspectos vinculados con el buen funcionamiento psicológico. Esto brindó una renovada visión hasta el momento dejada de lado, que las investigaciones empíricas ratificaron como sumamente importantes para el estudio científico de la psicología de los individuos. Sin embargo, el foco en los aspectos positivos desembocó, de alguna manera, en la misma carencia que el modelo médico tenía, el estudio exclusivo de un solo aspecto del fenómeno. ¿Qué ocurriría si estudiáramos ambos aspectos en conjunto? Los resultados hallados al momento que relacionan los rasgos patológicos y los rasgos positivos con distintos aspectos de la vida de las personas, ¿se sostendrían de estudiarse ambos rasgos en simultáneo? ¿Un modelo integral de la personalidad sería superador de los modelos separados de salud y enfermedad mental? En el siguiente capítulo se presenta un modelo teórico que pretende brindar una propuesta integradora de salud-enfermedad para el estudio de la personalidad: el Modelo Dual de la Personalidad.

4. Modelo Dual de la Personalidad

El Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad (ICCP)

Guadalupe de la Iglesia

Los *rasgos de la personalidad* pueden ser concebidos como constructos dimensionales que se presentan en mayor o menor medida en los individuos (valoración de los rasgos en término de gradiente). Su estudio desde una perspectiva dimensional nos permite analizarlos como un *continuum* en el que se pueden identificar versiones patológicas del rasgo y versiones sanas. Esta noción de continuo, que contempla tanto los aspectos patológicos y sanos en relación con los rasgos de la personalidad, no es nueva (Gunderson, 1979; Leary, 1957; Strack & Lorr, 1994). Dentro de las producciones teóricas y empíricas ligadas a esta idea, se puede decir que Millon (2011, 2012) ha sido su más ferviente defensor y divulgador.

Con la presentación de la quinta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013) se abrió camino a la evaluación dimensional de los rasgos patológicos de la personalidad. Tal como se describió en el capítulo 2, en la sección III del DSM-5 se propuso un modelo de *cinco rasgos patológicos* pasibles de ser estudiados dimensionalmente. Los rasgos patológicos que son parte de este modelo son: afecto negativo, desapego, antagonismo, desinhibición y psicoticismo (Krueger, Derringer, Markon, Watson, & Skodol, 2013). Partiendo de esta propuesta, y retomando la noción de continuo entre salud y enfermedad, De la Iglesia y Castro Solano (2018) propusieron un modelo de rasgos positivos que resultaba ser su espejo y que podía funcionar como una nosología de sanidad: el *Positive Personality Model* (PPM; véase capítulo 3). Los rasgos que componen el PPM son: serenidad, humanidad, integridad, moderación y vivacidad y foco. Con la nosología de sanidad propuesta con el PPM, se pudo integrar un modelo de rasgos positivos a un modelo de rasgos patológicos propuesto en el DSM-5.

EL MODELO DUAL DE LA PERSONALIDAD (MDP)

El modelo de rasgos patológicos y el de rasgos positivos resultan complementarios y necesarios para una valoración completa y confiable de los rasgos de la personalidad. Representan, de manera conjunta, la conceptualización de *continuo del rasgo*, y habilitan a una *evaluación dimensional* del grado de presencia de los rasgos de la personalidad. Esta visión integradora fue estudiada por De la Iglesia y Castro Solano

(2020) quienes postularon el *Modelo Dual de la Personalidad* (MDP). La noción central del MDP radica en que los rasgos de la personalidad pueden y deben ser valorados tanto en sus aspectos patológicos como en sus aspectos positivos de manera conjunta. Hacerlo así nos brindaría una noción del ajuste total de la personalidad ya que podríamos ponderar la presencia de ambos aspectos. Se obtiene así una noción integrada del funcionamiento total de la personalidad del sujeto en contraposición a una evaluación disociada.

La evaluación conjunta de patología y sanidad cuenta con precedentes en la evaluación de *sintomatología*. Debe recordarse aquí que, a diferencia de los rasgos, la sintomatología se asume como cambiante y menos estable en el tiempo. Modelos como el *Dual Factor Model* (Greenspoon & Saklofske, 2001) y el *Complete State Model of Health* (Keyes, 2005) dan cuenta de que los resultados son distintos cuando se evalúan síntomas y bienestar en conjunto que cuando se estudian por separado. Es decir, en las diversas investigaciones que se mencionan a continuación se ha hallado que los resultados obtenidos al analizarse las dimensiones de síntomas psicológicos, por un lado, y las dimensiones de signos de bienestar, por el otro, arrojan valores distintos a los resultados obtenidos al analizar ambos aspectos en conjunto. Esta valoración conjunta ha sido denominada por los autores como *estado de salud mental completa*. Se sabe que quienes poseen un estado de salud mental completa dado por la presencia de bienestar y la ausencia de sintomatología tienen menos chances de tener una enfermedad cardiovascular (Keyes, 2004), mejor salud física (Suldo & Shaffer, 2008), mejor rendimiento académico (Antamarian, 2015; Antamarian, Huebner, Hills & Valois, 2010; Guerra Vargas, 2017; Lyons, Huebner & Hills, 2012; Suldo & Shaffer, 2008; Suldo, Thalji & Ferron, 2011), menores problemas de conducta (Eklund, Dowdy, Jones & Furlong, 2010), entre otros.

El MDP postula que lo mismo ocurre en el terreno de los rasgos de la personalidad. Por ejemplo, no será lo mismo tener baja presencia de rasgos patológicos a la par de baja presencia de rasgos positivos, que tener baja presencia de rasgos patológicos a la par de alta presencia de rasgos positivos. En un nivel conceptual, los rasgos forman parte de un continuo en el que se pueden identificar versiones patológicas y sanas del constructo (véase Figura 1).

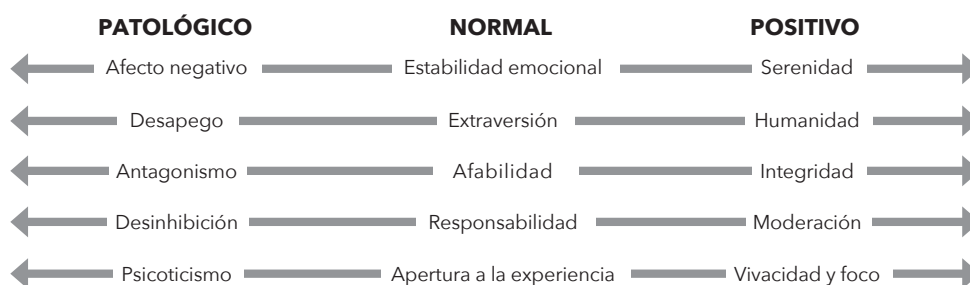


Figura 1. Continuos de rasgos de la personalidad

A nivel empírico, el continuo se debe estudiar como dos dimensiones unipolares asociadas. Es decir, no ubicaremos a un sujeto en un lugar del continuo, sino que valoraremos ambas dimensiones unipolares del continuo y las estudiaremos en conjunto para analizar así un **ajuste global de la personalidad** (véase Figura 2). De la

combinación de ambas dimensiones se pueden configurar distintos grupos de ajuste de la personalidad. El grupo de mayor ajuste es aquel conformado por quienes tienen una alta presencia de rasgos positivos y una baja presencia de rasgos patológicos. Este grupo se denomina *personalidad completamente sana*. Quienes presenten rasgos positivos pero también rasgos patológicos pertenecen al grupo *personalidad patológica compensada*. Los que presenten rasgos patológicos y baja presencia de rasgos positivos pertenecen al grupo *personalidad patológica*. Y, finalmente, quienes presenten baja presencia de rasgos patológicos y baja presencia de rasgos positivos pertenecen al grupo de *personalidad vulnerable*. Considerando los antecedentes en cuanto a los modelos integrados de síntomas y bienestar, se hipotetiza que tendrán mejor ajuste a nivel sintomático y en diferentes aspectos de la vida cotidiana quienes pertenezcan al grupo de personalidad completamente sana y, en menor grado, los del grupo de personalidad patológica compensada. Además, se hipotetiza que quienes presenten personalidad patológica tendrán graves dificultades en varios aspectos de la vida y quienes tengan personalidad vulnerable estarán más propensos a distintos tipos de sufrimiento.



Figura 2. Zonas de ajuste global de la personalidad

EL INVENTARIO DE LOS CINCO CONTINUOS DE LA PERSONALIDAD ICCP

El Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad (ICCP) es un instrumento especialmente diseñado para valorar los rasgos de la personalidad tanto en sus aspectos patológicos como en sus aspectos sanos de acuerdo con lo postulado por el MDP (De la Iglesia & Castro Solano, 2020). El ICCP cuenta con diferentes escalas globales y específicas que permiten describir la personalidad del evaluado así como también distintas escalas de validez que dan cuenta de la interpretabilidad del perfil.

Se trata de un inventario de 120 ítems que evalúa rasgos de personalidad positivos y patológicos mediante cinco continuos. Cada uno de los continuos tiene un polo positivo y uno patológico. La nosología utilizada está ajustada a la última propuesta del Manual

de Diagnóstico de los Trastornos Mentales en su quinta edición (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013).

El inventario encuentra entre sus ventajas el número reducido de ítems, lo que permite su aplicación en un tiempo relativamente corto (entre 15 y 30 minutos). Los 120 ítems se contestan con una opción Likert de seis posiciones que van desde 0 (*Totalmente en desacuerdo*) a 5 (*Totalmente de acuerdo*). Mediante ellos se pueden calcular diversas escalas para valorar la validez del protocolo, el ajuste global de la personalidad y, más específicamente, su perfil personalológico mediante las escalas específicas de personalidad.

Con esta nueva herramienta se logra describir la personalidad de los individuos de una manera integral considerándose tanto aspectos patológicos como salugénicos por separado y en conjunto. Sumado a ello, los resultados pueden emparentarse con aquella nosología propuesta por la última edición del DSM-5, por lo que el profesional cuenta así con una evaluación útil y actualizada a los estándares internacionales actuales.

En la siguiente tabla se encuentra una descripción breve de las escalas componentes del test. Para mayor detalle sobre la interpretación que se puede realizar a través de las mismas, véanse los capítulos 6 y 7 de este libro.

Tabla 1. Escalas del ICCP

ACRÓNIMO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
ESCALAS DE VALIDEZ		
AR	Ausencia de Respuesta	• Cantidad de respuestas no puntuables
INC	Inconsistencia	• Grado de respuesta aleatoria o inconsistente
MGPAT	Magnificación de Psicopatología	• Presencia de características patológicas infrecuentes
MNPAT	Minimización de Psicopatología	• Ausencia de características patológicas comunes
MGPOS	Magnificación de Rasgos Positivos	• Presencia de signos de bienestar infrecuentes
ÍNDICES GLOBALES		
IFP	Índice de Funcionamiento de la Personalidad	• Diagnóstico DSM-5 – Criterio A – Problemas de funcionamiento a nivel individual e interpersonal
IPAT	Índice de Rasgos Patológicos de la Personalidad	• Diagnóstico DSM-5 – Criterio B – Patrón habitual de conductas patológicas
IPOS	Índice de Rasgos Positivos de la Personalidad	• Patrón habitual de conductas sanas
IAP	Índice de Ajuste de la Personalidad	• Valoración integral de rasgos positivos y patológicos
IEXT	Índice de Conductas Externalizantes	• Tendencia a incurrir en conductas antisociales y desinhibidas
IINT	Índice de Conductas Internalizantes	• Tendencia a la emocionalidad negativa y al retraimiento

ESCALAS ESPECÍFICAS

Escalas Criterio A

FS	Funcionamiento del sí-mismo	• Dificultades con la propia identidad y las metas personales
FI	Funcionamiento interpersonal	• Carencia de empatía y dificultades para establecer vínculos íntimos

Continuos de rasgos de la personalidad

AF	Afecto negativo	• Patrón usual de emociones negativas incontroladas
SE	Serenidad	• Tranquilidad casi imperturbable
DA	Desapego	• Dificultad/desinterés para establecer vínculos y capacidad de disfrute
HU	Humanidad	• Interés por el bienestar ajeno, conductas solidarias, sensibilidad al entorno
AN	Antagonismo	• Conductas usuales de manipulación y engaño, sentimientos de superioridad
IN	Integridad	• Conductas de honestidad y humildad
DI	Desinhibición	• Tendencia a incurrir en conductas irresponsables, impulsivas y falta de concentración
MO	Moderación	• Tendencia a la planificación y ponderación de consecuencias antes de la acción
PS	Psicoticismo	• Distorsión en la percepción, experiencias de disociación y presencia de delirios
VF	Vivacidad y foco	• Facilidad para establecer metas, llevarlas a cabo con éxito y placenteramente

Los estudios psicométricos del ICCP fueron diversos (véase capítulo 5) y se ajustaron a las necesidades aplicadas del test y a los lineamientos internacionales del diseño de tests psicológicos (American Educational Research Association, American Psychological Association & National Council on Measurement in Education, 1999; Muñiz, Elosúa & Hambleton, 2013). El diseño de los ítems fue guiado por un criterio racional siguiendo la metodología *theory-driven* (véase capítulos 1 y 3). Sin embargo, se le dio suma importancia a que los modelos dimensionales teorizados contaran con un excelente soporte empírico dado por los resultados de los estudios psicométricos. Los ítems de las escalas específicas fueron redactados para reflejar las dimensiones que pretendían evaluar recurriendo a (a) las descripciones realizadas en el DSM-5 y en los manuales de medición de rasgos patológicos más utilizados para el caso de los rasgos patológicos; y (b) recurriendo a las conceptualizaciones de la psicología positiva, sus clasificaciones y antecedentes teóricos para el caso de los rasgos positivos. Todos ellos fueron sometidos a un juicio experto y a un estudio piloto para valorar su validez de contenido. Posterior a estos estudios iniciales, se generó una primera versión del instrumento que fue administrada a una muestra amplia de sujetos.

Para determinar qué ítems deberían componer cada una de las doce *escalas específicas* se realizaron distintos análisis factoriales exploratorios y confirmatorios. En todos los casos se obtuvo fundamentación empírica suficiente para el cálculo de las puntua-

ciones compuestas de las escalas específicas. El grado de consistencia interna de las escalas fue el esperado.

La construcción de los **índices globales** se basó en análisis factoriales confirmatorios que confirmaron dimensiones subyacentes a las puntuaciones compuestas calculadas. El ajuste de todos los modelos fue el esperado. La construcción del Índice de Ajuste de la Personalidad tuvo un tratamiento distinto. Este índice pretende reflejar la teoría propuesta por el Modelo Dual de la Personalidad (De la Iglesia & Castro Solano, 2020) en el que se propone abordar la evaluación de la personalidad desde una valoración integral de sus aspectos patológicos y sanos. Para su confección se tomó en cuenta la propuesta de Millon de un Índice de Ajuste tal como fue planteado en el caso del MIPS (Millon, 1997) y se la ajustó a las características particulares del ICCP.

Para el desarrollo de las escalas de validez se utilizaron estrategias diferenciales de acuerdo con el objetivo de la evaluación. En el caso de *Ausencia de Respuesta* se consideró que, tal como se estima en la mayoría de los inventarios de la personalidad, un porcentaje superior al 10% en cantidad de respuestas no puntuables era suficiente como para invalidar el perfil. Debe recordarse que se considera que una respuesta no es puntuable cuando el sujeto no eligió ninguna opción de respuesta o eligió múltiples opciones. Es por ello que protocolos con más de 12 respuestas no puntuables son considerados inválidos. Para la construcción de la escala *Inconsistencia* se analizó la matriz de correlaciones bivariadas de todos los ítems componentes del test. La escala quedó conformada por cinco pares positivos y cinco pares negativos que cumplieran con distintos criterios de correlación, distribución y frecuencia de inconsistencia. La escala *Magnificación de Psicopatología* quedó conformada por nueve ítems cuyo contenido es un aspecto patológico poco común o valorado como grave, que es infrecuente y tiene una alta correlación con el puntaje total del PID-5 (Góngora & Castro Solano, 2017) y con el IPAT. La escala *Minimización de Psicopatología* se conformó por siete ítems de síntomas más comunes que reflejan aspectos que cualquier persona estaría dispuesta a informar como levemente presente y que se asociaron a una medida externa de deseabilidad social (MCSDS; Cosentino & Castro Solano, 2008; Crowne & Marlowe, 1960). Finalmente, la escala de *Magnificación de Rasgos Positivos* incluye ocho ítems cuyo contenido son aspectos positivos no tan frecuentes porque son muy ideales y que la mayoría de las personas informa como no completamente de acuerdo en poseerlos. Estos ítems además tienen una alta correlación positiva con el puntaje total del MHC-SF (Keyes, 2005; Lupano Perugini, De la Iglesia, Castro Solano & Keyes, 2017) y el IPOS.

En el siguiente capítulo se brinda un mayor detalle de los estudios psicométricos y los resultados obtenidos en cada caso, y en los capítulos 6 y 7 se comenta la evaluación e interpretación del inventario.

5. Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad (ICCP)

Propiedades psicométricas

Guadalupe de la Iglesia, Alejandro Castro Solano y Mercedes Fernández Liporace

El Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad (ICCP) es un instrumento psicométrico destinado a operacionalizar el Modelo Dual de la Personalidad –MDP– (De la Iglesia & Castro Solano, 2020).

Tal como se vio en el capítulo anterior, mediante este test se pueden obtener medidas globales de ajuste total de la personalidad, así como también de cada rasgo patológico y positivo. Se podrá valorar de acuerdo al MDP si el evaluado se ubica en la zona de *personalidad patológica*, *personalidad vulnerable*, *personalidad patológica compensada* o *personalidad completamente sana*. Además, la herramienta cuenta con puntuaciones que evalúan posibles distorsiones de la respuesta y permiten valorar la validez del perfil obtenido.

A continuación se describen los estudios psicométricos realizados sobre el test.

DISEÑO DE ÍTEMS Y ESTUDIOS INICIALES

Los ítems que componen el ICCP fueron concebidos inicialmente mediante un criterio racional y siguiendo la metodología *theory-driven* (véanse capítulos 1 y 3). El pool inicial de ítems fue luego depurado de acuerdo con distintos análisis estadísticos que se describirán a continuación. Esto se hizo con el fin de darle un fuerte soporte empírico al modelo teórico que se pretendía operacionalizar.

La redacción de los ítems patológicos se inició con la consideración de las descripciones incluidas en el DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) para los cinco rasgos patológicos del modelo de Krueger, Derringer, Markon, Watson y Skodol (2013). Además se valoraron los aspectos evaluados por los inventarios de personalidad más utilizados a nivel mundial: MMPI-2-RF (Ben-Porath & Tellegen, 2008), PAI (Morey, 2007) y MCMI-IV (Millon, Grossman, & Millon, 2015). En el caso de los ítems positivos, estos provinieron del Inventario de Rasgos Positivos para el DSM-5 (IRP-5; De la Iglesia & Castro Solano, 2018). En la construcción del IRP-5 los ítems fueron generados a partir de la redacción del reflejo opuesto positivo a los ítems propuestos por el PID-5 (Krueger *et al.*, 2013). Luego, todos ellos fueron analizados mediante análisis factoriales y recurriendo a las clasificaciones de la psicología positiva para su interpretación.

La primera versión del test fue sometida a un juicio experto y a un estudio piloto para valorar su validez de contenido. Como resultado de ambas instancias se modificó la redacción de algunos ítems que resultaban confusos, se ajustó la redacción de la consigna y se simplificó la escala Likert para que solo valorara grado de acuerdo (previamente valoraba también grado de frecuencia). La versión obtenida a partir de esta instancia fue administrada a una muestra amplia de individuos que se describirá más adelante en este capítulo (véase Baremización).

ANÁLISIS DE LAS ESCALAS ESPECÍFICAS

Para determinar qué ítems deberían componer cada una de las escalas específicas se realizaron distintos análisis factoriales exploratorios (AFE) y confirmatorios (AFC). Para valorar la consistencia interna se calcularon alfas de Cronbach y alfas ordinales.

En el caso de las escalas del funcionamiento de la personalidad (Criterio A – DSM-5) se contaba con una muestra total de 342 casos que fue subdividida aleatoriamente en una submuestra A ($n = 171$) y una submuestra B ($n = 171$). La submuestra A fue utilizada para realizar un AFE. El método de estimación fue Minimum Rank Factor Analysis (MRFA) robusto con rotación varimax y sobre la base de la matriz policórica. La estructura factorial seleccionada de 12 ítems explicaba un 74.71% de la varianza y tenía un buen ajuste muestral, $KMO = .859$, $Bartlett(66) = 550.4$, $p < .001$. Todos los ítems tenían cargas factoriales superiores a .40 en un único factor y los factores tenían una excelente consistencia interna (véase tabla 1). El factor 1 representaba adecuadamente el *funcionamiento interpersonal* ya que sus ítems contemplaban la capacidad empatía y de intimidad. El factor 2 se correspondía con el *funcionamiento del sí-mismo* y tenía ítems que valoraban la identidad y la autodirección.

Tabla 1. Cargas factoriales de las escalas de funcionamiento de la personalidad (Criterio A)

	FACTOR 1	FACTOR 2
ÍTEM 5	.799	.097
ÍTEM 11	.195	.556
ÍTEM 19	.578	.315
ÍTEM 25	.665	.215
ÍTEM 32	.787	.379
ÍTEM 38	.708	.282
ÍTEM 43	.261	.745
ÍTEM 50	.305	.847
ÍTEM 88	.266	.437
ÍTEM 96	.144	.764
ÍTEM 112	.190	.463
ÍTEM 117	.565	.210
Varianza	38.1%	36.6%
Alfa de Cronbach	.792	.764
Alfa Ordinal	.799	.761

Luego, con la submuestra B, se calculó un AFC con el método de estimación robusto de Máxima Verosimilitud y sobre la matriz policórica por ser la más apropiada para el nivel de medida de las variables bajo análisis (Muthén & Kaplan, 1985; Freiberg Hoffmann, Stover, De la Iglesia & Fernández Liporace, 2013). Los índices de ajuste obtenidos reflejaban un excelente ajuste del modelo, Satorra-Bentler $\chi^2(54) = 93.75$, $p < .001$, CFI = .973, RMSEA = .066 (IC90% = .043 - .087). El rango de los pesos de regresión fue entre .43 y .83.

A continuación, para las escalas de rasgos patológicos (Criterio B – DSM-5) se dividió la muestra de baremización en dos submuestras: submuestra A ($n = 691$) y submuestra B ($n = 370$). Con la submuestra A se calculó un análisis factorial exploratorio con el método de estimación fue Minimum Rank Factor Analysis (MRFA) con rotación promin y sobre la base de la matriz policórica. La adecuación muestral fue la esperada $KMO = .894$, $Bartlett(1128) = 10337.9$, $p < .001$, y la estructura de cinco factores y 48 elementos explicaba el 57.22% de la varianza. Todos los ítems tenían cargas factoriales superiores a .40 en un único factor a excepción tres ítems que tenían cargas levemente inferiores (véase tabla 2). Dado su contenido y la valoración global de la estructura se decidió que era importante conservarlos. Los factores presentaban una adecuada consistencia interna. El factor 1 contenían ítems que evaluaban distorsiones en la percepción, experiencias disociativas y creencias inusuales por lo que se correspondía con el rasgo *psicoticismo*. El factor 2 contemplaba los aspectos del rasgo *desapego* ya que incluía ítems sobre aislamiento, introversión, evitación de la intimidad y anhedonia. En cuanto al factor 3 se lo denominó *afecto negativo* ya que sus ítems valoraban labilidad emocional, ansiedad, depresión, culpa, preocupación, catastrofismo, dependencia, inseguridad y agresividad. El factor 4 incluía ítems del rasgo *antagonismo* que evaluaban grandiosidad, engaño y manipulación. Finalmente, el factor 5 abarcaba ítems del rasgo *desinhibición* que se referían a impulsividad, irresponsabilidad y distractibilidad.

Tabla 2. Cargas factoriales de las escalas de rasgos patológicos

	FACTOR 1	FACTOR 2	FACTOR 3	FACTOR 4	FACTOR 5
ÍTEM 5	-.110	.023	.175	-.216	.581
ÍTEM 16	-.154	.058	.027	.620	-.028
ÍTEM 17	-.073	.157	.015	.041	.595
ÍTEM 23	.257	.036	-.316	-.014	.676
ÍTEM 28	.117	.192	-.305	.487	.081
ÍTEM 33	-.090	.105	.168	-.154	.674
ÍTEM 38	.011	-.187	.429	-.032	.341
ÍTEM 42	.139	.415	.125	-.171	.253
ÍTEM 56	.780	.038	-.031	-.109	.029
ÍTEM 58	.012	.113	.056	.050	.585
ÍTEM 59	.090	-.050	.695	-.015	.090
ÍTEM 60	.089	.142	.543	-.194	.144
ÍTEM 66	.073	.898	-.246	-.109	-.174
ÍTEM 69	.048	.641	-.033	.015	.180
ÍTEM 70	-.084	.143	-.034	.559	.248
ÍTEM 72	.693	.069	-.029	.049	.092

ÍTEM 80	.247	.135	.473	-.092	.063
ÍTEM 87	.191	.150	-.057	.495	-.137
ÍTEM 88	.554	.144	.101	.073	.058
ÍTEM 89	.116	-.028	.133	.526	.100
ÍTEM 112	.739	.099	-.168	-.038	.101
ÍTEM 115	.242	.134	.397	.187	.005
ÍTEM 116	-.052	.387	.012	.059	.157
ÍTEM 119	-.126	.054	.115	.647	-.150
ÍTEM 120	.675	-.029	.097	.056	-.049
ÍTEM 126	.046	.809	-.049	-.066	-.283
ÍTEM 127	-.007	-.357	.583	.122	.049
ÍTEM 128	-.076	-.052	.726	.154	.001
ÍTEM 129	-.068	.674	-.001	.098	.035
ÍTEM 132	.731	-.082	.153	-.107	-.018
ÍTEM 134	.868	-.119	.022	-.029	-.143
ÍTEM 137	.057	-.136	.212	.717	-.179
ÍTEM 142	.091	-.231	-.047	.250	.652
ÍTEM 154	-.170	.035	.415	-.104	.512
ÍTEM 159	.036	.385	.221	-.024	.068
ÍTEM 164	.132	.078	.537	.033	-.302
ÍTEM 171	.054	-.058	.534	.141	.106
ÍTEM 173	-.061	.119	.683	.050	-.037
ÍTEM 174	.005	.685	.095	-.084	.064
ÍTEM 177	.031	.191	.525	.015	-.138
ÍTEM 184	.763	-.084	.010	.049	.047
ÍTEM 185	.101	.181	.059	.415	.074
ÍTEM 188	-.209	.749	-.182	.087	.057
ÍTEM 196	.006	.435	.147	-.062	.254
ÍTEM 203	-.073	-.068	.734	.175	-.006
ÍTEM 204	.057	.079	.482	-.182	.253
ÍTEM 206	-.001	-.206	-.017	.242	.586
ÍTEM 209	.032	-.150	-.025	.644	.107
% Varianza	12.3	11.8	13.6	9.0	10.6
Alfa de Cronbach	.845	.817	.751	.779	.783
Alfa Ordinal	.835	.830	.858	.809	.823

Luego, se utilizó la submuestra B para realizar un AFC. El método de estimación utilizado fue Máxima Verosimilitud robusto y la matriz utilizada como *input* fue la policórica dada su mejor adecuación en el caso de variables ordinales (Freiberg Hoffmann *et al.*, 2013; Muthén & Kaplan, 1985). El modelo tenía un buen ajuste, Satorra-Bentler $\chi^2(1070) = 2037.20$, $CFI = .954$, $RMSEA = .049$ ($IC\ 90\% = .046 - .053$). Los pesos de regresión de los ítems oscilaron entre .39 y .82.

Como las escalas de rasgos positivos ya contaban con fuerte evidencia empírica en cuanto a su estructura factorial, se decidió realizar directamente un AFC. El método de estimación fue Máxima Verosimilitud y la matriz utilizada como *input* también fue la policórica. El ajuste del modelo fue el esperado, $\chi^2(1770) = 162017.12$, $CFI = .929$, $RMSEA = .080$ ($IC\ 90\% = .071 - .081$). Los pesos de regresión variaron entre .35 y .77. El grado de consistencia interna de las escalas fue para Serenidad = .86, Humanidad = .79, Integridad = .84, Moderación = .79, y Vivacidad y Foco = .90.

CONSTRUCCIÓN DE LOS ÍNDICES GLOBALES

La construcción de los Índices Globales se basó en AFC que confirmaban dimensiones subyacentes a las puntuaciones compuestas calculadas. En la tabla 3 se puede visualizar que en todos los casos los índices de ajuste fueron los esperados.

Tabla 3. Índices de ajuste: análisis factoriales confirmatorios de los índices globales

	χ^2	CFI	SRMR
IFP	179.86	.994	.000
IPAT	1512.43	.988	.024
IPOS	3234.06	.959	.043
IEXT	149.72	.993	.000
IINT	256.08	.996	.000

La construcción del Índice de Ajuste de la Personalidad tuvo un abordaje distinto. Este índice pretende reflejar la teoría propuesta por el Modelo Dual de la Personalidad (De la Iglesia & Castro Solano, 2020) en el que se propone abordar la evaluación de la personalidad desde una valoración integral que pondere tanto sus aspectos patológicos como sus aspectos sanos. Para su confección se tomó en cuenta la propuesta de Millon en el caso del MIPS (Millon, 1994) quien diseñó un Índice de Ajuste que integra rasgos deseables y no deseables en una única medida. En este caso, la fórmula utilizada fue similar:

$$IAP = \left(\frac{SE - \bar{x}_{SE}}{\sigma_{SE}} + \frac{HU - \bar{x}_{HU}}{\sigma_{HU}} + \frac{IN - \bar{x}_{IN}}{\sigma_{IN}} + \frac{MO - \bar{x}_{MO}}{\sigma_{MO}} + \frac{VF - \bar{x}_{VF}}{\sigma_{VF}} \right) - \left(\frac{AF - \bar{x}_{AF}}{\sigma_{AF}} + \frac{DA - \bar{x}_{DA}}{\sigma_{DA}} + \frac{AN - \bar{x}_{AN}}{\sigma_{AN}} + \frac{DI - \bar{x}_{DI}}{\sigma_{DI}} + \frac{PS - \bar{x}_{PS}}{\sigma_{PS}} \right)$$

Para probar su funcionamiento se realizó un análisis de conglomerados jerárquico utilizando el método de Ward y la distancia euclídea al cuadrado. Las variables bajo análisis fueron el **IPOS** y el **IPAT**. Con el resultado de este análisis se pudo determinar el número adecuado de *clusters* que maximizaba la diferencia entre los grupos y minimizaba las diferencias intragrupalas. De acuerdo con el historial del coeficiente de conglomeración y el dendograma se determinó que una solución de cuatro conglomerados era adecuada. Como siguiente paso se calculó un análisis de conglomerados de *k* medias en el que se solicitaron 4 *clusters*. Los ANOVAs indicaron que existían diferencias estadísticamente significativas en **IPOS** y en **IPAT** de acuerdo con la pertenencia al *cluster* ($p < .01$). Un análisis de las medias indicaba que los niveles de **IPOS** y en **IPAT** en cada *cluster* se podían interpretar de acuerdo al Modelo Dual de la Personalidad (MDP): un *cluster* tenía baja presencia de rasgos patológicos y alta presencia de rasgos positivos, constituyendo el *cluster* de personalidad completamente sana; el segundo tenía baja presencia de rasgos positivos y alta de rasgos patológicos, configurando el perfil de personalidad patológica; el tercero tenía baja presencia de rasgos positivos y de rasgos patológicos, coincidiendo con el diagnóstico de personalidad vulnerable;

y el cuarto *cluster* que se correspondía con el perfil de personalidad patológica, compensaba ya que tenía presencia tanto de rasgos positivos como patológicos. Como paso final se buscó si había diferencias estadísticamente significativas en el **IAP** de acuerdo con el *cluster*, de pertenencia. Los resultados fueron estadísticamente significativos, $F(3, 1057) = 448.59, p < .01$, y la prueba a posteriori indicó que Índice de Ajuste de la Personalidad presentaba valores *in crescendo* en el siguiente orden ($p < .01$): *personalidad patológica, personalidad vulnerable, personalidad patológica compensada y personalidad completamente sana*.

DESARROLLO DE LAS ESCALAS DE VALIDEZ

El desarrollo de las escalas de validez contó con diferentes etapas en las que se pusieron en marcha estrategias diferenciales de acuerdo con el objetivo de la evaluación. En el caso de la escala *Ausencia de respuesta*, por ejemplo, al momento de determinar qué porcentaje de respuestas era el mínimo necesario como para que el protocolo sea interpretable, se evaluó en primera instancia la tendencia utilizada en los inventarios de personalidad usados internacionalmente (Ben-Porath & Tellegen, 2008; Millon *et al.*, 2015; Morey, 2007). En la mayoría se estima que un porcentaje superior al 10% de respuestas impuntuables es suficiente para invalidar el perfil. Se considera que una respuesta es impuntuable cuando el sujeto no eligió ninguna opción de respuesta o eligió múltiples opciones. Es por ello que dado que el test cuenta con un total de 120 reactivos, protocolos con más de 12 respuestas impuntuables deben ser considerados inválidos.

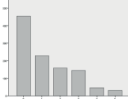
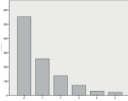
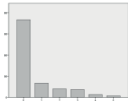
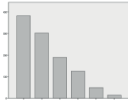
La construcción de la escala *Inconsistencia* requirió de un abordaje más complejo. Como primer paso se calculó la matriz de correlaciones bivariadas de todos los ítems componentes del test. A partir de su estudio se seleccionaron las correlaciones positivas o negativas altas ($r > .35$) y que fueran estadísticamente significativas ($p < .05$). Luego, se analizó el contenido de los ítems para verificar si tenía sentido que pertenecieran a un par de inconsistencia positivo/negativo. En el caso de los pares positivos, se esperaba que el contenido reflejara aspectos similares pero con otras palabras, y en el caso de los negativos, se esperaba que el contenido reflejara aspectos opuestos de una misma cuestión. Además, los ítems seleccionados debían pertenecer a un único par. Para evaluar la presencia de inconsistencia se calculó la diferencia en valores absolutos entre los puntajes de cada par de ítems. En el caso de los positivos, se consideró presencia de inconsistencia a la diferencia de 3 puntos o más, y en el caso de los negativos, la diferencia debía ser de 0 (cero). Sumado a ello, la frecuencia de inconsistencia para cada par debía ser baja ($< 15\%$) en la muestra estudiada. La escala de inconsistencia quedó conformada por cinco pares positivos y cinco pares negativos que cumplían con todos los criterios establecidos (véase tabla 4).

Tabla 4. Ítems de la escala Inconsistencia

ÍTEM 1	ÍTEM 2	CORRELACIÓN ENTRE ÍTEMS	FRECUENCIA DE INCONSISTENCIA
PARES POSITIVOS			
ÍTEM 40	ÍTEM 98	.548	6.4%
ÍTEM 108	ÍTEM 29	.516	8.1%
ÍTEM 007	ÍTEM 65	.511	9%
ÍTEM 019	ÍTEM 31	.486	12.4%
ÍTEM 126	ÍTEM 66	.485	13.3%
PARES NEGATIVOS			
ÍTEM 3	ÍTEM 42	-.440	8.7%
ÍTEM 128	ÍTEM 208	-.431	12.7%
ÍTEM 192	ÍTEM 33	-.398	13.9%
ÍTEM 154	ÍTEM 1	-.373	13.4%
ÍTEM 204	ÍTEM 157	-.357	13.3%

Para el diseño de la escala *Magnificación de Psicopatología* se analizaron todos los ítems del ICCP que medían psicopatología. En una primera selección se identificaron aquellos que tenían una alta correlación positiva con el **IPAT** y con el puntaje total del PID-5 (Góngora & Castro Solano, 2017). Además, cada ítem debía tener una marcada asimetría a derecha, indicando que pocos sujetos elegían la opción *completamente verdadero* de la escala Likert. Esto también se debía reflejar en el contenido que debía ser un aspecto patológico poco común o que fuera valorado como grave. Por último, ninguno de los ítems seleccionados podía pertenecer a la escala de *Minimización de Psicopatología*. La escala quedó conformada por nueve ítems que cumplían con esos criterios (véase tabla 5).

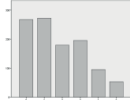
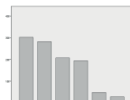
Tabla 5. Ítems de la escala Magnificación de Psicopatología

CONTENIDO	CORRELACIÓN CON IPAT	CORRELACIÓN CON PID-5-SF	DISTRIBUCIÓN
ÍTEM 60	.490**	.387**	
ÍTEM 58	.494**	.401**	
ÍTEM 42	.501**	.383**	
ÍTEM 88	.519**	.386**	
ÍTEM 129	.535**	.367**	
ÍTEM 59	.542**	.409**	
ÍTEM 196	.544**	.433**	
ÍTEM 69	.573**	.433**	
ÍTEM 80	.583**	.422**	

Los ítems de esta escala fueron seleccionados a partir del análisis de los ítems patológicos que no hubieran sido seleccionados para la escala *Magnificación de Psicopatología*. Los ítems debían tener un contenido que reflejase un aspecto que cualquier persona estaría dispuesta a informar como levemente presente y su distribución asimétrica a derecha no debía ser sumamente marcada. Además, se esperaba que tuvieran una correlación negativa con una medida externa de discapacidad social (MCSDS;

Cosentino & Castro Solano, 2008; Crowne & Marlowe, 1960).¹ Esta escala quedó constituida por siete ítems (véase tabla 6).

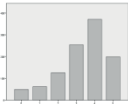
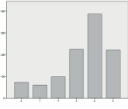
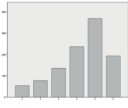
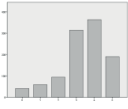
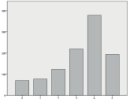
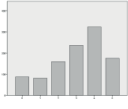
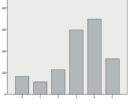
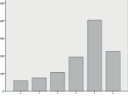
Tabla 6. Ítems de la escala Minimización de Psicopatología

CONTENIDO	CORRELACIÓN CON MCSDS	DISTRIBUCIÓN
ÍTEM 128	-.318**	
ÍTEM 16	-.294**	
ÍTEM 154	-.292**	
ÍTEM 17	-.291**	
ÍTEM 119	-.268**	
ÍTEM 204	-.250**	
ÍTEM 173	-.243**	

Finalmente, para la confección de la escala *Magnificación de Rasgos Positivos* se estudiaron los ítems positivos. Se buscó aquellos ítems en los que la asimetría fuera a izquierda por su característica positiva, pero en los que la opción más frecuente de respuesta no fuera *completamente verdadero*. Estos ítems deberían ser bastante ideales y este tipo de distribución indicaría que no tantas personas eligieron la opción *completamente verdadero*. Además debían tener una alta correlación positiva con el **IPOS** y con una medida externa de bienestar: el MHC-SF (Keyes, 2005; Lupano Perugini, De la Iglesia, Castro Solano & Keyes, 2017). Ocho ítems cumplían con estos criterios (véase tabla 7).

1. Luego, al calcularse la puntuación compuesta de esta escala y transformarla a una puntuación estandarizada, las correlaciones con una escala de deseabilidad social deberían ser positivas ya que el baremo está invertido para que, a mayor puntaje estandarizado (equivalente a menor puntuación bruta), mayor minimización de síntomas, es decir, mayor deseabilidad social.

Tabla 7. Ítems de la escala Magnificación de Rasgos Positivos

CONTENIDO	CORRELACIÓN CON IPOS	CORRELACIÓN CON MHC	DISTRIBUCIÓN
ÍTEM 210	.571**	.465**	
ÍTEM 133	.565**	.342**	
ÍTEM 114	.559**	.390**	
ÍTEM 195	.521**	.331**	
ÍTEM 157	.479**	.345**	
ÍTEM 192	.552**	.222**	
ÍTEM 215	.443**	.202**	
ÍTEM 15	.488**	.230**	

BAREMIZACIÓN

Para la baremización realizada en 2019 se utilizó una muestra compuesta por 1061 sujetos de edad promedio 39.87 años ($DE = 14.68$, $Mín = 18$, $Máx = 95$) residentes de Argentina. El 51% eran varones y el 49% restante eran mujeres. En cuanto al nivel de estudios, el 22.7 informó tener estudios de nivel de secundario completo o inferior, el 34.4% tenía estudios universitarios incompletos o en curso, y el 42.9% tenía un nivel de estudios de universitario/terciario completo o superior. La mayoría de ellos (64%) informó tener un nivel socio-económico (NSE) medio, el 19.9% dijo tener un NSE medio-alto, y el 13.3% un NSE medio-bajo, el 1.9% NSE alto y el 0.9% NSE bajo.

Con los datos obtenidos en la muestra se calcularon puntuaciones T lineales para cada una de las puntuaciones compuestas pasibles de ser calculadas. Para el cálculo de las puntuaciones T lineales se utilizaron los valores de medias y desviaciones estándar de cada una de las puntuaciones directas obtenidas en la muestra de baremización. Las puntuaciones T tienen una media centrada en 50 y una desviación estándar de 10 puntos. El uso de puntuaciones T lineales ha sido en ocasiones cuestionado (Friedman, Bolinsky, Levak, & Nichols, 2015). El debate en general ronda alrededor de que las mismas puntuaciones T en las distintas escalas no se corresponden con los mismos percentiles. Esto conllevaría que los puntos de interpretación de cada escala (e.g. T60, T80) no sean equivalentes a nivel del percentil. Sin embargo, este fenómeno de discrepancias entre percentiles y puntajes T a lo largo de las distintas escalas es natural y esperado en cualquier tipo de distribución diferente a la curva normal. En el caso de las variables psicológicas más usualmente medidas, la distancia de la distribución normal es el fenómeno más frecuente. Particularmente en los constructos patológicos las distribuciones frecuentes son asimétricas a derecha, y en el caso de los constructos positivos las distribuciones más usuales son asimétricas a izquierda. Forzar esas distribuciones a una distribución normalizada resultaría artificial y poco representativo de la realidad. Es por ello que en el caso del ICCP se consideró que el uso de T lineales era el más adecuado ya que como señaló Morey (2018) resulta ser la alternativa más parsimoniosa y, además, la distribución de T lineales implica una representación exacta de cómo se distribuye la variable en la población con la que se quiere comparar al sujeto evaluado.

De todos modos, a fines informativos se presentan los percentiles correspondientes con los puntajes de corte de T más comúnmente utilizados. Se puede visualizar que existe una aceptable concordancia entre las escalas patológicas por un lado, y las positivas por el otro (véase tabla 8).

Tabla 8. Percentiles correspondientes a puntuaciones T lineales

	T10	T20	T30	T40	T50	T60	T70	T80	T90
FS				13	60	80	95	99	
FI				1	59	81	94	99	
AF			1	16	50	84	97	99	
SE			4	17	42	82	99		
DA				14	53	83	96	99	
HU			4	15	45	80	99		
AN				17	48	82	97	99	
IN	1	3	5	14	40	86			
DI				17	50	83	96	99	
MO			3	16	47	83	99		
PS				38	62	86	94	98	99
VF		1	4	15	41	85	99		



IFP			11	62	84	95	99
IPAT		1	16	55	83	97	99
IPOS	1	5	14	43	87	99	
IAP		3	17	84	97	99	
IEXT		1	18	54	83	94	99
IINT		1	16	54	83	97	99
INC		1	27	63	87	96	99
MGPAT			17	55	84	96	99
MNPAT		97	85	51	18	1	
MGPOS		4	17	40	81	99	

Actualmente, los inventarios de personalidad de mayor uso en el mundo no presentan normas diferenciadas por sexo (e.g. Ben-Porath & Tellegen, 2008; Morey, 2007). Al respecto, Hathaway y Briggs (1957) así como Tellegen, Butcher y Hoeglund (1993) indicaron que la diferenciación de baremos por sexo estaría justificada en el caso de la presencia de diferencias en las puntuaciones directas de al menos dos desviaciones típicas. En el ICCP esto no ocurría en ninguno de los casos. Sumado a ello, la diferenciación de baremos de acuerdo al sexo conllevaría la pregunta acerca de por qué no sería necesario confeccionar baremos de acuerdo a otras características humanas tales como edad, raza, estado civil, nivel educativo, profesión, por sólo mencionar algunas. Una decisión en este sentido complejizaría la obtención de muestras representativas que combinen todas esas variables de manera equitativa y, probablemente, no aportarían demasiado a la descripción del sujeto evaluado, corriéndose el riesgo incluso de incurrir en conductas innecesariamente discriminatorias (Ben-Porath & Forbey, 2003). En el capítulo siguiente se especifican las normas de administración, puntuación e interpretación del ICCP.

6. Administración y Puntuación del ICCP

Guadalupe de la Iglesia

DESCRIPCIÓN DEL ICCP

El Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad (ICCP) es un instrumento que evalúa rasgos de personalidad patológicos y positivos mediante el análisis de cinco continuos de rasgos. Cuenta con 120 ítems, que se contestan con una opción Likert de seis posiciones que va desde 0 (*Totalmente en desacuerdo*) a 5 (*Totalmente de acuerdo*). El inventario es una operacionalización del Modelo Dual de la Personalidad postulado por De la Iglesia y Castro Solano (2020). Las puntuaciones obtenidas mediante este test brindan información acerca de la personalidad del evaluado desde una percepción holística que incluye aspectos sanos y enfermos. La nosología utilizada en el ICCP refleja la última propuesta del Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales en su quinta edición (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013). El ICCP ofrece una evaluación integral de la personalidad teniendo en cuenta los estándares internacionales actuales.

El ICCP es un test que puede ser administrado en forma *manual*, con lápiz y papel, y también en forma digitalizada mediante un sistema *on line*. En ambos casos, sea mediante la corrección manual o la versión *on line* del test se pueden obtener puntuaciones que representarán el grado de presencia de los rasgos de manera desagregada (*escalas específicas*) y de manera global (*índices globales*). También es posible evaluar la eventual distorsión de respuesta por parte de sujetos que hayan intentado mostrarse de manera más favorable o desfavorable ante el evaluador (*escalas de validez*). En todos los casos se obtienen puntuaciones brutas que se transforman en puntuaciones T mediante un baremo. Estos puntajes se vuelcan en un perfil en el que el evaluador podrá discriminar visualmente el grado de presencia de esos aspectos y su interpretación diagnóstica mediante zonas con distintas tonalidades de grises (véase Figura 1). Los grises claros y las zonas blancas indican salud y los grises oscuros son indicadores de patología.

ICCP

Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad
 de la Iglesia & Castro Solano (2020)

PERFIL

NOMBRE:

EDAD:

SEXO:

NIVEL EDUCATIVO:

NACIONALIDAD:

ESTADO CIVIL:

PB T

20 30 40 50 60 70 80 90 100

ESCALAS DE VALIDEZ	
Ausencia de Respuesta	AR
Inconsistencia	INC
Magnificación de Psicopatología	MGPAT
Minimización de Psicopatología	MNPAT
Magnificación de Rasgos Positivos	MGPOS

ÍNDICES GLOBALES	
Índice de Funcionamiento de la Personalidad (DIAGNÓSTICO DSM-5 - CRITERIO A)	IFP
Índice de Rasgos Patológicos de la Personalidad (DIAGNÓSTICO DSM-5 - CRITERIO B)	IPAT
Índice de Rasgos Positivos de la Personalidad	IPOS
Índice de Ajuste de la Personalidad	IAP
Índice de Conductas Externalizantes	IEXT
Índice de Conductas Internalizantes	IINT

ESCALAS ESPECÍFICAS	
<i>Escala Criterio A</i>	
Funcionamiento del Sí-mismo	FS
Funcionamiento Interpersonal	FI
<i>Continuos de rasgos de la personalidad</i>	
Afectividad Negativa	AF
Serenidad	SE
Desapego	DA
Humanidad	HU
Antagonismo	AN
Integridad	IN
Desinhibición	DI
Moderación	MO
Psicoticismo	PS
Vivacidad y Foco	VF

Figura 1. Perfil del ICCP

ESCALAS DE VALIDEZ

Uno de los mayores inconvenientes encontrados al momento de utilizar un test psicométrico autoadministrable, es la posibilidad de que sujeto distorsione respuestas para mostrarse de manera favorable o desfavorable. Es decir que, por efecto de la deseabilidad social o el temor a algún tipo de consecuencia potencial que podría tener el resultado de la evaluación, quienes responden a los ítems lo hagan tergiversando sus respuestas. Esta tendencia puede ser fácilmente detectada por el ICCP, gracias a las denominadas *escalas de validez*. Las escalas de validez del instrumento brindan información acerca de la posible invalidez del perfil de personalidad obtenido. La invalidez de un perfil puede deberse a: (a) que el evaluado no haya brindado suficiente información, (b) que haya respondido al azar y existan respuestas contradictorias entre sí, y (c) que haya intentado mostrar una imagen positiva o negativa de sí mismo mediante la distorsión de respuestas. El ICCP cuenta con cinco escalas de validez.

La escala **Ausencia de Respuesta (AR)** informa acerca de la cantidad de respuestas no puntuables, es decir, cuanta información está ausente en el perfil. La escala **Inconsistencia (INC)** nos indicará qué tan inconsistentes o contradictorias han sido las respuestas obtenidas. La escala **Magnificación de Psicopatología (MGPAT)** se verá aumentada con la presencia de síntomas patológicos infrecuentes que podrían indicar que el sujeto está mostrando una imagen sumamente desfavorable de sí mismo o que padece una patología grave. Por el contrario, la escala **Minimización de Psicopatología (MNPAT)** se elevará cuando el evaluado haya contestado con alta deseabilidad social, indicando que no informó como presentes aspectos patológicos de baja gravedad y bastante frecuentes en la población general. Por último, la escala **Magnificación de Rasgos Positivos (MGPOS)** nos informará acerca de una sobredimensión de los aspectos positivos, lo que podría indicarnos un intento por dar una imagen favorable de sí mismo. Estos elementos deben ser analizados como paso previo ineludible antes de la interpretación de las otras escalas.

En el ejemplo que figura a continuación podemos ver que no hay indicios de que el sujeto haya respondido al azar (**INC** dentro de la zona gris claro), tampoco hay indicios de que haya intentado mostrar una imagen desfavorable de sí mismo (**MGPAT** dentro de la zona gris claro), pero las puntuaciones de las escalas **MNPAT** y **MGPOS** sugieren que el sujeto intentó brindar una imagen en extremo favorable de sí mismo ya sea por no informar como presentes aspectos patológicos leves y comunes (**MNPAT** dentro de la zona de gris oscuro) o por exagerar la presencia de aspectos positivos (**MGPOS** dentro de la zona gris oscuro)

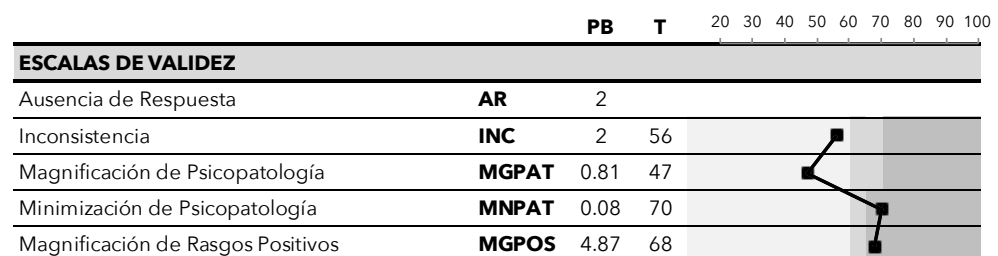


Figura 2. Ejemplo de escalas de validez

ÍNDICES GLOBALES

Los índices globales del ICCP brindan una información inicial y general acerca del perfil psicológico del evaluado. La escala *Índice de Funcionamiento de la Personalidad (IFP)* no indicará acerca del llamado Criterio A del DSM-5 que refiere al funcionamiento individual e interpersonal del evaluado. Una elevación podría estar representando la presencia de uno o más trastornos de la personalidad. Esta información deberá contrastarse con el resto de los resultados del test y con otros criterios diagnósticos externos. En el caso del *Índice de Rasgos Patológicos de la Personalidad (IPAT)*, su elevación nos habla de una presencia inusual de aspectos patológicos de la personalidad. Al ser una medida global, su evaluación deberá siempre estar complementada por la valoración de las escalas específicas de rasgos patológicos ya que el **IPAT** resume todas las otras puntuaciones de rasgos patológicos y podría no representar adecuadamente alguna puntuación específica que resulte de interés. Lo mismo ocurre con el *Índice de Rasgos Positivos de la Personalidad (IPOS)* que informará acerca del nivel de presencia en términos globales de aspectos positivos de la personalidad. El *Índice de Ajuste de la Personalidad (IAP)* es un índice global sumamente interesante ya que combina en una única medida la ponderación de los rasgos positivos y patológicos en conjunto. Su evaluación ubicará al sujeto dentro de la zona de diagnóstico de **personalidad patológica, personalidad vulnerable, personalidad patológica compensada o personalidad completamente sana**. Finalmente, los índices **IEXT** (*Índice de Conductas Externalizantes*) e **IINT** (*Índice de Conductas Internalizantes*) son medidas resumen sobre la tendencia a incurrir en conductas antisociales y/o desinhibidas, por un lado, y sobre la tendencia a experimentar emociones negativas y retraimiento, por otro.

En el ejemplo que presentamos a continuación podemos ver que el evaluado no parece tener un funcionamiento disfuncional de la personalidad (**IFP** en zona gris claro) aunque presenta rasgos patológicos en un grado superior al esperado (**IPAT** en zona gris intermedio). Además, sus rasgos positivos están en déficit (**IPOS** en zona gris oscuro). Ambos aspectos se ven reflejados en el **IAP** que ubica al sujeto en la zona de *personalidad patológica* (gris oscuro). De los rasgos patológicos puede visualizarse que los problemas se encuentran en las conductas internalizantes (**IINT** en zona gris oscuro) más que en las conductas externalizantes (**IEXT** en zona gris claro).



Figura 3. Ejemplo de índices globales

ESCALAS ESPECÍFICAS

La evaluación de las escalas específicas comienza por el análisis de las escalas específicas del Criterio A: **Funcionamiento del sí-mismo (FS)** y **Funcionamiento interpersonal (FI)**. Mediante ellas se podrá valorar si existen dificultades en cuanto a la propia identidad y los objetivos de vida, además de la presencia de empatía y dificultades en los vínculos interpersonales.

Luego se deben evaluar los continuos de rasgos. El continuo **Afecto negativo – Serenidad** nos informará acerca del manejo de las emociones negativas propias y ajenas.

El continuo **Desapego – Humanidad** se refiere al interés por los otros.

El continuo **Antagonismo – Integridad** evalúa la tendencia a incurrir en conductas antisociales u honestas.

El par **Desinhibición – Moderación** informará sobre el control de los impulsos y la planificación del comportamiento.

Y finalmente, el par **Psicoticismo – Vivacidad y Foco** no indicará acerca de la inmersión del sujeto en la realidad circundante: ésta podrá ser extraña por la presencia de experiencias y percepciones inusuales; o podrá ser agradable por la evaluación exitosa de su entorno con un consecuente dominio del mismo.

Del ejemplo que figura a continuación se visualiza que en este caso no existen problemas de funcionamiento a nivel individual ni interpersonal (zona gris claro en ambos casos). El rasgo Afecto negativo se encuentra elevado por sobre lo esperado (zona gris oscuro) y el rasgo Serenidad disminuido (zona gris oscuro). Es por ello que se puede interpretar con bastante certeza que el evaluado experimenta con asiduidad grandes emociones negativas y que éstas le resultan incontrolables. Tanto el rasgo Desapego como el rasgo Humanidad se encuentran dentro de los valores esperados (zonas gris claro) por lo que podemos inferir que el evaluado tiene un grado esperado de interés

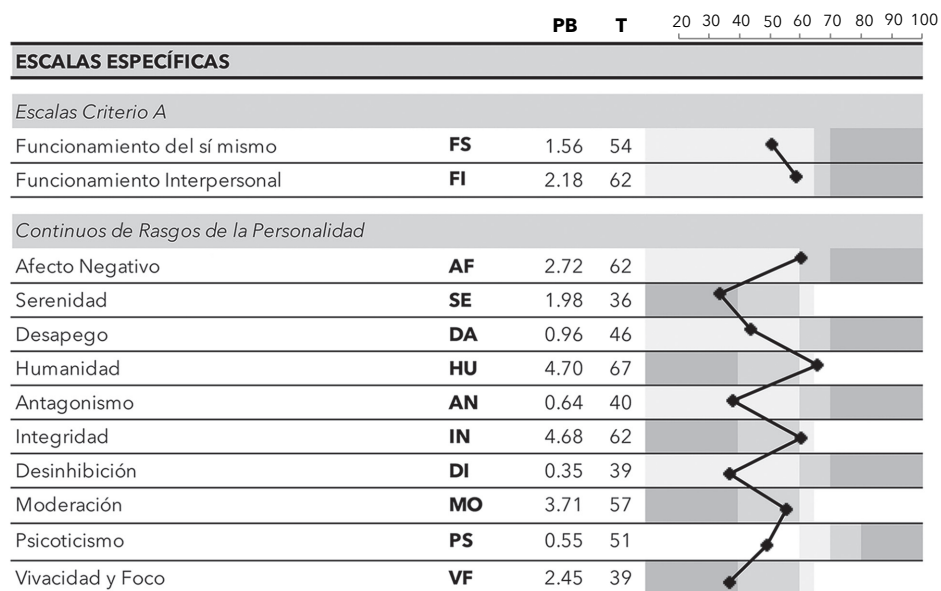


Figura 4. Ejemplo de escalas específicas

en cuanto a la vinculación con quienes los rodean. Lo mismo ocurre con el continuo *Antagonismo-Integridad*, lo que nos da pauta de que el evaluado se maneja de manera honesta en sus vínculos, aunque esto no es algo por lo que se destaque en demasía (ambos en zona gris claro). Del continuo *Desinhibición-Moderación* podemos interpretar que no existe riesgo de incurrir en conductas impulsivas o poco planificadas que impliquen algún tipo de riesgo. Finalmente, el evaluado no informó experimentar o tener creencias inusuales (**PS** en zona gris claro) y se visualizan dificultades para establecer metas claras y realistas y llevarlas a cabo con éxito, concentración y placer (**VF** en zona gris oscuro).

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL TEST

Desde la perspectiva de su diseño, el Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad (ICCP) está pensado para ser utilizado en diversos ámbitos de aplicación en los que sea necesaria la evaluación de la personalidad en sujetos adultos: forense, laboral, clínico, comunitario, entre otros. Mediante las escalas mencionadas anteriormente con el ICCP se podrá describir el modo usual de pensar, sentirse y comportarse del evaluado. Es por ello que el ICCP será útil en cualquier ámbito en el que uno de los objetivos de evaluación psicológica radique en la descripción de esos aspectos. El ICCP debería ser de especial utilidad en aquellas evaluaciones psicológicas en las que exista mayor posibilidad de distorsión de respuesta. Esta tendencia será fácilmente detectada mediante las escalas de validez del ICCP. Como se ejemplificó anteriormente, las puntuaciones globales darán cuenta de la tendencia general en cuanto a los aspectos patológicos y los positivos, así como también sobre la valoración conjunta de ambos aspectos. Con las escalas específicas se podrán describir los continuos de patología-salud de cada rasgo evaluado.

INDICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TEST

El ICCP fue diseñado para ser administrado en sujetos que cumplan con los siguientes requisitos:

- (1) contar con 18 años o más de edad,
- (2) haber completado estudios primarios completos,
- (3) no tener un impedimento psicológico o físico que impida comprender la consigna o contestar al test en su formato de papel y lápiz o en su formato digitalizado.

A todos los sujetos a los que se le administre el ICCP se les debe informar el objetivo de la evaluación y el uso que se le darán a los datos obtenidos. También se debe garantizar que se mantendrá la confidencialidad de los protocolos de evaluación, y se debe manifestar que el evaluado tiene derecho a conocer los resultados del test en una instancia de devolución si así lo desea.

La administración del ICCP podrá estar a cargo de individuos que hayan sido entrenados para la tarea de acuerdo con las pautas aquí delineadas, con diversos niveles de formación. Sin embargo, las tareas de puntuación e interpretación solo podrán llevarse

a cabo por quienes cuenten con una titulación de nivel universitario en materia de Psicología o Psiquiatría. Además, el profesional evaluador deberá contar con amplios conocimientos sobre las teorías de la personalidad que fundamentan el test y sobre la evaluación psicológica en general. Se espera que en la utilización del ICCP se sigan las normas internacionales vigentes de *buenas prácticas* en el uso de tests (International Test Commission, 2001).

El ICCP se encuentra protegido por los derechos de autor. La responsabilidad en el uso del material de la prueba está a cargo de los profesionales que acceden a este material, quienes deberán velar por su buen uso y por el mantenimiento de la confidencialidad del instrumento (International Test Commission, 2001). El profesional a cargo de la evaluación es responsable de la seguridad de los materiales al momento de administración de la prueba (e.g. resguardar que los sujetos no tomen fotos a los materiales, prohibir que los evaluados se lleven los materiales de la prueba para contestarlos en otro lugar) y luego en el archivo de los resultados (e.g. cuidar que nadie acceda a los protocolos e informes generados manual o digitalmente).

Tanto la administración manual como la digital insume un tiempo de **aproximadamente 30 minutos**. La toma debe ser idealmente individual aunque también puede ser colectiva siempre que se conserven las pautas ambientales mínimas necesarias. El ambiente de administración deberá ser iluminado, silencioso y libre de distracciones. En el caso de las tomas colectivas se debe intervenir las veces que sean necesarias para garantizar que los evaluados contesten el test individualmente y no conversen con otros evaluados. El sujeto deberá poder contestar el test en el tiempo que su ritmo de respuesta le permita y sin interrupciones. Será importante que el evaluador intente reducir la ansiedad del evaluado en caso de que esto ocurra. Para ello, el evaluador deberá buscar establecer un buen *rappor*t con el evaluado intentando iniciar y mantener un ambiente de evaluación ameno y receptivo. En caso de que el evaluado realice consultas sobre cómo contestar a la prueba, el evaluador deberá contestar de manera tal de no influenciar la respuesta del sujeto a los ítems. Respuestas del tipo “*No hay respuestas correctas o incorrectas*”, “*Elija la opción que más se parezca a como Ud. es la mayor parte del tiempo*”, “*Debe contestar lo primero que le venga a la mente*”, serían las más adecuadas en el caso de consultas.

Idealmente, tanto en la administración manual como en la *on line*, el evaluado debe leer las instrucciones de manera autónoma y marcar con un lápiz o birome la respuesta que elija en la hoja de respuestas o clicar entre las opciones que aparecen en pantalla. Es decir, el ICCP es una técnica autoadministrable. Sin embargo, será importante que el evaluado reciba una breve introducción sobre el objetivo del test. Para ello se sugiere que el evaluador verbalice la consigna del test y explique en términos generales qué es lo que se espera del evaluado. Por ejemplo, el evaluador puede señalar en el papel o en la pantalla el lugar dónde se encuentra la consigna, indicar dónde se encuentran los ítems y donde debe señalar la respuesta elegida.

De ser necesario, el ICCP podría ser administrado oralmente. En tal caso, el evaluador deberá leer las instrucciones y los ítems de manera clara y pausada para garantizar la comprensión de los mismos. Además, deberá mantenerse lo más neutral posible en cuanto a sus expresiones faciales y comentarios con el fin de no influir en las respuestas del evaluado.

Desde ya, como ocurre con cualquier test psicométrico, el ICCP debería ser utilizado como parte de una batería de tests y sus resultados deberían ser interpretados en inte-

gración con otros indicadores diagnósticos. Sumado a ello, como con todos los tests psicológicos, los profesionales han de resguardar los resultados obtenidos mediante el ICCP de manera confidencial y sólo darlos a conocer en caso de órdenes judiciales u otras circunstancias del ejercicio profesional en las que esté permitido violar el secreto profesional.

MATERIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y PUNTUACIÓN MANUAL

Para la *administración manual*, se deberá contar con:

- el Cuadernillo de Administración y la Hoja de Respuestas (véase Anexo 1.A)
- lapicera o lápiz para el evaluado
- Tablas de puntuación y de baremos (véase Anexo 1.B)
- Perfil vacío para ser completado por el evaluador (véase Anexo 1.C)

Debe garantizarse que el Cuadernillo en el que figuran los 120 ítems del test esté en su buen estado y sea legible. Además, para la interpretación el evaluador deberá contar con el contenido teórico y procedimental incluido en los diferentes capítulos de este libro.

Para arribar al diagrama del perfil del ICCP, el evaluador deberá seguir el paso a paso que se describe a continuación:

PASO 1 | Codificación de las respuestas

La puntuación del ICCP debe comenzar con la asignación de números a las opciones de respuestas del sujeto (codificación de las respuestas) de acuerdo con la escala Likert de la **Tabla B.1 del Anexo 1.B**. En el caso de encontrar frases en las que no se haya elegido ninguna opción de respuesta o en las que se haya elegido más de una opción, el evaluador deberá considerar que el ítem es impuntuable y no deberá asignarle ningún valor: la respuesta debe quedar en blanco, no se debe asignar el valor de 0 ni un valor intermedio. En ningún caso el evaluador deberá completar una respuesta a un ítem.

En el ejemplo que figura a continuación podemos ver que la respuesta a la primera pregunta fue la opción “Completamente falso” por lo que su codificación será el valor de 0. En el caso de la segunda pregunta la elección de “Bastante verdadero” se corresponde con una codificación de 4.

	COMPLETAMENTE FALSO	BASTANTE FALSO	ALGO FALSO	ALGO VERDADERO	BASTANTE VERDADERO	COMPLETAMENTE VERDADERO
1.	☒	☐	☐	☐	☐	☐
2.	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Figura 5. Ejemplo de codificación de respuestas

PASO 2 | Puntuaciones brutas de las escalas de validez

Una vez codificadas las respuestas, se deberán puntuar las **ESCALAS DE VALIDEZ**. En todos los casos se obtienen puntuaciones brutas (PB) que deben volcarse en la columna destinada para tal fin en el perfil.

		PB	T	20	30	40	50	60	70	80	90	100
ESCALAS DE VALIDEZ												
Ausencia de Respuesta	AR											
Inconsistencia	INC											
Magnificación de Psicopatología	MGPAT											
Minimización de Psicopatología	MNPAT											
Magnificación de Rasgos Positivos	MGPOS											

Figura 6. Espacio para transcribir las puntuaciones brutas

Para comenzar se obtendrá el puntaje bruto correspondiente a la escala *Ausencia de Respuesta* (**AR**). Para ello, el evaluador deberá contar la cantidad de frases no puntuables ya sea porque el evaluado no eligió ninguna opción de respuesta o porque eligió múltiples opciones. El resultado del conteo se volcará en el perfil sin transformarse en ninguna puntuación estándar. Para volcarlo en el perfil se debe ubicar la fila correspondiente a la escala *Ausencia de Respuesta* y en la columna PB (puntaje bruto)

En el ejemplo, las respuestas a las preguntas a los ítems 3, 4 y 5 no se pueden puntuar. En el caso del ítem 3 el sujeto no seleccionó ninguna opción de respuesta. En el caso del ítem 4 marcó su respuesta entre opciones por lo que no podemos saber si la respuesta es “Bastante falso” o “Algo falso”. En el ítem 5 marcó dos opciones de respuesta y no sabemos cuál es la opción que mejor representa a quien contesta. En ninguno de estos casos debemos elegir una opción de respuesta y debemos adjudicar un valor de 1 por cada respuesta no puntuable (en este caso es un total de 3 puntos) para la escala *Ausencia de Respuesta*.

	COMPLETAMENTE FALSO	BASTANTE FALSO	ALGO FALSO	ALGO VERDADERO	BASTANTE VERDADERO	COMPLETAMENTE VERDADERO
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
1.	☒	☐	☐	☐	☐	☐
2.	☐	☐	☐	☐	☒	☐
3.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	☐	☒	☐	☐	☐	☐
5.	☐	☐	☐	☒	☒	☐

Figura 7. Ejemplo de respuestas no puntuables (ítems 3, 4 y 5)

PB T 20 30 40 50 60 70 80 90 100		
ESCALAS DE VALIDEZ		
Ausencia de Respuesta	AR	3
Inconsistencia	INC	
Magnificación de Psicopatología	MGPAT	
Minimización de Psicopatología	MNPAT	
Magnificación de Rasgos Positivos	MGPOS	

Figura 8. Ejemplo de puntaje bruto de la escala **AR**

Luego, deberá obtenerse la puntuación bruta de escala *Inconsistencia* (**INC**). Para ello se deben calcular las discrepancias entre distintos pares de ítems positivos y negativos. Se recomienda el uso de la **TABLA B.2** del Anexo B. Para calcular cada discrepancia se deben restar los valores codificados de cada par de ítems tal como se puede ver en la Figura 9. Luego, el valor obtenido (que variará entre -5 y 5) se codifica en 0 ó 1 de acuerdo a lo indicado en la misma tabla. Para finalizar, se deben sumar todos los ceros y unos para obtener el puntaje bruto de la escala.

DISCREPANCIA PARES POSITIVOS			
<u>3</u> (ITEM 41) - <u>2</u> (ITEM 87) = <u>1</u>	entre -2 y 2	→ 0	<u>0</u>
	≤ -3 ó ≥ 3	→ 1	
<u>2</u> (ITEM 59) - <u>3</u> (ITEM 71) = <u>-1</u>	entre -2 y 2	→ 0	<u>0</u>
	≤ -3 ó ≥ 3	→ 1	
<u>4</u> (ITEM 63) - <u>0</u> (ITEM 66) = <u>4</u>	entre -2 y 2	→ 0	<u>1</u>
	≤ -3 ó ≥ 3	→ 1	
<u>5</u> (ITEM 39) - <u>5</u> (ITEM 80) = <u>0</u>	entre -2 y 2	→ 0	<u>0</u>
	≤ -3 ó ≥ 3	→ 1	
<u>5</u> (ITEM 21) - <u>3</u> (ITEM 56) = <u>2</u>	entre -2 y 2	→ 0	<u>0</u>
	≤ -3 ó ≥ 3	→ 1	
DISCREPANCIA PARES NEGATIVOS			
<u>5</u> (ITEM 106) - <u>2</u> (ITEM 118) = <u>3</u>	≤ -1 ó ≥ 1	→ 0	<u>0</u>
	0	→ 1	
<u>1</u> (ITEM 92) - <u>2</u> (ITEM 102) = <u>-1</u>	≤ -1 ó ≥ 1	→ 0	<u>0</u>
	0	→ 1	
<u>3</u> (ITEM 82) - <u>1</u> (ITEM 103) = <u>2</u>	≤ -1 ó ≥ 1	→ 0	<u>0</u>
	0	→ 1	
<u>4</u> (ITEM 6) - <u>4</u> (ITEM 26) = <u>0</u>	≤ -1 ó ≥ 1	→ 0	<u>1</u>
	0	→ 1	
<u>5</u> (ITEM 9) - <u>3</u> (ITEM 97) = <u>2</u>	≤ -1 ó ≥ 1	→ 0	<u>0</u>
	0	→ 1	
PUNTAJE BRUTO =			<u>2</u>

Figura 9. Ejemplo de cálculo de puntaje bruto de la escala **INC**

Finalmente, el puntaje bruto se registra en la hoja de perfil como se ve en la Figura 10.

		PB	T	20	30	40	50	60	70	80	90	100
ESCALAS DE VALIDEZ												
Ausencia de Respuesta	AR											
Inconsistencia	INC	2										
Magnificación de Psicopatología	MGPAT											
Minimización de Psicopatología	MNPAT											
Magnificación de Rasgos Positivos	MGPOS											

Figura 10. Ejemplo de puntaje bruto de la escala **INC**

A continuación se puntuarán las escalas *Magnificación de Psicopatología* (**MGPAT**), *Minimización de Psicopatología* (**MNPAT**) y *Magnificación de Rasgos Positivos* (**MGPOS**). En todos los casos se debe obtener el promedio de los ítems que pertenecen a cada una de ellas (ver **TABLA B.3 del Anexo 1.B**). Por ejemplo, supongamos que los ítems que pertenecen a la escala **MGPAT** tienen la siguiente codificación: 0, 0, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 2. Al calcular su promedio $[(0+0+3+1+0+1+0+0+2)/9]$ obtengo el valor 0.77 y lo transcribo en el espacio del perfil destinado al puntaje bruto de esta escala.

		PB	T	20	30	40	50	60	70	80	90	100
ESCALAS DE VALIDEZ												
Ausencia de Respuesta	AR											
Inconsistencia	INC											
Magnificación de Psicopatología	MGPAT	0.77										
Minimización de Psicopatología	MNPAT											
Magnificación de Rasgos Positivos	MGPOS											

Figura 11. Ejemplo de puntaje bruto de la escala **MGPAT**

PASO 3 | Puntuaciones brutas de las escalas específicas

Luego, se deben obtener las puntuaciones brutas de las doce **ESCALAS ESPECÍFICAS**: *Funcionamiento del sí mismo* (**FS**), *Funcionamiento interpersonal* (**FI**), *Afecto Negativo* (**AF**), *Serenidad* (**SE**), *Desapego* (**DA**), *Humanidad* (**HU**), *Antagonismo* (**AN**), *Integridad* (**IN**), *Desinhibición* (**DI**), *Moderación* (**MO**), *Psicoticismo* (**PS**) y *Vivacidad y foco* (**VF**). Para ello se deben promediar los ítems que las componen recurriendo a la **TABLA B.4 del Anexo 1.B**.

En este caso, el procedimiento es el mismo. Si, por ejemplo, las respuestas codificadas correspondientes a la escala *Funcionamiento del sí-mismo* son 2, 2, 3, 1, 0 y 1 su puntaje bruto (promedio) es 1.50 y ese valor deberá transcribirse en el espacio destinado a informar el PB de la escala **FS**.

ESCALAS ESPECÍFICAS			
<i>Escala Criterio A</i>			
Funcionamiento del sí mismo	FS	1.50	
Funcionamiento Interpersonal	FI		
<i>Continuos de Rasgos de la Personalidad</i>			
Afectividad Negativa	AF		
Serenidad	SE		
Desapego	DA		
Humanidad	HU		
Antagonismo	AN		
Integridad	IN		

Figura 12. Ejemplo de puntaje bruto de una escala específica

PASO 4 | Puntuaciones brutas de los índices globales

Finalmente, se deben calcular los índices globales: el *Índice de Funcionamiento de la Personalidad (IFP)*, el *Índice de Rasgos Patológicos de la Personalidad (IPAT)*, el *Índice de Rasgos Positivos de la Personalidad (IPOS)*, el *Índice de Conductas Externalizantes (IEXT)* y el *Índice de Conductas Internalizantes (IINT)*. Para ello es necesario promediar las puntuaciones brutas de distintas escalas específicas (el cálculo será sobre los promedios ya obtenidos y no sobre los ítems de las escalas específicas). Será necesario recurrir a la **TABLA B.5 del Anexo 1.B**.

Por ejemplo, si el sujeto obtuvo un puntaje bruto de 1.50 en la escala **FS** y un puntaje bruto de 1.72 en la escala **FI** que componen el *Índice de Funcionamiento de la Personalidad (IFP)*, su puntuación bruta será el promedio de esos promedios. Es decir $[(1.50+1.72)/2] = 1.61$. El puntaje bruto del **IFP** es 1.61 y ese dato se transcribe a la columna para puntajes brutos del perfil en la fila correspondiente a ese índice.

ÍNDICES GLOBALES			
Índice de Funcionamiento de la Personalidad (DIAGNÓSTICO DSM-5 - CRITERIO A)	IFP	1.61	
Índice de Rasgos Patológicos de la Personalidad (DIAGNÓSTICO DSM-5 - CRITERIO B)	IPAT		
Índice de Rasgos Positivos de la Personalidad	IPOS		
Índice de Ajuste de la Personalidad	IAP		
Índice de Conductas Externalizantes	IEXT		
Índice de Conductas Internalizantes	IINT		

Figura 13. Ejemplo de puntaje bruto de una escala global

PASO 5 | Puntuación bruta del Índice de Ajuste de la Personalidad

Para el cálculo del *Índice de Ajuste de la Personalidad (IAP)* debe utilizarse la fórmula de la **TABLA B.6 del Anexo 1.B**. Siempre será necesario contar con los datos de medias y desviaciones estándar para las escalas específicas implicadas en el cálculo del baremo vigente (ver **TABLA B.7 del Anexo 1.B**).

Supongamos que un sujeto obtuvo las siguientes puntuaciones brutas en los rasgos: 3.38 en *Afecto Negativo (AF)*, 2.38 en *Serenidad (SE)*, 2.40 en *Desapego (DA)*, 3.38 en *Humanidad (HU)*, 1.33 en *Antagonismo (AN)*, 4.46 en *Integridad (IN)*, 1.88 en *Desinhibición (DI)*, 3.11 en *Moderación (MO)*, 0.38 en *Psicoticismo (PS)* y 2.53 en *Vivacidad y foco (VF)*. Lo primero será completar la parte de la ecuación correspondiente a las puntuaciones brutas de las escalas de rasgos de esta manera:

$$IAP = \left(\frac{\frac{2.38 - \bar{x}_{SE}}{\sigma_{SE}} + \frac{3.38 - \bar{x}_{HU}}{\sigma_{HU}} + \frac{4.46 - \bar{x}_{IN}}{\sigma_{IN}} + \frac{3.11 - \bar{x}_{MO}}{\sigma_{MO}} + \frac{2.53 - \bar{x}_{VF}}{\sigma_{VF}}}{5} \right) - \left(\frac{\frac{3.38 - \bar{x}_{SE}}{\sigma_{SE}} + \frac{2.40 - \bar{x}_{HU}}{\sigma_{HU}} + \frac{1.33 - \bar{x}_{IN}}{\sigma_{IN}} + \frac{1.88 - \bar{x}_{MO}}{\sigma_{MO}} + \frac{0.39 - \bar{x}_{VF}}{\sigma_{VF}}}{5} \right)$$

Luego, se deben incluir los valores de medias y desviaciones estándar de cada rasgo de acuerdo con el baremo vigente y realizar el cálculo de la ecuación. En este caso el resultado es -0.86. Este valor es el puntaje bruto de este índice.

PASO 6 | Transformación a puntuaciones T

Para transformar un puntaje bruto a una puntuación T se debe recurrir a las **tablas B.8 y B.9 del Anexo 1.B**. En ellas se debe buscar la columna correspondiente a la escala cuya puntuación bruta se desea transformar en puntaje T. Una vez ubicada, se debe localizar la fila en la que figura la puntuación bruta obtenida. Finalmente, en los puntos extremos de las filas se encuentra el dato de la puntuación T que corresponde a ese puntaje bruto. Esto debe hacer para todas las escalas de validez, para todos los índices globales y para las escalas específicas.

Por ejemplo, un puntaje bruto de 4.71 en la escala **FS** se corresponde con una puntuación T de 85. Una puntuación bruta de 4.19 en la escala **FI** se corresponde con un puntaje T de 81.

T	FS	FI
100		
99		
98		
97		
96		
95		
94		
93		
92		
91		
90		
89		4.91 - 5
88	5	4.80 - 4.90
87	4.90 - 4.99	4.70 - 4.79
86	4.80 - 4.89	4.60 - 4.69
85	4.70 - 4.79	4.50 - 4.59
84	4.60 - 4.69	4.40 - 4.49
83	4.50 - 4.59	4.30 - 4.39
82	4.40 - 4.49	4.20 - 4.29
81	4.30 - 4.39	4.10 - 4.19
80	4.19 - 4.28	4.00 - 4.09
79	4.09 - 4.18	3.90 - 3.99

Figura 14. Ejemplo de uso del baremo

PASO 7 | Diagrama del perfil

Con los datos obtenidos el evaluador debe volcar esta información en el perfil. Al lado de cada escala se informa el dato de cada escala en cuanto a su puntuación bruta (columna **PB**) y su puntuación T (columna **T**). Luego en el sector de zonas de grises se debe marcar la puntuación T obtenida y diagramar el perfil uniando los puntos en cada sector de puntuaciones.

Por ejemplo, en el caso que figura a continuación podemos ver que la puntuación de la escala Inconsistencia (**INC**) es 2 y su puntaje T correspondiente es 56 (de acuerdo con el baremo de la **tabla B.8 del Anexo 1.B**). Al graficarlo en la zona de grises esta puntuación T cayó dentro de la zona gris claro. Otro ejemplo es el de la escala *Conductas Internalizantes* (**IINT**) para la que se obtuvo una puntuación bruta de 3.04 que, de acuerdo con el baremo de la **tabla B.8 del Anexo 1.B**, se corresponde con una puntuación T de 71 por lo que al graficarlo cae en la zona de gris oscuro.

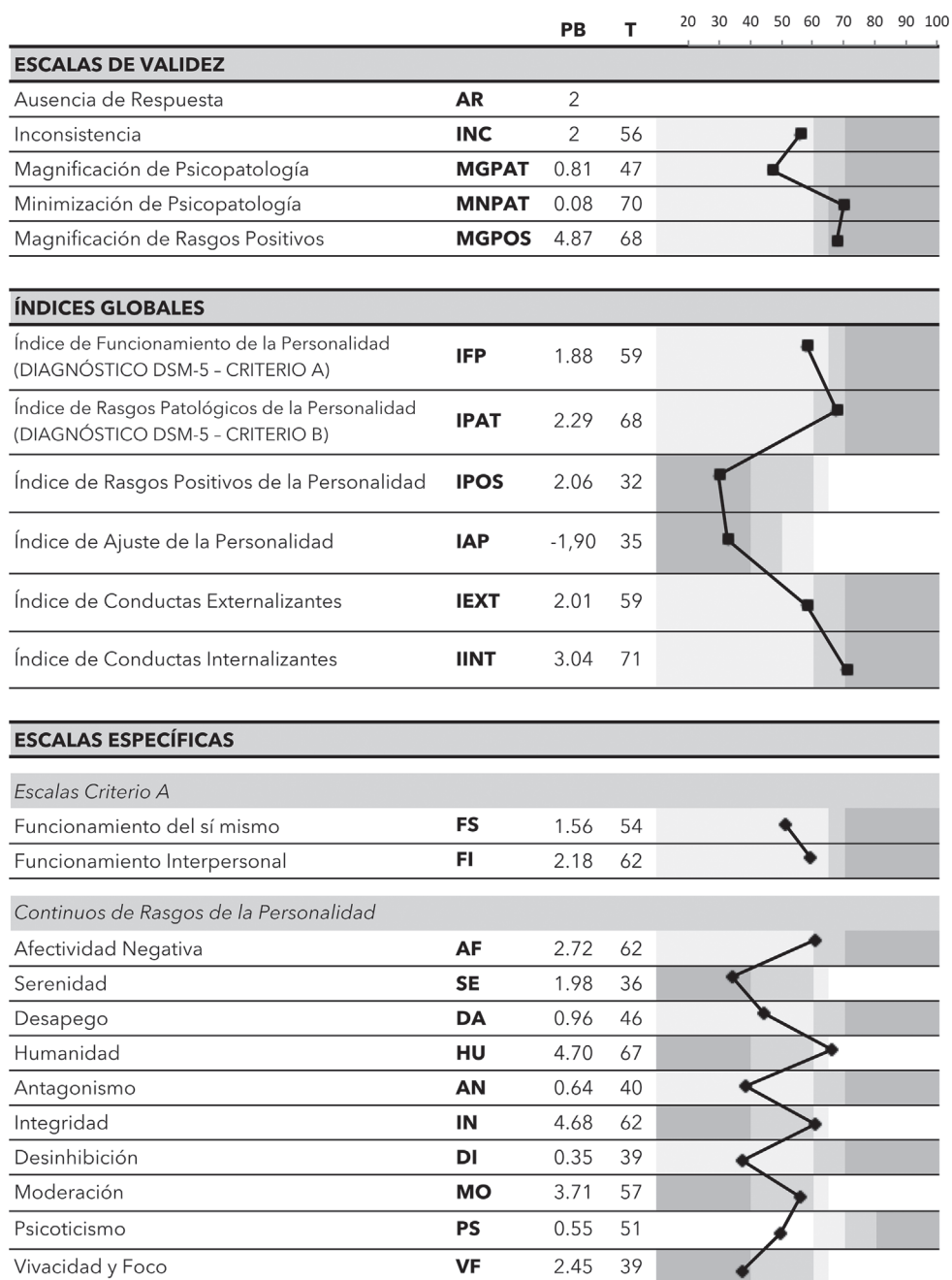


Figura 15. Ejemplo de perfil

MATERIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y PUNTUACIÓN *ON LINE*

Para la *administración on line* deberá contar con:

- una computadora con conexión a Internet.
- una licencia de uso o toma, que se incluye en este mismo ejemplar como gentileza.

Para cada administración de un caso, habrá de utilizarse una licencia de uso o toma. En el Anexo 2 se detalla el procedimiento que ha de realizarse para activar las tomas ofrecidas en este ejemplar. En dicho Anexo encontrará el lector todos los aspectos relativos a la administración de la toma, su activación y la adquisición de nuevas tomas. El sistema informatizado contiene las normas o baremos y procesa los resultados del test en forma automatizada. Al terminar el procesamiento, entregará los resultados en un perfil, como el que se observa en el Anexo 2. Además, al igual que en la interpretación manual, la interpretación requiere del contenido teórico y procedimental incluido en los diferentes capítulos de este libro.

En el caso de la administración y puntuación online, el sistema generará un perfil en el cual las zonas de interpretación de las puntuaciones T estarán representadas por una escala de colores (a diferencia de la escala de grises de la interpretación manual). La correspondencia entre la escala de grises y la de colores es la siguiente:

GRIS OSCURO	ROJO
GRIS MEDIO	AMARILLO
GRIS CLARO	VERDE
BLANCO	CELESTE.

INTERPRETACIÓN DE LOS PERFILES DEL ICCP

En el capítulo siguiente se brindarán mayores detalles para la interpretación de las escalas de validez, índices globales y escalas específicas del ICCP, además de ejemplos de interpretación de casos reales. Las puntuaciones utilizadas en el baremo son las puntuaciones T lineales, las cuales cuentan con un valor medio de 50 y una desviación estándar de 10 puntos (véase capítulo 5). Para todos los casos se brindan puntajes de corte establecidos de acuerdo con la distribución de cada variable estudiada.

En ningún caso se debería diagnosticar un trastorno de la personalidad basándose exclusivamente en los puntajes del ICCP. Los perfiles obtenidos con el ICCP deberían ser siempre interpretados globalmente, contrastando todas las medidas que se obtienen en conjunto con otros criterios diagnósticos y bajo la guía de la experiencia del evaluador en el diagnóstico psicológico. Adicionalmente a la guía interpretativa brindada en este capítulo y en el capítulo siguiente, el evaluador deberá estar familiarizado con las teorías de la personalidad descriptas en los capítulos anteriores y en la bibliografía allí referenciada, en especial en las nosologías diagnósticas vigentes (DSM-5).

Se aconseja que la interpretación del perfil siga los siguientes pasos:

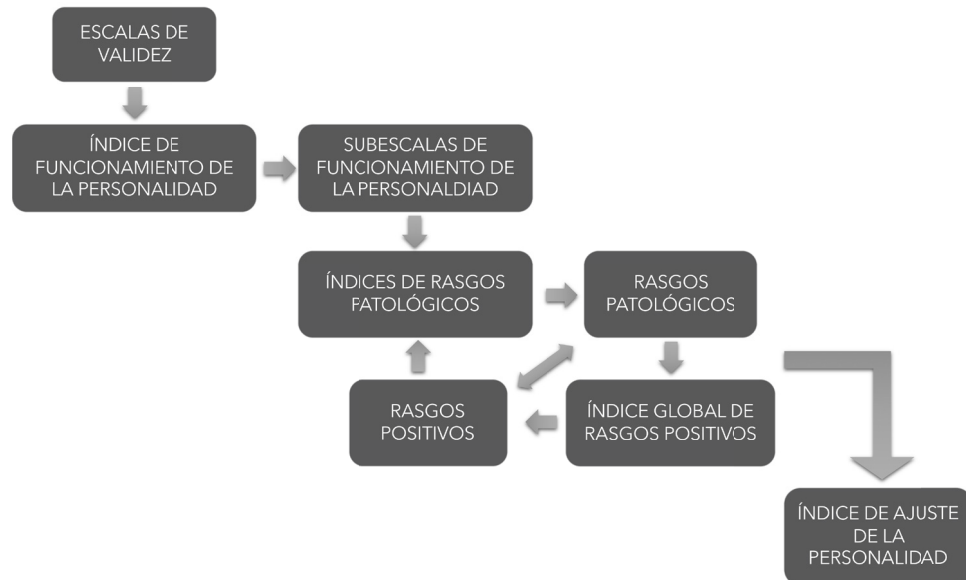


Figura 16. Guía para la interpretación del perfil obtenido con el ICCP

Como primer paso se deben analizar las *escalas de validez* para estudiar si el perfil es interpretable. Este primer paso es fundamental ya que el resto de las escalas obtenidas en el perfil no serán válidas si el evaluado distorsionó demasiado sus respuestas, no brindó información insuficiente y/o respondió incoherentemente a los distintos ítems del test. Luego, se debe estudiar la puntuación global del criterio A (*Índice de Funcionamiento de la Personalidad*) y sus subescalas (*Funcionamiento de sí-mismo* y *Funcionamiento interpersonal*). A continuación se evalúan los tres índices de rasgos patológicos y las escalas específicas de rasgos patológicos, para continuar inmediatamente con el *Índice de Rasgos Positivos* y las *escalas específicas de rasgos positivos*. Como puede interpretarse en el gráfico precedente, en este momento la interpretación resulta circular ya que la valoración de los rasgos positivos debería realizarse retomando los resultados obtenidos en los rasgos patológicos para obtener una interpretación holística y que contemple la noción de continuo de salud-patología. Finalmente, se debe brindar una evaluación final del perfil, ubicando al sujeto dentro de las zonas diagnósticas delimitadas por el *Índice de Ajuste de la Personalidad* a la par de destacar aquellos aspectos de la evaluación más importantes. En el capítulo siguiente se brinda mayor detalle de cómo interpretar cada una de las puntuaciones del ICCP de acuerdo los distintos puntos de corte que delimitan las zonas de grises del perfil.

7. Interpretación del ICCP y casuística

Guadalupe de la Iglesia y Alejandro Castro Solano

En el capítulo anterior se brindaron las pautas para la administración y puntuación del Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad (ICCP). A continuación, se realizará un recorrido más pormenorizado por la interpretación de las puntuaciones y sus puntos de corte. Para finalizar se ejemplificará la interpretación de perfiles con distintos casos.

INTERPRETACIÓN DE LOS PERFILES DEL ICCP

Una vez obtenidas las puntuaciones T para cada escala del ICCP y diagramado el perfil (véase capítulo 6 pág. XXX), el evaluador podrá interpretar las escalas de acuerdo con los puntajes de corte indicados a continuación. La interpretación debería guiarse por el diagrama de flujo presentado en el capítulo precedente (véase capítulo 6 pág. 99). Los casos con los que se finaliza este capítulo servirán de ejemplo de lo que es dable esperar de la interpretación de los perfiles del ICCP.

Escalas de validez

Como se especificó en el capítulo precedente, la interpretación comienza con la valoración de las escalas de validez del instrumento. Éstas nos brindarán información acerca de la posible invalidez del perfil de personalidad obtenido. La invalidez de un perfil puede darse por varios elementos: (a) que el evaluado no haya dado la cantidad de información necesaria para realizar un diagnóstico de su personalidad, (b) que haya respondido azarosamente sin pensar demasiado en sus respuestas, por lo que existan respuestas contradictorias entre sí, y (c) que haya distorsionado sus respuestas para mostrarse de manera favorable o desfavorable.

Ausencia de respuesta (AR)

La escala *Ausencia de respuesta (AR)* fue desarrollada como medida del porcentaje de respuestas no informativas del perfil. Serán respuestas ausentes aquellos ítems en

los que el evaluado no haya marcado ninguna de las opciones, en las que haya elegido más de una opción o en las que no quede claro cuál fue la opción elegida. Cuanto mayor sea la ausencia de respuestas más riesgo existirá de que la información obtenida sea inválida (véase tabla 1). Un porcentaje superior al 10% de ítems no puntuables indicará que el perfil no debería interpretarse.

Tabla 1. Interpretación de Ausencia de Respuesta (AR)

Puntuación bruta	Validez del protocolo	Interpretación
≥ 12	No interpretable	Las respuestas que no se pueden puntuar (por ausencia, por marca múltiple o marca que no se comprende) superan el porcentaje de tolerancia e invalidan la interpretación del protocolo. Esto puede deberse a varias razones, entre ellas: que el sujeto no comprendió la consigna (e.g. por un nivel educativo inferior al sugerido), que no quiere colaborar en la evaluación, que tenga alguna dificultad física (e.g. visual) o psíquica (e.g. obsesividad marcada).
1-11	Algunas escalas pueden ver su validez afectada	Identificar si las respuestas no puntuables responden a algún tipo de patrón (e.g. respuesta vacía cada 30 ítems) o están englobadas bajo algún aspecto específico (e.g. todas las preguntas vinculadas con las relaciones interpersonales). Valorar la necesidad de descartar la interpretación de alguna puntuación si la ausencia de respuesta se encuentra concentrada (e.g. > 10% de los ítems que la componen) en alguna escala particular.
0	Sin problemas	El protocolo cuenta con todas las respuestas necesarias para proceder con la interpretación. El sujeto colaboró completamente con la evaluación realizada.

Inconsistencia (INC)

◀ La escala *Inconsistencia (INC)* fue generada mediante el estudio de la matriz de correlaciones entre los ítems componentes del test. Fueron seleccionadas aquellas correlaciones negativas o positivas que fueran altas para detectar pares de ítems que deberían ser contestados en el mismo sentido (correlaciones positivas) o en el sentido opuesto (correlaciones negativas). Luego, se evaluó el contenido de los ítems para corroborar efectivamente que el contenido podría representar una inconsistencia en la respuesta. Como evaluación final se analizó que la cantidad de sujetos que incurrieran en esa inconsistencia era infrecuente. Además, los ítems seleccionados sólo podían pertenecer a un único par. Cuanto mayor sea el puntaje más inválido será el perfil obtenido en el instrumento ya que el sujeto ha respondido de manera incoherente/contradictoria (véase tabla 2).

Tabla 2. Interpretación de Inconsistencia (INC)

Puntuación T	Validez del protocolo	Interpretación
≥ 70	Inconsistente	Gran parte de las respuestas brindadas por el sujeto son contradictorias. Esto podrían indicar: una distorsión consciente de las respuestas; falta de colaboración en la evaluación; cierto desorden del pensamiento que influye en la capacidad de responder al test; nivel de comprensión lectora inferior al requerido para la administración; error en el uso de las casillas para marcar sus respuestas. El protocolo debe ser descartado y debe elegirse otra herramienta de evaluación psicológica.
60-69	Levemente inconsistente	En algunas partes del test el sujeto dio una respuesta y en otras partes del test dio una respuesta opuesta. Algunas respuestas obtenidas no son coherentes entre sí. El protocolo obtenido debe ser interpretado con cautela o descartado.
≤ 59	Consistente	Las respuestas del sujeto son coherentes entre sí, lo que indica un mayor grado de validez del protocolo y actitud colaborativa con la evaluación.

Magnificación de Psicopatología (MGPAT)

◀ La escala *Magnificación de Psicopatología (MGPAT)* se diseñó para considerar la posible exageración de malestar psicopatológico. La decisión de incluir ciertos ítems específicos en esta escala estuvo dada por los siguientes criterios: (1) el ítem debía tener una alta correlación con el puntaje total de la escala de rasgos patológicos a la que pertenece, (2) el ítem debía ser infrecuente en la población, y (3) el ítem tenía una alta correlación con una medida externa de psicopatología. Puntajes elevados indican que el evaluado intentó mostrarse desfavorablemente, lo que indica un mayor malestar psicopatológico del que padece realmente (véase tabla 3).

Tabla 3. Interpretación de Magnificación de Psicopatología (MGPAT)

Puntuación T	Validez del protocolo	Interpretación
≥ 70	Muchos síntomas infrecuentes	El sujeto informó como verdaderos una gran cantidad de ítems patológicos que son infrecuentes en la población general. Esto nos podría indicar que ha exagerado su psicopatología con el fin de brindar una imagen desfavorable de sí mismo (exageración de malestar psicopatológico) o que padece de una psicopatología grave. Esta dicotomía debería ser fácilmente detectable con un criterio externo como los antecedentes del sujeto y una evaluación del contexto y su situación actual mediante una entrevista.
60-69	Varios síntomas infrecuentes	Entre las respuestas brindadas por el evaluado se contestaron como verdaderas algunos ítems psicopatológicos infrecuentes. Se puede sospechar cierta exageración de psicopatología si no existen antecedentes clínicos significativos.
≤ 59	No hay exageración	El sujeto no informó sintomatología infrecuente. No hay sospecha de magnificación de psicopatología.

Minimización de Psicopatología (MNPAT)

◀ La escala *Minimización de Psicopatología (MNPAT)* contempla la posibilidad de que el evaluado haya informado menor psicopatología de la que realmente padece. Se construyó a partir de la selección de ítems pertenecientes a las escalas de rasgos patológicos que tenían una alta correlación negativa con una medida externa de deseabilidad social. Además, estos ítems describen aspectos de la personalidad que cualquier persona estaría dispuesta a informar como levemente presentes (véase tabla 4).

Tabla 4. Interpretación de Minimización de Psicopatología (MNPAT)

Puntuación T	Validez del protocolo	Interpretación
≥ 65	Minimización	El evaluado informó como ausentes muchos ítems psicopatológicos de tipo leve que son bastante frecuentes en la población general. Este patrón de respuesta informa una tendencia a mostrar una imagen favorable de sí mismo. El sujeto no está dispuesto a admitir la presencia del más mínimo malestar. Es posible también la presencia de cierta negación en cuanto al propio malestar o poca capacidad introspectiva. Este aspecto debería despejarse mediante una entrevista clínica u otro indicador externo.
60-64	Posible minimización	La presencia de ítems psicopatológicos leves y frecuentes es poca. Es posible que el sujeto no haya contestado sinceramente a los ítems del test con el fin de mostrarse libre de malestar y brindar una imagen positiva de sí mismo.
≤ 59	No hay minimización	Las respuestas del evaluado dan cuenta de que no tiene inconvenientes en asumir la presencia de aspectos patológicos leves. Se sospecha que ha contestado con sinceridad a los ítems.

Magnificación de Rasgos Positivos (MGPOS)

◀ La posibilidad de que el sujeto haya intentado exagerar sus rasgos positivos se puede evaluar mediante la escala *Magnificación de Rasgos Positivos (MGPOS)*. Los ítems pertenecientes a ella fueron seleccionados mediante la evaluación de su alta correlación positiva con una medida externa de deseabilidad social. Son ítems que reflejan aspectos bastante ideales y que pocos sujetos tienden a informar como completamente verdaderos al autodescribirse (véase tabla 5).

Tabla 5. Interpretación de Magnificación de Rasgos Positivos (MNPOS)

Puntuación T	Validez del protocolo	Interpretación
≥ 65	Presencia alta de magnificación	El evaluado informó una gran presencia de aspectos positivos ideales. Esto nos informa la presencia de una tendencia a exagerar al describir sus aspectos sanos con el fin de mostrar una imagen favorable de sí mismo. Es posible también la presencia de cierta necesidad de autoafirmación y de enaltecimiento ajena a los objetivos de la evaluación psicológica. Este aspecto debería despejarse mediante una entrevista clínica u otro indicador externo.
60-64	Presencia leve de magnificación	En el protocolo evaluado el sujeto indicó como presentes varios ítems positivos que suelen ser ideales. Es posible que haya distorsionado levemente sus respuestas para mostrar una imagen favorable de sí mismo.
≤ 59	No hay magnificación	La presencia de aspectos positivos es la esperada de acuerdo con la población general. No se sospecha exageración de rasgos positivos.

INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES GLOBALES

Índice de Funcionamiento de la Personalidad (IFP)

◀ El Índice de Funcionamiento de la Personalidad (IFP) es una medida de funcionamiento de la personalidad basada en aquellos aspectos valorados por el Criterio A del DSM-5 (véase Capítulo 2 pp. XX). Altos puntajes indican dificultades en el sí mismo y en lo interpersonal, los cuales constituyen el núcleo de la psicopatología de la personalidad (véase tabla 6).

Tabla 6. Interpretación de Índice de Funcionamiento de la Personalidad (IFP)

Puntuación T	Interpretación
≥ 70	Es altamente probable que el evaluado padezca de uno o más trastornos de la personalidad. Contrastar con el IPAT y las escalas específicas de rasgos patológicos. Verificar si las dificultades de funcionamiento se dan en aspectos del sí mismo, interpersonales o en ambos (escalas FS y FI).
65-69	El sujeto presenta las condiciones mínimas que suelen acompañar la presencia de un trastorno de la personalidad. Analizar el IPAT, las escalas específicas de rasgos patológicos y las escalas FS y FI.
≤ 64	El sujeto no presenta indicadores de disfunción de la personalidad. Esto da pauta de un funcionamiento esperado en cuanto a la identidad, la autodirección, la empatía y la intimidad.

Índice de Rasgos Patológicos de la Personalidad (IPAT)

◀ El Índice de Rasgos Patológicos de la Personalidad (**IPAT**) es una medida global de la severidad de los trastornos de la personalidad. Puntajes altos indican la posibilidad de la presencia de trastornos de personalidad y la vulnerabilidad del desarrollo de sintomatología psicológica. Su cálculo surge de promediar las puntuaciones de los ítems pertenecientes a las cinco escalas de rasgos patológicos de la personalidad (véase tabla 7).

Tabla 7. Interpretación del Índice de Rasgos Patológicos de la Personalidad (**IPAT**)

Puntuación T	Interpretación
≥ 70	El evaluado presenta una elevada presencia de psicopatología. Existe una alta vulnerabilidad para el desarrollo de sintomatología psicológica. Se debe contrastar este resultado con la elevación de la escala IFP y con las escalas específicas de rasgos patológicos. De su análisis se pueden perfilar el diagnóstico de uno o más trastornos de la personalidad.
60-69	Existe una presencia moderada de psicopatología que debería ser objeto de atención clínica. El análisis de las escalas específicas debería dar cuenta de los aspectos psicopatológicos presentes y de la posible configuración del diagnóstico de un trastorno de la personalidad. Para ello se deberá estudiar la elevación de la escala IFP, que es un criterio necesario para ese diagnóstico.
≤ 59	No existen indicadores graves de psicopatología de la personalidad.

Índice de Rasgos Positivos de la Personalidad (IPOS)

◀ El Índice de Rasgos Positivos de la Personalidad (**IPOS**) es una medida global de los rasgos positivos de la personalidad. Puntuaciones altas en este índice se dan en sujetos caracterizados por tener formas de actuar, pensar y sentir sanas y asociadas al bienestar en general. Su cálculo surge de promediar las puntuaciones de los ítems pertenecientes a las cinco escalas de rasgos positivos de la personalidad (véase tabla 8).

Tabla 8. Interpretación del Índice de Rasgos Positivos de la Personalidad (**IPOS**)

Puntuación T	Interpretación
≥ 65	El sujeto cuenta con recursos útiles para experimentar bienestar en situaciones cotidianas y también en contextos estresantes. Tiene una predisposición natural o aprendida a funcionar óptimamente en el entorno en el que se encuentre. El análisis de las escalas específicas de rasgos positivos dará cuenta de los puntos fuertes en su repertorio de aspectos positivos.

60-64	Existe una presencia moderada de aspectos positivos que funcionan como factores protectores ante posibles emociones negativas y que, a la vez, promueven el desarrollo saludable en distintos ámbitos de su vida. Las escalas de rasgos positivos informarán sobre dónde radican las fortalezas específicas del sujeto.
40-59	El evaluado no cuenta con una presencia de rasgos positivos que se destaque por sobre el común de la población.
≤ 39	Existe un déficit en la presencia de rasgos positivos, el evaluado no cuenta con recursos saludables para contrarrestar aspectos patológicos ni para promover su propio funcionamiento óptimo. Existe una alta vulnerabilidad para el desarrollo de sintomatología psicológica.

Índice de Ajuste de la Personalidad (IAP)

◀ Mediante el Índice de Ajuste de la Personalidad (**IAP**) se puede valorar en conjunto el grado de presencia de rasgos patológicos y positivos. Brinda una medida conjunta de ajuste psicológico que informa sobre el funcionamiento del sujeto al considerarse todo el continuo de enfermedad-salud en cuanto a rasgos de la personalidad. Puntajes elevados indicarán un mayor funcionamiento psicológico óptimo. Su cálculo surge de una combinación entre los puntajes obtenidos en las escalas de rasgos patológicos y las escalas de rasgos positivos (véase tabla 9).

Tabla 9. Interpretación del Índice de Ajuste de la Personalidad (IAP)

Puntuación T	Interpretación
≥ 60	Perfil correspondiente con una personalidad sana. El sujeto se caracteriza por la presencia de rasgos positivos y la ausencia de rasgos patológicos.
50-59	Perfil correspondiente con una personalidad compensada. El sujeto tiene presencia tanto de aspectos de rasgos positivos como de rasgos patológicos.
40-49	Perfil correspondiente con una personalidad vulnerable. El sujeto no presente rasgos positivos y patológicos en gran medida.
≤ 39	Perfil correspondiente con una personalidad patológica. El sujeto se caracteriza por la ausencia de rasgos positivos y la presencia de rasgos patológicos.

Índice de Conductas Externalizantes (IEXT)

◀ Se entiende como conductas externalizantes a dificultades en el comportamiento dadas por la falta de control, la impulsividad, la agresividad, el abuso, el engaño y la delincuencia. Los sujetos que puntúan alto en el Índice de Conductas Externalizantes (**IEXT**) se caracterizan por tener problemas en su inserción en la sociedad ya que sus comportamientos generalmente van en contra de lo socialmente esperado (véase tabla 10).

Tabla 10. Interpretación del Índice de Conductas Externalizantes (IEXT)

Puntuación T	Interpretación
≥ 70	Existe una presencia patológica de conductas impulsivas y antisociales. El sujeto frecuentemente se comporta agresivamente e incurre en acciones de engaño o utilización de otras personas para su propio beneficio. El evaluado carece de autocontrol.
60-69	El evaluado presenta un grado moderado de conductas patológicas de falta de control y daño hacia los demás.
≤ 59	El evaluado no presenta los aspectos patológicos evaluados en un nivel superior al esperado en la mayoría de los sujetos.

Índice de Conductas Internalizantes (IINT)

◀ Los trastornos internalizantes se refieren a dificultades en los aspectos emocionales. En la escala Índice de Conductas Internalizantes (IINT) se incluyen ítems pertenecientes a los rasgos patológicos de desapego y afecto negativo. Puntuaciones elevadas indicarán la presencia de emociones negativas que se perciben como inmanejables por el sujeto. Las personas que obtienen puntajes altos en esta escala se caracterizan por experimentar en su cotidianeidad sentimientos de tristeza, culpa, desesperanza, así como también de irritación, tensión, ansiedad y preocupación (ver tabla 11).

Tabla 11. Interpretación del Índice de Conductas Internalizantes (IINT)

Puntuación T	Interpretación
≥ 70	El evaluado generalmente presenta altos niveles de malestar emocional. Tiene un gran desinterés por establecer vínculos personales y relaciones íntimas. Hay presencia de emociones negativas tales como tristeza, culpa, ansiedad, irritación, que para el sujeto son vivenciadas como inmanejables.
60-69	Existe una moderada presencia de emociones negativas y desinterés en los vínculos interpersonales. El sujeto no cuenta con herramientas para contrarrestar su malestar en esos aspectos.
≤ 59	El evaluado no presenta los aspectos patológicos evaluados en un nivel superior al esperado en la mayoría de los sujetos.

Interpretación de las Escalas Específicas

Funcionamiento del Sí-Mismo (FS)

◀ La escala *Funcionamiento del Sí-Mismo* (FS) es un aspecto del funcionamiento de la personalidad que valora el funcionamiento del evaluado a nivel personal, nos indica cómo funciona la persona en relación a sí mismo (véase tabla 12). Esto puede darse por problemas con la propia identidad (experimentar un límite entre sí-mismo y los otros, tener una autoestima estable, poder regular las propias experiencias emocionales) y

por problemas de autodirección (contar con metas personales propias, capacidad de autorreflexión, normas internas de comportamiento acordes a lo posible).

Tabla 12. Interpretación de Funcionamiento del Sí-Mismo (FS)

Puntuación T	Interpretación
≥ 70	El evaluado presenta grandes dificultades en cuanto a su propia identidad y autodirección. Tiene problemas para reconocer cuál es el límite entre sí-mismo y los demás, presenta una autoestima disminuida y le resulta difíciles regular sus emociones. Además, le cuesta establecer metas personales y cuando lo hace éstas son difíciles de cumplir. Tiene problemas de introspección ya que en general no sabe cómo se siente y qué piensa. Analizar este puntaje a la par de la puntuación de la escala FI.
65-69	Existe cierto grado de disfunción en el cuanto a la identidad y la autodirección. Analizar este puntaje a la par de la puntuación de la escala FI.
≤ 54	El evaluado no presenta dificultades en el funcionamiento de sí-mismo en un nivel superior al esperado en la mayoría de los sujetos.

Funcionamiento Interpersonal (FI)

◀ Las dificultades en el funcionamiento interpersonal (escala *Funcionamiento Interpersonal* - FI) refieren a problemas relacionados con la empatía y la intimidad (véase tabla 13). En cuanto a la empatía, en caso de disfunción, el evaluado tendrá dificultades en la comprensión de las emociones ajenas, no tolerará que otros opinen distinto a su propia opinión y tendrá un bajo registro del impacto de sus propias acciones en los demás. El aspecto de intimidad refiere a problemas en establecer vínculos positivos con los demás, desinterés en establecer relaciones cercanas así como se observa la presencia de una alta expectativa acerca del comportamiento que deben tener los otros.

Tabla 13. Interpretación de Funcionamiento Interpersonal (FI)

Puntuación T	Interpretación
≥ 70	El evaluado presenta grandes dificultades para reconocer las emociones que experimentan las otras personas y tiene un bajo o nulo registro sobre el impacto que sus propias conductas pueden tener o tienen en los demás. Además, le cuesta relacionarse con sujetos que tienen distintos puntos de vista al propio. El evaluado tiene grandes dificultades para establecer relaciones positivas y vínculos cercanos. Generalmente tiene grandes expectativas sobre el comportamiento que los demás deben tener y estas expectativas suelen estar insatisfechas. Analizar este puntaje a la par de la puntuación de la escala FS.
65-69	Existe una moderada disfunción en el funcionamiento interpersonal en cuanto a la capacidad de empatía y de intimidad del evaluado. Analizar este puntaje a la par de la puntuación de la escala FS.
≤ 64	El evaluado no presenta dificultades en el funcionamiento interpersonal en un nivel superior al esperado en la mayoría de los sujetos.

Afecto Negativo (AF)

◀ El rasgo *Afecto Negativo (AF)* representa la vivencia de emociones negativas del tipo ansiedad, depresión, inseguridad y preocupación. Quienes obtienen puntuaciones altas en esta escala sienten que sus emociones negativas son impredecibles y pueden invadirlos en cualquier momento. Además, se sienten incapaces de poder manejarlas (véase tabla 14).

Tabla 14. Interpretación de Afecto Negativo (AF)

Puntuación T	Interpretación
≥ 70	El evaluado presenta un gran abanico de emociones negativas que le resultan intolerables. En general se siente tenso, preocupado y ansioso. Normalmente se siente culpable e inseguro. En general le cuesta estar en soledad. Tiene una tendencia a sentirse triste, experimentar sentimientos de irritabilidad y enojo. Suele tener grandes dificultades para controlar el sentimiento de enojo.
60-69	Existe un grado moderado de labilidad emocional, ansiedad, inseguridad y agresividad.
≤ 59	El evaluado no presenta un grado de afecto negativo en un nivel superior al esperado en la mayoría de los sujetos.

Serenidad (SE)

◀ Puntajes altos en *Serenidad (SE)* representan sujetos caracterizados por tener una paz casi imperturbable. Tienen una gran capacidad para dominar las emociones negativas cuando se encuentran en situaciones fuera de su control, situaciones que les resultan desagradables o les generan incomodidad. Además suelen mantener la calma y el buen trato ante conflictos interpersonales en los que sus interlocutores expresan grandes emociones negativas (véase tabla 15).

Tabla 15. Interpretación de Serenidad (SE)

Puntuación T	Interpretación
≥ 65	Quienes obtienen puntuaciones dentro de este rango presentan generalmente un estado de paz casi imperturbable. Pueden contrarrestar fácil y rápidamente cualquier emoción negativa propia y ajena con conductas y sentimientos de calma y tranquilidad. Además, no tienen inconvenientes en verse involucrados en situaciones que estén fuera de su control o que resulten desagradables. Se sienten tranquilos y cómodos en la mayoría de los lugares. Manejan los conflictos interpersonales con calma y manteniendo un buen trato incluso si su/s interlocutor/es los maltratan.
60-64	El evaluado cuenta con los aspectos valorados en este factor en un nivel superior a lo comúnmente hallado en la población -tranquilidad casi imperturbable, gran manejo de emociones negativas propias y ajenas-. Este rasgo puede cumplir el rol de factor protector ante la presencia de aspectos patológicos propios y ante la exposición a un ambiente hostil.

40-59	La presencia de serenidad se da en un grado similar al esperado en la mayoría de los sujetos.
≤ 39	Existe un déficit en los aspectos que constituyen este rasgo. El evaluado informó que su capacidad para mantenerse tranquilo es baja o nula, tampoco hay manejo de las propias emociones negativas ni de las ajenas. Pocas veces experimentan paz y comodidad en los lugares y situaciones en las que se encuentran. La capacidad para manejarse con calma ante conflictos interpersonales es baja o nula.

Desapego (DA)

◀ Mediante *Desapego (DA)* se entiende un extremo desinterés del sujeto en los vínculos interpersonales. Quienes obtienen puntuaciones altas en Desapego tienen grandes dificultades para establecer relaciones de amistad o amorosas. Generalmente se sienten tan incómodos en situaciones sociales que de ser posible las evitan (véase tabla 16).

Tabla 16. Interpretación de Desapego (DA)

Puntuación T	Interpretación
≥ 70	Existe un gran desinterés en todo lo relacionado con los vínculos interpersonales especialmente a los vínculos de carácter íntimo, los cuales evita. El evaluado prefiere no asistir a reuniones sociales y prefiere mantenerse aislado aunque tenga la opción de vincularse con otras personas. Además experimenta anhedonia ya que pocas cosas le dan placer, no tiene capacidad de disfrute ni manifiesta interés por casi nada.
60-69	El evaluado presenta un nivel moderado de introversión/aislamiento, evitación de la intimidad y anhedonia.
≤ 59	El evaluado no presenta un grado de desapego en un nivel superior al esperado en la mayoría de los sujetos.

Humanidad (HU)

◀ Puntajes altos en *Humanidad (HU)* remiten a sujetos sumamente sensibles a lo que ocurre a su alrededor y que no tienen dificultades en mostrarse vulnerables o sensibles ante otros. No solo representan a sujetos que están volcados hacia los otros, hacia los vínculos, sino que además de ello estos sujetos son compasivos, solidarios con los demás, se movilizan con el sufrimiento ajeno y actúan con el fin de ayudar a sacar a otros del sufrimiento (véase tabla 17). Es posible que este rasgo predisponga a la vivencia de emociones negativas debido a la exposición voluntaria al sufrimiento ajeno. Por ello, será importante que se encuentre acompañado de la presencia de otros rasgos positivos como Serenidad (SE) y Vivacidad y Foco (VF).

Tabla 17. Interpretación de Humanidad (HU)

Puntuación T	Interpretación
≥ 65	Quienes obtienen puntuaciones dentro de este rango son individuos sumamente sensibles a lo que ocurre a su alrededor. Tienen una gran capacidad de percepción del sufrimiento ajeno, que los lleva a actuar con el fin de ayudar a apaciguarlo. Suelen involucrarse en acciones solidarias. Además se sienten cómodos mostrando su sensibilidad y vulnerabilidad. Se podría decir que quienes puntúan alto en este rasgo dan un gran valor a la humanidad propia y ajena.
60-64	El evaluado cuenta con los aspectos valorados en este factor en un nivel superior a lo comúnmente hallado en la población –sensibilidad al sufrimiento ajeno, ayuda y solidaridad a quienes lo necesitan, comodidad con la propia sensibilidad-. Este rasgo puede cumplir el rol de factor protector ante la presencia de aspectos patológicos propios y ante la exposición a un ambiente hostil.
40-59	La presencia de humanidad se da en un grado similar al esperado en la mayoría de los sujetos.
≤ 39	Existe un déficit en los aspectos que constituyen este rasgo. El evaluado no suele sensibilizarse con lo que ocurre a su alrededor y su capacidad de ayuda ante el sufrimiento ajeno es nula o baja. En general no se muestra sensible o vulnerable ante la presencia de otros.

Antagonismo (AN)

◀ Quienes obtienen puntuaciones altas en *Antagonismo (AN)* se caracterizan por conductas antisociales. Suelen recurrir a la agresividad, el engaño y la manipulación para lograr sus objetivos personales. Tienen sentimientos de superioridad y piensan que las reglas no los atañen por lo que pueden hacer lo que deseen con tal de lograr sus metas (véase tabla 18).

Tabla 18. Interpretación de Antagonismo (AN)

Puntuación T	Interpretación
≥ 70	El evaluado incurre frecuentemente en un amplio repertorio de conductas antisociales. Generalmente intenta sacar ventaja de las situaciones y las personas. No tiene inconvenientes en manipular a las personas y distorsionar el relato de los hechos para su propio provecho. Además tiene sentimiento de grandiosidad: piensa que los demás sujetos son inferiores a él y que su forma de ser no solo es superior sino que es la mejor.
60-69	Existe una moderada presencia de conductas de manipulación y engaño así como de sentimientos de grandiosidad.
≤ 59	El evaluado no presenta un grado de antagonismo en un nivel superior al esperado en la mayoría de los sujetos.

Integridad (IN)

◀ Personas con el rasgo positivo *Integridad (IN)* son personas en las que se puede confiar porque son sinceras en cuanto a sus intenciones, dicen la verdad, se muestran tal cual son y cumplen sus promesas. Sumado a ello son humildes, esperan siempre un trato igualitario y no tienen problemas en admitir sus errores (véase tabla 19).

Tabla 19. Interpretación de Integridad (IN)

Puntuación T	Interpretación
≥ 65	Quienes obtienen puntuaciones dentro de este rango son individuos con un compás moral arraigado. Se manejan con sinceridad y las personas pueden confiar en ellos. No alardean de sus logros y defienden el trato igualitario ya que sienten que todas las personas son igual de importantes. Además, se hacen cargo de sus responsabilidades y siempre intentan cumplir sus promesas. Les resulta natural y adecuado asumir sus propias fallas y errores.
60-64	El evaluado cuenta con los aspectos valorados en este factor en un nivel superior a lo comúnmente hallado en la población -honestidad, sinceridad, modestia-. Este rasgo puede cumplir el rol de factor protector ante la presencia de aspectos patológicos propios y ante la exposición a un ambiente hostil.
40-59	La presencia de integridad se da en un grado similar al esperado en la mayoría de los sujetos.
≤ 39	Existe un déficit en los aspectos que constituyen este rasgo. El evaluado no suele manejarse con sinceridad, no encuentra valor en el trato igualitario, no suele hacerse cargo de sus responsabilidades y en general no asume sus propias fallas y errores.

Desinhibición (DI)

◀ El rasgo *Desinhibición (DI)* se refiere a una gran impulsividad en la conducta. Los sujetos con esta característica buscan la gratificación inmediata sin considerar las posibles consecuencias de sus actos. Generalmente incurren y re-incurren en conductas riesgosas (véase tabla 20).

Tabla 20. Interpretación de Desinhibición (DI)

Puntuación T	Interpretación
≥ 70	Generalmente el sujeto tiene dificultades para cumplir con sus responsabilidades y compromisos. Tiende a tener conductas impulsivas relacionadas con el consumo de alcohol y drogas. Además, presenta usualmente dificultades para concentrarse ya que se distrae fácilmente.
60-69	Existe una moderada presencia de irresponsabilidad, impulsividad en el consumo de sustancias y distractibilidad.
≤ 59	El evaluado no presenta un grado de desinhibición en un nivel superior al esperado en la mayoría de los sujetos.

Moderación (MO)

◀ Los sujetos caracterizados poseer el rasgo *Moderación (MO)* se toman el tiempo necesario para ponderar bien riesgos y ganancias antes de actuar. Planifican sus acciones pensando en las consecuencias y siempre que pueden evitan riesgos (véase tabla 21). Es posible que puntuaciones extremas en este rasgo redunden en una rumiación paralizante por lo que se debe contrastar con las puntuaciones del rasgo Vivacidad y Foco.

Tabla 21. Interpretación de Moderación (MO)

Puntuación T	Interpretación
≥ 65	Quienes obtienen puntuaciones dentro de este rango son individuos que otorgan gran valor al tiempo dedicado a la planificación y ponderación de costos y beneficios de las distintas opciones de acción posibles. En general no improvisan ya que entienden que tomar un tiempo para considerar las diferentes opciones de acción y sus posibles consecuencias es parte de cualquier toma de decisión. Suelen evitar embarcarse en acciones riesgosas innecesarias.
60-64	El evaluado cuenta con los aspectos valorados en este factor en un nivel superior a lo comúnmente hallado en la población –planificación, prudencia–. Este rasgo puede cumplir el rol de factor protector ante la presencia de aspectos patológicos propios y ante la exposición a un ambiente hostil.
40-59	La presencia de moderación se da en un grado similar al esperado en la mayoría de los sujetos.
≤ 39	Existe un déficit en los aspectos que constituyen este rasgo. El evaluado no suele tomar un tiempo para planificar sus acciones, no tiene en consideración las posibles consecuencias de sus actos y no evita riesgos innecesarios.

Psicoticismo (PS)

◀ La escala *Psicoticismo (PS)* evalúa una percepción distorsionada de la realidad. Puntuaciones altas indican la presencia de experiencias extrañas generalmente ligadas con alucinaciones o delirios (véase tabla 22). En esta escala se valoran elementos que pueden coincidir con creencias religiosas y/o espirituales, ello puede elevar la puntuación de la escala y no son indicadores de psicopatología. En caso de haber obtenido una puntuación elevada, el evaluador deberá contrastar la información obtenida con un criterio diagnóstico externo.

Tabla 22. Interpretación de Psicoticismo (PS)

Puntuación T	Interpretación
≥ 80	La puntuación en esta escala es extremadamente alta e inusual. El evaluador deberá tomar esta puntuación como un indicador de riesgo y continuar la evaluación diagnóstica con otras herramientas hasta arribar a un diagnóstico acabado y certero de la psicología característica del evaluado.
70-79	El evaluado presenta una marcada presencia de experiencias inusuales tales como ver cosas, animales o personas que no están, o percibir seres que no se hallan presentes físicamente. Además, tiene dificultades para diferenciar la fantasía de la realidad y manifiesta experiencias de disociación. Es posible que tenga ideas inusuales, tales como que tiene una misión especial en este mundo, que tiene poderes o que es observado por un ser superior. Todos estos componentes deben ser contrastados con los componentes religiosos y/o espirituales del sujeto.
60-69	Existe una moderada presencia de alteración de la percepción, creencias inusuales y experiencias extrañas. Contrastar con una entrevista clínica para verificar si el contenido es de índole religioso, espiritual u otro.
≤ 59	El evaluado no presenta un grado de psicoticismo en un nivel superior al esperado en la mayoría de los sujetos.

Vivacidad y Foco (VF)

◀ El rasgo *Vivacidad y Foco* (VF) remite a sujetos que saben lo que quieren, tienen sus objetivos claros, pueden concentrar su energía para intentar lograrlos y disfrutan de lo que hacen cotidianamente. Los sujetos que puntúan alto en esta escala se sienten activos, enérgicos, satisfechos, útiles y seguros de sí mismos (véase tabla 23).

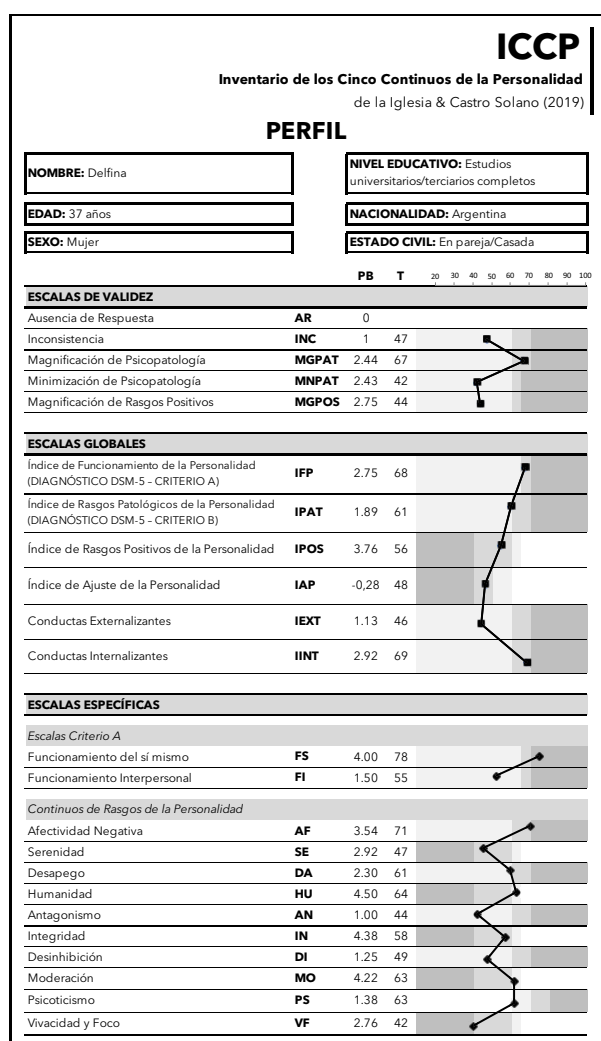
Tabla 23. Interpretación de Vivacidad y Foco (VF)

Puntuación T	Interpretación
≥ 65	Puntuaciones que caigan en este rango resultan excepcionales y darán cuenta de la presencia de un modo usual de actuar, sentir y pensar ligado a la búsqueda y vivencia de bienestar, seguridad en sí mismo, el foco en las metas personales y la sensación de energía y capacidad para llevarlas a cabo. Los sujetos con alta vivacidad y foco cuentan con un factor protector que los ayudará a sobrellevar los posibles vaivenes de la vida y que los impulsará a funcionar óptimamente en el mundo.
60-64	El evaluado cuenta con los aspectos valorados en este factor en un nivel superior a lo comúnmente hallado en la población -energía, concentración, seguridad en sí mismo, capacidad de disfrute, metas personales claras-. Este rasgo puede cumplir el rol de factor protector ante la presencia de aspectos patológicos propios y ante la exposición a un ambiente hostil.
40-59	La presencia de vivacidad y foco se da en un grado similar al esperado en la mayoría de los sujetos.
≤ 39	Existe un déficit en los aspectos que constituyen este rasgo. El evaluado informó que su capacidad de disfrute es baja o nula, tampoco hay presencia de seguridad de sí mismo, su capacidad de concentración es limitada, y posiblemente exista confusión en cuanto a las metas personales.

CASUÍSTICA

En este apartado describiremos algunos casos evaluados con el ICCP. Todos ellos son casos reales en los que se modificó información descriptiva y anecdótica para resguardar la confidencialidad de los evaluados. El lector podrá visualizar que con un fin ilustrativo se mencionan los nombres de las escalas y los puntajes obtenidos junto con su interpretación. Esto se realizó con el único fin de ejemplificar el modo de interpretarlos. En la práctica, los profesionales deberían resguardar el dato de los nombres de las escalas y los puntajes obtenidos y no mencionarlos en el informe descriptivo del caso debido a que los nombres de las escalas pueden prestarse a confusión para quienes no se dedican a la psicología y las puntuaciones pueden resultar estigmatizantes o ser malinterpretadas por otros profesionales o profesionales no capacitados en el uso de este test.

1. CASO DELFINA



por ahora
queda así

Figura 1. Perfil del caso Delfina

Contextualización del caso

Se trata de una mujer de 37 años, que inició psicoterapia hace tres meses. El diagnóstico inicial presuntivo es de trastorno depresivo persistente (distimia). Al momento de la evaluación no tomaba medicación psiquiátrica. Los siguientes son los resultados del test.

Interpretación de la información obtenida mediante el test

El perfil de Delfina resulta ser válido ya que no presenta ausencia de respuestas y ha contestado a todos los ítems del test. El indicador de respuestas inconsistentes es bajo (T47), lo que estaría indicando que contestó de forma coherente a todos los elementos de la prueba, que estuvo concentrada durante la evaluación y que no contestó por azar.

La escala de minimización de rasgos patológicos se encuentra dentro de los límites esperados (T42), lo que nos indica que la evaluada contestó con baja deseabilidad social, no intentó mostrar una imagen favorable de sí misma. El indicador de magnificación de psicopatología se encuentra por encima de los parámetros esperados (T67). Esto nos indica que la evaluada ha señalado como presentes aspectos patológicos que la mayoría de los sujetos no poseen o no informan tener. Esto puede ser compatible con una tendencia a mostrar una imagen más desfavorable de sí misma.

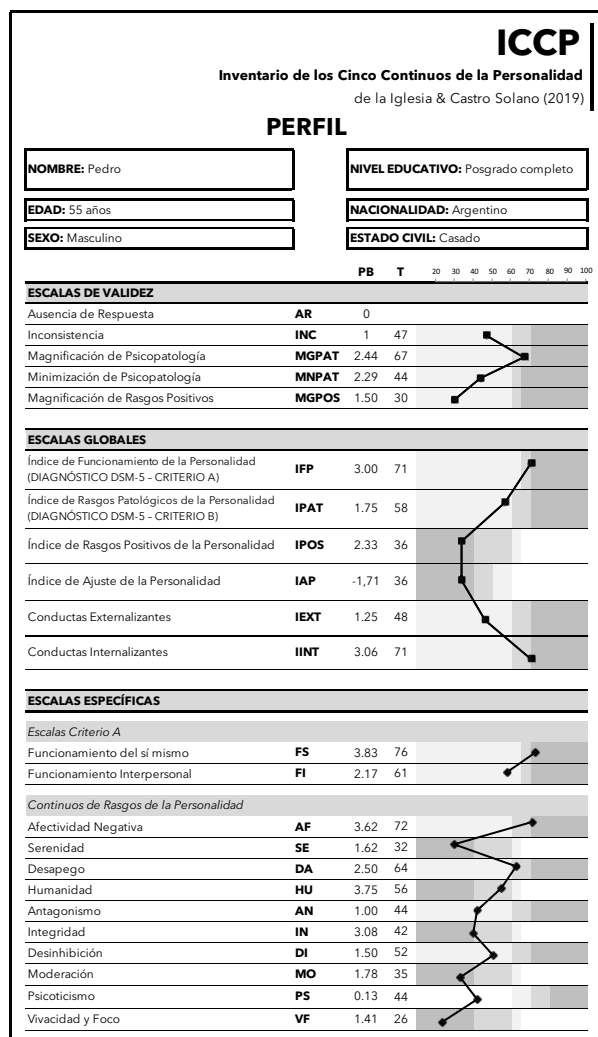
En términos generales el *funcionamiento general* de la personalidad (criterio A) está disminuido y debe descartarse la presencia de un trastorno de la personalidad (T68). Más detalladamente, las dificultades se dan en torno al *funcionamiento del sí-mismo*. Delfina presenta dificultades en cuanto a la definición de propia identidad, tiene dificultades en los límites entre sí misma y los otros, también le resulta difícil establecer metas personales realizables y llevarlas a cabo. Su autoestima es bastante inestable y su capacidad de regulación emocional es baja. No se hallan dificultades en cuanto a su *funcionamiento interpersonal* (empatía e intimidad).

En cuanto a los rasgos de personalidad patológicos, a nivel global Delfina tiene una puntuación algo elevada (T61). Se visualiza que los aspectos patológicos presentes son de carácter internalizante (IINT T69), es decir, de índole emocional. Esto se evidencia también en la elevación de las puntuaciones en los rasgos *afectividad negativa* y *desapego*. Afectividad negativa es el rasgo patológico más elevado e indica la tendencia a presentar frecuentemente emociones negativas (e.g. ansiedad, depresión, inseguridad, preocupación, enojos) y poca capacidad para manejarlas. La puntuación elevada en desapego nos da pauta de dificultades para establecer vínculos afectivos e incomodidad en las relaciones sociales, con una tendencia a evitarlas. Además, nos informa acerca de la presencia de signos de anhedonia característicos de cuadros depresivos. También se observa una elevación en la escala *psicoticismo*, lo que indica la presencia de creencias y/o experiencias inusuales. Se debe indagar con mayor profundidad estos aspectos para descartar algún trastorno psicológico grave. La combinación de puntuaciones elevadas en estos rasgos patológicos y de los componentes del criterio A podrían ser compatibles con alguno de los siguientes diagnósticos de trastornos de la personalidad: *evitativo* y/o *esquizotípico*. Deben contrastarse estos resultados con otros criterios diagnósticos externos (e.g. entrevista clínica estructurada) para confirmar o rechazar esos posibles diagnósticos.

En términos generales, la presencia de rasgos positivos de Delfina es la esperada (IPOS T56). La evaluada cuenta con una presencia superior a la esperada en los rasgos de personalidad positivos *humanidad* y *moderación*. El rasgo humanidad nos señala que Delfina tiene una gran sensibilidad a lo que ocurre en su entorno. La evaluada tiene una especial capacidad para percibir el sufrimiento y la necesidad ajenos, los que la motorizan a actuar en consecuencia para apaciguar el malestar y fomentar el bienestar de quienes la rodean. La presencia de este rasgo positivo es interesante dado el nivel observado de su versión patológica: *desapego*. Es posible, y recomendable, que Delfina se enfoque en su natural inclinación hacia la ayuda de otros y su sensibilidad al sufrimiento ajeno para indirectamente involucrarse en vínculos interpersonales y compensar su tendencia al aislamiento y a la anhedonia. Por otra parte, la presencia en un nivel superior al esperado del rasgo positivo moderación nos indica que Delfina tiende a ponderar adecuadamente los riesgos y beneficios antes de tomar decisiones y de actuar. Esto nos habla de una buena capacidad de control y de estabilidad en su personalidad, lo que podría tener un impacto positivo tanto en los componentes de la afectividad negativa como en los del psicoticismo.

El ajuste total de su personalidad coincide con el perfil de una *personalidad vulnerable* (IAP48) aunque se encuentra en el límite con el perfil correspondiente a una personalidad patológica compensada. Delfina cuenta con cierta presencia de rasgos positivos pero éstos no son suficientes como para compensar los aspectos patológicos que se encuentran en un nivel que requieren atención aunque no son alarmantes. Esto la posiciona en una situación de vulnerabilidad o de riesgo, y estará más propensa a padecer sintomatología y a tener dificultades para desenvolverse en distintos aspectos de su vida. La psicoterapia podría enfocarse en un mayor desarrollo de sus rasgos positivos ya que es posible que en ellos se encuentren muchos recursos para tratar los patológicos.

2. CASO PEDRO



por ahora
queda así

Figura 2. Perfil del caso Pedro

Contextualización del caso

El evaluado es un hombre de 55 años que tiene como diagnóstico inicial un trastorno de ansiedad social. Pedro manifiesta tener dificultades para vincularse y muchos miedos. Recientemente se enteró de que padece una enfermedad crónica.

Interpretación de la información obtenida mediante el test

El perfil de Pedro resulta interpretable ya que respondió a todos los ítems y sus respuestas han sido lo suficientemente coherentes entre sí. En relación con la posible distorsión de respuesta, es posible que Pedro haya magnificado sus aspectos pato-

lógicos (T67) para dar una imagen desfavorable de sí mismo ya que dio por presentes muchos ítems patológicos que son infrecuentes en la población, o que esto se deba a que padece una patología grave y fácilmente observable (debe contrastarse con antecedentes y criterios diagnósticos externos). Las escalas de minimización de rasgos patológicos y magnificación de rasgos positivos se encuentran dentro de los rasgos esperados por lo que no se sospecha que haya contestado de una manera socialmente deseable o haya exagerado sus aspectos positivos.

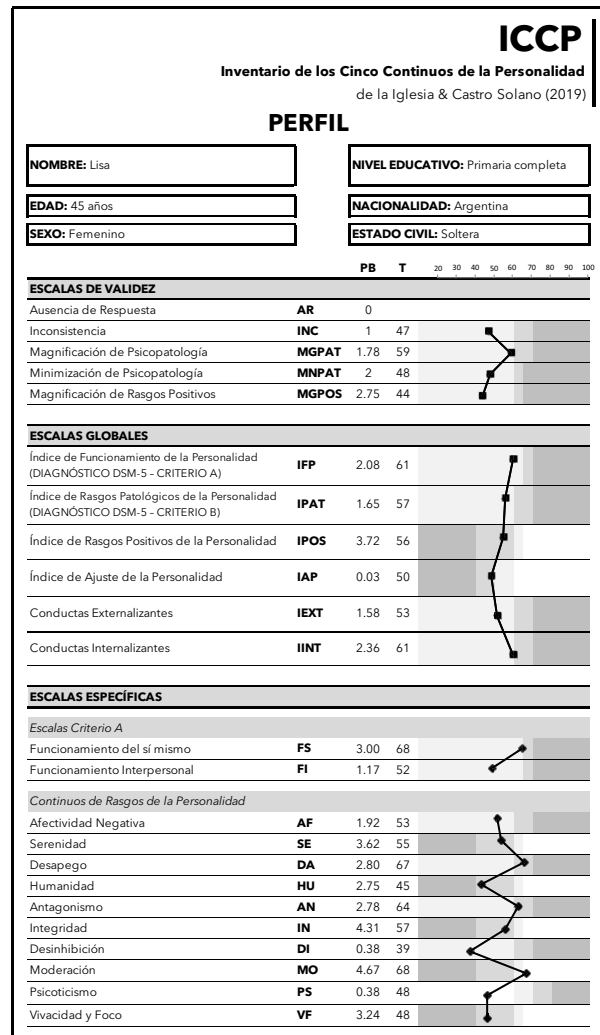
El indicador de funcionamiento de la personalidad (criterio A) nos da pauta de que es probable que el sujeto cumpla con los criterios diagnósticos de uno o más trastornos de la personalidad. En el caso de Pedro las dificultades observadas se dan en el *funcionamiento del sí-mismo* (T76). Pedro encuentra problemas para definir su propia identidad y para establecer claramente los límites entre sí mismo y los otros. Su autoestima es lábil y tiene poca regulación emocional. Existen dificultades para establecer metas personales coherentes y llevarlas a cabo.

Los rasgos patológicos de Pedro se encuentran dentro de lo esperado aunque cercano al límite superior, lo que informaría patología (T58). Al desglosarse los aspectos patológicos en conductas externalizantes e internalizantes, puede verse con claridad la elevada puntuación de aspectos patológicos internalizantes. Esto se evidencia también en las puntuaciones elevadas de los rasgos que componen ese índice: *afectividad negativa* y *desapego*. La presencia elevada de estos rasgos nos da pauta de una marcada tendencia a experimentar emociones negativas que le resultan incontrolables (tristeza, enojo, inseguridad, preocupación, culpa). Además, Pedro se caracteriza por un desinterés en establecer vínculos interpersonales íntimos y por asistir a reuniones sociales. En general, Pedro tiene poca capacidad de disfrute y le cuesta interesarse en algo.

Los rasgos positivos, por el contrario, se encuentran disminuidos (T36). Pedro tiene un déficit en los rasgos *serenidad* (T32), *moderación* (T35) y en *vivacidad y foco* (T26). De todos ellos, resulta más relevante el rasgo serenidad ya que se combina con una alta presencia de afectividad negativa, por lo que se estima que la inundación de emociones negativas es prácticamente constante e inmanejable para Pedro. La baja presencia del rasgo moderación nos indica poca capacidad de planificación y ponderación de riesgos previo al actuar. En el caso de Pedro, esto se da junto con una presencia no patológica del rasgo desinhibición por lo que el riesgo de incurrir en conductas impulsivas y riesgosas no es tan elevado aunque sí está levemente presente. Finalmente, la baja presencia del rasgo vivacidad y foco nos da pauta de una gran dificultad para disfrutar, poca seguridad en sí mismo, poca concentración y posiblemente gran confusión en cuanto a las metas personales.

El desbalance entre la presencia de rasgos patológicos y rasgos positivos se ve reflejado en el índice de *ajuste de la personalidad*, que es compatible con un diagnóstico de *personalidad patológica*. Los rasgos patológicos son predominantes y Pedro no cuenta con rasgos positivos para contrabalancearlos. Es posible que Pedro tenga dificultades para desempeñarse en muchas áreas de su vida y desarrolle sintomatología psicológica y física con facilidad. Debería indagarse en mayor profundidad y mediante indicadores clínicos más específicos acerca de la presencia de un trastorno de la personalidad evitativa. La terapia de Pedro debería focalizarse enfáticamente en el desarrollo de las características implicadas en los rasgos *serenidad* y *vivacidad y foco* ya que serán posiblemente los que mejor puedan contrarrestar su psicopatología.

3. CASO LISA



por ahora
queda así

Figura 3. Perfil del caso Lisa

Contextualización del caso

Protocolo enviado por la terapeuta a cargo del paciente. Se trata de una mujer de 45 años, que realiza una consulta psicoterapéutica, manifestando experimentar ataques de ira que le resultan incontrolables.

Interpretación de la información obtenida mediante el test

El perfil de Lisa resulta ser válido ya que no tiene ausencia de respuestas y ha contestado a todos los ítems del test. Asimismo, su patrón de inconsistencias es bajo (T47) lo que estaría indicando que contestó de forma coherente a todos los elementos de la prueba, que estuvo concentrada durante la evaluación y que no contestó por azar.

Las escalas de minimización de psicopatología y de rasgos positivos se encuentran dentro de los límites normales, por lo que podemos inferir que la evaluada contestó tanto a los ítems positivos como a los patológicos de forma sincera y con baja deseabilidad social. La escala de magnificación de psicopatología se encuentra dentro de los límites esperados. Todos estos indicadores nos informan que no existen evidencias de distorsión en las respuestas con el fin de mostrarse favorable ni desfavorablemente.

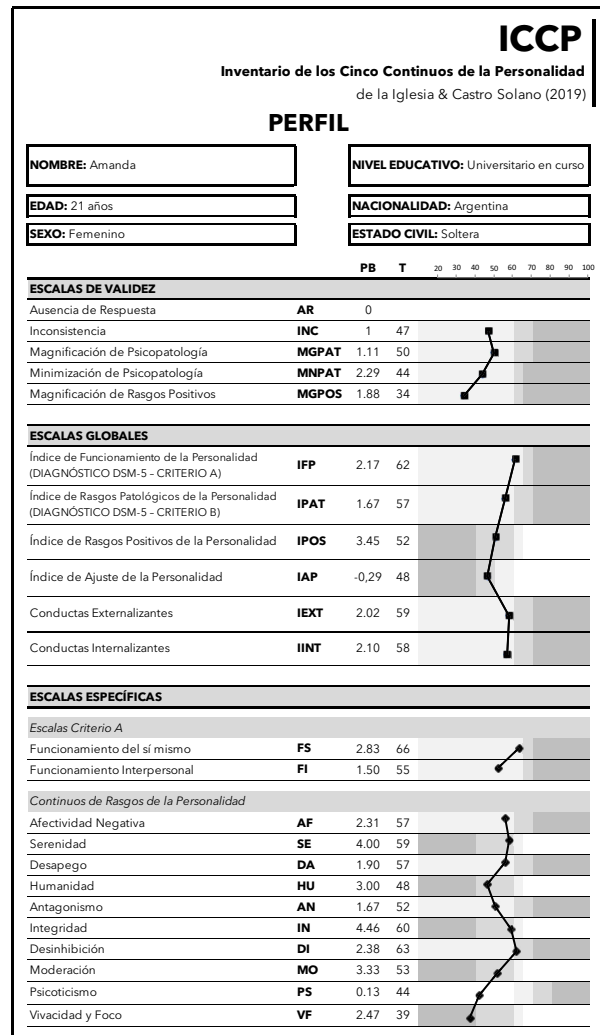
El índice de *funcionamiento de la personalidad* (criterio A) se encuentra dentro de los parámetros esperados (T61) por lo que no se sospecha la presencia de algún trastorno de la personalidad. Del análisis de sus subescalas se evidencian ciertas dificultades en el *funcionamiento del sí-mismo*, lo que nos da pauta de problemas en cuanto a la definición de la identidad, el establecimiento de límites entre sí misma y los otros, baja autoestima y la definición de metas personales. No se hallan dificultades marcadas en el *funcionamiento interpersonal*.

A nivel global, Lisa presenta puntuaciones esperadas en cuanto a los rasgos patológicos evaluados, aunque su presencia está cercana al límite superior (T57). El análisis desglosado de los rasgos de personalidad patológicos denota que Lisa tiene puntuaciones elevadas en *desapego* y *antagonismo*. La puntuación elevada en *desapego* estaría señalando dificultades para establecer vínculos afectivos e incomodidad en las relaciones sociales, con tendencia a evitarlas. Además, nos indica la presencia de anhedonia, en general tiene desinterés por lo que le ocurre y no suele disfrutar de lo que le ocurre. La elevación en el rasgo antagonismo nos informa acerca de una tendencia a sentirse superior a las personas que la rodean y a manejarse con engaños y manipulación para obtener lo que desea.

En relación con los rasgos positivos, en su valoración global éstos se encuentran levemente disminuidos. *Humanidad* se encuentra en niveles esperados aunque cercanos al límite inferior (T45). El nivel de presencia de este rasgo posiblemente no es lo suficientemente elevado como para contrarrestar la patología hallada en su contraparte (*desapego*). El rasgo *moderación* se halla en un nivel superior al comúnmente hallado en la población general. Esto da cuenta de la tendencia de Lisa a tomarse un tiempo para pensar y planificar antes de actuar. Lisa pondera los beneficios y costos de sus acciones antes de tomar decisiones. Esto generalmente es una característica positiva que previene conductas impulsivas que podrían ser dañinas para el sujeto o para su entorno. En el caso de Lisa, su combinación con un elevado antagonismo podría ser contraproducente ya que podría potenciar sus conductas de engaño y manipulación. Esto debería contrastarse con otros indicadores clínicos. De lo valorado por este instrumento, no se observan en Lisa indicadores que validen su motivo de consulta. De hecho, el continuo de rasgos *afectividad negativa-serenidad*, se encuentra en los niveles esperados. Es posible entonces, que los ataques de ira que son motivo de consulta tengan carácter de sintomatología y no sean fruto de su personalidad.

En relación con su *ajuste global de la personalidad*, Lisa se encuentra en el límite entre los diagnósticos de *personalidad vulnerable* y *personalidad patológica compensada*. Debería indagarse en mayor profundidad y mediante indicadores clínicos más específicos acerca de la presencia de un trastorno de la personalidad narcisista. El foco en el rasgo positivo *integridad*, que se encuentra dentro del límite superior de los valores esperados, podría ser una buena estrategia para compensar o disminuir sus características antagónicas y también posiblemente su sintomatología.

CASO AMANDA



por ahora
queda así

Figura 4. Perfil del caso Amanda

Contextualización del caso

Se trata de una joven de población general no consultante, cuya profesión es actriz. Tiene estudios universitarios en curso.

Interpretación de la información obtenida mediante el test

El perfil de Amanda resulta ser válido ya que no tiene ausencia de respuestas, ha contestado a todos los ítems del test. Asimismo, su patrón de inconsistencias es bajo (T47), ello indica que contestó de forma coherente a todos los elementos de la prueba, que estuvo concentrada durante la evaluación y que no contestó por azar.

Tanto las escalas de magnificación de psicopatología como la de rasgos positivos, como las de minimización de psicopatología se encuentran dentro de los límites normales. Esto indica que la evaluada contestó a los ítems de forma sincera y con baja deseabilidad social. Asimismo, dado que la escala de magnificación de psicopatología se encuentra dentro de los límites normales se trata de un perfil típico de población general sin mayor grado de psicopatología y no se sospecha exageración de sintomatología.

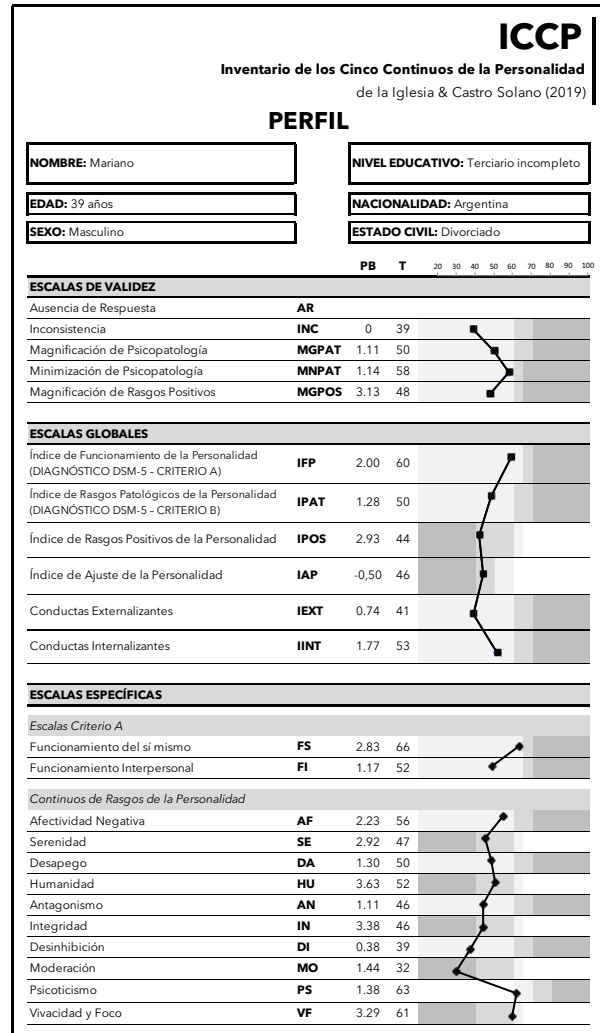
Amanda presenta niveles esperados en el indicador global del criterio A (*funcionamiento de la personalidad*), por lo que no se sospecha la presencia de un trastorno de la personalidad. De la valoración de sus subescalas, se evidencia una pequeña elevación de la escala *funcionamiento del sí-mismo* (T66) que se corresponde con dificultades en la definición de la propia identidad y para establecer límites claros entre sí misma y los otros. Su autoestima es lábil y tiene poca regulación emocional. Es posible que existan dificultades para establecer metas personales coherentes y llevarlas a cabo. Todo esto podría ser un reflejo del momento del ciclo vital en el que se encuentra la evaluada (adultez temprana) y no necesariamente un indicador de psicopatología. No se hallan dificultades en el *funcionamiento interpersonal*.

A nivel global, no se evidencia una presencia superior a la esperada de rasgos patológicos de la personalidad. Del análisis detallado de cada rasgo, se observa que Amanda tiene una única puntuación elevada en el rasgo *desinhibición* (T63). El resto de los rasgos patológicos se encuentra dentro del rango esperado. La elevación del rasgo desinhibición informa una tendencia a tener ciertas dificultades para cumplir con sus responsabilidades y compromisos, la posible presencia de conductas impulsivas relacionadas con el consumo de alcohol y/o drogas, y distractibilidad. Estos aspectos podrían estar relacionados con las características necesarias para ejercer su profesión de actriz y también a lo antedicho acerca de su ciclo vital. Sumado a ello, el rasgo positivo moderación se encuentra dentro de los límites esperados, por lo que complementa y posiblemente contrabalancee la presencia de desinhibición, no encontrándose así Amanda en una situación evidente de riesgo.

El nivel general de rasgos positivos es el esperado, y el rasgo *integridad* se halla levemente aumentado (T60). Esto nos estaría señalando que Amanda es una persona sincera y que no tiene segundas intenciones, que se maneja honestamente y puede asumir sus fallas y errores sin problemas. Además, se estima que es modesta y espera un trato igualitario en cuanto al resto de las personas. Este rasgo positivo podría cumplir el rol de protector ante un medio ambiente hostil y servirá a Amanda para el establecimiento y mantenimiento de vínculos interpersonales sanos.

El *índice de ajuste de la personalidad* se encuentra en la zona de diagnóstico de *personalidad vulnerable* y en el límite del diagnóstico de *personalidad psicopatológica compensada* (T49). Sería ideal que Amanda desarrolle aún más los rasgos positivos de los que dispone para poder contar con un contrabalanceo mayor de rasgos patológicos-positivos. Del análisis de las escalas específicas no se evidencian elementos suficientes como para diagnosticar un trastorno de la personalidad. Sería prudente seguir la evolución de Amanda a lo largo de su transición por este ciclo vital y alentar sus características positivas con el fin de que cuente con mayores recursos que le serán útiles ante situaciones difíciles.

CASO MARIANO



por ahora
queda así

Figura 5. Perfil del caso Mariano

Contextualización del caso

Se trata de un adulto masculino de población general no consultante, que trabaja realizando sesiones de reiki.

Interpretación de la información obtenida mediante el test

El perfil de Mariano resulta ser válido ya que no tiene ausencia de respuestas y ha contestado a todos los ítems del test. Asimismo, su patrón de inconsistencias es bajo (T39). Esto indica que contestó de forma coherente a todos los elementos de la prueba, que estuvo concentrado durante la evaluación y que no contestó por azar.

Tanto las escalas de magnificación de psicopatología como la de rasgos positivos se encuentran dentro de los límites normales. Esto indica que el evaluado contestó a los ítems de forma sincera y con baja deseabilidad social. La escala de magnificación de psicopatología se encuentra algo elevada, lo que estaría indicando que tal vez el sujeto esté informando menor psicopatología de la que realmente padece.

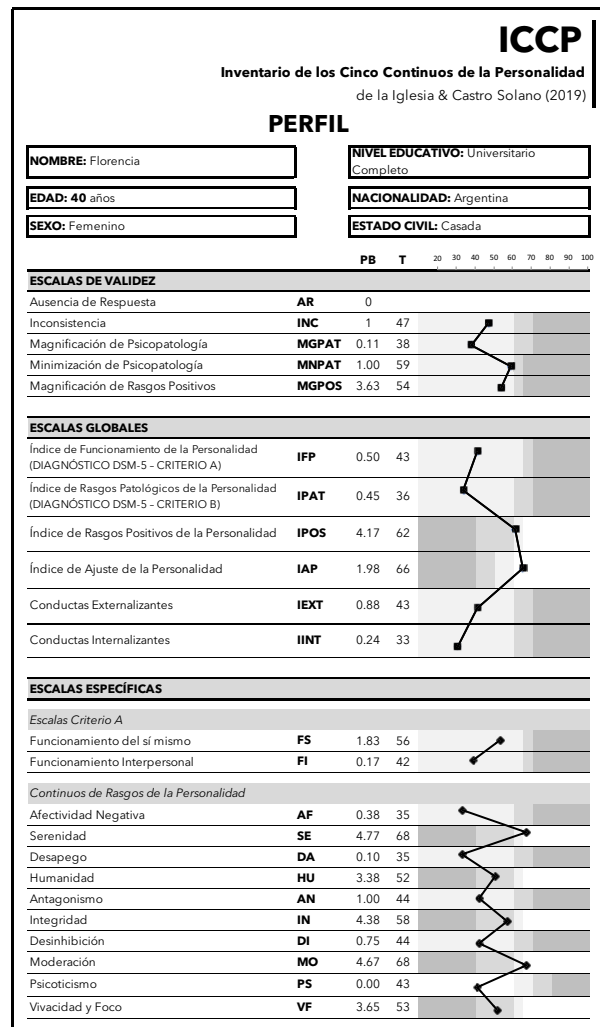
No se evidencian dificultades en el *funcionamiento de la personalidad* (criterio A) por lo que no se sospecha la presencia de algún trastorno de la personalidad. En análisis de la subescalas se visualizan ciertas dificultades en el *funcionamiento de sí-mismo*. Es decir, Mariano presentaría algunos problemas en cuanto a la definición de su identidad, el límite entre sí-mismo y los otros, y el establecimiento de metas personales realistas. No se hallan dificultades en el *funcionamiento interpersonal*.

En relación con el indicador resumen de todos los rasgos patológicos puede decirse que se encuentra dentro de los límites esperados. En cuanto a los rasgos de personalidad patológicos se visualiza una única puntuación por encima de lo esperado en el rasgo *psicoticismo* (T63). Dentro de este rasgo se valoran elementos que indican la presencia de creencias y/o experiencias inusuales o extrañas. Dada su profesión de reikista, es esperable que Mariano presente un tipo de personalidad poco convencional con un pensamiento de corte místico o espiritual y una particular visión del mundo. Es probable que la elevación de esta escala se deba a este aspecto de su vida, especialmente por las puntuaciones dentro del rango esperado de los otros rasgos patológicos.

En cuanto a los rasgos positivos, globalmente se encuentran dentro de los valores esperados aunque cercanos al límite inferior (T44). Un análisis a nivel de las escalas de rasgos positivos nos demuestra que el rasgo positivo *vivacidad y foco* (T61) está presente en un grado superior a la población general. Esto indica que Mariano cuenta con energía, concentración y capacidad de disfrute. Este rasgo es un factor protector muy importante y predictor de buenos resultados psicológicos. También brinda mayores evidencias a que la elevación del rasgo psicoticismo no se debe a una percepción distorsionada de la realidad de índole patológica, sino que es debida a su profesión. Se halla cierto déficit en el rasgo *moderación*, lo que indica que la capacidad para planificar y ponderar riesgos y consecuencias antes de actuar se encuentra disminuida. Esto sería grave en caso de hallarse elevada la escala desinhibición, pero este no es el caso en Mariano, por lo que no existe un riesgo elevado de incurrir en conductas riesgosas.

El análisis de *índice de ajuste de la personalidad* ubica a Mariano dentro de la zona de diagnóstico de *personalidad vulnerable*: la presencia de rasgos patológicos no es grande pero tampoco hay una gran presencia de rasgos positivos que sirvan de factores protectores. Esto ubica a Mariano en una situación de cierta vulnerabilidad a desarrollar sintomatología en caso de hallarse en situaciones sumamente difíciles. No existen elementos que den pauta de la presencia de un trastorno de la personalidad. Mariano cuenta con una elevada presencia de vivacidad y foco lo cual es una gran fortaleza ya que se trata del rasgo positivo asociado a mejores escenarios en distintas áreas de la vida. De todos modos, sería ideal fomentar en Mariano el mayor desarrollo de otros rasgos positivos tales como humanidad y serenidad, que se encuentran dentro de los límites esperados, pero de incrementarse funcionarían como factores protectores y lo moverían de la zona de vulnerabilidad.

CASO FLORENCIA



por ahora
queda así

Figura 6. Perfil del caso Florencia

Contextualización del caso

Se trata de una adulta de población general, de 40 años, con estudios universitarios completos, de nivel económico medio alto.

Interpretación de la información obtenida mediante el test

El perfil de Florencia resulta ser válido ya que no tiene ausencia de respuestas y ha contestado a todos los ítems del test. Asimismo, su patrón de inconsistencias es bajo (T47), ello indica que contestó de forma coherente a todos los elementos de la prueba, que estuvo concentrada durante la evaluación y que no contestó por azar.

Tanto las escalas de magnificación de psicopatología como la de rasgos positivos se encuentran dentro de los límites normales. Esto indica que la evaluada contestó a los ítems de forma sincera y con baja deseabilidad social. La escala de minimización de psicopatología se encuentra algo elevada (aunque dentro de límites normales, T59) lo que estaría señalando que marcó pocos ítems psicopatológicos, mostrándose libre de malestar psicológico.

Su funcionamiento de la personalidad se encuentra dentro de los valores esperados tanto en su medición global con sus subescalas por lo que no se sospecha la presencia de algún trastorno de la personalidad ni se evidencian dificultades en cuanto al funcionamiento tanto del sí-mismo como de las relaciones interpersonales.

A nivel global tampoco se observa la presencia de rasgos patológicos (IPAT; IEXT; IINT) lo cual coincide con la baja elevación de las escalas específicas de rasgos. Por el contrario, Florencia presenta una elevada presencia de rasgos positivos (T62). Los rasgos positivos *serenidad* y *moderación* se encuentran con puntuaciones elevadas (T68). Esto nos da pauta de una presencia superior a la esperada en estos aspectos positivos que constituyen fortalezas de su personalidad. Florencia presenta un buen equilibrio emocional con un estado de paz imperturbable que le ayuda a contrarrestar rápidamente cualquier emoción negativa que sienta y a manejar cualquier situación interpersonal conflictiva con mucha calma. Asimismo, por la puntuación elevada en *moderación* nos da pauta de que Florencia otorga un tiempo valioso a la planificación y a la ponderación de costos y beneficios cuando tiene que emprender un curso de acción determinado y que suele evitar situaciones riesgosas.

Su índice de *ajuste de la personalidad* es alto (T66) lo que la ubica dentro de la zona de *personalidad completamente sana*. Florencia se caracteriza por una gran presencia de rasgos positivos y la ausencia de rasgos psicopatológicos. En suma, Florencia no presenta indicadores de psicopatología, ni alteraciones en su personalidad. Se puede pronosticar un funcionamiento como óptimo en distintas áreas de la vida.

Referencias bibliográficas

DEL CAPÍTULO 1. LA PERSONALIDAD NORMAL

- Allport, G. (1937). *Personality: A Psychological Interpretation*. Nueva York: Holt.
- Allport, G. W. & Odbert, H. S. (1936). Trait-names: A psychol-lexical study. *Psychological Monographs*, 47(1), i-171.
- Barenbaum, N. B. & Winter, D. G. (2008). History of modern personality theory and research. En O. P. John, R. W. Robins & L. A. Pervin (Eds.), *Handbook of Personality. Theory And Research* (pp. 3-20). Nueva York: Guilford Press.
- Ben-Porath, Y. S. & Tellegen, A. (2009). *MMPI-2-RF. Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota 2*. Madrid: TEA.
- Berry, H. W. (1969). On cross-cultural comparability. *International Journal of Psychology*, 4, 119-128.
- Buck, J. N. (1947). The HTP, a projective device. *American Journal of Mental Deficiency*, 51, 606-610.
- Buck, J. N. (1948). The HTP Technique. A qualitative and quantitative scoring Manual. *Journal of Clinical Psychology*, 4, 317-396.
- Burns, R. C. & Kaufman, S. H. (1978). *Los dibujos kinéticos de la familia como técnica psicodiagnóstica*. Buenos Aires: Paidós.
- Castro Solano, A. (2005). *Técnicas de evaluación psicológica en los ámbitos militares*. Buenos Aires: Paidós.
- Castro Solano, A. (2014). Concepciones teóricas de la personalidad. Modelos teóricos y definiciones. En M. Fernández Liporace & A. Castro Solano (Eds.), *Evaluación de la personalidad normal y sus trastornos* (pp. 15-32). Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Castro Solano, A. (2017). La evaluación psicológica infantil. Aspectos conceptuales. En A. Castro Solano & M. Fernández Liporace (Eds.), *Evaluación psicológica en niños* (pp. 23-40). Buenos Aires: Paidós.
- Castro Solano, A. & Casullo, M. M. (2001). Rasgos de personalidad, bienestar psicológico y rendimiento académico en adolescentes argentinos. *Interdisciplinaria*, 18(1). 65-85.
- Castro Solano, A., Casullo, M. & Pérez, M. (2004). *Aplicaciones del MIPS en los ámbitos laboral, educativo y médico*. Buenos Aires: Paidós.
- Castro Solano, A. & Cosentino, A. C. (2016). Una aproximación léxica al estudio de las características psicológicas humanas positivas. Un estudio con población general argentina. *Perspectivas en Psicología*, 13(2), 75-83.
- Casullo, M. M. & Fernández Liporace, M. (2006). Concepciones sobre la sabiduría. Perspectivas en psicología. *Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 3(1), 1-7.

- Cohen, R. J., Swerdlik & Sturman, E. (2012). *Psychological Testing and Assessment*. Auckland: Mc Graw Hill.
- Córdoba, J. & Pigem, J.M. (1946). La expresión desiderativa como manifestación de la personalidad. *Medicina Clínica*, 4(3), 20-23.
- Costa, P. & McCrae, R. (1990). Personality disorders and the Five-Factor Model of Personality. *Journal of Personality Disorders*, 4, 362-371.
- Cupani, M., Vaiman, M., Font, M. L., Pizzichini, F. & Saretti, B. (2012). Análisis factorial confirmatorio del neo-fi utilizando parcelización de ítems y método bootstrap. *Avaliação Psicológica*, 11(2), 159-168.
- Cupani, M., Pilatti, A., Urrizaga, A., Chincolla, A., & Richaud de Minzi, M. C. (2014). Inventario de Personalidad IPIP-NEO: estudios preliminares de adaptación al español en estudiantes argentinos. *Revista Mexicana de Investigación en Psicología*, 6(1), 55-73.
- De la Iglesia, G. & Freiberg Hoffman, A. (2014). La aproximación analítico-factorial. El enfoque de los cinco factores. En M. Fernández Liporace & A. Castro Solano (Eds.), *Evaluación de la personalidad normal y sus trastornos* (pp. 33-47). Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Emmons, R. (1995). Levels and domains in personality: An introduction. *Journal of Personality*, 63(3), 341-364.
- Fernández Liporace, M. (2015). Instrumentos de evaluación de la personalidad. En M. Fernández Liporace & A. Castro Solano (Eds.), *Evaluación de la personalidad normal y sus trastornos* (pp. 107-127). Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Fernández Liporace, M., Cayssials, A. & Pérez, M. (2009). *Curso básico de psicometría*. Buenos Aires: Lugar.
- Fierro, A. (1996). El ámbito de la personalidad en psicología. En: Fierro, A (Comp.), *Manual de psicología de la personalidad*. Barcelona: Paidós.
- Fiske, D. M. (1949). Consistency of factorial structures of personality ratings from different sources. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 44(3), 329-244.
- Hughes, D. J., Rowe, M., Batey, M. & Lee, A. (2012). A tale of two Sites: Twitter vs. Facebook and the personality predictors of social media usage. *Computers in Human Behavior*, 28(2), 561-569.
- Jafar, H. (2012). Personality characteristics in smokers and non-smokers according to the Five Factor Model of Personality. *Journal of Psychology*, 16(3), 232-250.
- John, O. P., Donahue, E. M. & Kentle, R. L. (1991). *The Big Five Inventory* (versiones 4 y 54).
- Ledesma, R. D., Sánchez, R. & Díaz Lázaro, C. M. (2011). Adjective checklist to assess the Big Five Personality Factors in the Argentine population. *Journal of Personality Assessment*, 93(1), 46-55.
- Machover, K. (1949). *Personality Projection in the Drawing of the Human Figure*. Springfield: Charles Thomas.
- Meehl, P. E. (1954). *Clinical versus Statistical Prediction: A Theoretical Analysis and a Review of the Evidence*. University of Minnesota Press: Minneapolis.
- Millon, T. (1969). *Psicopatología moderna*. Buenos Aires: Salvat.
- Millon, T. (1981). *Disorders of Personality: DSM-III, Axis II*. Nueva York: Wiley.
- Millon, T. (1994). *Inventario Millon de Estilos de Personalidad*. Buenos Aires: Paidós.
- Millon, T. (1996). *Disorders of Personality*. Nueva York: Wiley & Sons.
- Millon, T., Grossman, S. & Millon, C. (2015). *MCMI-IV*. Minneapolis: Pearson.
- Morey, L. (1991, 2007). *Personality Assessment Inventory*. Florida: Psychological Assessment Resources.
- Morgan, C. D. & Murray, H. A. (1935). A method for investigating fantasies: The Thematic Apperception Test. *Archives of Neurology and Psychiatry*, 34, 289-306.
- Murray, H. (1938). *Explorations in Personality*. Nueva York: Oxford University Press.
- Norenzayan, A. & Heine, S. (2005). Psychological Universals: What are they and how can we know? *Psychological Bulletin*, 131(5), 763-784.
- Pennebaker, J. (2011). *The Secret Life of Pronouns*. Nueva York: Bloombury Press.

- Pervin, L. (1985). Personality: Current controversies, issues and directions. *Annual Review of Psychology*, 36, 83-114.
- Phillipson, H. (1955). *The object relations technique*. Glencoe, IL: FreePress.
- Quilty, L. C., Sellbom, M., Tackett, J. L. & Bagby, R. M. (2009). Personality trait predictors of bipolar disorder symptoms. *Psychiatry Research*, 169(2), 159-163.
- Rorschach, H. (1942). *Psychodiagnostics. A Diagnostic Test Based on Perception*. (P. Lenkau & B. Kronenmburg, Tr.). Berna: Huber. Edición estadounidense Grunne & Stratton.
- Sánchez-Cánovas, J. S. & Sánchez López, M. P. (1994). *Psicología diferencial: Diversidad e individualidad humanas*. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
- Sharp, K., Williams, A., Rhyner, K. & Ilardi, S. (2013). The clinical interview. En K. F. Geisinger (Ed.), *APA Handbook of Testing and Assessment in Psychology: Vol. 2. Testing and Assessment in Clinical and Counseling Psychology* (pp. 103-117). Washnigton, D.C.: APA.
- Spengler, M., Lüdtke, O., Martin, R. & Brunner, M. (2013). Personality is related to educational outcomes in late adolescence: Evidence from two large-scale achievement studies. *Journal of Research in Personality*, 47(5), 613-625.
- Timmermar, T. A. (2004). Relationships between NEO PI-R Personality measures and job performance ratings of inbound call center employees. *Applied H. R. H. Research*, 9(1-2), 35-38.
- Törnroos, M., Hintsanen, M., Hintsu, T., Jokela, M., Pulkki-Råback, L., Hutri-Kähönen, N. & Keltikangas-Järvinen, L. (2013). Associations between Five-Factor Model traits and perceived job strain: A population-based study. *Journal of Occupational Health Psychology*, 18(4), 492-500.
- Triandis, H. C., Malpas, R. S. & Davidson, A. R. (1973). Psychology and culture. *Annual Review of Psychology*, 24, 355-378.
- Tupes, E. C. & Christal, R. E. (1961). Recurrent personality factors based on trait ratings. *USAF ASD Technical Report*, 61-97.

DEL CAPÍTULO 2. LA PERSONALIDAD “PATOLÓGICA”

- American Psychiatric Association (1952). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. Washington, DC: American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association (1968). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. Washington, DC: American Psychiatric Association
- American Psychiatric Association (1980). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. Washington D. C.: American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association (1987). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Third Edition Revised*. Washington D. C.: American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association (1994). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition*. Washington D. C.: American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association (2000). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision*. Washington D. C.: American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition*. Washington D. C.: American Psychiatric Association.
- Anderson, J. L., Sellbom, M., Bagby, R. M., Quilty, L. C., Veltri, C. O. C., Markon, K. E. & Krueger, R. F. (2013). Assessment of DSM-5 personality traits on the convergence between PSY-5 domains and PID-5 domains and facets: implications for assessment of DSM-5 personality traits. *Assessment*, 20(3), 286-294.
- Auchincloss, E. L. & Michels, R. (1983). Psychoanalytic theory of character. *Current Perspectives on Personality*, 2-17.
- Bastiaansen, L., De Fruyt, F., Rossi, G., Schotte, C. & Hofmans, J. (2013). Personality disorders dysfunction versus traits: Structural and conceptual issues. *Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*, 4(4), 293-303.

- Bastiaansen, L., Rossi, G., Schotte, C. & De Fruyt, F. (2011). The structure of personality disorders: Comparing the DSM-IV-TR Axis II classification with the five-factor model framework using structural equation modeling. *Journal of Personality Disorders*, 25(3), 378-396.
- Belloch, A., Martínez Narváez, M. P. & Pascual, L. M. (1996). Personalidad sana y personalidad trastornada. En A. Fierro. (Ed.), *Manual de psicología de la personalidad*. (pp. 255-285). Barcelona: Paidós.
- Bender, D. S., Morey, L. C. & Skodol, A. E. (2011). Toward a model for assessing level of personality functioning in DSM-5, part I: A review of theory and methods. *Journal of Personality Assessment*, 93(4), 332-346.
- Blashfield, R. K. & Reynolds, S. M. (2012). An invisible college view of the DSM-5 personality disorder classification. *Journal of Personality Disorders*, 26(6), 821-829.
- Bornstein, R. F. & Huprich, S. K. (2011). Beyond dysfunction and threshold-based classification: A multidimensional model of personality disorder diagnosis. *Journal of Personality Disorders*, 25(3), 331-337.
- Butcher, J. N., Bubany, S. & Mason, S. N. (2013). Assessment of personality and psychopathology with self-report inventories. En K. F. Geisinger, B. A. Bracken, J. F. Carlson, J.-I. C. Hansen, N. R. Kuncel, S. P. Reise, & M. C. Rodríguez (Eds.), *APA Handbooks in Psychology. APA Handbook of Testing and Assessment in Psychology, Vol. 2. Testing and Assessment in Clinical and Counseling Psychology* (pp. 171-192). Washington, DC, US: American Psychological Association.
- Butcher, J. N., Dahlstrom, W. G., Graham, J. R., Tellegen, A. & Kaemmer, B. (1989). *Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2): Manual for the Administration, Scoring and Interpretation*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Casullo, M. M. & Samartino, L. (1996). Argentine studies on the MMPI-2. En J. N. Butcher (Ed.), *International Adaptations of the MMPI-2* (pp. 315-329). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Casullo, M. M., Castro Solano, A., Braude, M. & Koldovsky, N. (2000). Diagnóstico psicopatológico de adultos: aportaciones del Inventario Clínico Multiaxial MCMI III. *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina*, 46(2), 135-43.
- Casullo, M. M. (Ed.) (1999). *Aplicaciones del MMPI-2 en los ámbitos clínico, forense y laboral*. Buenos Aires: Paidós.
- De la Iglesia, G. & Castro Solano, A. (2018). The Positive Personality Model (PPM): Exploring a new conceptual framework for personality assessment. *Frontiers in Psychology*, 9, 2027. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02027>.
- Echeburúa, E., Salaberría, K. & Cruz-Sáez, M. (2014). Aportaciones y limitaciones del DSM-5 desde la Psicología Clínica. *Terapia Psicológica*, 32(1), 65-74.
- Fernández Liporace, M. (2015). Instrumentos de evaluación de la personalidad. En M. Fernández Liporace & A. Castro Solano (Eds.), *Evaluación de la personalidad normal y sus trastornos* (pp. 107-127). Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Góngora, V. C. & Castro Solano, A. (2017). Pathological Personality Traits (DSM-5), Risk Factors, and Mental Health. *SAGE Open*, 7(3), 2158244017725129.
- Gunderson, J. G. (1984). *Borderline Personality Disorder*. Albany: SUNY Press.
- Hathaway, S. R. & McKinley, J. C. (1942). *The Minnesota Multiphasic Personality Schedule*. Minneapolis: University of Minnesota.
- Hopwood, C. J., Wright, A. G. C., Krueger, R. F., Schade, N., Markon, K. E. & Morey, L. C. (2013). DSM-5 pathological personality traits and the personality assessment inventory. *Assessment*, 20(3) 269-285.
- Huprich, S. (2015). Introduction: Personality disorders into the 21st Century. En S. K. Huprich (Ed.), *Personality Disorders: Toward Theoretical and Empirical Integration in Diagnosis and Assessment* (pp. 3-19). Washington D. C.: American Psychological Association.

- Johnson, J. G., Cohen, P., Kasen, S., Skodol, A. E., Hamagami, F. & Brook, J. S. (2000). Age-related change in personality disorder trait levels between early adolescence and adulthood: A community-based longitudinal investigation. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 102, 265-275. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0447.2000.102004265>.
- Kendell, R. E. (1975). *The Role Of Diagnosis in Psychiatry*. Blackwell Scientific Publications.
- Kernberg, O. (1984). *Severe Personality Disorders*. New Haven: Yale University Press.
- Keuroghlian, A. S. & Zanarini, M. C. (2015). Lessons learned from longitudinal studies of personality disorders. En S. K. Huprich (Ed.), *Personality Disorders: Toward Theoretical and Empirical Integration in Diagnosis and Assessment* (pp. 145-161). Washington D. C.: American Psychological Association.
- Kraepelin, E. (1907). *Clinical psychiatry. A text book for students and physicians*. New York: Macmillan Company.
- Kretschmer, E. (1925). *Physique and character*. London: Kegan, Trench, and Trubner.
- Krueger, R. F. (2013). Personality disorders are the vanguard of the Post-DSM-5.0 Era. *Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*, 4(4), 355-362.
- Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., Watson, D. & Skodol, A. E. (2012). Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM-5. *Psychological Medicine*, 42, 1879-1890.
- Krueger, R. F., Eaton, N. R., Clark, L. A., Watson, D., Markon, K. E., Derringer, J., Skodol, A. & Livesley, J. (2011). Deriving an empirical structure of personality pathology for DSM-5. *Journal of Personality Disorders*, 25(2), 170-191.
- Lenzenweger, M. F. (1999). Stability and change in personality disorder features: The longitudinal study of personality disorders. *Archives of General Psychiatry*, 56(11), 1009-1015.
- Livesley, W. J., Schroeder, M. L., Jackson, D. N., & Jang, K. L. (1994). Categorical distinctions in the study of personality disorder: Implications for classification. *Journal of Abnormal Psychology*, 103(1), 6-17. <https://doi.org/10.1037/0021-843X.103.1.6>
- Markon, K. E., Quilty, L. C., Bagby, R. M. & Krueger, R. F. (2013). The development and psychometric properties of an informant-report form of the Personality Inventory for DSM-5 (PID-5). *Assessment*, 20(3), 370-383.
- Meehan, K. B. & Clarkin, J. F. (2015). A critical evaluation of moving toward a trait system for personality disorder assessment. En S. K. Huprich (Ed.), *Personality Disorders: Toward Theoretical and Empirical Integration in Diagnosis and Assessment* (pp. 85-106). Washington D. C.: American Psychological Association.
- Mervielde, I., De Clercq, B., De Fruyt, F. & Van Leeuwen, K. (2006). Temperament and personality as broad-spectrum antecedents of psychopathology in childhood and adolescence. En T. A. Widiger, E. Simonsen, P. J. Siorvatka & D. A. Regier (Eds.), *Dimensional Models of Personality Disorders*. Washington D. C.: American Psychiatric Association.
- Millon, T. (1969). *Psicopatología moderna*. Buenos Aires: Salvat.
- Millon, T. (1981). *Disorders of Personality: DSM-III, Axis II*. Nueva York: Wiley.
- Millon, T. (1984). On the renaissance of personality assessment and personality theory. *Journal of Personality Assessment*, 48(5), 450-466.
- Millon, T. (1994). *Inventario Millon de Estilos de Personalidad*. Buenos Aires: Paidós.
- Millon, T. (1996). *Disorders of Personality*. Nueva York: Wiley & Sons.
- Millon, T. & Davis, R. D. (2000). *Personality Disorders in Modern Life*. Nueva York: John Wiley.
- Millon, T. & Everly, G. S. (1994). *La personalidad y sus trastornos*, prólogo de Manuel Valdés. Barcelona: Martínez Roca.
- Millon, T., Grossman, S. & Millon, C. (2015). *MCMI-IV*. Minnessotta: Pearson.
- Morey, L. (1991, 2007). *Personality Assessment Inventory*. Florida: Psychological Assessment Resources.
- Morey, L. C., Berghuis, H., Bender, D. S., Verheul, R., Krueger, R. F. & Skodol, A. E. (2011). Toward a model for assessing level of personality functioning in DSM-5, part II: Empirical

- articulation of a core dimension of personality pathology. *Journal of Personality Assessment*, 93(4), 347-353.
- Mullins-Sweatt, S. N. & Widiger, T. A. (2011). Clinician's judgments of the utility of the DSM-IV and Five-Factor Models for Personality disordered patients. *Journal of Personality Disorders*, 25(4), 463-477.
- Ortiz-Tallo, M., Santamaría, P., Cardenal, V. & Sánchez M. P. (2011). *Inventario de Evaluación de la Personalidad PAI*, sobre el original de Morey (2007). Madrid: TEA.
- Pelechano, V., De Miguel, A. & Hernández, M. (1995). Trastornos de la personalidad. En A. Belloch, B. Sandín & F. Ramos (Eds.), *Manual de psicopatología. Vol. II*. Madrid: McGraw-Hill.
- Sharp, K., Williams, A., Rhyner, K. & Ilardi, S. (2013). The Clinical Interview. En K. F. Geisinger (Ed.), *APA Handbook of Testing and Assessment in Psychology: Vol. 2. Testing and Assessment in Clinical and Counseling Psychology*. (pp. 103-117). Washington D. C.: APA.
- Silk, K. R. (2015). The value of retaining personality disorder diagnoses. En S. K. Huprich (Ed.), *Personality Disorders: Toward Theoretical and Empirical Integration in Diagnosis and Assessment* (pp. 23-41). Washington D. C.: American Psychological Association.
- Skodol, A. E., Bender, D. S., Morey, L. C., Clark, L. A., Oldham, J. M., Alarcon, R. D., Krueger, R. F., Verheul, R., Bell, C. C. & Siever, L. J. (2011). Personality Disorder Types Proposed for DSM-5. *Journal of Personality Disorders*, 25(2), 136-169.
- Skodol, A. E., Morey, L. C., Bender, D. S. & Oldham, J. M. (2013b). When is it time to move on? Rejoinder for "The Ironic Fate of the Personality Disorders in DSM-5". *Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*, 4(4), 354.
- Stover, J. B. (2014). Los trastornos de personalidad. Hacia el DSM-5. En M. Fernández Liporace & A. Castro Solano (Eds.), *Evaluación de la personalidad normal y sus trastornos*. (pp. 65-106). Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Stover, J. B., De la Iglesia, G., Castro Solano, A. & Fernández Liporace, M. (2017). Inventario de Evaluación de la Personalidad para adolescentes: consistencia interna y dimensionalidad en adolescentes de Buenos Aires. *Pensamiento Psicológico*, 13(22), 15-27. <https://doi.org/10.16925/pe.v13i22.1985>.
- Stover, J. B., Castro Solano, A. & Fernández Liporace, M. (2015). Personality Assessment Inventory: Psychometric analysis of the Argentinean version. *Psychological Reports*, 117(3), 799-823. <https://doi.org/10.2466/08.03.PRO.117c27z2>.
- Stover, J. B., Castro Solano, A. & Fernández Liporace, M. (2019, en prensa). Dysfunctional personality traits: its relationship with Five Factor Model, adaptation and symptomatology in a community sample from Buenos Aires. *Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome*.
- Stover, J. B., Freiberg Hoffmann, A., Fernández Liporace, M. M. & Castro Solano, A. (2016). Consistencia interna y dimensionalidad del Inventario de Evaluación de la Personalidad en estudiantes universitarios de Buenos Aires. *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina*, 62(3), 153-163.
- Summerfeldt, L. J., Kloosterman, P. H. & Antony, M. M. (2010). Structured and semistructured diagnostic interviews. En M. M. Antony & D. H. Barlow (Eds.), *Handbook of Assessment and Treatment Planning for Psychological Disorders* (pp. 95-137). Nueva York: Guilford Press.
- Wakefield, J. C. (1998). The DSM's theory-neutral nosology is scientifically progressive: Response to Follette and Houts (1996). *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 66, 846-852.
- Widiger, T. A. (2011). Integrating normal and abnormal personality structure: A proposal for DSM-V. *Journal of Personality Disorders*, 25(3), 338-363.
- Widiger, T. A. & Clark, L. A. (2000). Toward DSM-V and the classification of psychopathology. *Psychological Bulletin*, 126(6), 946-963.
- Widiger, T. A., Huprich, S. & Clarkin, J. (2011). Proposals for DSM-5: Introduction to special section of Journal of Personality Disorders. *Journal of Personality Disorders*, 25(2), 135.

- Widiger, T. A., Simonsen, E., Krueger, R., Livesley, J. & Verheul, R. (2005). Personality disorder research agenda for the DSM-V. *Journal of Personality Disorders*, 19(3), 315-338.
- Widiger, T. A., Simonsen, E., Siorvatka, P. J. & Regier, D. A. (2006). *Dimensional Models of Personality Disorders*. Washington D. C.: American Psychiatric Association.

DEL CAPÍTULO 3. LA PERSONALIDAD “POSITIVA”

- Alex Linley, P., Joseph, S., Harrington, S. & Wood, A. M. (2006). Positive Psychology: past, present, and (possible) future. *The Journal of Positive Psychology*, 1(1), 3-16.
- Allport, G. W. (1937). *Personality: A Psychological Interpretation*. Nueva York: Holt, Rinehart & Winston.
- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5a ed). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>.
- Barenbaum, N. B. & Winter, D. G. (2008). History of modern personality theory and research. En O. P. John, R. W. Robins & L. A. Pervin (Eds.), *Handbook of Personality. Theory and Research* (pp. 3-20). Nueva York: Guilford Press.
- Berry, H. W. (1969). On cross-cultural comparability. *International Journal of Psychology*, 4, 119-128.
- Biswas-Diener, R. (2006). From the Equator to the North Pole: A study of character strengths. *Journal of Happiness Studies*, 7(3), 293-310. <https://doi.org/10.1007/s10902-005-3646-8>.
- Brdar, I. & Kashdan, T. B. (2010). Character strengths and well-being in Croatia: An empirical investigation of structure and correlates. *Journal of Research in Personality*, 44, 151-154. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2009.12.001>.
- Castro Solano, A. (2010). *Fundamentos de Psicología Positiva*. Buenos Aires: Paidós.
- Castro Solano, A. (2014). *Positive Psychology in Latin America*. Springer, Dordrecht, Netherlands: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-9035-2>.
- Castro Solano, A. & Cosentino, A. C. (2016a). The relationships between character strengths and life fulfillment in the view of lay-people in Argentina. *Interdisciplinaria Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 33(1), 65-80.
- Castro Solano, A. & Cosentino, A. C. (2016b). Una aproximación léxica al estudio de las características psicológicas humanas positivas: un estudio con población general argentina. *Perspectivas en Psicología*, 13(2), 75-83.
- Castro Solano, A. & Cosentino, A. C. (2017). High Five Model: Los factores altos están asociados con bajo riesgo de enfermedades médicas, mentales y de personalidad. *Psicodebate. Psicología, Cultura y Sociedad*, 17(2), 69-82.
- Castro Solano, A. & Cosentino, A. C. (2018). IVyF abreviado -IVyFabre-: análisis psicométrico y de estructura factorial en Argentina. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 36(3), 619-637.
- Castro Solano, A. & Cosentino, A. (2019, en prensa). The High Five Model: Associations of the high factors with complete mental well-being and academic adjustment in University Students. *Europe's Journal of Psychology*.
- Casullo, M. M. & Fernández Liporace, M. (2006). Las propuestas de la psicología positiva: ¿universales psicológicos o particulares de una visión cultural? *Anuario de Investigaciones*, 14, 261-268.
- Cawley, M. J., Martin, J. E. & Johnson, J. A. (2000). A virtues approach to Personality. *Personality and Individual Differences*, 28(5), 997-1013. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(99\)00207-X](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00207-X).
- Christopher, J. C. & Hickinbottom, S. (2008). Positive psychology, ethnocentrism, and the disguised ideology of individualism. *Theory & Psychology*, 18(5), 563-589.
- Cosentino, A. C. (2010). Evaluación de las virtudes y fortalezas humanas en población de habla hispana. *Psicodebate*, 10, 53-72.
- Cosentino, A. C. (2011). Fortalezas del carácter en militares argentinos. Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, tesis doctoral no publicada.

- Cosentino, A. (2014). Character strengths: Measurement and studies in Argentina with military and general population samples. En A. Castro Solano (Ed.), *Positive Psychology in Latin America* (pp. 111-127). Netherlands: Springer.
- Cosentino, A. C. & Castro Solano, A. (2008). Inventario de virtudes y fortalezas. Manuscrito no publicado.
- Cosentino, A. C. & Solano, A. C. (2012). Character strengths: A study of Argentinean soldiers. *The Spanish Journal of Psychology*, 15(1), 199-215.
- Cosentino, A. C. & Solano, A. C. (2015). IVyF: validez de un instrumento de medida de las fortalezas del carácter de la clasificación de Peterson y Seligman (2004). *Psicodebate. Psicología, Cultura y Sociedad*, 15(2), 99-122.
- Cosentino, A. C. & Castro Solano, A. (2017). *The High Five: Associations of the Five Positive Factors with the Big Five and Well-Being*. *Frontiers in Psychology*, 8, 1250. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01250>.
- Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1985). *The NEO Personality Inventory Manual*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Dahlsgaard, K., Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2005). Shared virtue: The convergence of valued human strengths across culture and history. *Review of General Psychology*, 9, 203-213.
- Davidson, A. R., Jaccard, J. J., Triandis, H. C., Morales, M. L. & Díaz-Guerrero, R. (1976). Cross-cultural model testing: Toward a solution of the etic-emic dilemma. *International Journal of Psychology*, 11(1), 1-13.
- De la Iglesia, G. & Castro Solano, A. (2018a). El Inventario de Rasgos de Personalidad Positivos (IRP-5). Construcción y análisis de características psicométricas básicas. *Perspectivas en Psicología*, 15(1), 46-57.
- De la Iglesia, G. & Castro Solano, A. (2018b). The Positive Personality Model (PPM): Exploring a New Conceptual Framework for Personality Assessment. *Frontiers in Psychology*, 9, 2027. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02027>.
- De la Iglesia, G. & Castro Solano, A. (2019a). Academic Achievement in College Students: What Role does the Positive Personality Model Play? Manuscrito sometido a evaluación para su publicación.
- De la Iglesia, G. & Castro Solano, A. (2019b). Positive Personality Model: Which Traits Relate to Complete Mental Health as Conceived by the Dual Factor Model? Manuscript Submitted for Publication.
- De la Iglesia, G., Lupano Perugini, M. L. & Castro Solano, A. (2019, en prensa). Positive Personality Model: su asociación al funcionamiento óptimo en trabajadores activos. *Revista de Psicología PUCP*.
- Duan, W., Ho, S. M. Y., Yu, B., Tang, X., Zhang, Y., Li, T. & Yuen, T. (2012). Factor Structure of the Chinese Virtues Questionnaire. *Research on Social Work Practice*, 22(6), 680-688. <https://doi.org/10.1177/1049731512450074>.
- Elston, F. & Boniwell, I. (2011). A grounded theory study of the value derived by women in financial services through a coaching intervention to help them identify their strengths and practice using them in the workplace. *International Coaching Psychology Review*, 6(1), 16-32.
- Gander, F., Proyer, R. T., Ruch, W. & Wyss, T. (2012). Strength-based positive interventions: Further evidence for their potential in enhancing well-being. *Journal of Happiness Studies*, 14, 1241-1259. <https://doi.org/10.1007/s10902-012-9380-0>.
- Goldberg, L. R. (1999). A broad-bandwidth, public-domain, personality inventory measuring the lower-level facets of several Five-Factor Models. En I. Mervielde, I. Deary, F. De Fruyt & F. Ostendorf (Eds.), *Personality Psychology in Europe*, Vol. 7 (pp. 7-28). Tilburg: Tilburg University Press.
- Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Robert, C. & Gough, H. G. (2006). The international personality item pool and the future of public-domain personality measures. *Journal of Research in Personality*, 40(1), 84-96. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2005.08.007>.

- Grinhauz, A. S. & Castro Solano, A. (2013). Validez factorial del Inventario de Virtudes y Fortalezas Para Niños (IV y F. Niños). *Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología*, Universidad Buenos Aires, 20(1), 357-364.
- Grinhauz, A. S. & Castro, S. A. (2015). Un estudio exploratorio acerca de las fortalezas del carácter en niños argentinos. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 33(1), 45-56. doi: dx.doi.org/10.12804/apl33.01.2015.
- Helfrich, H. (1999). Beyond the dilemma of cross-cultural psychology: Resolving the tension between etic and emic approaches. *Culture & Psychology*, 5(2), 131-153.
- Huppert, F. A. & So, T. T. C. (2013). Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for defining well-being. *Social Indicators Research*, 110(3), 837-861. https://doi.org/10.1007/s11205-011-9966-7.
- Jahoda, M. (1958). *Joint Commission on Mental Health and Illness Monograph Series: Vol. 1. Current Concepts Of Positive Mental Health*. Nueva York.
- John, O. P., Donahue, E. M. & Kentle, R. L. (1991). *The "Big Five" Inventory* (versiones 4 y 54). Berkeley: University of California, Berkeley, Institute of Personality and Social Research.
- Keyes, C. L. M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. *Journal of Health and Social Behavior*, 43, 207-222. doi:10.2307/3090197.
- Keyes, C. L. M. (2005). Mental illness and/or mental health? Investigating Axioms of the Complete State Model of Health. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73(3), 539-548. https://doi.org/10.1037/0022-006X.73.3.539.
- Keyes, C. L. M. & Haidt, J. (2002). *Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-Lived*. Washington, D. C.: American Psychological Association.
- Khumalo, I. P., Wissing, M. P. & Temane, Q. M. (2008). Exploring the validity of the Values-in-action Inventory of Strengths (VIA-IS) in an African context. *Journal of Psychology in Africa*, 18(1), 133-142.
- Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., Watson, D. & Skodol, A. E. (2013). *The Personality Inventory for DSM-5-Brief Form (PID-5-BF)-Adult*. Massachusetts: American Psychiatric Association.
- Lambert, L., Pasha-Zaidi, N., Passmore, H. A. & Al-Karam, C. Y. (2015). Developing an indigenous positive psychology in the United Arab Emirates. *Middle East Journal of Positive Psychology*, 1(1), 1-23.
- Lavy, S. & Littman-Ovadia, H. (2017). My better self: Using strengths at work and work productivity, organizational citizenship behavior and satisfaction. *Journal of Career Development*, 44(2), 95-109. https://doi.org/10.1177/0894845316634056.
- Leary, T. (1957). *Interpersonal Diagnosis of Personality*. Nueva York: Ronald Press.
- Leising, D. (2008). Applying principles of intercultural communication to personality disorder therapy. *Psychology and Psychotherapy-Theory, Research, and Practice*, 81, 261-272. https://doi.org/10.1348/147608308X299652.
- Leising, D., Rogers, K. & Ostner, J. (2009). The undisordered personality: Normative assumptions underlying personality disorder diagnoses. *Review of General Psychology*, 13(3), 230-241. https://doi.org/10.1037/a0017139.
- Linley, P. A., Maltby, J., Wood, A. M., Joseph, S., Harrington, S., Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2007). Character strengths in the United Kingdom: The VIA Inventory of Strengths. *Personality and Individual Differences*, 43(2), 341-351. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.12.004.
- López, S. J., Prosser, E. C., Edwards, L. M., Magyar-Moe, J. L., Neufeld, J. E. & Rasmussen, H. N. (2002). Putting positive psychology in a multicultural context. En C. R. Snyder & S. J. López (Eds.), *Handbook of Positive Psychology* (pp. 700-714). New York: Oxford University Press.
- Lounsbury, J. W., Fisher, L. A., Levy, J. J. & Welsh, D. P. (2009). An investigation of character strengths in relation to the academic success of college students. *Individual Differences Research*, 7(1), 52-69.

- Macdonald, C., Bore, M. & Munro, D. (2008). Values in action scale and the Big 5: An empirical indication of structure. *Journal of Research in Personality*, 42(4), 787-799. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2007.10.003>.
- Martínez Martí, M. L. & Ruch, W. (2014). Character strengths and well-being across the life span: Data from a representative sample of German-speaking adults living in Switzerland. *Frontiers in Psychology*, 5, 1253. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01253>.
- Mazzucchelli, T. G., Kane, R. T. & Rees, C. S. (2010). Behavioral activation interventions for well-being: A meta-analysis. *The Journal of Positive Psychology*, 5(2), 105-121.
- McCullough, M. E. & Snyder, C. R. (2000). Classical sources of human strength: Revisiting an old home and building a new one. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 19, 1-10.
- Meyers, M. C. & Van Woerkom, M. (2014). Effects of a strengths intervention on work engagement and burnout: Positive affect as a mediator. *Academy of Management Proceedings*, 2014(1), 15558-15563. <https://doi.org/10.5465/AMBPP.2014.15558.abstract>.
- Millon, T. (1996). *Disorders of Personality*. Nueva York: Wiley & Sons.
- Millon, T. (2011). *Disorders of Personality* (3^{ra} ed). Nueva York: Wiley & Sons.
- Morales-Vives, F., De Raad, B. & Vigil-Colet, A. (2014). Psycho-lexically based virtue factors in Spain and their relation with personality traits. *The Journal of General Psychology*, 141(4), 297-325. <https://doi.org/10.1080/00221309.2014.938719>.
- Murray, H. (1938). *Explorations in Personality*. Nueva York: Oxford University Press.
- Nicholson, I. A. M. (1998). Gordon Allport, character and the "culture of personality", 1897-1937. *History of Psychology*, 1, 52-68. <https://doi.org/10.1037/1093-4510.1.1.52>.
- Noronha, A. P. P., Dellazzana-Zanon, L. L. & Zanon, C. (2015). Internal structure of the characters strengths scale in Brazil. *Psico-USF*, 20(2), 229-235. <https://doi.org/10.1590/1413-82712015200204>.
- Offer, D. & Sabshin M. (1991). *The Diversity of Normal Behavior*. Nueva York: Basic Books.
- Park, N. & Peterson, C. (2009). Strengths of character in schools. En R. Gilman, E. S. Huebner & M. J. Furlong (Eds.), *Handbook of Positive Psychology in Schools* (pp. 65-76). Nueva York: Routledge.
- Park, N., Peterson, C. & Ruch, W. (2009). Orientations to happiness and life satisfaction in twenty-seven nations. *The Journal of Positive Psychology*, 4(4), 273-279.
- Park, N., Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2004). Strengths of character and well-being. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 23(5), 603-619. <https://doi.org/10.1521/jscp.23.5.603.50748>.
- Peterson, C. (2006). *A primer in positive psychology*. New York: Oxford University Press.
- Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2004). *Character Strengths And Virtues: A Handbook and Classification*. Washington, D. C.: American Psychological Association; Oxford University Press.
- Peterson, C., Park, N. & Seligman, M. E. P. (2005). Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life. *Journal of Happiness Studies*, 6, 25-41.
- Peterson, C., Park, N. & Seligman, M. E. P. (2006). Greater strengths of character and recovery from illness. *The Journal of Positive Psychology*, 1(1), 17-26. <https://doi.org/10.1080/17439760500372739>.
- Peterson, C., Park, N., Pole, N., D'Andrea, W. & Seligman, M. E. (2008). Strengths of character and post-traumatic growth. *Journal of Traumatic Stress*, 21(2), 214-217. <https://doi.org/10.1002/jts.20332>.
- Peterson, C., Ruch, W., Beerman, U., Park, N. & Seligman, M. E. P. (2007). Strengths of character, orientations to happiness, and life satisfaction. *Journal of Positive Psychology*, 2, 149-156.
- Petkari, E. & Ortiz-Tallo, M. (2018). Towards youth happiness and mental health in the United Arab Emirates: The path of character strengths in a multicultural population. *Journal of Happiness Studies*, 19(2), 333-350.
- Proyer, R. T., Gander, F., Wyss, T. & Ruch, W. (2011). The relation of character strengths to past, present, and future life satisfaction among German-Speaking women. *Applied Psychology: Health and Well-Being*, 3 (3), 370-384.

- Proyer, R. T., Ruch, W. & Buschor, C. (2012). Testing strengths-based interventions: A preliminary study on the effectiveness of a program targeting curiosity, gratitude, hope, humor, and zest for enhancing life satisfaction. *Journal of Happiness Studies*, 275-292.
- Ruch, W., Proyer, R. T., Harzer, C., Park, N., Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2010). Values in Action Inventory of Strengths (VIA-IS): Adaptation and validation of the German version and the development of a peer-rating form. *Journal of Individual Differences*, 31(3), 138-149. <https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000022>.
- Sadler, J. Z. & Fulford, B. (2006). Normative warrant in diagnostic criteria: The case of DSM-IV-TR personality disorders. *Journal of Personality Disorders*, 20, 170-180. <https://doi.org/10.1521/pedi.2006.20.2.170>.
- Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. *Advances in Experimental Social Psychology*, 25, 1-65. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60281-6](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6).
- Seligman, M. E. P. (2012). *Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being*. Nueva York: Simon & Schuster.
- Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2001). Positive Psychology: An introduction: Reply. *American Psychologist*, 56(1), 89-90. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.1.89>.
- Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive Psychology: An introduction. En M. Csikszentmihalyi (Ed.), *Flow and the Foundations of Positive Psychology* (pp. 279-298). Nueva York: Springer US.
- Sheldon, K. M., Jose, P. E., Kashdan, T. B. & Jarden, A. (2015). Personality, effective goal-striving, and enhanced well-being: Comparing 10 candidate personality strengths. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 41(4), 575-585.
- Sin, N. L. & Lyubomirsky, S. (2009). Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with Positive Psychology interventions: A practice-friendly meta-analysis. *Journal of Clinical Psychology*, 65(5), 467-487.
- Singh, K. & Choubisa, R. (2010). Empirical validation of values in Action-Inventory of Strengths (VIA-IS) in Indian context. *Psychological Studies*, 55(2), 151-158. <https://doi.org/10.1007/s12646-010-0015-4>.
- Snyder, C. R., Lopez, S. J. & Pedrotti, J. T. (2011). *Positive Psychology: The Scientific and Practical Explorations of Human Strengths* (2^{da} ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Steger, M. F., Hicks, B. M., Kashdan, T. B., Krueger, R. F. & Bouchard Jr, T. J. (2007). Genetic and environmental influences on the positive traits of the values in action classification, and biometric covariance with normal personality. *Journal of Research in Personality*, 41(3), 524-539. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2006.06.002>.
- Strack, S. & Lorr, M. (1994). *Differentiating Normal and Abnormal Personalities*. Nueva York: Springer.
- Triandis, H. C., Malpas, R. S. & Davidson, A. R. (1973). Psychology and culture. *Annual Review of Psychology*, 24, 355-378.
- Wagner, L., Gander, F., Proyer, R. T. & Ruch, W. (2018). Character strengths and PERMA: Investigating the relationships of character strengths with a multidimensional framework of well-being. *Applied Research in Quality of Life*, 1-22.
- Wakefield, J. C. (1992). The concept of mental disorder. On the boundary between biological facts and social values. *American Psychologist*, 47, 373-388. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.47.3.373>.
- Walker, L. J. & Pitts, R. C. (1998). Naturalistic conceptions of moral maturity. *Developmental Psychology*, 34(3), 403. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.34.3.403>.

DEL CAPÍTULO 4. MODELO DUAL DE LA PERSONALIDAD

- American Educational Research Association, American Psychological Association & National Council on Measurement in Education (1999). *Standards for Educational and Psychological Testing*. Washington: AERA.
- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5^{ta} ed). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>.
- Antamarian, S. (2015). Assessing psychological symptoms and well-being: Application of a dual-factor mental health model to understand College student performance. *Journal of Psycho-educational Assessment*, 33(5) 419-429. <https://doi.org/10.1177/0734282914557727>.
- Antamarian, S. P., Huebner, E. S., Hills, K. J. & Valois, R. F. (2010). A dual-factor model of mental health: Toward a more comprehensive understanding of youth functioning. *American Journal of Orthopsychiatry*, 80(4), 462-472. <https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.2010.01049.x>.
- Cosentino, A. C. & Castro-Solano, A. (2008). Adaptación y validación argentina de la Marlowe-Crowne Social Desirability Scale. *Interdisciplinaria*, 25(2), 197-216.
- Crowne, D. P. & Marlowe, D. (1960). A new scale of social desirability independent of psychopathology. *Journal of Consulting Psychology*, 24, 349-354.
- De la Iglesia, G. & Castro Solano, A. (2018). The Positive Personality Model (PPM): A new conceptual framework for personality assessment. *Frontiers in Psychology*, 9, 2025. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02027>.
- De la Iglesia, G. & Castro Solano, A. (2019). Modelo Dual de la Personalidad (MDP). Manuscrito sometido a evaluación para su publicación.
- Eklund, K., Dowdy, E., Jones, C. & Furlong, M. (2010). Applicability of the Dual-Factor Model of mental health for College students. *Journal of College Student Psychotherapy*, 25, 79-92. <https://doi.org/10.1080/87568225.2011.532677>.
- Góngora, V. & Castro Solano, A. (2017). Pathological personality traits (DSM-5), Risk factors and mental health. *SAGE Open* 7, 1-10. <https://doi.org/10.1177/2158244017725129>.
- Greenspoon, P. J. & Saklofske, D. H. (2001). Toward an integration of subjective well-being and psychopathology. *Social Indicators Research*, 54, 81-108. <https://doi.org/10.1023/A:1007219227883>.
- Guerra Vargas, S. N. (2017). *El modelo de salud mental dual y su relación con el rendimiento académico de estudiantes universitarios*. México: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Gunderson, J. G. (1979). The relatedness of borderline to schizophrenic disorders. *Schizophrenia Bulletin*, 5, 17-23. <https://doi.org/10.1093/schbul/5.1.17>.
- Keyes, C. L. K. (2004). The nexus of cardiovascular disease and depression revisited: The complete mental health perspective and the moderating role of age and gender. *Aging & Mental Health*, 8(3), 266-274. <https://doi.org/10.1080/13607860410001669804>.
- Keyes, C. L. M. (2005). Mental illness and/or mental health? Investigating axioms of the complete state model of health. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73, 539-548. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.73.3.539>.
- Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., Watson, D. & Skodol, A. E. (2013). *The Personality Inventory for DSM-5-Brief Form (PID-5-BF)-Adult*. Massachusetts: American Psychiatric Association. <https://doi.org/10.1037/t30042-000>.
- Leary, T. (1957). *Interpersonal Diagnosis of Personality*. Nueva York: Ronald Press.
- Lupano Perugini, M. L., De la Iglesia, G., Castro Solano, A. & Keyes, C. L. M. (2017). The Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) in the Argentinean context: Confirmatory factor analysis and measurement invariance. *Europe's Journal of Psychology*, 13, 93-108. <https://doi.org/10.5964/ejop.v13i1.1163>.
- Lyons, M. D., Huebner, E. S. & Hills, K. J. (2012) The Dual-Factor Model of mental health: A

- short-term longitudinal study of school-related outcomes. *Social Indicators Research*, 114(2), 549-565. <https://doi.org/10.1007/s11205-012-0161-2>.
- Millon, T. (1997). *El inventario de Estilos de Personalidad*. MIPS. Buenos Aires: Paidós.
- Millon, T. (2011). *Disorders of Personality* (3^{ra} ed). Nueva York: Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118099254>.
- Millon, T. (2012). On the history and future study of personality and its disorders. *Annual Review of Clinical Psychology*, 8, 1-19. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032511-143113>.
- Muñiz, J., Elosúa, P. & Hambleton, R. K. (2013). Directrices para la traducción y adaptación de los tests. *Psicothema*, 25(2), 151-157, 2^{da} ed.
- Strack, S. & Lorr, M. (1994). *Differentiating Normal and Abnormal Personalities*. Nueva York: Springer.
- Stuldo, S. M. & Shaffer, E. J. (2008). Looking beyond psychopathology: The Dual-Factor Model of mental health in youth. *School Psychology Review*, 37(1), 52-68.
- Stuldo, S., Thalji, A. & Ferron, J. (2011). Longitudinal academic outcomes predicted by early adolescents' subjective well-being, psychopathology, and mental health status yielded from a Dual Factor Model. *The Journal of Positive Psychology: Dedicated to Furthering Research and Promoting Good Practice*, 6(1), 7-30. <https://doi.org/10.1080/17439760.2010.536774>.

DEL CAPÍTULO 5. INVENTARIO DE LOS CINCO CONTINUOS DE LA PERSONALIDAD (ICCP)

- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5^{ta} ed). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>.
- Ben-Porath, Y. S. & Forbey, J. D. (2003). *Non-Gendered Norms for the MMPI-2*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Ben-Porath, Y. S. & Tellegen, A. (2008). *MMPI-2 RF Manual for Administration, Scoring, and Interpretation*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Cosentino, A. C. & Castro-Solano, A. (2008). Adaptación y validación argentina de la Marlowe-Crowne Social Desirability Scale. *Interdisciplinaria*, 25(2), 197-216.
- Crowne, D. P. & Marlowe, D. (1960). A new scale of social desirability independent of psychopathology. *Journal of Consulting Psychology*, 24(4), 349-354.
- De la Iglesia, G. & Castro Solano, A. (2018). The Positive Personality Model (PPM): A new conceptual framework for personality assessment. *Frontiers in Psychology*, 9, 2025. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02027>.
- De la Iglesia, G. & Castro Solano, A. (2019). Modelo Dual de la Personalidad (MDP). Manuscrito sometido a evaluación para su publicación.
- Freiberg Hoffmann, A., Stover, J. B., De la Iglesia, G. & Fernández Liporace, M. (2013). Correlaciones policóricas y tetracóricas en estudios exploratorios y confirmatorios. *Ciencias Psicológicas*, 7, 151-164.
- Friedman, A. F., Bolinsky, P. K., Levak, R. W. & Nichols, D. S. (2015). *Psychological Assessment with the MMPI-2/MMPI-2-RF* (3^{ra} ed.). Nueva York: Routledge/Taylor & Francis Group.
- Góngora, V. & Castro Solano, A. (2017). Pathological personality traits (DSM-5), Risk factors and mental health. *SAGE Open* 7, 1-10. <https://doi.org/10.1177/2158244017725129>.
- Hathaway, S. R. & Briggs, P. F. (1957). Some normative data on new MMPI scales. *Journal of Clinical Psychology*, 13, 364-368.
- Keyes, C. L. M. (2005). Mental illness and/or mental health? Investigating axioms of the complete state model of health. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73, 539-548. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.73.3.539>.

- Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., Watson, D. & Skodol, A. E. (2013). *The Personality Inventory for DSM-5-Brief Form (PID-5-BF)-Adult*. Massachusetts: American Psychiatric Association. <https://doi.org/10.1037/t30042-000>.
- Lupano Perugini, M. L., De la Iglesia, G., Castro Solano, A. & Keyes, C. L. M. (2017). The Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) in the Argentinean context: Confirmatory Factor Analysis and Measurement Invariance. *Europe's Journal of Psychology*, 13, 93-108. <https://doi.org/10.5964/ejop.v13i1.1163>.
- Morey, L. (2007). *Personality Assessment Inventory (PAI). Professional Manual* (2^{da} ed.). Odessa: Psychological Assessment Resources.
- Morey, L. (2018). PAI-A. *Inventario de Evaluación de la Personalidad para Adolescentes* (V. Cardenal, M. Ortiz-Tallo, M. M. Campos y P. Santamaría adaptadores). Madrid: TEA.
- Millon, T. (1994). *Inventario Millon de Estilos de Personalidad*. Buenos Aires: Paidós.
- Millon, T., Grossman, S. & Millon, C. (2015). *MCMI-IV*. Minnessotta: Pearson.
- Muthén, B. & Kaplan, D. (1985). A comparison of some methodologies for the factor analysis of non-normal Likert variables. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 38, 171-189. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.1985.tb00832.x>.
- Tellegen, A., Butcher, J. N. & Hoeglund, T. (1993). Are unisex norms for the MMPI-needed? Would they work? *News and Profiles*, 4, 4-5.

DEL CAPÍTULO 6. ADMINISTRACIÓN Y PUNTUACIÓN DEL ICCP

- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, (5^{ta} ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>.
- De la Iglesia, G. & Castro Solano, A. (2019). Modelo Dual de la Personalidad (MDP). Manuscrito sometido a evaluación para su publicación.
- International Test Commission (2001). International Guidelines for Test Use. *International Journal of Testing*, 1(2), 93-114.
- Muñiz, J. (2010). Las teorías de los tests: teoría clásica y teoría de respuesta a los ítems. *Papeles del Psicólogo*, 31(1), 57-66.

ANEXO 1

Administración manual

- 1.A.** ICCP - Cuadernillo de Administración
- 1.B.** ICCP - Tablas de puntuación y Baremo
- 1.C.** ICCP - Perfil

ATENCIÓN

“Para lograr una evaluación psicológica adecuada y completa, la información obtenida a partir de los resultados del ICCP debería estar acompañada por la valoración y el contraste con otras fuentes de información (otros tests, datos clínicos, entrevistas, etc.). No resulta conveniente basar el proceso de evaluación psicológica en una sola técnica de evaluación psicológica. Para más información sobre las características de las puntuaciones obtenidas mediante un test psicométrico, consultar Cohen y Swerdlik (2007)”.

DATOS DE LA PERSONA EVALUADA

Nombre: _____					
Fecha de nacimiento:	DÍA	MES	AÑO	Edad: _____	Sexo: ☐ Mujer ☐ Varón ☐ Otro
Estado civil: ☐ Soltero/a ☐ En pareja /Casado/a ☐ Divorciado/a - Separado/a ☐ Viudo/a				Lugar de residencia actual: ☐ Ciudad Autónoma de Buenos Aires ☐ Gran Buenos Aires ☐ Provincia de Argentina → ¿Cuál? _____ ☐ Exterior del país → ¿Qué país? _____	
Nacionalidad: _____					
Nivel educativo <u>máximo</u> alcanzado: ☐ Nunca estudió. ☐ Cursó (o está cursando) algunos grados de la escuela primaria ☐ Finalizó la escuela primaria. ☐ Cursó (o está cursando) algunos años de la escuela secundaria. ☐ Finalizó la escuela secundaria. ☐ Cursó (o está cursando) algunas materias en la universidad o en un terciario. ☐ Finalizó estudios universitarios/terciarios. ☐ Cursó (o está cursando) algunas materias de un posgrado. ☐ Finalizó estudios de posgrado.				¿Con quién vive actualmente? (MARQUE <u>TODAS</u> LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN) ☐ Madre ☐ Padre ☐ Hermanos/as ☐ Abuelos/as ☐ Amigos/as ☐ Sólo/a ☐ Hijo/s ☐ Pareja ☐ Otros → ¿Con quién? _____	
Nivel socio-económico: ☐ Bajo ☐ Medio-alto ☐ Medio-bajo ☐ Alto ☐ Medio					
Su situación laboral actual: ☐ Empleador/a ☐ Trabaja por su cuenta (sin patrón) ☐ Empleado/a ☐ Trabajo sin salario (no recibo pago o ad honorem) ☐ Desempleado/a ☐ Ama/o de casa ☐ Jubilado/a - Pensionado/a ☐ No trabaja				Según su opinión su salud física es: ☐ Mala ☐ Regular ☐ Buena ☐ Excelente	
				Realiza actividad física regularmente: ☐ SI ☐ NO	
				Asiste a psicoterapia actualmente: ☐ SI ☐ NO	
				Consume psicofármacos actualmente: ☐ SI ☐ NO	
ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN ☐ Clínico ☐ Educacional ☐ Laboral ☐ Forense ☐ Comunitario ☐ Otro: _____					

INSTRUCCIONES: Esta es una lista de frases que las personas podrían decir y/o pensar sobre sí mismas. Quisiéramos saber cómo se describiría a usted mismo. Lea cada frase cuidadosamente y seleccione la opción que mejor lo describa como **usted es la mayor parte del tiempo**. Para cada frase encontrará 6 opciones de respuestas, que van desde **Completamente falso** a **Completamente verdadero**. Elija sólo una opción y no deje frases sin contestar. No hay respuestas "correctas" o "incorrectas". Responda honestamente. Sus respuestas serán tratadas en forma confidencial. Tómese el tiempo que necesite.

MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN POR FRASE — NO DEJE FRASES SIN CONTESTAR

MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN POR FRASE — NO DEJE FRASES SIN CONTESTAR	
¿CÓMO ES USTED LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO?	
1	Tengo buen carácter.
2	Siempre trato de mantener distancia en relación a las personas.
3	Si alguien me insulta o me ofende intento mantener la calma.
4	He tenido éxito en varias cosas.
5	No presto demasiada atención, o no me importa demasiado, el efecto que mis acciones puedan tener en otras personas.
6	Me cuesta enfocarme en una tarea por demasiado tiempo.
7	Soy una persona prudente.
8	La mayoría de las veces puedo controlar mis reacciones emocionales (por ejemplo: enojo, tristeza, alegría, miedo) si estoy en un lugar en el que no sería apropiado hacer un escándalo.
9	Si alguien me contradice, empiezo a dudar de mí mismo.
10	Generalmente puedo mantenerme concentrado durante un tiempo considerable.
11	Establezco estándares personales que me son muy difíciles de cumplir.
12	Usualmente estoy tranquilo/a incluso cuando hay cosas que están fuera de mi control.
13	Puedo sentirme cómodo/a al mostrarme sensible frente a los demás.
14	Me asusto cuando siento que un vínculo se vuelve demasiado cercano.
15	Suelo ser muy distraído/a.
16	Sé como lograr que otros se encarguen de mis obligaciones si no me dan ganas de hacer algo.
17	Me cuesta mucho estar solo/a.
18	Pocas cosas me dan placer en la vida.
19	No entiendo en absoluto cuáles son las intenciones de las personas.
20	A veces me dan ganas de romper todo.

MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN POR FRASE — NO DEJE FRASES SIN CONTESTAR
¿CÓMO ES USTED LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO?

	COMPLETAMENTE FALSO	BASTANTE FALSO	ALGO FALSO	ALGO VERDADERO	BASTANTE VERDADERO	COMPLETAMENTE VERDADERO
21 Prefiero quedarme en casa aunque tenga la opción de salir con amigos.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22 A veces no sé si estoy despierto/a o soñando.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23 Prefiero no involucrarme en actividades que implican un alto riesgo.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24 Es fácil aprovecharse de la gente.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25 No puedo tolerar cuando las diferencias de opinión son muy marcadas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26 Usualmente logro concentrarme en mis tareas aunque me interrumpen.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
27 A veces pierdo el control y consumo demasiadas drogas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28 Generalmente no cumplo con mis compromisos.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
29 Generalmente me gusta estar solo/a.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
30 Me preocupo más que el resto de las personas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
31 Me emborracho casi todas las semanas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
32 No suelo tener muchas interacciones positivas o agradables con las personas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
33 Las mentiras son necesarias.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
34 Alguien observa todo lo que hago.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
35 Prefiero no correr grandes riesgos.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
36 Me cuesta cumplir con mis responsabilidades.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
37 No soy ni más ni menos importante que los demás.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
38 Me interesa muy poco establecer vínculos cercanos.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
39 Soy de evitar riesgos innecesarios.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40 A menudo me involucro en causas solidarias.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

COMPLETAMENTE VERDADERO →

BASTANTE VERDADERO →

ALGO VERDADERO →

ALGO FALSO →

BASTANTE FALSO →

COMPLETAMENTE FALSO →

[illegible]

MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN POR FRASE — NO DEJE FRASES SIN CONTESTAR
¿CÓMO ES USTED LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO?

	COMPLETAMENTE FALSO	BASTANTE FALSO	ALGO FALSO	ALGO VERDADERO	BASTANTE VERDADERO	COMPLETAMENTE VERDADERO	
61 Usualmente me hago cargo de mis responsabilidades.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	61
62 Generalmente me siento tenso/a.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	62
63 Antes de hacer algo pienso qué consecuencias podrían tener mis actos.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	63
64 Si tengo diferencias con alguien, prefiero hablar calmado/a.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	64
65 Siempre espero que me traten de igual manera que a los demás, no espero un trato preferencial.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	65
66 Antes de tomar algún riesgo pienso en las posibles consecuencias.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	66
67 En ocasiones abandono mi cuerpo y me veo desde afuera.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	67
68 Aunque se requiera cierta urgencia, siempre trato de pensar lo que voy a hacer.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	68
69 Soy una persona valiosa.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	69
70 Mayormente me siento a gusto con mi vida.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	70
71 Normalmente soy bastante amable con todas las personas, incluyendo gente que me cae mal.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	71
72 Si sorpresivamente tengo una emoción intensa, casi siempre puedo manejar mi forma de actuar y pensar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	72
73 Cuando halago a alguien es porque realmente lo pienso.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	73
74 A veces me siento tan mal que no lo puedo tolerar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	74
75 Soy sincero/a en cuanto a mis intenciones cuando pido ayuda.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	75
76 Casi nadie está a mi nivel.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	76
77 Ciertas imágenes o situaciones pueden ponerme sensible.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	77
78 Casi nada me entusiasma.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	78
79 Soy una persona paciente con los demás.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	79
80 Casi siempre prefiero no tomar riesgos innecesarios.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	80

COMPLETAMENTE VERDADERO →

BASTANTE VERDADERO →

ALGO VERDADERO →

ALGO FALSO →

BASTANTE FALSO →

COMPLETAMENTE FALSO →

81	Los logros de los demás son igual de importantes que los míos.	☐	☐	☐	☐	☐	81
82	Casi siempre puedo concentrarme en la mayoría de las cosas que hago.	☐	☐	☐	☐	☐	82
83	Si hice una promesa, hago todo lo que está en mis manos para cumplirla.	☐	☐	☐	☐	☐	83
84	Soy una persona tranquila.	☐	☐	☐	☐	☐	84
85	La gente suele ser tonta.	☐	☐	☐	☐	☐	85
86	La mayor parte del tiempo estoy satisfecho/a conmigo mismo.	☐	☐	☐	☐	☐	86
87	Cuando me propongo algo pongo toda mi atención en lograrlo.	☐	☐	☐	☐	☐	87
88	Cuando las personas están descontentas conmigo, me es difícil mantener mis emociones bajo control.	☐	☐	☐	☐	☐	88
89	Siempre pienso en la posibilidad de que las cosas salgan mal.	☐	☐	☐	☐	☐	89
90	La mayor parte del tiempo la vida me parece hermosa.	☐	☐	☐	☐	☐	90
91	Generalmente ayudo a los demás.	☐	☐	☐	☐	☐	91
92	Me altero fácilmente.	☐	☐	☐	☐	☐	92
93	No puedo dejar de estar en alerta.	☐	☐	☐	☐	☐	93
94	Suelo mostrar mis emociones.	☐	☐	☐	☐	☐	94
95	Me suelo enojar mucho más que otras personas.	☐	☐	☐	☐	☐	95
96	En tiempos difíciles a veces pierdo de vista lo que es importante para mí.	☐	☐	☐	☐	☐	96
97	Soy una persona segura de sí misma.	☐	☐	☐	☐	☐	97
98	Hago lo que haga siempre siento culpa.	☐	☐	☐	☐	☐	98
99	Intento conseguir lo que quiero mostrándome tal cual soy.	☐	☐	☐	☐	☐	99
100	Suelo rechazar a las personas.	☐	☐	☐	☐	☐	100

MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN POR FRASE — NO DEJE FRASES SIN CONTESTAR
¿CÓMO ES USTED LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO?

	COMPLETAMENTE FALSO	BASTANTE FALSO	ALGO FALSO	ALGO VERDADERO	BASTANTE VERDADERO	COMPLETAMENTE VERDADERO	
101	☐	☐	☐	☐	☐	☐	101
102	☐	☐	☐	☐	☐	☐	102
103	☐	☐	☐	☐	☐	☐	103
104	☐	☐	☐	☐	☐	☐	104
105	☐	☐	☐	☐	☐	☐	105
106	☐	☐	☐	☐	☐	☐	106
107	☐	☐	☐	☐	☐	☐	107
108	☐	☐	☐	☐	☐	☐	108
109	☐	☐	☐	☐	☐	☐	109
110	☐	☐	☐	☐	☐	☐	110
111	☐	☐	☐	☐	☐	☐	111
112	☐	☐	☐	☐	☐	☐	112
113	☐	☐	☐	☐	☐	☐	113
114	☐	☐	☐	☐	☐	☐	114
115	☐	☐	☐	☐	☐	☐	115
116	☐	☐	☐	☐	☐	☐	116
117	☐	☐	☐	☐	☐	☐	117
118	☐	☐	☐	☐	☐	☐	118
119	☐	☐	☐	☐	☐	☐	119
120	☐	☐	☐	☐	☐	☐	120

TABLAS DE PUNTUACIÓN

Tabla B.1. Codificación de las respuestas

RESPUESTA	CODIFICACIÓN
COMPLETAMENTE FALSO	0
BASTANTE FALSO	1
ALGO FALSO	2
ALGO VERDADERO	3
BASTANTE VERDADERO	4
COMPLETAMENTE VERDADERO	5

Tabla B.2. Ítems de la escala INC

DISCREPANCIA PARES POSITIVOS			
____ (ITEM 41) - ____ (ITEM 87) = ☐	entre -2 y 2	→ 0	☐
	≤ -3 ó ≥ 3	→ 1	
____ (ITEM 59) - ____ (ITEM 71) = ☐	entre -2 y 2	→ 0	☐
	≤ -3 ó ≥ 3	→ 1	
____ (ITEM 63) - ____ (ITEM 66) = ☐	entre -2 y 2	→ 0	☐
	≤ -3 ó ≥ 3	→ 1	
____ (ITEM 39) - ____ (ITEM 80) = ☐	entre -2 y 2	→ 0	☐
	≤ -3 ó ≥ 3	→ 1	
____ (ITEM 21) - ____ (ITEM 56) = ☐	entre -2 y 2	→ 0	☐
	≤ -3 ó ≥ 3	→ 1	
DISCREPANCIA PARES NEGATIVOS			
____ (ITEM 106) - ____ (ITEM 118) = ☐	≤ -1 ó ≥ 1	→ 0	☐
	0	→ 1	
____ (ITEM 92) - ____ (ITEM 102) = ☐	≤ -1 ó ≥ 1	→ 0	☐
	0	→ 1	
____ (ITEM 82) - ____ (ITEM 103) = ☐	≤ -1 ó ≥ 1	→ 0	☐
	0	→ 1	
____ (ITEM 6) - ____ (ITEM 26) = ☐	≤ -1 ó ≥ 1	→ 0	☐
	0	→ 1	
____ (ITEM 9) - ____ (ITEM 97) = ☐	≤ -1 ó ≥ 1	→ 0	☐
	0	→ 1	
PUNTAJE BRUTO = ☐			

Tabla B.3. Ítems de las escalas MGPAT, MNPAT y MGPOS

ESCALA	ÍTEMS
MGPAT	002 - 022 - 028 - 074 - 078 - 098 - 100 - 111 - 118
MNPAT	006 - 009 - 033 - 036 - 062 - 092 - 113
MGPOS	004 - 049 - 082 - 086 - 097 - 101 - 114 - 120

Tabla B.4. Ítems de las escalas específicas

ESCALA	ÍTEMS
FS	011 - 043 - 050 - 088 - 096 - 112
FI	005 - 019 - 025 - 032 - 038 - 117
AF	009 - 017 - 020 - 030 - 062 - 074 - 089 - 092 - 093 - 095 - 098 - 105 - 111
SE	001 - 003 - 008 - 012 - 044 - 053 - 059 - 064 - 071 - 072 - 079 - 084 - 102
DA	002 - 014 - 018 - 021 - 029 - 056 - 058 - 078 - 100 - 118
HU	013 - 040 - 048 - 052 - 077 - 091 - 094 - 116
AN	016 - 024 - 033 - 054 - 055 - 076 - 085 - 110 - 113
IN	037 - 042 - 045 - 047 - 060 - 061 - 065 - 073 - 075 - 081 - 083 - 099 - 115
DI	006 - 015 - 027 - 028 - 031 - 036 - 103 - 107
MO	007 - 023 - 035 - 039 - 063 - 066 - 068 - 080 - 119
PS	022 - 034 - 046 - 051 - 057 - 067 - 104 - 108
VF	004 - 010 - 026 - 041 - 049 - 069 - 070 - 082 - 086 - 087 - 090 - 097 - 101 - 106 - 109 - 114 - 120

Tabla B.5. Escalas pertenecientes a los Índices Globales

ESCALA	ESCALAS ESPECÍFICAS
IFP	FS - FI
IPAT	AF - DA - AN - DI - PS
IPOS	SE - HU - IN - MO - VF
IEXT	AN - DI
IINT	AF - DA

Tabla B.6. Fórmula para el cálculo del Índice de Ajuste de la Personalidad

$$IAP = \left(\frac{SE - \bar{x}_{SE} + \frac{HU - \bar{x}_{HU}}{\sigma_{HU}} + \frac{IN - \bar{x}_{IN}}{\sigma_{IN}} + \frac{MO - \bar{x}_{MO}}{\sigma_{MO}} + \frac{VF - \bar{x}_{VF}}{\sigma_{VF}}}{5} \right) - \left(\frac{AF - \bar{x}_{AF} + \frac{DA - \bar{x}_{DA}}{\sigma_{DA}} + \frac{AN - \bar{x}_{AN}}{\sigma_{AN}} + \frac{DI - \bar{x}_{DI}}{\sigma_{DI}} + \frac{PS - \bar{x}_{PS}}{\sigma_{PS}}}{5} \right)$$

Tabla B.7. Medias y desviaciones estándar para el cálculo manual del Índice de ajuste de la personalidad

	AF	SE	DA	HU	AN	IN	DI	MO	PS	VF
<i>M</i>	1.7027	3.1972	1.3390	3.1821	1.4948	3.7201	1.2942	3.0909	0.5117	3.3939
<i>DE</i>	0.86837	0.85966	0.84765	0.90954	0.85790	0.80498	0.84407	0.89303	0.68247	0.83598

Tabla B.8. Baremo para las Escalas de Validez e Índices Globales del ICCP

ESCALAS DE VALIDEZ						ÍNDICES GLOBALES							
T	AR	INC	MGPAT	MNPAT	MGPOS	IFP	IPAT	IPOS	IAP	IEXT	IINT	T	
100	NO ADMITIR PROTOCOLOS CON 12 O MÁS RESPUESTAS INCOMPLETAS O CON MÚLTIPLE ELECCIÓN	≥ 7					≥ 4.15		≥ 6.2	≥ 4.89		100	
99			4.98 - 5				4.09 - 4.14		6.1	4.82 - 4.88		99	
98			4.90 - 4.97				4.04 - 4.08		6.0	4.75 - 4.81		98	
97			4.82 - 4.89				3.98 - 4.03		5.8 - 5.9	4.68 - 4.74	4.97 - 5	97	
96			4.74 - 4.81				3.92 - 3.97		5.7	4.61 - 4.67	4.90 - 9.96	96	
95			4.66 - 4.73				3.86 - 3.91		5.6	4.54 - 4.60	4.82 - 4.89	95	
94			4.58 - 4.65				4.99 - 5	3.80 - 3.85		5.5	4.47 - 4.53	4.75 - 4.81	94
93			4.50 - 4.57				4.90 - 4.98	3.74 - 3.79		5.3 - 5.4	4.40 - 4.46	4.68 - 4.74	93
92			4.42 - 4.49				4.81 - 4.89	3.69 - 3.73		5.2	4.33 - 4.39	4.60 - 4.67	92
91			4.34 - 4.41				4.72 - 4.80	3.63 - 3.68		5.1	4.26 - 4.32	4.53 - 4.59	91
90			4.26 - 4.33				4.63 - 4.71	3.57 - 3.62		5.0	4.19 - 4.25	4.45 - 4.52	90
89			4.18 - 4.25				4.54 - 4.62	3.51 - 3.56		4.8 - 4.9	4.12 - 4.18	4.38 - 4.44	89
88			4.10 - 4.17				4.45 - 4.53	3.45 - 3.50		4.7	4.05 - 4.11	4.30 - 4.37	88
87			4.02 - 4.09				4.36 - 4.44	3.40 - 3.44		4.6	3.98 - 4.04	4.23 - 4.29	87
86			3.94 - 4.01				4.27 - 4.35	3.34 - 3.39		4.5	3.91 - 3.97	4.16 - 4.22	86
85			3.85 - 3.93				4.19 - 4.26	3.28 - 3.33		4.3 - 4.4	3.83 - 3.90	4.08 - 4.15	85
84		3.78 - 3.84				4.10 - 4.18	3.22 - 3.27		4.2	3.76 - 3.82	4.01 - 4.07	84	
83		3.69 - 3.77				4.01 - 4.09	3.16 - 3.21		4.1	3.69 - 3.75	3.93 - 4.00	83	
82		3.61 - 3.68				3.92 - 4.00	3.11 - 3.15		4.0	3.62 - 3.68	3.86 - 3.92	82	
81		3.53 - 3.60				3.83 - 3.91	3.05 - 3.10		3.8 - 3.9	3.55 - 3.61	3.79 - 3.85	81	
80		3.45 - 3.52				3.74 - 3.82	2.99 - 3.04		3.7	3.48 - 3.54	3.71 - 3.78	80	

NO ADMITIR PROTOCOLOS CON 12 O MAS RESPUESTAS INCOMPLETAS O CON MÚLTIPLE ELECCIÓN

79		3.37 - 3.44		3.65 - 3.73	2.93 - 2.98		3.6	3.41 - 3.47	3.64 - 3.70	79
78		3.29 - 3.36		3.56 - 3.64	2.87 - 2.92		3.5	3.34 - 3.40	3.56 - 3.63	78
77		3.21 - 3.28		3.47 - 3.55	2.81 - 2.86		3.4	3.27 - 3.33	3.49 - 3.55	77
76		3.13 - 3.20		3.38 - 3.46	2.76 - 2.80		3.2 - 3.3	3.20 - 3.26	3.42 - 3.48	76
75		3.05 - 3.12		3.30 - 3.37	2.70 - 2.75	5	3.1	3.13 - 3.19	3.34 - 3.41	75
74		2.97 - 3.04		3.21 - 3.29	2.64 - 2.69	4.93 - 4.99	3	3.06 - 3.12	3.27 - 3.33	74
73	4	2.89 - 2.96		3.12 - 3.20	2.58 - 2.63	4.86 - 4.92	2.9	2.99 - 3.05	3.19 - 3.26	73
72		2.81 - 2.88		3.03 - 3.11	2.52 - 5.57	4.79 - 4.85	2.7 - 2.8	2.92 - 2.98	3.12 - 3.18	72
71		2.73 - 2.80	0 - 0.07	2.94 - 3.02	2.47 - 2.51	4.72 - 4.78	2.6	2.85 - 2.91	3.04 - 3.11	71
70		2.65 - 2.72	0.08 - 0.15	2.85 - 2.93	2.41 - 2.46	4.66 - 4.71	2.5	2.78 - 2.84	2.97 - 3.03	70
69		2.57 - 2.64	0.16 - 0.23	2.76 - 2.84	2.35 - 2.40	4.59 - 4.65	2.4	2.71 - 2.77	2.90 - 2.96	69
68		2.49 - 2.56	0.24 - 0.32	2.67 - 2.75	2.29 - 2.34	4.52 - 4.58	2.2 - 2.3	2.63 - 2.70	2.82 - 2.89	68
67		2.41 - 2.48	0.33 - 0.40	2.58 - 2.66	2.23 - 2.28	4.45 - 4.51	2.1	2.56 - 2.62	2.75 - 2.81	67
66		2.33 - 2.40	0.41 - 0.49	2.49 - 2.57	2.17 - 2.22	4.38 - 4.44	2.0	2.49 - 2.55	2.67 - 2.74	66
65	3	2.25 - 2.32	0.50 - 0.57	2.40 - 2.48	2.12 - 2.16	4.31 - 4.37	1.9	2.42 - 2.48	2.60 - 2.66	65
64		2.17 - 2.24	0.58 - 0.65	2.32 - 2.39	2.06 - 2.11	4.25 - 4.30	1.7 - 1.8	2.35 - 2.41	2.53 - 2.59	64
63		2.09 - 2.16	0.66 - 0.74	2.23 - 2.31	2.00 - 2.05	4.18 - 4.24	1.6	2.28 - 2.34	2.45 - 2.52	63
62		2.01 - 2.08	0.75 - 0.82	2.14 - 2.22	1.94 - 1.99	4.11 - 4.17	1.5	2.21 - 2.27	2.38 - 2.44	62
61		1.93 - 2.00	0.83 - 0.91	2.05 - 2.13	1.88 - 1.93	4.04 - 4.10	1.4	2.14 - 2.20	2.30 - 2.37	61
60		1.85 - 1.92	0.92 - 0.99	1.96 - 2.04	1.83 - 1.87	3.97 - 4.03	1.2 - 1.3	2.07 - 2.13	2.23 - 2.29	60
59		1.77 - 1.84	1.00 - 1.08	1.87 - 1.95	1.77 - 1.82	3.90 - 3.96	1.1	2.00 - 2.06	2.16 - 2.22	59
58		1.69 - 1.76	1.09 - 1.16	1.78 - 1.86	1.71 - 1.76	3.83 - 3.89	1.0	1.93 - 1.99	2.08 - 2.15	58
57		1.61 - 1.68	1.17 - 1.24	1.69 - 1.77	1.65 - 1.70	3.77 - 3.82	0.9	1.86 - 1.92	2.01 - 2.07	57
56	2	1.53 - 1.60	1.25 - 1.33	1.60 - 1.68	1.59 - 1.64	3.70 - 3.76	0.7 - 0.8	1.79 - 1.85	1.93 - 2.00	56
55		1.45 - 1.52	1.34 - 1.41	1.51 - 1.59	1.54 - 1.58	3.63 - 3.69	0.6	1.72 - 1.78	1.86 - 1.92	55

NO ADMITIR PROTOCOLOS CON
12 O MAS RESPUESTAS O CON MÚLTIPLE ELECCIÓN

Tabla B.8. Baremo para las Escalas de Validez e Índices Globales del ICCP (cont.)

ESCALAS DE VALIDEZ					ÍNDICES GLOBALES							
T	AR	INC	MGPAT	MNPAT	MGPOS	IFP	IPAT	IPOS	IAP	IEXT	IINT	T
54			1.37 - 1.44	1.42 - 1.50	3.61 - 3.69	1.43 - 1.50	1.48 - 1.53	3.56 - 3.62	0.5	1.65 - 1.71	1.79 - 1.85	54
53			1.29 - 1.36	1.51 - 1.58	3.52 - 3.60	1.34 - 1.42	1.42 - 1.47	3.49 - 3.55	0.4	1.58 - 1.64	1.71 - 1.78	53
52			1.21 - 1.28	1.59 - 1.66	3.43 - 3.51	1.25 - 1.33	1.36 - 1.41	3.42 - 3.48	0.2 - 0.3	1.51 - 1.57	1.64 - 1.70	52
51			1.13 - 1.20	1.67 - 1.75	3.34 - 3.42	1.16 - 1.24	1.30 - 1.35	3.36 - 3.41	0.1	1.43 - 1.50	1.56 - 1.63	51
50			1.05 - 1.12	1.76 - 1.83	3.25 - 3.33	1.07 - 1.15	1.24 - 1.29	3.29 - 3.35	0.0	1.36 - 1.42	1.49 - 1.55	50
49			0.97 - 1.04	1.84 - 1.92	3.16 - 3.24	0.98 - 1.06	1.19 - 1.23	3.22 - 3.28	-0.1	1.29 - 1.35	1.41 - 1.48	49
48			0.89 - 0.98	1.93 - 2.00	3.07 - 3.15	0.89 - 0.97	1.13 - 1.18	3.15 - 3.21	-0.2 - -0.3	1.22 - 1.28	1.34 - 1.40	48
47		1	0.81 - 0.88	2.01 - 2.08	2.98 - 3.06	0.80 - 0.88	1.07 - 1.12	3.08 - 3.14	-0.4	1.15 - 1.21	1.27 - 1.33	47
46			0.73 - 0.80	2.09 - 2.17	2.89 - 2.97	0.71 - 0.79	1.01 - 1.06	3.01 - 3.07	-0.5	1.08 - 1.14	1.19 - 1.26	46
45			0.65 - 0.72	2.18 - 2.25	2.80 - 2.88	0.62 - 0.70	0.95 - 1.00	2.95 - 3.00	-0.6	1.01 - 1.07	1.12 - 1.18	45
44			0.57 - 0.64	2.26 - 2.34	2.71 - 2.79	0.53 - 0.61	0.90 - 0.94	2.88 - 2.94	-0.7 - -0.8	0.94 - 1.00	1.04 - 1.11	44
43			0.49 - 0.56	2.35 - 2.42	2.62 - 2.70	0.45 - 0.52	0.84 - 0.89	2.81 - 2.87	-0.9	0.87 - 0.93	0.97 - 1.03	43
42			0.41 - 0.48	2.43 - 2.50	2.53 - 2.61	0.36 - 0.44	0.78 - 0.83	2.74 - 2.80	-1.0	0.80 - 0.86	0.90 - 0.96	42
41			0.32 - 0.40	2.51 - 2.59	2.44 - 2.52	0.27 - 0.35	0.72 - 0.77	2.67 - 2.73	-1.1	0.73 - 0.79	0.82 - 0.89	41
40			0.24 - 0.31	2.60 - 2.67	2.35 - 2.43	0.18 - 0.26	0.66 - 0.71	2.60 - 2.66	-1.2 - -1.3	0.66 - 0.72	0.75 - 0.81	40
39		0	0.16 - 0.23	2.68 - 2.76	2.26 - 2.34	0.09 - 0.17	0.60 - 0.65	2.54 - 2.59	-1.4	0.59 - 0.65	0.67 - 0.74	39
38			0.08 - 0.15	2.77 - 2.84	2.17 - 2.25	0 - 0.08	0.55 - 0.59	2.47 - 2.53	-1.5	0.52 - 0.58	0.60 - 0.66	38
37			0 - 0.07	2.85 - 2.92	2.08 - 2.16		0.49 - 0.54	2.40 - 2.46	-1.6	0.45 - 0.51	0.53 - 0.59	37
36				2.93 - 3.01	1.99 - 2.07		0.43 - 0.48	2.33 - 2.39	-1.7 - -1.8	0.38 - 0.44	0.45 - 0.52	36
35				3.02 - 3.09	1.90 - 1.98		0.37 - 0.42	2.26 - 2.32	-1.9	0.31 - 0.37	0.38 - 0.44	35
34				3.10 - 3.18	1.81 - 1.89		0.31 - 0.36	2.19 - 2.25	-2.0	0.23 - 0.30	0.30 - 0.37	34

33		3.19 - 3.26	1.72 - 1.80		0.26 - 0.30	2.12 - 2.18	-2.1	0.16 - 0.22	0.23 - 0.29	33
32		3.27 - 3.35	1.63 - 1.71		0.20 - 0.25	2.06 - 2.11	-2.2 - -2.3	0.09 - 0.15	0.16 - 0.22	32
31		3.36 - 3.43	1.54 - 1.62		0.14 - 0.19	1.99 - 2.05	-2.4	0.02 - 0.08	0.08 - 0.15	31
30		3.44 - 3.51	1.45 - 1.53		0.08 - 0.13	1.92 - 1.98	-2.5	0 - 0.01	0.01 - 0.07	30
29		3.52 - 3.60	1.36 - 1.44		0.02 - 0.07	1.85 - 1.91	-2.6		0	29
28		3.61 - 3.68	1.27 - 1.35		0 - 0.01	1.78 - 1.84	-2.7 - -2.8			28
27		3.69 - 3.77	1.18 - 1.26			1.71 - 1.77	-2.9			27
26		3.78 - 3.85	1.09 - 1.17			1.65 - 1.70	-3.0			26
25		3.86 - 3.93	1.00 - 1.08			1.58 - 1.64	-3.1			25
24		3.94 - 4.02	0.91 - 0.99			1.51 - 1.57	-3.2 - -3.3			24
23		4.03 - 4.10	0.82 - 0.90			1.44 - 1.50	-3.4			23
22		4.11 - 4.19	0.73 - 0.81			1.37 - 1.43	-3.5			22
21		4.20 - 4.27	0.64 - 0.72			1.30 - 1.36	-3.6			21
20		4.28 - 4.35	0.55 - 0.63			1.24 - 1.29	-3.7			20
19		4.36 - 4.44	0.46 - 0.54			1.17 - 1.23	-3.8 - -3.9			19
18		4.45 - 4.52	0.37 - 0.45			1.10 - 1.16	-4.0			18
17		4.53 - 4.61	0.28 - 0.36			1.03 - 1.09	-4.1			17
16		4.62 - 4.69	0.19 - 0.27			0.96 - 1.02	-4.2			16
15		4.70 - 4.77	0.10 - 0.18			0.89 - 0.95	-4.3 - -4.4			15
14		4.78 - 4.86	0.01 - 0.09			0.82 - 0.88	-4.5			14
13		4.87 - 4.94	0			0.76 - 0.81	-4.6			13
12		4.95 - 5				0.69 - 0.75	-4.7			12
11						0.62 - 0.68	-4.8 - -4.9			11
10						0.55 - 0.61	-5.0			10
9						0.48 - 0.54	-5.1			9

Tabla B.8. Baremo para las Escalas de Validez e Índices Globales del ICCP (cont.)

ESCALAS DE VALIDEZ						ÍNDICES GLOBALES						
T	AR	INC	MGPAT	MNPAT	MGPOS	IFP	IPAT	IPOS	IAP	IEXT	IINT	T
8								0.41 - 0.47	-5.2			8
7								0.35 - 0.40	-5.3 - -5.4			7
6								0.28 - 0.34	-5.5			6
5								0.21 - 0.27	-5.6			5
4								0.14 - 0.20	-5.7			4
3								0.07 - 0.13	-5.8 - -5.9			3
2								0 - 0.06	-6.0			2
1									≤ -6.1			1

Tabla B.9. Baremo para las Escalas Específicas del ICCP

ESCALAS ESPECÍFICAS													
T	FS	FI	AF	SE	DA	HU	AN	IN	DI	MO	PS	VF	T
100											≥ 3.89		100
99											3.83 - 3.88		99
98											3.76 - 3.82		98
97											3.69 - 3.75		97
96											3.62 - 3.68		96
95											3.55 - 3.61		95
94									4.97 - 5		3.49 - 3.54		94
93					4.95 - 5				4.89 - 4.96		3.42 - 3.48		93
92					4.86 - 4.94				4.80 - 4.88		3.35 - 3.41		92
91					4.78 - 4.85		4.97 - 5		4.72 - 4.79		3.28 - 3.34		91
90					4.69 - 4.77		4.89 - 4.96		4.63 - 4.71		3.21 - 3.27		90
89		4.91 - 5			4.61 - 4.68		4.80 - 4.88		4.55 - 4.62		3.14 - 3.20		89
88	5	4.80 - 4.90	4.96 - 5		4.52 - 4.60		4.72 - 4.79		4.46 - 4.54		3.08 - 3.13		88
87	4.90 - 4.99	4.70 - 4.79	4.88 - 4.95		4.44 - 4.51		4.63 - 4.71		4.38 - 4.45		3.01 - 3.07		87
86	4.80 - 4.89	4.60 - 4.69	4.79 - 4.87		4.35 - 4.43		4.55 - 4.62		4.30 - 4.37		2.94 - 3.00		86
85	4.70 - 4.79	4.50 - 4.59	4.70 - 4.78		4.27 - 4.34		4.46 - 4.54		4.21 - 4.29		2.87 - 2.93		85
84	4.60 - 4.69	4.40 - 4.49	4.62 - 4.69		4.18 - 4.26		4.37 - 4.45		4.13 - 4.20		2.80 - 2.86		84
83	4.50 - 4.59	4.30 - 4.39	4.53 - 4.61		4.10 - 4.17		4.29 - 4.36		4.04 - 4.12		2.73 - 2.79		83
82	4.40 - 4.49	4.20 - 4.29	4.44 - 4.52		4.01 - 4.09		4.20 - 4.28		3.96 - 4.03		2.67 - 2.72		82
81	4.29 - 4.39	4.10 - 4.19	4.36 - 4.43		3.93 - 4.00		4.12 - 4.19		3.87 - 3.95		2.60 - 2.66		81
80	4.19 - 4.28	4.00 - 4.09	4.27 - 4.35		3.84 - 3.92		4.03 - 4.11		3.79 - 3.86		2.53 - 2.59		80

Tabla B.9. Baremo para las Escalas Específicas del ICCP (cont.)

ESCALAS ESPECÍFICAS													
T	FS	FI	AF	SE	DA	HU	AN	IN	DI	MO	PS	VF	T
79	4.09 - 4.18	3.90 - 3.99	4.18 - 4.26		3.76 - 3.83		3.94 - 4.02		3.70 - 3.78		2.46 - 2.52		79
78	3.99 - 4.08	3.80 - 3.89	4.10 - 4.17		3.68 - 3.75		3.86 - 3.93		3.62 - 3.69		2.39 - 2.45		78
77	3.89 - 3.98	3.69 - 3.79	4.01 - 4.09		3.59 - 3.67		3.77 - 3.85		3.54 - 3.61		2.33 - 2.38		77
76	3.79 - 3.88	3.59 - 3.68	3.92 - 4.00		3.51 - 3.58		3.69 - 3.76		3.45 - 3.53		2.26 - 2.32		76
75	3.69 - 3.78	3.49 - 3.58	3.84 - 3.91		3.42 - 3.50		3.60 - 3.68		3.37 - 3.44		2.19 - 2.25		75
74	3.59 - 3.68	3.39 - 3.48	3.75 - 3.83		3.34 - 3.41		3.52 - 3.59		3.28 - 3.36		2.12 - 2.18		74
73	3.48 - 3.58	3.29 - 3.38	3.66 - 3.74		3.25 - 3.33		3.43 - 3.51		3.20 - 3.27		2.05 - 2.11		73
72	3.38 - 3.47	3.19 - 3.28	3.57 - 3.65		3.17 - 3.24		3.34 - 3.42		3.11 - 3.19		1.98 - 2.04		72
71	3.28 - 3.37	3.09 - 3.18	3.49 - 3.56	4.96 - 5	3.08 - 3.16		3.26 - 3.33		3.03 - 3.10	4.93 - 5	1.92 - 1.97		71
70	3.18 - 3.27	2.99 - 3.08	3.40 - 3.48	4.88 - 4.95	3.00 - 3.07	4.96 - 5	3.17 - 3.25		2.95 - 3.02	4.84 - 4.92	1.85 - 1.91		70
69	3.08 - 3.17	2.89 - 2.98	3.31 - 3.39	4.79 - 4.87	2.91 - 2.99	4.87 - 4.95	3.09 - 3.16		2.86 - 2.94	4.75 - 4.83	1.78 - 1.84	4.95 - 5	69
68	2.98 - 3.07	2.79 - 2.88	3.23 - 3.30	4.71 - 4.78	2.83 - 2.90	4.78 - 4.86	3.00 - 3.08		2.78 - 2.85	4.66 - 4.74	1.71 - 1.77	4.86 - 4.94	68
67	2.88 - 2.97	2.69 - 2.78	3.14 - 3.22	4.62 - 4.70	2.74 - 2.82	4.69 - 4.77	2.92 - 2.99		2.69 - 2.77	4.57 - 4.65	1.64 - 1.70	4.78 - 4.85	67
66	2.78 - 2.87	2.59 - 2.68	3.05 - 3.13	4.53 - 4.61	2.66 - 2.73	4.60 - 4.68	2.83 - 2.91	4.97 - 5	2.61 - 2.68	4.48 - 4.56	1.57 - 1.63	4.69 - 4.77	66
65	2.67 - 2.77	2.48 - 2.58	2.97 - 3.04	4.45 - 4.52	2.57 - 2.65	4.51 - 4.59	2.74 - 2.82	4.89 - 4.96	2.52 - 2.60	4.39 - 4.47	1.51 - 1.56	4.61 - 4.68	65
64	2.57 - 2.66	2.38 - 2.47	2.88 - 2.96	4.36 - 4.44	2.49 - 2.56	4.41 - 4.50	2.66 - 2.73	4.81 - 4.88	2.44 - 2.51	4.30 - 4.38	1.44 - 1.50	4.53 - 4.60	64
63	2.47 - 2.56	2.28 - 2.37	2.79 - 2.87	4.28 - 4.35	2.40 - 2.48	4.32 - 4.40	2.57 - 2.65	4.73 - 4.80	2.35 - 2.43	4.21 - 4.29	1.37 - 1.43	4.44 - 4.52	63
62	2.37 - 2.46	2.18 - 2.27	2.71 - 2.78	4.19 - 4.27	2.32 - 2.39	4.23 - 4.31	2.46 - 2.56	4.65 - 4.72	2.27 - 2.34	4.12 - 4.20	1.30 - 1.36	4.36 - 4.43	62
61	2.27 - 2.36	2.08 - 2.17	2.62 - 2.70	4.10 - 4.18	2.23 - 2.31	4.14 - 4.22	2.40 - 2.45	4.57 - 4.64	2.19 - 2.26	4.03 - 4.11	1.23 - 1.29	4.28 - 4.35	61
60	2.17 - 2.26	1.98 - 2.07	2.53 - 2.61	4.02 - 4.09	2.15 - 2.22	4.05 - 4.16	2.31 - 2.39	4.46 - 4.56	2.10 - 2.18	3.94 - 4.02	1.17 - 1.22	4.19 - 4.27	60
59	2.07 - 2.16	1.88 - 1.97	2.45 - 2.52	3.93 - 4.01	2.06 - 2.14	3.96 - 4.04	2.23 - 2.30	4.41 - 4.45	2.02 - 2.09	3.85 - 3.93	1.10 - 1.16	4.11 - 4.18	59

58	1.96 - 2.06	1.78 - 1.87	2.36 - 2.44	3.85 - 3.92	1.98 - 2.05	3.87 - 3.95	2.14 - 2.22	4.33 - 4.40	1.93 - 2.01	3.77 - 3.84	1.03 - 1.09	4.03 - 4.10	58
57	1.86 - 1.95	1.68 - 1.77	2.27 - 2.35	3.76 - 3.84	1.89 - 1.97	3.78 - 3.86	2.06 - 2.13	4.25 - 4.32	1.85 - 1.92	3.68 - 3.76	0.96 - 1.02	3.94 - 4.02	57
56	1.76 - 1.85	1.58 - 1.67	2.19 - 2.26	3.68 - 3.75	1.81 - 1.88	3.69 - 3.77	1.97 - 2.05	4.17 - 4.24	1.76 - 1.84	3.59 - 3.67	0.89 - 0.95	3.86 - 3.93	56
55	1.66 - 1.75	1.48 - 1.57	2.10 - 2.18	3.59 - 3.67	1.73 - 1.80	3.60 - 3.68	1.89 - 1.96	4.09 - 4.16	1.68 - 1.75	3.50 - 3.58	0.82 - 0.88	3.78 - 3.85	55
54	1.56 - 1.65	1.38 - 1.47	2.01 - 2.09	3.50 - 3.58	1.64 - 1.72	3.51 - 3.59	1.80 - 1.88	4.01 - 4.08	1.59 - 1.67	3.41 - 3.49	0.76 - 0.81	3.69 - 3.77	54
53	1.46 - 1.55	1.27 - 1.37	1.92 - 2.00	3.42 - 3.49	1.56 - 1.63	3.41 - 3.50	1.71 - 1.79	3.93 - 4.00	1.51 - 1.58	3.32 - 3.40	0.69 - 0.75	3.61 - 3.68	53
52	1.36 - 1.45	1.17 - 1.26	1.84 - 1.91	3.33 - 3.41	1.47 - 1.55	3.32 - 3.40	1.63 - 1.70	3.85 - 3.92	1.43 - 1.50	3.23 - 3.31	0.62 - 0.68	3.52 - 3.60	52
51	1.26 - 1.35	1.07 - 1.16	1.75 - 1.83	3.25 - 3.32	1.39 - 1.46	3.23 - 3.31	1.54 - 1.62	3.77 - 3.84	1.34 - 1.42	3.14 - 3.22	0.55 - 0.61	3.44 - 3.51	51
50	1.15 - 1.25	0.97 - 1.06	1.66 - 1.74	3.16 - 3.24	1.30 - 1.38	3.14 - 3.22	1.46 - 1.53	3.68 - 3.76	1.26 - 1.33	3.05 - 3.13	0.48 - 0.54	3.36 - 3.43	50
49	1.05 - 1.14	0.87 - 0.96	1.58 - 1.65	3.07 - 3.15	1.22 - 1.29	3.05 - 3.13	1.37 - 1.45	3.60 - 3.67	1.17 - 1.25	2.96 - 3.04	0.41 - 0.47	3.27 - 3.35	49
48	0.95 - 1.04	0.77 - 0.86	1.49 - 1.57	2.99 - 3.06	1.13 - 1.21	2.96 - 3.04	1.29 - 1.36	3.52 - 3.59	1.09 - 1.16	2.87 - 2.95	0.35 - 0.40	3.19 - 3.26	48
47	0.85 - 0.94	0.67 - 0.76	1.40 - 1.48	2.90 - 2.98	1.05 - 1.12	2.87 - 2.95	1.20 - 1.28	3.44 - 3.51	1.00 - 1.08	2.78 - 2.86	0.28 - 0.34	3.11 - 3.18	47
46	0.75 - 0.84	0.57 - 0.66	1.32 - 1.39	2.82 - 2.89	0.96 - 1.04	2.78 - 2.86	1.11 - 1.19	3.36 - 3.43	0.92 - 0.99	2.69 - 2.77	0.21 - 0.27	3.02 - 3.10	46
45	0.65 - 0.74	0.47 - 0.56	1.23 - 1.31	2.73 - 2.81	0.88 - 0.95	2.69 - 2.77	1.03 - 1.10	3.28 - 3.35	0.83 - 0.91	2.60 - 2.68	0.14 - 0.20	2.94 - 3.01	45
44	0.55 - 0.64	0.37 - 0.46	1.14 - 1.22	2.64 - 2.72	0.79 - 0.87	2.60 - 2.68	0.94 - 1.02	3.20 - 3.27	0.75 - 0.82	2.52 - 2.59	0.07 - 0.13	2.86 - 2.93	44
43	0.45 - 0.54	0.27 - 0.36	1.06 - 1.13	2.56 - 2.63	0.71 - 0.78	2.50 - 2.59	0.86 - 0.93	3.12 - 3.19	0.67 - 0.74	2.43 - 2.51	0 - 0.06	2.77 - 2.85	43
42	0.34 - 0.44	0.17 - 0.26	0.97 - 1.05	2.47 - 2.55	0.62 - 0.70	2.41 - 2.49	0.77 - 0.85	3.04 - 3.11	0.58 - 0.66	2.34 - 2.42		2.69 - 2.76	42
41	0.24 - 0.33	0.06 - 0.16	0.88 - 0.96	2.39 - 2.46	0.54 - 0.61	2.32 - 2.40	0.68 - 0.76	2.96 - 3.03	0.50 - 0.57	2.25 - 2.33		2.60 - 2.68	41
40	0.14 - 0.23	0 - 0.05	0.80 - 0.87	2.30 - 2.38	0.45 - 0.53	2.23 - 2.31	0.60 - 0.67	2.88 - 2.95	0.41 - 0.49	2.16 - 2.24		2.52 - 2.59	40
39	0.04 - 0.13		0.71 - 0.79	2.21 - 2.29	0.37 - 0.44	2.14 - 2.22	0.51 - 0.59	2.80 - 2.87	0.33 - 0.40	2.07 - 2.15		2.44 - 2.51	39
38	0 - 0.03		0.62 - 0.70	2.13 - 2.20	0.28 - 0.36	2.05 - 2.13	0.43 - 0.50	2.72 - 2.79	0.24 - 0.32	1.98 - 2.06		2.35 - 2.43	38
37			0.54 - 0.61	2.04 - 2.12	0.20 - 0.27	1.96 - 2.04	0.34 - 0.42	2.64 - 2.71	0.16 - 0.23	1.89 - 1.97		2.27 - 2.34	37
36			0.45 - 0.53	1.96 - 2.03	0.11 - 0.19	1.87 - 1.95	0.26 - 0.33	2.56 - 2.63	0.08 - 0.15	1.80 - 1.88		2.19 - 2.26	36
35			0.36 - 0.44	1.87 - 1.95	0.03 - 0.10	1.78 - 1.86	0.17 - 0.25	2.48 - 2.55	0 - 0.07	1.71 - 1.79		2.10 - 2.18	35
34			0.27 - 0.35	1.78 - 1.86	0 - 0.02	1.69 - 1.77	0.08 - 0.16	2.40 - 2.47		1.62 - 1.70		2.02 - 2.09	34

Tabla B.9. Baremo para las Escalas Específicas del ICCP (cont.)

ESCALAS ESPECÍFICAS													
T	FS	FI	AF	SE	DA	HU	AN	IN	DI	MO	PS	VF	T
33			0.19 - 0.26	1.70 - 1.77		1.60 - 1.68	0 - 0.07	2.32 - 2.39		1.53 - 1.61		1.94 - 2.01	33
32			0.10 - 0.18	1.61 - 1.69		1.50 - 1.59		2.24 - 2.31		1.44 - 1.52		1.85 - 1.93	32
31			0.01 - 0.09	1.53 - 1.60		1.41 - 1.49		2.16 - 2.23		1.35 - 1.43		1.77 - 1.84	31
30			0	1.44 - 1.52		1.32 - 1.40		2.07 - 2.15		1.27 - 1.34		1.69 - 1.76	30
29				1.35 - 1.43		1.23 - 1.31		1.99 - 2.06		1.18 - 1.26		1.60 - 1.68	29
28				1.27 - 1.34		1.14 - 1.22		1.91 - 1.98		1.09 - 1.17		1.52 - 1.59	28
27				1.18 - 1.26		1.05 - 1.13		1.83 - 1.90		1.00 - 1.08		1.43 - 1.51	27
26				1.10 - 1.17		0.96 - 1.04		1.75 - 1.82		0.91 - 0.99		1.35 - 1.42	26
25				1.01 - 1.09		0.87 - 0.95		1.67 - 1.74		0.82 - 0.90		1.27 - 1.34	25
24				0.92 - 1.00		0.78 - 0.86		1.59 - 1.66		0.73 - 0.81		1.18 - 1.26	24
23				0.84 - 0.91		0.69 - 0.77		1.51 - 1.58		0.64 - 0.72		1.10 - 1.17	23
22				0.75 - 0.83		0.59 - 0.68		1.43 - 1.50		0.55 - 0.63		1.02 - 1.09	22
21				0.67 - 0.74		0.50 - 0.58		1.35 - 1.42		0.46 - 0.54		0.93 - 1.01	21
20				0.58 - 0.66		0.41 - 0.49		1.27 - 1.34		0.37 - 0.45		0.85 - 0.92	20
19				0.49 - 0.57		0.32 - 0.40		1.19 - 1.26		0.28 - 0.36		0.77 - 0.84	19
18				0.41 - 0.48		0.23 - 0.31		1.11 - 1.18		0.19 - 0.27		0.68 - 0.76	18
17				0.32 - 0.40		0.14 - 0.22		1.03 - 1.10		0.10 - 0.18		0.60 - 0.67	17
16				0.24 - 0.31		0.05 - 0.13		0.95 - 1.02		0.01 - 0.09		0.51 - 0.59	16
15				0.15 - 0.23		0 - 0.04		0.87 - 0.94		0		0.43 - 0.50	15
14				0.06 - 0.14				0.79 - 0.86				0.35 - 0.42	14
13				0 - 0.05				0.71 - 0.78				0.26 - 0.34	13

12		0.63 - 0.70	0.18 - 0.25	12
11		0.55 - 0.62	0.10 - 0.17	11
10		0.46 - 0.54	0.01 - 0.09	10
9		0.38 - 0.45	0	9
8		0.30 - 0.37		8
7		0.22 - 0.29		7
6		0.14 - 0.21		6
5		0.06 - 0.13		5
4		0 - 0.05		4
3				3
2				2
1				1

ICCP

Inventario de los Cinco Continuos de la Personalidad
de la Iglesia & Castro Solano (2020)

PERFIL

NOMBRE:	NIVEL EDUCATIVO:
EDAD:	NACIONALIDAD:
SEXO:	ESTADO CIVIL:

PB T 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ESCALAS DE VALIDEZ	
Ausencia de Respuesta	AR
Inconsistencia	INC
Magnificación de Psicopatología	MGPAT
Minimización de Psicopatología	MNPAT
Magnificación de Rasgos Positivos	MGPOS

ÍNDICES GLOBALES	
Índice de Funcionamiento de la Personalidad (DIAGNÓSTICO DSM-5 - CRITERIO A)	IFP
Índice de Rasgos Patológicos de la Personalidad (DIAGNÓSTICO DSM-5 - CRITERIO B)	IPAT
Índice de Rasgos Positivos de la Personalidad	IPOS
Índice de Ajuste de la Personalidad	IAP
Índice de Conductas Externalizantes	IEXT
Índice de Conductas Internalizantes	IINT

ESCALAS ESPECÍFICAS	
<i>Escala Criterio A</i>	
Funcionamiento del Sí-mismo	FS
Funcionamiento Interpersonal	FI
<i>Continuos de rasgos de la personalidad</i>	
Afectividad Negativa	AF
Serenidad	SE
Desapego	DA
Humanidad	HU
Antagonismo	AN
Integridad	IN
Desinhibición	DI
Moderación	MO
Psicoticismo	PS
Vivacidad y Foco	VF



ANEXO 2

Administración *on line*

